



DG ENCADREMENT

**CORRECTION DES DE BLANC
DES 8 ANTENNES**

ABENGOUROU

**DIPLOME D'ETAT BLANC CHIRURGIE LICENCE 3 IDE
ABENGOUROU**

Date : .../08/2025

VERSION : A

Durée :

I. QCD : Répondre par A=Vrai et B=Faux ; bonne réponse=1 point, fausse réponse= -1 et aucune réponse=0

Q1- La clinique du cancer du rein est caractérisée par la triade douleur, syndrome tumoral, hématurie. **A**

Q2- Le pancréas a une fonction endocrine et une fonction exocrine. **A** L1p123 (Doc d'anatomie)

Q3- Les glandes endocrines sont parcourues par des vaisseaux sanguins. **A** L1p148 (Doc d'anatomie)

Q4- En général localisée dans l'épiphyse, l'ostéomyélite aiguë est due à une invasion de l'organisme par le staphylocoque doré. **B** L1p51(Doc sémio chirurgicale) « la metaphyse »

Q5- Les glandes mixtes ont un parenchyme entièrement endocrine. **B** (glandes mixtes= endocrine et exocrine)

Q6- La cryptorchidie est une anomalie de descente des testicules dans la bourse. **A** L2p171

Q7- Les glandes sudoripares déversent leur sécrétion dans le sang. **B** L1p181 (Doc d'anatomie) (déversent leur sécrétion à l'extérieur)

Q8- La réduction de la hernie étranglée est un geste à proscrire chez le patient vu tardivement **A**

Q9- Le frottement chimique de la peau est un facteur local de survenue de furoncle. **A** L1p37(Doc sémio chirurgicale)

Q10- L'appréciation de la gravité d'une brûlure se fait uniquement en fonction de l'étendue de la surface corporelle brûlée. **B** L1p78(Doc sémio chirurgicale) (Selon l'âge, SCB, les tares)

Q11- La malformation congénitale de membre est liée à des aplasies ou atrophies des divers éléments du membre. **A** L1p71(Doc sémio chirurgicale)

Q12- Une étudiante infirmière affirme : « Le genu valgum » est la déviation des cuisses en abduction formant les jambes en parenthèse. **B** L1p74(Doc sémio chirurgicale) (Le genu varum)

Q13- La polydactylie est l'union de deux ou plusieurs doigts sur tout ou une partie de leur longueur. **B L1p72(Doc sémio chirurgicale) (La syndactylie)**

Q14- La désinfection avec un antiseptique est le premier geste dans la chronologie de soins d'une plaie. **B L1p56(Doc sémio chirurgicale) (Découvrir la plaie)**

Q15- La crépitation neigeuse est un signe physique de la gangrène gazeuse. **A L1p49(Doc sémio chirurgicale)**

Q16- Les malformations congénitales sont des anomalies de développement par défaut, par excès ou par disposition. **A L1p71(Doc sémio chirurgicale)**

II. QCM : Choisissez-la ou les bonne(s) réponse(s)

Q17- Monsieur YOUAN doit être transfusé avec du sang total iso groupe iso rhésus pour relever son taux d'hémoglobine à 11,5 g /dl, choisir la quantité de sang correspondante. Sachant que son poids est de 60 kg et son taux d'hémoglobine est de 6,5 g /dl

A- 900 ml

B- 450 ml

C -863 ml

$$Q_{te\ sang} = (HB\ souhaiter - HB\ actuel) \times pds \times 3$$

$$Q_{te\ sang} = (11,5 - 6,5) \times 60 \times 3$$

Q18- Choisir le débit de cette transfusion que vous devez faire passer en 4 heures

A-57 gttes /mn

B-29 gttes /mn

C-28 gttes/mn

$$D = \frac{Q \times 15}{T \times 60} = \frac{900 \times 15}{4 \times 60} = 56,25$$

Q19- Parmi les organes suivants, relever les deux organes qui constituent les organes de l'appareil urinaire haut.

A- Les reins

B- La vessie

C- L'urètre

D- Les uretères

E- La prostate

Q20- Relever les deux organes de l'appareil digestif haut parmi les organes suivants :

A- L'Estomac

B- La cavité buccale

C- L'œsophage

D- Le colon

E- L'intestin grêle

L1p26 (Doc de sémio Médicale)

Q21- L'urine est :

A- un liquide jaune, clair, limpide

B- un liquide jaune pâle, clair, trouble

C- un liquide jaune pâle, clair, limpide

Q22- Chez l'homme, l'urètre mesure environ :

A-24cm

B-14cm

C-04cm

Q23- L'anurie se caractérise par :

A-Une grande quantité d'urine

B-Une petite quantité d'urine

C-Une absence d'urine

Q24- La diurèse normale de 24heures est de : **L 3p58(Doc Nephro-Uro)**

A-1500ml

B- 1000ml

C-800ml

Q25-La rétention urinaire chronique est dite rétention avec distension lorsque le volume du résidu post-mictionnel est : **L2p163(Doc Chirurgie)**

A-supérieur à 300 ml

B-inférieur à 300 ml

C-égale à 300 ml

Q26- Parmi les signes suivants, relever le signe fonctionnel de la rétention chronique d'urine : **L2p162(Doc Chirurgie)**

A-Impossibilité d'uriner

B-besoin impérieux d'uriner permanent devenant douloureux et n'aboutissant au mieux qu'à l'émission de quelques gouttes d'urines

C-Impossibilité de vider totalement la vessie

Q27-Relever parmi les examens biologiques suivants ceux qui peuvent être demandés à un patient de l'adénome de la prostate. (choisir les trois bonnes réponses)

A-NFS

B-UREE

L2p155 (Doc de Chirurgie)

C-GE

D-PSA

E-ECBU

Q28-Parmi les signes suivants, relever les deux signes physiques de la rétention aigue d'urine : **L2p162(Doc Chirurgie)**

A-Douleur sus-pubienne de plus en plus intense

B-Douleur à la palpation augmentant le besoin d'uriner

C-Impossibilité d'uriner

D-Masse hypogastrique pouvant remonter jusqu'à l'ombilic

E-Globe vésical flaccide parfois énorme de 2 à 3 litres et indolore

Q29-En cas de rétention urinaire, relever parmi les propositions suivantes l'objectif visé dans la démarche de soins infirmiers : **L2p165(Doc Chirurgie)**

A-la pose de la sonde urinaire

B-Le retour du mode d'élimination normal des urines

C-La ponction sus-pubienne

Q30- Parmi les examens radiographiques suivants, identifier les deux qui peuvent être prescrits dans le cas d'une rétention d'urine : : **L2p164(Doc Chirurgie)**

- A- L'échographie abdominale
- B- L'échographie rein, vessie, prostate**
- C- L'urographie intraveineuse**
- D- L'abdomen sans préparation

Q31- Quel oligoélément est essentiel à l'hémoglobine ? **L1p14 (Doc d'anatomie)**

- A. Fer**
- B. Iode
- C. Sodium
- D. Potassium

Q32- Quel élément est nécessaire à la synthèse de l'hormone thyroïdienne ?

- A. Fer
- B. Calcium
- C. Iode**
- D. Potassium

L1p14 (Doc d'anatomie)

Q33- Quelle association d'ions sont essentiels à la contraction musculaire ?

- A. Sodium et Potassium**
- B. Fer et Calcium
- C. Iode et Chlore
- D. Azote et Hydrogène

L1p14 (Doc d'anatomie)

Q34- Quelle proportion d'eau compose les cellules vivantes ?

- A. 80%
- B. 60%**
- C. 40%
- D. 90%

L1p14 (Doc d'anatomie)

CAS CLINIQUE N°1 :

Vous recevez au cours de votre permanence dans le service de chirurgie, monsieur **Koné Yaya**, victime d'un accident de moto sur une voie publique. Il souffre atrocement au niveau de l'abdomen. Après un examen clinique effectué par le chirurgien de service et une ponction abdominale, il confirme une hémorragie intrapéritonéale.

Q35- Quel tableau d'urgence abdominal présente Monsieur Koné ?

- A. Tableau hémorragique de l'abdomen
- B. Tableau d'hémato-péritonite
- C. Tableau d'hémopéritoine**
- D. Tableau de péritonite

Q36-Enumérez trois symptômes qui vous orientent sur ce tableau d'urgence abdominal ?

- A. Un silence abdominal
- B. Pâleur extrême des téguments et des extrémités
- C. Un arrêt réflexe du transit
- D. Douleur abdominale provoquée avec défense généralisée
- E. Une matité déclive des flancs

Q37-Un examen d'imagerie de première intention est réalisé pour visualiser et quantifier l'hémorragie. De quel examen s'agit-il ?

- A. ASP (Radiographie de l'abdomen sans préparation)
- B. Radiographie abdominale
- C. Echographie abdominale
- D. UIV (Urographie Intraveineuse)

Q38-Enumérez deux moyens médicaux de réanimations pour M. Koné.

- A. Prendre une voie veineuse sûre au cathéter
- B. Faire la détersion de l'abdomen
- C. Injecter des produits médicamenteux pour calmer les douleurs
- D. Grouper rapidement le patient

Q39-Dans les contusions abdominales deux mécanismes isolés ou associés rendent compte des lésions. Lesquels ?

- A. Choc direct sur l'abdomen
- B. Choc à distance de l'abdomen
- C. Choc indirect dû à la décélération
- D. Choc indirect dû à la dilacération
- E. Choc direct avec écrasement

Q40-Dans les contusions abdominales, les lésions viscérales peuvent concerner plusieurs organes. (Choisir trois d'entre)

- A. Le foie
- B. Le flanc gauche
- C. Le rein
- D. Le cœur
- E. La rate

Q41-Trois tableaux symptomatologiques sont observés dans les contusions abdominales. Lesquels ? (Choisir les trois bonnes réponses).

- A. Tableau de hémato-péritonite
- B. Tableau d'hémorragie abdominale
- C. Tableau d'abdomen contus
- D. Tableau d'abdomen simple

E. Tableau de péritonite

F. Tableau d'hémopéritoine

Q42-Dans quelle région abdominale trouve-t-on la bile ?

A. La fosse iliaque gauche

B. L'hypochondre droit

C. Le flanc gauche

ETUDE DE CAS N°2 : (Voir support en annexe)

Vous êtes infirmier aux urgences de l'EPHD de Transua. Au cours de votre permanence vous recevez Monsieur Kouman, Planteur âgé de 34 ans victime d'une brûlure du tronc et de la cuisse gauche. La mesure des constantes hémodynamiques nous donne : poids=43Kg, TA= 9/6, Taille=1,55m. A l'interrogatoire il ressort que monsieur Kouman, est connu diabétique.

Q43-Relever parmi les paramètres suivants les deux permettant de déterminer l'Indice de BAUX (IB) chez un brûlé :(Choisir les deux bonnes réponses)

A. Taille

B. Age

C. Poids

D. Insuffisance cardiaque

E. Sexe

F. Tension Artérielle

Q44-La surface corporelle brûlée selon la table de LUND et BROWDER de monsieur Kouman, est :(Choisir la bonne réponse)

A. 35,5%

B. 22,5%

C. 30,5%

SCB = Tronc + Cuisse gauche

avec **Tronc = Tronc postérieur + Tronc antérieur**

SCB = 13% + 13% + 9,5% = 35,5%

Q45-Quel est selon vous l'évaluation du pronostic vital de Monsieur Kouman ?

A. Monsieur Kouman, a une chance sur deux de guérison

B. La guérison de Monsieur Kouman, est infiniment probable

C. La mort de Monsieur Kouman, est quasi certaine

Q46-Parmi les propositions suivantes, relever le critère de gravité de la brûlure correspondant aux circonstances de survenue de la brûlure :(Choisir la bonne réponse)

A. Temps d'exposition

B. Destruction complète de la membrane basale

C. Brûlure des orifices naturels

Q47-Dans la prise en charge d'un brûlé, les premiers secours consistent à : (Choisir les deux bonnes réponses).

A. Corriger les détresses vitales

B. Evaluer la surface corporelle brûlée

- C. Couvrir la victime avec les draps propres ou stériles
- D. Refroidir la victime avec de l'eau à 15°C pendant 15 minutes environ
- E. Administrer une ampoule de ACUPAN en IV

Q48-En cas de réanimation hydroélectrolytique d'un brûlé, la formule de remplissage vasculaire le premier jour selon BAXTER est : (Choisir la bonne réponse)

- A. Qté=AGE +15 X SCB
- B. Qté=AGE X 4X SCB
- C. Qté=POIDS (kg) x 4 x SCB

Q49-Déterminer la quantité de soluté à faire passer en perfusion le premier jour à Monsieur Kouman,. (Choisir la bonne réponse)

- A. 3870 ml
- B. 6106 ml
- C. 5246 ml

$$QJ1 = 4 \times Pds \times SCB$$

$$QJ1 = 4 \times 43 \times 35,5$$

Q50-Déterminer le nombre de flacons de solutés de remplissage de 500ml à utiliser pour le traitement de M. Kouman,. (Choisir la bonne réponse)

- A. 13,473
- B. 12,687
- C. 12,212
- D. 13,744

$$\text{Nbre de flacons} = \frac{6106}{500} = 12,212$$

Q51-La valeur de l'Indice de Baux est:(Choisir la bonne réponse)

- A. 88,5
- B. 93,5
- C. 78,5

$$IB = SCB + Age + 15$$

$$IB = 35,5 + 34 + 15$$

$$IB = 84,5$$

Q52-Chaque soluté pour la perfusion de Monsieur Kouman, doit passer en 2h15min. Déterminer le débit de cette perfusion:(Choisir la bonne réponse)

- A. 74,07 gouttes/min
- B. 73,46 gouttes/min
- C. 75 gouttes/min

$$D = \frac{Q \times 20}{T} \text{ avec } T = (2 \times 60) + 15 = 135\text{min}$$

$$D = \frac{500 \times 20}{135}$$

Support annexe : Tableau de LUND et BROWDER

Age	0-1 an	1-4 ans	5-9 ans	10-15 ans	Adulte
Localisation					
Cou	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
Tronc antérieur	13 %	13 %	13 %	13 %	13 %
Tronc postérieur	13 %	13 %	13 %	13 %	13 %
Une fesse	2.50 %	2.50 %	2.50 %	2.50 %	2.50 %
Une cuisse	5.50 %	6.50 %	8.50 %	8.50 %	9.50 %

Une jambe	5 %	5 %	5.50 %	6 %	7 %
-----------	-----	-----	--------	-----	-----

INFAS ABENGOUROU

DIPLOME D'ETAT BLANC
EPREUVRE DE SOINS EN MEDECINE L3

❖ **QUESTIONS A CHOIX DIRECT** : Cochez par : A = Vrai ; B = faux

1. Le rôle de l'infirmier dans l'hépatite virale repose sur l'accueil, les soins, la surveillance du malade, la prophylaxie et **la préinscription**. **B L2p40 (Doc de Médecine)** « la prévention »
2. Les virus des hépatites B et C sont les causes les plus fréquentes d'hépatite aiguë. **A**
3. La néphropathie gravidique vrai apparait dans n'importe quelle grossesse par contre la néphropathie gravidique ajoutée survient que chez la femme primipare et se guérie sans séquelle. **B L2p109 (Doc de Médecine)** « **La néphropathie gravidique vrai survient chez la femme primipare** alors que la néphropathie gravidique ajoutée survient chez la femme hypertendue »
4. La lithiasie urinaire est une complication de la lithiasie biliaire. **B** « ce sont deux maladies différentes »
5. La ponction d'ascite est un acte qui comporte beaucoup d'accident qu'il faut éviter en surveillant le malade pendant et après la ponction. **A L2p92 (Doc de SI)**
6. Le syndrome œdème-ascitique est l'accident évolutif le plus fréquent de la cirrhose. **A L2p47(Doc de Médecine)**
7. Le collapsus cardio-vasculaire est l'un des accidents de la ponction d'ascite. **A L2p92 (Doc de SI)**
8. L'insuffisance rénale chronique (IRC) ou insuffisance rénale terminale est une détérioration progressive et **réversible** de la déformation rénale. **B L2p105(Doc de Médecine)** « **IRREVERSIBLE** »
9. La lithiasie urinaire se définit comme la formation de calculs ou précipitation dans les cavités excrétrices rénales urétrales en vésicale de différents composés organiques. **A L2p83(Doc de Médecine)**
10. Le reflux gastro-œsophagien est la remontée des aliments dans le tube digestif. **A**
- 11- L'ulcère gastroduodénal (UGD) se définit comme une perte de substance de la paroi gastrique ou duodénale atteignant en profondeur la musculuse. **A L2p66 (Doc de Médecine)**
12. Le signe capital dans l'ulcère gastro duodénale est **le vomissement**. **B** « les brulures »
- 13- La maladie ulcéreuse gastroduodénale liée à l'infection Helicobacter pylori. **A**
14. **Le foie** intervient dans la régulation de la glycémie. **B** « **pancréas** »
15. La graisse est la principale source d'énergie cellulaire. **B** « **glucose** »
16. Un diabète peut être dû à une prédisposition génétique et a des facteurs environnementaux comme l'alimentation. **A**
17. L'hypophyse est contrôlée principalement par l'hypothalamus. **A**
18. Les coronaropathies sont aussi appelées cardiopathies ischémiques. **A**
19. Dans l'angine de poitrine, lorsque la douleur persiste en l'absence d'activité physique, on parle d'angor d'effort. **B**
20. La douleur de l'angor est de siège thoracique antérieur et retro sternal. **A L2p17 (Doc de Médecine)**
21. Le test diagnostique de l'angor est la trinitrine en sublingual. **A**
22. Dans la Démarche de Soins l'analyse consiste en la Classification des données en données d'indépendances et Données indépendantes. **B**

23. Le problème de dépendance et la source de difficulté sont les deux composantes du Diagnostic infirmier. **A**

24. Le Diagnostic infirmier est orienté vers l'individu tandis que le Diagnostic Médical est orienté vers la pathologie **A**

❖ QUESTIONS A CHOIX MULTIPLE

25. L'appareil digestif est composé de deux grandes parties lesquelles :

A. La bouche

B. Les glandes Annexes du digestif

C. Les glandes salivaires

D. Le tube digestif

26. Le côlon fait partie :

A. Tube digestif

B. De la partie haute du tube digestif

C. De la partie basse du tube digestif

D. Des Annexes de l'appareil digestif

27. Les complications de la néphropathie gravidique sont : L2p109(Doc de Médecine)

A. La mort fœtale in utero

B. L'hématome retro placentaire

C. Epilepsie

D. Eclampsie

28. Dans les ulcères gastro-duodénaux le(s) siège(s) de la sténose est (sont) : L2p69(Doc de Médecine)

A. Le duodénum

B. Cardia

C. Le pylore

29. L'examen complémentaire essentiel dans le diagnostic des gastrites est : L2p64(Doc de Médecine)

A. Tubage gastrite

B. Radiologie

C. Fibroscopie

30. La ponction d'ascite est l'évacuation des épanchements contenus en abondance dans : L2p88(Doc de SI)

A. La cavité pleurale

B. La cavité pancréatique

C. La cavité péritonéale

31. La ponction d'ascite se fait dans : L2p91(Doc de SI)

A. La fosse iliaque droite

B. L'hypochondre droit

C. La fosse iliaque gauche

D. L'hypochondre gauche

32. La cirrhose est une pathologie du : L2p44(Doc de Médecine)

A. Rate

B. Cœur

C. Foie

33. Tous ces composants font partie des organes Annexes de l'appareil digestif sauf deux les quels :

A. Le foie

B. Le pancréas

C. L'estomac

D. Les glandes salivaires

E. L'œsophage

F. La vésicule biliaire

34. Dans l'angiocholite aigüe deux signes cliniques sont exacts :

A. Douleur

B. Constipation

C. Diarrhée rare

D. Fièvre élevée

35. L'occlusion intestinale présente deux mécanismes

A. Occlusion organique

B. Hémorragie

C. Douleur biliaire

D. Occlusion fonctionnelle

36. Les complications de l'ulcère gastro duodénal sont les suivantes sauf une, laquelle ?

L2p69(Doc de Médecine) / L2p83(Doc de SI)

A. La cancérisation

B. Perforation digestive

C. Hémorragie digestive

D. Sténose duodénale

37. Quel diagnostic évoquer devant le tableau clinique suivant :

Rejet brutal et massif d'une grande quantité de pus ou de liquide claire à la faveur d'un effort de toux. L1p14(Doc de Sémio Médicale)

A. Expectoration

B. Vomique

C. Hémoptysie

D. Toux

38. Parmi les complications suivantes de l'UGD, il existe un intrus : lequel ? L2p69(Doc de Médecine) / L2p83(Doc de SI)

A. Perforation

B. Hémorragie

C. Ostéoporose

39. Choisir les deux bonnes réponses : L'hypophyse est formée de :

A. Lobe supérieur

B. Lobe inférieur

C. Lobe antérieur

D. Lobe postérieur

E. Lobe en amont

40. Les complications de l'ulcère gastroduodénal sont les suivantes : L2p69(Doc de Médecine) / L2p83(Doc de SI)

A. Hémorragie digestive

B. Perforation gastrique

C. Sténose

D. Rétention aiguë d'urine

41- Reliez les complications aux pathologies correspondantes.

Complications	Maladies
a- Dermatite	1- Thrombose veineuse profonde Des membres inférieurs

b- Embolie pulmonaire	2- Varice des membres inférieures
c- Dermatose	3- Œdème aigu des poumons

A. (b -1)

B. (a - 2)

C. (a - 1)

D. (b -2)

E. (b-3)

Cas pratique

- ❖ Vous êtes en service au CSU Aniassué et vous recevez Mlle Motiky âgée de 32 ans, caissière dans une banque pour céphalées, fièvre, vertiges, diarrhée, anorexie, insomnie depuis deux jours. A l'examen vous notez : T° 40°C. Pouls 70puls/mn. TA 120/70 mmhg. Poids 90 kg. Taille 1.70 m

42. Quelle est votre hypothèse diagnostique ?

A. Paludisme

B. Fièvre typhoïde

C. Méningite

43. Cochez parmi les éléments ci-dessous, les trois qui justifient votre hypothèse diagnostique

A. Céphalées

B. Diarrhée

C. Pouls 70 puls/mn

D. T° 40°C

E. Vomissement

44. Quel est le germe responsable de cette maladie ?

A. Méningocoque

B. Salmonelle

C. Plasmodium

D. Staphylocoque

45. Quel est l'examen biologique qui peut aider à poser le diagnostic ?

A. Goutte épaisse

B. Coproculture

C. NFS

D. PL

- ❖ Par ailleurs, vous constatez qu'elle tousse, à l'interrogatoire elle affirme que cette toux évolue depuis un (01) mois avec une anorexie et une asthénie. La radiographie pulmonaire montre des cavitations, l'examen de crachat est positif au BK, la sérologie VIH est négative.

46. De quelle autre pathologie souffre Mlle Motiky :

A. Tuberculose osseuse

B. Tuberculose pulmonaire

C. Miliare tuberculeuse

47. Quel est le protocole adapté à cette maladie

A. Rifampicine, Isoniazide Ethambutol, Pyrazinamide pdt 4 mois et Rifampicine et Isoniazide pdt 4 mois

B. Rifampicine, Isoniazide, Ethambutol, Pyrazinamide pdt 2 mois et Rifampicine et Isoniazide pdt 4 mois

C. Rifampicine, Isoniazide, Ethambutol, Pyrazinamide pdt 4 mois et Rifampicine et Isoniazide pdt 2 mois

D. Rifampicine, Isoniazide, Ethambutol, Pyrazinamide pdt 3 mois et Rifampicine et Isoniazide pdt 3 mois

48. L'indice de masse corporelle de Mlle. Motiky est :

A. 20,14

B. 28.14

C. 30,14

$$IMC = \frac{P}{T^2} = \frac{90}{(1,70)^2} = 30,14$$

49. Mlle Motiky est-elle :

A. Maigre

B. Corpulent

C. Obèse

Inf 18,5 $\Rightarrow$ Maigre
 18,5 – 24,9 $\Rightarrow$ Normal
 25– 34,9 $\Rightarrow$ Surpoids
 ≥ 35 $\Rightarrow$ Obèse

50. La NFS demande montre un taux d'hémoglobine à 6g/dl. Le médecin vous demande de lui faire une transfusion de sang de 420cc en 3h30mn, quel doit être le débit de cette transfusion

A. 29 gouttes/mn

B. 30 gouttes/mn

C. 31 gouttes/mn

$$D = \frac{Q \times 15}{T} \quad \text{avec } T = (3 \times 60) + 30 = 210$$

$$D = \frac{420 \times 15}{210} = 30$$

INFAS ABENGOUROU

DIPLOME D'ETAT BLANC
EPREUVRE DE SOINS EN PEDIATRIE L3

QCD

- ❖ Réponse Juste (+1) point
- ❖ Réponse fausse (-1) point
- ❖ Aucune réponse (0) point

1. KX, qui est allaité par une autre femme, court moins le risque de faire de la diarrhée et des infections respiratoires. **A**

2. KX est un sujet à risque d'infections virales a VIH et hépatiques. **A**

3. La ration alimentaire du nouveau-né et du nourrisson est fonction de l'âge et du poids. **A**

L1p35 (Doc diététique)

4. Dans la ration alimentaire du nouveau-né et de l'enfant on fait une progression de 10 ml par semaine dans la 2eme - 3eme - 4eme semaine. **A L1p36 (Doc diététique)**

5. Le cordon ombilical traité à la Chlorhexidine chute entre 5 et 10 jours de vie. **A**

6. L'alimentation de complément doit être AFADS pour la bonne santé de l'enfant. **B L1p35 (Doc diététique)**

7. L'agent de santé doit arrêter de ventiler le nouveau- né après la minute d'or. **A**

8. La toilette du nouveau-né est une technique qui consiste à exécuter l'ensemble des soins de propreté du corps. **A L1p6 (Doc soins aux enfants)**

9. Il existe deux types de toilettes. **A L1p1 (Doc SI en Pédiatrie) « simple et incubateur »**

10. Le carnet de santé est un document légal dans lequel le professionnel de santé inscrit tous les renseignements utiles au suivi de la mère pendant la grossesse. **B L1p30 (Doc SI en Pédiatrie)**

11. Le carnet de santé mère-enfant comprend cinq (05) parties. **B L1p30 (Doc SI en Pédiatrie)**

« 4 parties »

12. Il existe trois types de bain. **A L1p3 (Doc SI en Pédiatrie) « Propreté, Détente et Thérapeutique »**

13. Le Bain de propreté se réalise chez le nouveau-né après cicatrisation de la plaie ombilicale. **A L1p10 (Doc soins aux enfants)**

14. Le pansement du cordon frais a lieu les deux premiers jours de vie du nouveau-né. **B**

L1p11 (Doc SI en Pédiatrie) « 3 premiers jours de vie »

15. Les indicateurs de croissance en pratique courante sont au nombre de cinq (05). **B L1p15 (Doc SI en Pédiatrie) « Pds, Taille, PC, PB, »**

16. Les besoins en nutriments sont couverts par deux groupes d'aliments. **B**

17. Les nutriments sont des substances chimiques provenant de la transformation des aliments dans l'organisme. **A L1p22 (Doc Santé Publique)**

18. Les micronutriments sont nécessaires en petite quantité au bon fonctionnement de l'organisme. **A L1p31 (Doc diététique)**

19. Les besoins en micronutriments sont couverts par deux groupes d'aliments. **B**

20. L'alimentation de remplacement est l'action de nourrir un enfant avec un lait autre que le lait de femme. **A**

21. La mère de KX est malade. Il est allaité exclusivement par sa tante jusqu'à 6 mois. Je conclus que KX est nourri à une alimentation de remplacement. **B**

22. Le nouveau-né peut avoir un paludisme grave avant la première semaine de vie. **A**

23. L'administration de la vitamine K1 permet d'éviter la maladie hémolytique chez le nouveau-né. **B**

24. Le soin mère-kangourou est efficace dans la prise en charge du grand prématuré. **B**

CAS CLINIQUE

EU a abandonné son bébé âgé d'une semaine au bureau de la sage-femme qui la ramené à la famille grâce aux informations du carnet de santé mère-enfant. Sa grand- mère encore jeune en attendant de retrouver sa mère l'allaita exclusivement. A ce jour, l'enfant est bien suivi et se développe correctement et est âgé de cinq semaines.

25. Lorsque EU abandonnait son bébé, ses seins produisaient du

A. Lait adulte

B. Lait de transition

C. Lait semi-définitif

D. Lait mature

26. EU risque d'avoir

A. Des crevasses

B. Une lymphangite

C. Une hypogalactie

D. Un engorgement mammaire

27. Le bébé EU bénéficie de

A. L'allaitement exclusif

B. L'alimentation de complément

C. L'alimentation mixte

D. L'allaitement mixte

28. Le bébé EU bénéficie de

A. L'alimentation mixte

B. L'alimentation de remplacement

C. L'allaitement mixte

D. L'allaitement exclusif

29. EU revenue à la maison ce jour peut allaiter le bébé

A. Vrai

B. Faux

30. EU ne peut plus allaiter

A. Vrai

B. Faux

31. L'allaitement exclusif doit durer absolument 6 mois

A. Vrai

B. Faux

QCM

❖ Réponse Juste (+1) point

❖ Réponse fausse (0) point

❖ Aucune réponse (0) point

Trouver les réponses correctes aux propositions ci- dessous

32. Le carnet de santé mère-enfant comprend essentiellement : L1p30 (Doc SI en Pédiatrie)

A. Deux parties

B. Trois parties

C. Quatre parties

D. Cinq parties

33. Des indications des soins des orifices

L1p6 (Doc SI en Pédiatrie)

- A. Infection de l'orifice
- B. Sécrétion sanguinolente des orifices
- C. Maladies infectieuses
- D. Malnutrition grave
- E. Inflammation du conduit auditif externe
- F. Tuméfaction du pavillon de l'oreille.

34. Les soins du nez nécessitent le matériel suivant

L1p16 (Doc soins aux enfants)

- A. Un plateau stérile
- B. Du sérum bicarbonaté 14%0
- C. Un tampon de coton stérile
- D. Des gants propres
- E. Une pissette remplie d'alcool à 90°
- F. Un coton tige.

35. Les soins ombilicaux sont un ensemble de pratiques consistant à : L1p20 (Doc soins aux enfants)

- A. Nettoyer le moignon du cordon de manière aseptique jusqu'à sa chute.
- B. Protéger le moignon du cordon de manière aseptique jusqu'à sa chute
- C. Nettoyer et à protéger le moignon du cordon de manière aseptique jusqu'à sa chute
- D. Protéger seulement le moignon du cordon de manière aseptique jusqu'à sa chute.

36. Après le soin ombilical quelques gestes importants doivent être réalisés à savoir : L1p22(Doc soins aux enfants)

- A. Se laver les mains après avoir appliqué le gel de Chlorhexidine ;
- B. Noter le soin dans le registre : date, heure, identité du soignant, observations, signature ;
- C. Aucun conseil éducatif relatif au soin à la mère ;
- D. Vérifier la cicatrisation la plaie ombilicale
- E. Signifier le quand revenir à la mère et au chef de l'équipe.

37. Après le soin ombilical il faudrait faire une communication pour le changement social de comportement (CCSC) de la mère à savoir :

- A. Réaliser des soins du cordon ombilical sans précaution
- B. Les soins ombilicaux se font avec les produits prescrits à l'hôpital
- C. Conseiller la mère de voir l'ASC dès qu'il y a une anomalie sur le cordon ou la plaie ombilicale
- D. Déconseiller l'utilisation des produits traditionnels pour les soins ombilicaux
- E. Nourrir son enfant et de venir aux séances de vaccination programmées par le personnel de santé.

38. Les nutriments sont :

- A. utilisés dans les voies métaboliques spécifiques ;
- B. Dépendant les uns des autres ;
- C. stockés au niveau de l'organisme
- D. en quantité tissulaire invariable ;
- E. contrôlés par les apports en vitamine C

39. Trouver ce qui n'est pas un inconvénient de l'alimentation de remplacement L1p31-32 (Doc diététique)

- A. Les difficultés de préparation du lait de vache
- B. Difficultés de contact direct et affectif mère-enfant
- C. Le manque d'affection de la mère pour son enfant
- D. Difficultés d'adaptation du lait de vache aux besoins nutritionnels et de protection à l'organisme du bébé humain.

40. Les conditions AFADS pour l'alimentation de remplacement sont au nombre de :

L1p35 (Doc diététique)

- A. Trois
- B. Quatre
- C. Cinq**
- D. Six

- | |
|------------------|
| ➤ A : Acceptable |
| ➤ F : Faisable |
| ➤ A : Abordable |
| ➤ D : Durable |
| ➤ S : Sure |

41. L'allaitement permet de :

- A. Réduire les risques d'hémorragie après l'accouchement.
- B. Améliorer les acquisitions psychomotrices de l'enfant
- C. Réduire les risques de cancer pré-ménopausique du sein et de l'utérus.
- D. Avoir un enfant protégé et constamment en bonne santé**

Choisir la réponse incorrecte

42. Avant d'organiser la référence pour une souffrance cérébrale l'infirmier ou la sage-femme doit absolument :

- A. Faire la mise au sein précoce après l'avoir asséché**
- B. Désobstruer le nouveau-né après l'avoir asséché et stimulé
- C. Administrer la vitamine K1 après l'avoir asséché
- D. Faire les soins essentiels

Choisir la réponse incorrecte

43. Le parent de l'enfant doit se laver les mains à l'eau propre et du savon, observer les bonnes pratiques d'hygiène du milieu avant de :

- A. Ranger les aliments
- B. Préparer les repas des enfants**
- C. Offrir à boire aux enfants
- D. Laver les ustensiles des enfants après le repas

44. Le bol de lait d'un nourrisson de 6 kg avec du lait sec maternisé est composé de :

- A. 180 g pour la ration par repas
- B. 05 cuillères mesures de lait par repas
- C. 06 cuillères mesures de lait par repas**
- D. 170 ml pour la ration par repas en 5 repas**

45. La réanimation du nouveau-né ne doit pas excéder :

- A. 01 minute
- B. 05 minutes
- C. 15 minutes
- D. 30 minutes**

46. Parmi les activités de réanimation néonatale ci-dessous, choisir le premier geste à faire :

- A. Assécher le nouveau-né en le stimulant par des frictions
- B. Déposer le nouveau-né sur l'abdomen de sa mère
- C. Désobstruer les voies respiratoires**
- D. Le recouvrir avec un linge sec

47. Pendant l'alimentation à la tulipe, ce paramètre n'est pas à surveiller chez l'enfant,

- A. La coloration
- B. Les vomissements
- C. La prise de poids**
- D. Les réactions du nouveau-né

48. Les indications du gavage chez l'enfant sont :

- A. La détresse respiratoire
- B. Les grands brûlés**
- C. Le nouveau-né ictérique**

D. La maladie grave de la mère

49. La perte de poids physiologique est la conséquence de :

A. La température ambiante (chaleur du milieu)

B. La déperdition d'eau de la peau

C. La mise au sein tardive

D. L'élimination du méconium

Choisir la réponse incorrecte

50. Le carnet de santé mère-enfant comprend quatre parties intitulées :

A. Identité et conditions de vie des parents

B. Suivi de la grossesse

C. Suivi de la vaccination de l'enfant et de la mère

D. Suivi de l'enfant (sain ou malade)

Choisir la réponse incorrecte

51. Deux éléments de surveillances après le gavage parmi ceux-ci

A. Agitations de l'enfant

B. Nausées chez l'enfant

C. Couleur et le nombre de selles

D. Suffocation de l'enfant

52. Instiller un collyre ophtalmique consiste à

A. Mettre 1 goutte sur le globe oculaire en écartant les paupières de l'œil

B. Tirer la paupière vers le bas et mettre une goutte du produit dans le cul de sac conjonctival

C. Mettre une goutte du produit dans le canthus interne

D. Mettre une goutte du produit dans l'œil et laisser couler le surplus dans le canthus externe

53. Les complications suivantes sont fréquentes au cours de la première heure de vie, sauf une. Laquelle ?

A. Anoxie

B. Hypothermie

C. Déshydratation

D. Hypoglycémie

54. Les soins essentiels du nouveau-né sont limités aux :

A. 30 premières minutes de vie

B. 60 premières minutes de vie

C. 90 premières minutes de vie

D. 120 premières minutes de vie

55. Après avoir administré des soins au nouveau-né, le prestataire de soins doit mener les activités suivantes, sauf une. Laquelle ?

A. Laver, rincer, sécher et ranger le matériel

B. Faire la communication pour le changement social et comportemental à la mère

C. Se rendre propre, présentable et remettre le nouveau-né à sa mère

D. Transcrire le soin dans le carnet et dans le dossier du nouveau-né

INFAS ABENGOUROU

DIPLOME D'ETAT BLANC
EPREUVRE DE SANTE PUBLIQUE L3

L'IDE du CSR de Boboloua dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action décide de monitorer les activités de vaccination des enfants de 0 à 23 mois pour la période de **juin a novembre de sa structure.**

- Population de l'aire de santé : 22 840 hbts
- Population cible a moins de 5 km : 321 enfants
- Population cible à partir de 5 km ayant bénéficié d'au moins 03 stratégies avancées : 250 enfants
- Population cible à partir de 5 km ayant bénéficié de 04 stratégies avancées : 75 enfants
- Population cible ayant reçu le Penta 1+ le VPO1 au cours de la période : 679 enfants
- Population cible complètement vaccinée au cours de la période : 275 enfants
- Population cible correctement vaccinée au cours de la période : 102 enfants

Les autres informations de son activité sont mentionnées dans les tableaux ci-dessous :

	Juin	Juil	Aout	Sept	Oct	Nov	Total
Jours	30	31	31	30	31	30	183
Jours rupture vaccins	04	00	17	00	00	00	
Jours rupture matériel	00	06	31	00	00	02	

	Juin	Juil	Aout	Sept	Oct	Nov	Total
Jours	30	31	31	30	31	30	183
Nbre jours de demi-journée T°Inf à +2°C Sup à +8°C	02	00	00	00	Pas de feuille	08	

1. Le monitoring est une activité qui permet d'évaluer localement la couverture des activités à partir des déterminants de couverture : Choisis la bonne réponse L3p5

A. Vrai

B. Faux

2. Le monitoring réalisé par l'IDE est celui de Décembre : L3p12

A. Vrai

B. Faux

3. Le monitoring est réalisé par les équipes cadre du District sanitaire avec l'appui de l'Equipe Régionale de Santé. L3p5 (les équipes locales sous la supervision de l'Equipe cadre du District sanitaire et l'appui de l'Equipe Régionale de Santé)

- A. Vrai
B. Faux

4. Le monitoring s'effectue périodiquement : Choisis la bonne réponse L3p5

- A. Tous les trois mois
B. Tous les six mois
C. Tous les ans

5. La population cible de la période monitorée est : Choisis la bonne réponse

- A. 1 558
B. 779
C. 778

$$P(0 \text{ à } 23\text{mois}) = 6,82\% \times P_t = 6,82\% \times 22840 = 1558\text{hbts}$$

$$P_c \text{ du monitoring} = \frac{155}{2} = 779$$

6. La population PEV+ de la période monitorée est : Choisis la bonne réponse

- A. 571
B. 396
C. 646

$$321 + 250 + 75 = 646$$

7. Le pourcentage de temps pendant lequel les ressources nécessaires à l'exécution de l'activité étaient disponibles est : Choisis la bonne réponse

- A. 76.50%
B. 67.21%
C. 32.79%

$$\left. \begin{array}{l} \text{Jours de rupture Vaccins} = 21 \\ \text{Jours de rupture Matériel} = 39 \end{array} \right\} 60\text{jrs} \quad \left| \quad DR = \frac{183 - 60}{183} \times 100 \right.$$

8. Le pourcentage de la population cible vivant suffisamment près du service et qui y a accès facilement est. Choisis la bonne réponse

- A. 82.93%
B. 50,83%
C. 73.30%

$$AG \frac{\text{Pop à moins de 5km} + \text{Pop à partir de 5km}}{\text{ou au moins trois stratégies ont été effectuées}} \times 100$$

$$AG \frac{(321 + 250)}{779} \times 100 = 73,299$$

9. L'utilisation des services de vaccination par la population cible au cours de la période est : Choisis la bonne réponse

- A. 40,50%
B. 87,16%
C. 43,58%

$$US \frac{\text{Population cible ayant reçu le Penta 1+ le VPO1}}{PC} \times 100$$

$$US \frac{679}{779} \times 100 = 87,16$$

10. La proportion de la population cible qui a bénéficié de l'activité selon l'intensité et la fréquence requises est. Choisis la bonne réponse

- A. 13.09%
B. 37.09%
C. 40,50%

$$CA \frac{\text{Population cible correctement vaccinée au cours de la période}}{PC} \times 100$$

$$CA \frac{102}{779} \times 100 = 13,09$$

11. La Proportion de la population cible qui a reçu une couverture adéquate avec des vaccins conservés entre +2°C et +8°C : Choisis la bonne réponse

- A. 11,62%
B. 10.51%

$$CE = \frac{\text{Population cible qui a reçu une couverture adéquate avec des vaccins conservés entre } +2^{\circ}\text{C et } +8^{\circ}\text{C}}{PC} \times 100$$

C. 04,30%

$$CE = \frac{82}{779} \times 100 = 10,52$$

$$(2+31+8) \times 2 = 82$$

12. Après analyse des résultats des différents indicateurs du monitoring, l'IDE/For noire Choisis la bonne réponse

- A. Deux goulots d'étranglements
- B. Trois goulots d'étranglements
- C. Quatre goulots d'étranglements
- D. Cinq goulots d'étranglements

13. La supervision est un processus continu qui consiste à guider et former l'agent de santé, soutenir et encourager ses initiatives sur le site du travail : cochez la bonne réponse L3p43

A. Vrai

B. Faux

14. Les activités de supervision ont pour cibles : Coche-la ou les bonnes réponses L3p44

A Le personnel de santé en activité

B. Les activités selon les directives

C. L'établissement

15. Dans la supervision lorsque le superviseur donne des instructions spécifiques et surveille de près l'exécution des tâches. Il utilise le style : Coche la bonne réponse L3p44

A. Autocratique

B. Démocratique

C. Anarchique

16. Les avantages du style démocratique utilisées au cours de la supervision sont : Choisis les bonnes réponses L3p45

A. Augmente le rendement de façon durable ;

B. Permet d'atteindre une performance élevée

C. Est motivant et aide à prendre des décisions

D. Encourage les initiatives et permet une bonne coordination des activités

ETUDE DE CAS :

KONEKAHA est un village du département de TINGRELA. La population de cette bourgade était estimée à 16500 habitants selon le Recensement général de la Population (RGPH2021) avec un taux d'accroissement annuel de 2%. Au cours l'année 2024, l'année de votre prise de fonction en tant qu'IDE du CSR de KONEKAHA, vous faites une analyse situationnelle. Il ressort les constats suivants :

- Les enfants de 0 à 23 mois ne sont pas correctement vaccinés contre les maladies cibles du PEV ;
- Les femmes enceintes ne fréquentent pas les services de CPN.
- 310 cas de paludisme dont 4 décès
- 52 cas de IRA avec 6 décès dont 3 enfants de deux semaines
- 44 cas de diarrhée avec 6 décès dont 4 enfants entre le huitième et les vingt huitièmes jours
- Il y a eu 120 naissances vivantes au cours de l'année 2024.

Le village a accueilli 300 personnes venues de la sous-région à la recherche de terre fertile. 50 jeunes natifs de KONEKAHA ont quitté le village pour aller chercher du travail au port de SAN-PEDRO

17. La population totale de KONEKAHA

A. $P_{2024} = 15710$

B. $P_{2024} = 17150$

$$P(2024) = P(2021) \times \left(1 + \frac{TAA}{100}\right)^3$$

$$P(2024) = 16500 \times \left(1 + \frac{2}{100}\right)^3$$

$$C. P_{(2024)} = 17510$$

$$D. P_{\{2024\}} = 15170$$

$$\frac{2}{100}$$

18. La population d'enfants de 0 à 23 mois.

A. 1419

B. 1914

C. 1941

D. 1194

$$P(0 \text{ à } 23 \text{ mois}) = 6,82\% \times Pt$$

$$P(0 \text{ à } 23 \text{ mois}) = 6,82\% \times 17510$$

19. Femmes enceintes :

A. 876

B. 786

C. 867

D. 687

$$P(FE) = 5\% \times Pt$$

$$P(FE) = 5\% \times 17510$$

20. Balance migratoire :

A. 502

B. 205

C. 520

D. 250

$$BM = \text{Immigration} - \text{Emigration}$$

$$BM = 300 - 50$$

21. Femme en âge de reproduire (FAR) :

A. 3250

B. 3052

C. 3502

D. 3520

$$\text{Nbre FAR} = 20\% \times Pt$$

$$\text{Nbre FAR} = 20\% \times 17510$$

22. Taux général de fécondité (TGF)

A. 3,34%

B. 4,33%

C. 0,343%

D. 3,43%

$$TGF = \frac{NV}{\text{Nbre FAR}} \times 100 = \frac{120}{3502} \times 100$$

23. En prenant 2024 comme année de repère en quelle année la population va doubler ?

A. AD= 2085

B. AD= 2059

C. AD= 2905

D. AD= 2509

$$AD = AR + TD \text{ avec } TD = \frac{70}{TAA} = \frac{70}{2} = 35 \text{ans}$$

$$AD = 2024 + 35$$

24. Taux brut de morbidité

A. TBM= 2,32%

B. TBM= 30, 2%

C. TBM= 3,20%

D. TBM= 2,03%

$$TBM = \frac{\text{Maladie}}{Pt} \times 100$$

$$TBM = \frac{310 + 52 + 44}{17510} \times 100$$

25. La létalité du paludisme

A. TL= 2,85%

B. TL= 28,5%

C. TL= 25,8%

D. TL= 1,25%

$$TL = \frac{\text{Décès}}{\text{Cas}} \times 100$$

$$TL = \frac{4}{310} \times 100$$

26. Le taux de mortalité néonatal tardif

A. TMNNT=3,58%

B. TMNNT=0,583%

C. TMNNT=5,38%

$$TMNNT = \frac{\text{Décès d'enfants de 8 à moins de 28jrs}}{NV} \times 100$$

$$TMNNT = \frac{3+4}{120} \times 100$$

D. TMNNT=5,83%

27. Les différents axes (Albouty-Liaty, 2009) en épidémiologie sont L1p81

A. au nombre de 2

B. au nombre de 6

C. au nombre de 3

28. Les domaines d'application en épidémiologie sont L1p81

A. au nombre de 2

B. au nombre de 6

C. au nombre de 3

29. L'axe descriptif en épidémiologie réponds à la question : L1p81

A. Pourquoi ?

B. Quand ? Qui ? Combien ?

C. Quand ? Où ? Qui ? Combien

30. Une épidémie L1p82

A. C'est une maladie qui sévit de manière permanente, continue et constante dans la population et qui est circonscrite à une zone donnée. Elle est illimitée dans le temps mais limitée dans l'espace

B. C'est une apparition soudaine, inattendue d'une maladie dans une population donnée, pendant un temps donné. Elle est limitée dans le temps et dans l'espace.

C. C'est une maladie qui touche la population d'un ou de plusieurs continents à la fois, voire la planète. Elle est illimitée dans l'espace mais limitée dans le temps

31. Une endémie L1p82

A. C'est une maladie qui sévit de manière permanente, continue et constante dans la population et qui est circonscrite à une zone donnée. Elle est illimitée dans le temps mais limitée dans l'espace

B. C'est une apparition soudaine, inattendue d'une maladie dans une population donnée, pendant un temps donné. Elle est limitée dans le temps et dans l'espace.

C. C'est une maladie qui sévit de manière permanente, continue et constante dans la population et qui est circonscrite à une zone donnée. Elle est illimitée dans le temps mais limitée dans l'espace.

D. C'est une apparition soudaine, inattendue d'une maladie dans une population donnée. Elle est illimitée dans le temps et dans l'espace.

31. **Action de santé** publique est un ensemble d'orientations, de choix stratégiques et de décisions prises par les pouvoirs d'un pays pour maintenir et/ou améliorer l'état de santé d'une population. **B L1p7 (Politique de santé publique)**

32. Programme de santé est un ensemble coordonné d'actions ou stratégies misent en œuvre pour atteindre un objectif. **A L1p7**

33. Promotion de la santé est le processus qui consiste à permettre aux individus de mieux maîtriser les déterminants de la santé et d'améliorer ainsi leur santé. **A L1p7**

34. La participation de la population n'est pas essentielle dans toute action de promotion de la santé. **B**

35. Il existe trois types de prévention. **B (4 types préventions)**

Primaire : Vaccination Secondaire : Dépistage précoce Tertiaire : Prévenir les complications Quaternaire : soins palliatifs
--

36. La prévention primaire consiste à lutter contre les risques avant l'apparition de tout problème de santé. **A**

37. Le dépistage du VIH/sida est une prévention primaire. **B**

38. Une pandémie L1p82

A. C'est une maladie qui sévit de manière permanente, continue et constante dans la population et qui est circonscrite à une zone donnée. Elle est illimitée dans le temps mais limitée dans l'espace

B. C'est une apparition soudaine, inattendue d'une maladie dans une population donnée, pendant un temps donné. Elle est limitée dans le temps et dans l'espace.

C. C'est une maladie qui touche la population d'un ou de plusieurs continents à la fois, voire la planète. Elle est illimitée dans l'espace mais limitée dans le temps.

39. Choisir parmi les réponses suivantes celles qui correspondent aux étapes de la démarche en Santé Publique. L1p11

A. Les volontés programmatiques des Etats ;

B. Formulation des objectifs

C. L'absence de mécanisme de sécurité sociale dans la plupart des PVD

D. La dépendance des systèmes de soins aux disponibilités budgétaires

E. Choix des stratégies (activités)

40. Choisir parmi les réponses suivantes celle qui correspond à un facteur pouvant influencer la mise en œuvre d'une politique de santé publique L1p13

A. Analyse de la situation et identification du ou des problèmes de santé ;

B. Définition des priorités (problème prioritaire) ;

C. La dépendance des systèmes de soins aux disponibilités budgétaires ;

D. Formulation du problème et détermination de la population cible ;

41. Axe descriptif étudie la fréquence de la répartition de la maladie ou de la santé dans le temps, dans l'espace et en fonction des caractéristiques de la population. **A** L1p81

42. Axe évaluatif ou d'intervention évalue le bien-fondé ou non des mesures prises pour améliorer l'état de santé de la population. **A** L1p81

43. Axe analytique recherche les causes d'apparition de la maladie, du phénomène de santé ou les lie à des facteurs de risque. **A** L1p81

44. **Axe descriptif** recherche les causes d'apparition de la maladie, du phénomène de santé ou les lie à des facteurs de risque. **B** L1p81 (Axe analytique)

45. La santé est un « état de complet bien-être physique, mental et social et (qui) ne consiste pas seulement en **une présence** de maladie ou d'infirmité ». [OMS, 1946] **B** L1p5 (une absence)

46. Communauté est un groupe d'individus qui vivent ensemble dans des conditions spécifiques d'organisation et de cohésion sociales. **A** L1p6

47. **La politique de santé publique** est une opération collective en vue de l'amélioration de la santé d'une population. **B** L1p5 (Action de santé publique)

ABIDJAN

EPREUVE DE SOINS INFIRMIERS EN CHIRURGIE DE L'INSTITUT NATIONALE
DE
FORMATION DES AGENTS DE SANTÉ (INFAS)

CIBLE : Licence 3 / GROUPE 1

Durée : 1H30 Minutes

VERSION

I. QUESTIONS A CHOIX DOUBLE (QCD) (1 à 24)

Réponse exacte= + 1 Réponse fausse= -1 Pas de réponse = 0
Enoncé vrai = A Enoncé faux = B

1. L'anthrax est l'infection bénigne siégeant toujours sur les fesses. **B**
2. L'abcès chaud a pour étiologie le Bacille de KOCH d'origine tuberculeuse. **B**
3. Pour l'infirmier(ère), la réfection de lit occupé et les soins de siège font partie des exigences pour un patient en immobilisation prolongée. **A**
4. La période post-opératoire dure depuis la pose du dernier fil sur la paroi opérée jusqu'au départ du malade (3^{ème} au 10^{ème} jour). **A**
5. La confrontation et la compréhension empathique font partie des attitudes primordiales en relation d'aide. **A**
6. La déviation rachidienne antalgique est constatée dans les signes fonctionnels des sciatalgies. **A**
7. L'ostéosynthèse de l'os fracturé constitue le début du traitement commun à toutes les fractures. **B**
8. L'os cède en un point faible selon un trait volontiers au cours du choc direct. **B**
9. Seule la radiographie permet de confirmer le diagnostic et de préciser le type de fracture. **B**
10. Le déplacement transversal est encore appelé déplacement en baïonnette. **A**
11. L'état de dépendance du patient fait partie du rôle de l'infirmier en préopératoire dans les traumatismes des ménisques. **A**
12. Le polytraumatisé est tout malade ayant au moins deux traumatismes. **A**
1. La plaie est une solution de continuité du tissu osseux. **B**
2. Le pronostic vital du patient est en danger, en cas de brûlures limitées ou peu étendues. **B**
3. Découvrir la plaie est le premier geste à faire dans la chronologie de soins devant toute plaie. **A**
4. Dans l'éjaculation, il y a 30% de sécrétion prostatique. **A**
5. Les niveaux d'intervention du soignant regroupent respectivement les soins infirmiers et la relation d'aide. **A**
6. Dans le traumatisme crânien avec perte de connaissance ou amnésie, le score de GLASGOW est de 13 à 15. **B**
7. L'éjaculation rétrograde est la conséquence de la prostatectomie après la guérison du malade. **A**
8. Le rétrécissement urétral est la réduction de la lumière de l'uretère. **B**
9. La déformation est un signe physique de la fracture. **A**

10. Lorsque la peau est lésée par un fragment osseux il s'agit d'une fracture ouverte véritable. **B**
11. La réduction est un signe physique de la fracture. **B**
12. L'impotence fonctionnelle relative ou absolue est un signe fonctionnel du traumatisme du bassin. **A**

II. QUESTIONS À CHOIX MULTIPLE (QCM)

Réponse exacte = +2 (Tous les items exacts). Réponse fausse ou Pas de réponse = 0 Pas de pénalité

CAS CLINIQUE N°1

IDE, dans un centre hospitalier de la place, vous recevez Mlle EIFI 29 ans pour douleur à la fesse gauche suite à une injection intramusculaire, une semaine révolue. L'examen clinique révèle: T°= 40° c, TA = 10/6 Pds = 40 Kg, conjonctives peu colorées, une tuméfaction luisante et fluctuante de la fesse. La ponction ramène du pus épais, presque membraneux, légèrement verdâtre. Informé, le chirurgien de garde décide une mise à plat du néoplasme.

13. Quel est votre diagnostic parmi ces propositions ci-dessous indiquées :

- A. Une lymphangite
- B. Un abcès froid
- C. Un abcès chaud**
- D. Un phlegmon

14. Quel est le germe en cause parmi ces propositions.

- A. Staphylocoque
- B. Streptocoque
- C. Pneumocoque**
- D. Bacille de Koch

15. Vous descendez de garde le lendemain, indiquez la consigne en rapport avec le pansement que vous deviez prescrire à votre relai.

- A. Pansement chaque 2 jours avec méchage à la Bétadine jaune
- B. Pansement chaque 2 jours avec méchage à l'alcool
- C. Pansement quotidien avec méchage au Dakin**
- D. Pansement quotidien avec méchage à l'hexomédine

16. Le chirurgien prescrit du SGI 5% 750 ml à perfuser à un débit de 30 gouttes/min. Exprimez en min puis en heure le temps de passage de la perfusion. Identifier votre réponse parmi ces propositions.

- A. 187 min soit 3h 07 min
- B. 250 min soit 4h 10 min
- C. 120 min soit 2h 00 min
- D. 500 min soit 8h 30 min**

$$D = \frac{Q \times 20}{T} \Rightarrow T = \frac{Q \times 20}{D}$$

$$T = \frac{750 \times 20}{30} = 500 \text{ min}$$

17. La NFS révèle une anémie sévère, il prescrit alors une poche de concentré érythrocytaire à transfusé en 2 heures à un débit de 60 gouttes/min. calculez le volume de sang transfusé. Quel est le résultat parmi les propositions indiquées ci-dessous :

- A. 520 ml
- B. 480 ml**
- C. 720 ml
- D. 620 ml

$$D = \frac{Q \times 15}{T \times 60} \Rightarrow Q = \frac{D \times T \times 60}{15}$$

$$Q = \frac{60 \times 2 \times 60}{15}$$

18. Quelle est parmi ces propositions l'indication d'un ionogramme sanguin :

- A. Perturbation métabolique aiguë**
- B. Affection hépatique
- C. Syndrome anémique
- D. Affection néphrétique

19. Quel est le besoin prioritaire chez un patient présentant une occlusion du côlon :
cocher la bonne réponse

- A. Besoin d'éliminer**
- B. Besoin de manger et boire
- C. Besoin d'être propre, soigné et protéger ses téguments.
- D. Besoin de dormir et se reposer

20. Quelle est le besoin prioritaire chez un patient présentant une occlusion du grêle :
cocher la réponse juste

- A. Besoin de respirer
- B. Besoin d'éliminer
- C. Besoin de dormir et se reposer
- D. Besoin de manger et boire**

21. Indiquer dans les suites opératoires deux avantages du lever précoce parmi ces propositions

- A. Accélère la reprise du transit**
- B. Préviend les hémorragies
- C. Préviend les chocs hémodynamiques
- D. Préviend la stase et l'obstruction bronchique**
- E. Favorise la cicatrisation
- F. Lutte contre l'infection

L3p72 (Doc MT SI SPECIALISES)

22. Parmi ces gestes deux sont accomplis dans un établissement de premier contact par l'infirmier. Indiquer les :

- A. Préparation du champ opératoire
- B. Pose d'une voie veineuse**
- C. Effectuer la prémédication
- D. Pose d'une sonde nasogastrique
- E. Établir une feuille ou fiche d'évacuation**

23. On distingue l'occlusion haute et l'occlusion basse. Relier chaque type d'occlusion à sa clinique et à son siège.

Types d'occlusion	Clinique et siège
Occlusion haute 1.	A. Début insidieux B. Vomissement précoce C. Niveaux hydroaériques hauts que larges D. Niveaux hydroaériques larges que hauts E. Altération de l'état général précoce F. Intestin grêle
Occlusion basse 2.	G. Colon H. Ballonnement abdominal en cadre I. Pose de sonde nasogastrique

A. (1, DCEF) / (2, AIGH)

B. (1, BDEF) / (2, ACGH)

C. (1, BCIF) / (2, AEGH)

D. (1, ADGH) / (2, BCEF)

24. Les complications secondaires des traumatismes du bassin sont : cochez les deux (02) bonnes réponses.

A. Lésions du rectum

B. Thromboembolie

C. Lésions de l'urètre

L2p68 (Doc chirurgie)

D. Infection

E. Ouverture cutanée

25. Les examens complémentaires ci-dessous énumérés sont effectués en cas de septicémie. Sauf deux (02) ; lesquels ?

A. Numération Formule Sanguine (NFS)

B. Hématocrite

L1p23 (Doc Sémio chirurgicale)

C. Ionogramme sanguin

D. Hémoculture

26. Les complications générales des furoncles sont : (choisir deux bonnes réponses)

A. L'abcès chaud circonscrit

B. La lymphangite

L1p41 (Doc Sémio chirurgicale)

C. La septicémie aiguë

D. La bactériémie passagère

E. L'adénite aiguë ou adéno-phlegmon

27. Les germes souvent mis en cause dans l'abcès chaud sont : (choisir deux bonnes réponses)

A. Colibacille

B. Gonocoque

C. Pneumocoque

L1p32 (Doc Sémio chirurgicale)

D. Staphylocoque blanc ou doré

E. Streptocoque

28. Le rôle de l'infirmier sur les lieux de l'accident en cas de suspicion de fracture consiste à : (choisir une seule réponse)

A. Préparer le champ opératoire

B. Faire une immobilisation provisoire

C. Faire un pansement aseptique

29. Trois activités entrent dans la prise en charge infirmière du panaris, parmi celles citées ci-dessous, lesquelles ?

A. Pansement avec bain quotidien

B. Préparation psychologique du patient

L1p27 (Doc Sémio chirurgicale)

C. Rééducation après cicatrisation

D. Information éducation-communication

E. Prélèvements biologiques en vue d'antibiogramme

30. Les symptômes cités ci-dessous évoquent le syndrome de wolkman, exceptés deux (02) ; lesquels ?

A. Œdème

B. Hématome

L2p32 (Doc chirurgie)

C. Douleur + ou - vive de l'avant-bras ou la main.

D. Hémarthrose

E. Impotence fonctionnelle

31. Faire le nursing du malade consiste à : (choisir une seule réponse)

A. Faire la préparation physique pour une éventuelle opération

B. Faire la toilette et la prévention des escarres

C. Faire le prélèvement pour le bilan préopératoire

32. Ces différents types de choc font suite aux traumatismes violents, sauf un (01) ; lequel ?

A. Choc hypovolémique

L2p70 (Doc chirurgie)

B. Choc opératoire

C. Choc traumatique

33. Le premier symptôme de l'adénome de la prostate parmi ceux cités ci-dessous est :

A. La dysurie

B. La pollakiurie nocturne et ou diurne

L2p154 (Doc chirurgie)

C. L'incontinence urinaire

D. La miction retardée.

34. Toute hernie de la paroi abdomen est constituée par un élément anatomique par lequel le viscère hernié s'engage. (Choisir la bonne réponse)

A. Le contenu

B. Les enveloppes.

L2p101 (Doc chirurgie)

C. L'orifice herniaire

35. Le malade étant couché, des caractères essentiels permettent d'affirmer qu'il s'agit d'une hernie non compliquée ; Lesquels ? (Choisir les 02 bonnes réponses)

A. Irréductibilité

B. Non impulsive à la toux

L2p101 (Doc chirurgie)

C. Réductibilité

D. Impulsion à la toux

E. Pas de tympanisme (intestin).

36. La principale complication de la hernie est : (Choisir la bonne réponse)

A. Le plastron appendiculaire

B. L'hydrocèle

L2p101 (Doc chirurgie)

C. La hernie inguino-scrotale.

D. L'étranglement herniaire

37. L'un des buts du traitement de la hernie est de :

L2p102 (Doc chirurgie)

A. Traiter le contenu du sac herniaire.

B. Éviter les récidives.

C. Faire une réfection pariétale par raphie.

CAS CLINIQUE 2

Agé de 40 ans, pour 1m80 et pesant 85 Kg, M.SALL est évacué aux urgences chirurgicales du CHU de COCODY pour des douleurs abdominales et des vomissements. L'interrogatoire et l'examen clinique du patient faits par le chirurgien de permanence relèvent un arrêt des matières et des gaz et un météorisme abdominal. La radiographie de l'abdomen sans préparation (ASP) effectuée par la suite, évoque une occlusion intestinale aiguë.

Vu les signes de déshydratation que présente M.SALL, et au regard des résultats de l'ionogramme sanguin, il est préconisé le traitement ci-après :

- Sérum salé isotonique : 1000 cc
- Potassium (K) : 5 cc
- Calcium (Ca) : 10 cc
- Magnésium (Mg) : 10 cc
- Sodium à 10% (Na) : 10 cc
- Héptaminol : 5 cc

38. Laquelle des trois (03) propositions suivantes justifie ce besoin fondamental prioritaire à satisfaire par M. SALL ?

- A. SALL présente des douleurs abdominales et des vomissements et un arrêt des matières et des gaz suite à l'occlusion intestinale aiguë. Ceci représente une agression interne contre laquelle il doit se protéger pour maintenir sa santé.
- B. SALL hospitalisé est devenu dépendant et ne peut plus vaquer à ses occupations. Il sollicite l'aide de quelqu'un pour éviter le pire.
- C. SALL ne peut pas se déplacer du fait de la maladie qui l'empêche de se recréer, s'épanouir, assurer ses activités quotidiennes ; ce qui le contraint à des difficultés de tous genres.

39. Les signes biologiques en cas d'occlusion intestinale aiguë sont en faveur : (cochez les 4 bonnes réponses) L2p118(Doc Chirurgie)

- A. D'une hyperprotidémie
- B. D'une acidose
- C. D'une hypocalcémie
- D. D'une hypokaliémie
- E. D'une hémodilution
- F. D'une hémococoncentration

40. Indiquez le débit de cette perfusion qui doit être administrée en 4 h à M. SALL.

- A. 86,25 gttes/mn
- B. 87 gttes/mn
- C. 86,66 gttes/mn
- D. 83,33 gttes/mn

$$D = \frac{Q \times 20}{T \times 60} = \frac{(1000 + 5 + 10 + 10 + 10 + 5) \times 20}{4 \times 60}$$

41. Trois (03) gestes d'urgence peuvent être réalisés en dehors des radiographies d'usage chez M. SALL dès son admission dans votre service. L2p120(Doc Chirurgie)

- A. Faire la préparation psychologique du patient
- B. Faire la prévention des escarres après avoir procédé à la réfection de lit du patient admis dans votre service

- C. Mettre en place une sonde gastroduodénale en aspiration continue pour décompresser le tube digestif
- D. Mettre en place une perfusion de sérum auquel sont ajoutés les électrolytes (K, Na, Mg, Ca) selon l'ionogramme
- E. Prélever du sang pour le bilan électrolytique complet et groupage, numération globulaire avec hématoците

F. Faire la toilette générale du patient

42. Quels sont les trois (03) diagnostics infirmiers en rapport avec la maladie de M. SALL parmi ceux proposés ci-dessous :

- A. Douleur reliée à l'occlusion intestinale aiguë
- B. Risque de déshydratation relié à l'occlusion intestinale aiguë
- C. Difficulté d'éliminer les déchets biologiques
- D. Perturbation dans l'exercice du rôle social reliée à l'hospitalisation
- E. Difficulté à assurer ses rôles sociaux reliée à l'hospitalisation
- F. Risque de déficit du volume liquidien relié aux vomissements

43. Les causes ci-dessous citées aboutissent à une occlusion mécanique sauf une ; laquelle ?

- A. Invagination intestinale
- B. Torsion d'une anse intestinale sur elle-même
- C. Corps étrangers
- D. Dérèglement du système nerveux intestinal

L2p115 (Doc neurochirurgie)

44. Un seul signe physique caractérise l'occlusion parmi les quatre (04) symptômes essentiels du syndrome occlusif, lequel ?

- A. Vomissements
- B. Arrêt des matières et des gaz
- C. Météorisme abdominal
- D. Douleurs abdominales

L2p117 (Doc neurochirurgie)

45. Dans la prise en charge infirmière de ce patient, selon le modèle conceptuel de VIRGINIA HENDERSON, 01 besoin fondamental en rapport avec l'affection est prioritaire parmi ceux identifiés ci-dessous ; lequel ?

- A. Se mouvoir et se maintenir en position convenable
- B. Éviter les dangers
- C. S'occuper en vue de se réaliser
- D. Se recréer

46. A propos de l'occlusion, cochez les deux affirmations inexactes

- A. Les occlusions inflammatoires ou mixtes peuvent se rencontrer au cours des péritonites aiguës ou chroniques.
- B. Dans les occlusions fonctionnelles, l'obstacle est organique, anatomique, relevant de deux (02) mécanismes.
- C. L'occlusion intestinale aiguë est l'arrêt complet et persistant du transit des matières et des gaz dans un segment intestinal donné.
- D. Le météorisme abdominal est le signe physique caractéristique de l'occlusion intestinale aiguë.
- E. Aucune réponse

47. Parmi les complications suivantes, une seule fait partie des complications immédiates des fractures, laquelle ?

- A. Pseudarthrose
 - B. Retard de consolidation
 - C. État de choc traumatique
- L1p65 (Doc Sémio chirurgicale)**

48. La contusion des parties molles peut réaliser. (Choisir une seule réponse)

- A. Une lésion du tissu de revêtement
 - B. Un durcissement de la peau
 - C. Un accident thrombo-embolique
 - D. Un hématome ou épanchement sanguin
- L1p58 (Doc Sémio chirurgicale)**

49. Le score de GLASGOW dans le traumatisme crânien modéré est de : L3p5(Doc neurochirurgie)

- A. 13 à 15
- B. 9 à 12
- C. 3 à 8

50. L'examen sensitif du fracturé du rachis permet de préciser si le patient a (cocher une seule réponse) :

- A. Une hypoesthésie
 - B. Une anesthésie
 - C. Toutes les deux (02) propositions ci-dessus indiquées
- L3p16 (Doc neurochirurgie)**

51. Parmi les signes ci-dessous cités du score de GLASGOW, deux (02) appartiennent à l'ouverture des yeux, lesquels ?

- A. Spontanée 4
 - B. Adaptée, orientée à la douleur 5
 - C. Volontaire sur commande 6
 - D. Mouvement de retrait 4
 - E. A la douleur 2
- L3p3 (Doc neurochirurgie)**

52. Ces signes sont ceux de la meilleure réponse verbale du score de GLASGOW, exceptés deux :

- A. Confuse 4
 - B. Incohérente 3
 - C. En flexion anormale 3
 - D. Spontanée 4
 - E. Incompréhensible 2
- L3p4 (Doc neurochirurgie)**

53. Deux (02) parmi les éléments du principe des quatre (04) tuyaux, sont des moyens de prévention du syndrome de MENDELSON et l'œdème cérébral : Lesquels ?

- A. Sonde urinaire
- B. Tubulure d'oxygénation
- C. Sonde nasogastrique
- D. Perfusion par voie veineuse

54. Le score de GLASGOW permet d'évaluer l'état de conscience et de suivre son évolution à partir des trois (03) éléments énumérés ci-dessous, sauf un, lequel ? L3p3-4(Doc neurochirurgie)

- A. L'ouverture des yeux aux stimulations verbales
- B. Le signe de BABINSKI**
- C. L'appréciation de la réponse motrice à la parole et/ou à la douleur

INFAS ABIDJAN

Année académique :2024-2025

**EXAMEN BLANC DU DIPLOME D'ETAT 2025- IDE/GROUPE 2
SI EN CHIRURGIE VERSION C**

I. QCD : Répondre par A=Vrai et B=Faux ; bonne réponse=1 point, fausse réponse= -1 et aucune réponse=0

Q1- La clinique du cancer du rein est caractérisée par la triade douleur, syndrome tumoral, hématurie **A**

Q2- Le pancréas a une fonction endocrine et une fonction exocrine. **A**

Q3- Les glandes endocrines sont parcourues par des vaisseaux sanguins. **A**

Q4- En général localisée dans l'épiphyse, l'ostéomyélite aiguë est due à une invasion de l'organisme par le staphylocoque doré. **B**

Q5- Les glandes mixtes ont un parenchyme entièrement endocrine. **B**

Q6- La cryptorchidie est une anomalie de descente des testicules dans la bourse. **A**

Q7- Les glandes sudoripares déversent leur sécrétion dans le sang. **B**

Q8- La réduction de la hernie étranglée est un geste à proscrire chez le patient vu tardivement. **A**

Q9- Le frottement chimique de la peau est un facteur local de survenue de furoncle. **A**

Q10- L'appréciation de la gravité d'une brûlure se fait uniquement en fonction de l'étendue de la surface corporelle brûlée. **B**

Q11- La malformation congénitale de membre est liée à des aplasies ou atrophies des divers éléments du membre. **A**

Q12- Une étudiante infirmière affirme : « Le genu valgum » est la déviation des cuisses en abduction formant les jambes en parenthèse. **B**

Q13- La polydactylie est l'union de deux ou plusieurs doigts sur tout ou une partie de leur longueur. **B**

Q14- La désinfection avec un antiseptique est le premier geste dans la chronologie de soins d'une plaie. **B**

Q15- La crépitation neigeuse est un signe physique de la gangrène gazeuse. **A**

Q16- Les malformations congénitales sont des anomalies de développement par défaut, par excès ou par disposition. **A**

II. QCM : Choisissez-la ou les bonne(s) réponse(s)

Q17-Monsieur YOUAN doit être transfusé avec du sang total iso groupe iso rhésus pour relever son taux d'hémoglobine à 11,5 g /dl, choisir la quantité de sang correspondante, sachant que son poids est de 60 kg et son taux d'hémoglobine est de 6,5 g /dl

A- 900 ml

B- 450 ml

C -863 ml

$$\text{Qte sang} = (\text{HB souhaiter} - \text{HB actuel}) \times \text{pds} \times 3$$

$$\text{Qte sang} = (11,5 - 6,5) \times 60 \times 3$$

Q18-Choisir le débit de cette transfusion que vous devez faire passer en 4 heures, sachant que nous avons des poches de 450 ml

A-57 gttes /mn

B-29 gttes /mn

C-28 gttes/mn

$$D = \frac{Q \times 15}{T \times 60} = \frac{450 \times 15}{4 \times 60} = 28,12$$

Q19-Parmi les organes suivants, relever les deux organes qui constituent les organes de l'appareil urinaire haut.

A- Les reins

B-La vessie

C-L'urètre

D-Les uretères

E-La prostate

Q20-Relever les deux organes de l'appareil digestif haut parmi les organes suivants :

A-L'Estomac

B-La cavité buccale

C-L'œsophage

D-Le colon

E-L'intestin grêle

Q21-L'urine est :

A-un liquide jaune, clair, limpide

B-un liquide jaune pâle, clair, trouble

C-un liquide jaune pâle, clair, limpide

Q22- Chez l'homme, l'urètre mesure environ :

A-24cm

B-14cm

C-04cm

Q23- L'anurie se caractérise par :

A-Une grande quantité d'urine

B-Une petite quantité d'urine

C-Une absence d'urine

Q24- La diurèse normale de 24heures est de :

A-1500ml

B- 1000ml

C-800ml

Q25-La rétention urinaire chronique est dite rétention avec distension lorsque le volume du résidu post-mictionnel est :

A-supérieur à 300 ml

B-inférieur à 300 ml

C-égale à 300 ml

Q26- Parmi les signes suivants, relever le signe fonctionnel de la rétention chronique d'urine

A-Impossibilité d'uriner

B-besoin impérieux d'uriner permanent devenant douloureux et n'aboutissant au mieux qu'à l'émission de quelques gouttes d'urines

C-Impossibilité de vider totalement la vessie

Q27-Relever parmi les examens biologiques suivants ceux qui peuvent être demandés à un patient de l'adénome de la prostate. (choisir les trois bonnes réponses)

A-NFS

B-UREE

C-GE

D-PSA

E-ECBU

Q28-Parmi les signes suivants, relever les deux signes physiques de la rétention aigue d'urine

A-Douleur sus-pubienne de plus en plus intense

B-Douleur à la palpation augmentant le besoin d'uriner

C-Impossibilité d'uriner

D-Masse hypogastrique pouvant remonter jusqu'à l'ombilic

E-Globe vésical flaccide parfois énorme de 2 à 3 litres et indolore

Q29-En cas de rétention urinaire, relever parmi les propositions suivantes l'objectif visé dans la démarche de soins infirmiers :

A-la pose de la sonde urinaire

B-Le retour du mode d'élimination normal des urines

C-La ponction sus-pubienne

Q30-Parmi les examens radiographiques suivants, identifier les deux qui peuvent être prescrits dans le cas d'une rétention d'urine :

A- L'échographie abdominale

B-L'échographie rein, vessie, prostate

C-L'urographie intraveineuse

D-L'abdomen sans préparation

Q31- Quel oligoélément est essentiel à l'hémoglobine ?

A. Fer

B. Iode

C. Sodium

D. Potassium

Q32- Quel élément est nécessaire à la synthèse de l'hormone thyroïdienne ?

A. Fer

B. Calcium

C. Iode

D. Potassium

Q33- Quelle association d'ions sont essentiels à la contraction musculaire ?

A. Sodium et Potassium

B. Fer et Calcium

C. Iode et Chlore

D. Azote et Hydrogène

Q34- Quelle proportion d'eau compose les cellules vivantes ?

A. 80%

B. 60%

C. 40%

D. 90%

CAS CLINIQUE N°1 :

Vous recevez au cours de votre permanence dans le service de chirurgie, monsieur **Koné Yaya**, victime d'un accident de moto sur une voie publique. Il souffre atrocement au niveau de l'abdomen. Après un examen clinique effectué par le chirurgien de service et une ponction abdominale, il confirme une hémorragie intrapéritonéale.

Q35- Quel tableau d'urgence abdominal présente Monsieur Koné ?

- A. Tableau hémorragique de l'abdomen
- B. Tableau d'hémato-péritonite
- C. Tableau d'hémopéritoine**
- D. Tableau de péritonite

Q36- Enumérez trois symptômes qui vous orientent sur ce tableau d'urgence abdominal ?

- A. Un silence abdominal
- B. Pâleur extrême des téguments et des extrémités**
- C. Un arrêt réflexe du transit
- D. Douleur abdominale provoquée avec défense généralisée**
- E. Une matité déclive des flancs**

Q37- Un examen d'imagerie de première intention est réalisé pour visualiser et quantifier l'hémorragie. De quel examen s'agit-il ?

- A. ASP (Radiographie de l'abdomen sans préparation)
- B. Radiographie abdominale
- C. Echographie abdominale**
- D. UIV (Urographie Intraveineuse)

Q38- Enumérez deux moyens médicaux de réanimations pour M. Koné.

- A. Prendre une voie veineuse sûre au cathéter**
- B. Faire la détersion de l'abdomen
- C. Injecter des produits médicamenteux pour calmer les douleurs
- D. Grouper rapidement le patient**

Q39- Dans les contusions abdominales deux mécanismes isolés ou associés rendent compte des lésions. Lesquels ?

- A. Choc direct sur l'abdomen**
- B. Choc à distance de l'abdomen
- C. Choc indirect dû à la décélération**
- D. Choc indirect dû à la dilacération
- E. Choc direct avec écrasement

Q40- Dans les contusions abdominales, les lésions viscérales peuvent concerner plusieurs organes. (Choisir trois d'entre)

- A. Le foie**
- B. Le flanc gauche
- C. Le rein**
- D. Le cœur
- E. La rate**

Q41-Trois tableaux symptomatologiques sont observés dans les contusions abdominales. Lesquels ? (Choisir les trois bonnes réponses).

- A. Tableau de hémato-péritonite
- B. Tableau d'hémorragie abdominale
- C. Tableau d'abdomen contus**

- D. Tableau d'abdomen simple
- E. Tableau de péritonite
- F. Tableau d'hémopéritoine

Q42- Dans quelle région abdominale trouve-t-on la bile ?

- A. La fosse iliaque gauche
- B. L'hypochondre droit
- C. Le flanc gauche

ETUDE DE CAS N°2 : (Voir support en annexe)

Vous êtes infirmier aux urgences de l'EPHD de Transua. Au cours de votre permanence vous recevez Monsieur Kouman, Planteur âgé de 34 ans victime d'une brûlure du tronc et de la cuisse gauche. La mesure des constantes hémodynamiques nous donne : poids=43Kg, TA= 9/6, Taille=1,55m. A l'interrogatoire il ressort que monsieur Kouman, st connu diabétique.

Q43- Relever parmi les paramètres suivants les deux permettant de déterminer l'Indice de BAUX (IB) chez un brûlé :(Choisir les deux bonnes réponses)

- A. Taille
- B. Age
- C. Poids
- D. Insuffisance cardiaque
- E. Sexe
- F. Tension Artérielle
- G. Surface corporelle Brûlée

Q44- La surface corporelle brûlée selon la table de LUND et BROWDER de monsieur Kouman, est :(Choisir la bonne réponse)

- A. 35,5%
- B. 22,5%
- C. 30,5%

SCB = Tronc + Cuisse gauche
 avec Tronc = Tronc postérieur + Tronc antérieur
 $SCB = 13\% + 13\% + 9,5\% = 35,5\%$

Q45- Quel est selon vous l'évaluation du pronostic vital de Monsieur Kouman ?

- A. Monsieur Kouman, a une chance sur deux de guérison
- B. La guérison de Monsieur Kouman, est infiniment probable
- C. La mort de Monsieur Kouman, est quasi certaine

Q46- Parmi les propositions suivantes, relever le critère de gravité de la brûlure correspondant aux circonstances de survenue de la brûlure :(Choisir la bonne réponse)

- A. Temps d'exposition
- B. Destruction complète de la membrane basale
- C. Brûlure des orifices naturels

Q47- Dans la prise en charge d'un brûlé, les premiers secours consistent à : (Choisir les deux bonnes réponses).

- A. Corriger les détresses vitales
- B. Evaluer la surface corporelle brûlée
- C. Couvrir la victime avec les draps propres ou stériles
- D. Refroidir la victime avec de l'eau à 15°C pendant 15 minutes environ
- E. Administrer une ampoule de ACUPAN en IV

Q48- En cas de réanimation hydroélectrolytique d'un brûlé, la formule de remplissage vasculaire le premier jour selon BAXTER est : (Choisir la bonne réponse)

- A. Qté=AGE +15 X SCB
- B. Qté=AGE X 4X SCB
- C. Qté=POIDS (kg) x 4 x SCB**

Q49- Déterminer la quantité de soluté à faire passer en perfusion le premier jour à Monsieur Kouman.,(Choisir la bonne réponse)

- A. 3870 ml
- B. 6106 ml**
- C. 5246 ml
- D. 4828 ml

$$QJ1 = 4 \times Pds \times SCB$$

$$QJ1 = 4 \times 43 \times 35,5$$

Q50- Déterminer le nombre de flacons de solutés de remplissage de 500ml à utiliser pour le traitement de M. Kouman., (Choisir la bonne réponse)

- A. 13,473
- B. 12,687
- C. 12,212**
- D. 13,744
- E. 10

$$\text{Nbre de flacons} = \frac{6106}{500} = 12,212$$

Q51- La valeur de l'Indice de Baux est:(Choisir la bonne réponse)

- A. 88,5
- B. 93,5
- C. 78,5
- D. 84,5**

$$IB = SCB + Age + 15$$

$$IB = 35,5 + 34 + 15$$

$$IB = 84,5$$

Q52- Chaque soluté pour la perfusion de Monsieur Kouman, doit passer en 2h15min. Déterminer le débit de cette perfusion:(Choisir la bonne réponse)

- A. 74,07 gouttes/min**
- B. 73,46 gouttes/min
- C. 75 gouttes/min

$$D = \frac{Q \times 20}{T} \text{ avec } T = (2 \times 60) + 15 = 135 \text{ min}$$

$$D = \frac{500 \times 20}{135}$$

Support annexe : Tableau de LUND et BROWDER

localisation	0-1 an	1-4 ans	5-9 ans	10-15 ans	Adulte
Cou	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
Tronc antérieur	13 %	13 %	13 %	13 %	13 %
Tronc postérieur	13 %	13 %	13 %	13 %	13 %
Une fesse	2.50 %	2.50 %	2.50 %	2.50 %	2.50 %
Une cuisse	5.50 %	6.50 %	8.50 %	8.50 %	9.50 %
Une jambe	5 %	5 %	5.50 %	6 %	7 %

**DIPLOME D'ETAT BLANC DE SOINS INFIRMIERS EN MEDECINE - Licence 3-
IDE 2025**

COMPOSITION Sujet Version A Groupe 1 Durée : 1h 30

I-QCD

Répondre par A pour la proposition juste et B pour la proposition fausse
(une réponse juste= 1point – une réponse fausse = - 1 point – une question sans réponse = 0)

Q1. Les soins du mal perforant plantaire consiste en un lavage chirurgical jusqu'à l'os et à l'articulation. **A** **L3p79(Doc de MT SI Spécialisés)**

Q2. La dyspnée laryngée est une difficulté respiratoire ou détresse respiratoire à type de tachypnée inspiratoire avec tirage sus sternal accompagnée de cornage et de trouble de la voix. **B**

L3p5(Doc de MT SI Spécialisés) « bradypnée »

Q3. Chez le malade comateux l'on observe une interruption de la vie de relation. **A**

L3p5(Doc de MT SI Spécialisés)

Q4. L'intubation est un soin réalisé exclusivement par le médecin anesthésiste réanimateur. **B**

L3p20(Doc de MT SI Spécialisés)

Q5. L'aspiration trachéale est l'acte de soins visant à éliminer les sécrétions des voies aériennes chez le patient intubé ou trachéotomisé afin d'en assurer la dépendance. B

L3p24(Doc de MT SI Spécialisés) « la liberté »

Q6. La décision de limitation ou d'arrêt de thérapeutique active ne constitue en rien une pratique d'euthanasie mais vise à restituer son caractère naturel à la mort. **A L3p5(Doc soins palliatifs)**

Q7. Les soins palliatifs sont des soins passifs dans une approche globale de la personne atteinte d'une maladie grave, évolutive ou primitive. **B**

L3p9(Doc soins palliatifs) « actifs ; terminale »

Q8. Dans le paludisme, à la phase sexuée, la réplication des mérozoïtes, des parasites sexués mâles et femelles (gamétocytes) sont formés à l'intérieur des globules rouges. **A**

L1p6(Doc de Maladie infectieuse)

Q9. Chez le sujet atteint de dengue fébrile on observe une thrombocytopénie et une leucopénie. **A** (Doc de COURS PDF de LA DENGUE)

Q10. En cas d'envenimation, l'injection du venin est immédiatement suivie de troubles cliniques. **A**

Q11. Chez le patient diabétique, la glycosurie ne reflète pas le taux de glycémie du moment et donne une information cumulative. **A**

Q12. Dans la méningite purulente, les signes physiques sont représentés par la raideur méningée et l'hyperesthésie cutanée. **A** **L1p100(Doc de Maladie infectieuse)**

Q13. Le troisième objectif des stratégies 95-95-95 de l'ONUSIDA vise le counseling de 95 PVVIH sur 100. **B**

Q14. Dans l'infection à VIH, l'approche de prise en charge qui implique un laboratoire est l'approche étiologique. **A**

Q15. La prévention secondaire des IST prévient la survenue des IST. **B L1p10(Doc de COURS DE VIH SIDA)**

II- QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES

Hachurez les alvéoles correspondant aux bonnes réponses sachant qu'une bonne réponse vaut 1 et une mauvaise réponse 0 point.

Choisir la lettre correspondant à la bonne réponse

Q16- Le premier septénaire de la fièvre typhoïde est caractérisé par deux des manifestations suivantes. Lesquelles ? L1p89(Doc de Maladie infectieuse)

A Épistaxis B Fièvre en plateau C Tiphos **D Fièvre à oscillations ascendantes**

Q17- La phase d'incubation de la Schistosomiase est marquée par un signe dominant : Cochez-le : L1p17(Doc de Maladie infectieuse)

A Une hématurie **B Une dermatite cercarienne** C Une fièvre (phase d'invasion)

Q18. A la phase d'état de la fièvre typhoïde les signes cutanés sont marqués par : Cocher les deux bonnes propositions L1p89(Doc de Maladie infectieuse)

A les tâches rosées lenticulaires,

B un érythème maculoprurigineux fugace

C l'angine de Duguet

D les lésions vésiculaires prurigineuses

E un dessèchement de la peau

Q19. Les pathologies en rhumatologie peuvent se signaler par un prodrome fait de signes généraux : Cochez la bonne proposition L1p42(Doc de Sémio Médicale)

A douleurs articulaires, tuméfaction, pâleur, rougeur, névralgie

B raideur, instabilité, boiterie, claudication

C fièvre, sueur, céphalée, asthénie, tachycardie, anémie

D Douleurs abdominales, vomissements et diarrhée intermittente

Q20. Devant une hémoptysie de faible ou moyenne abondance, les actions de l'IDE sont : Cocher les deux gestes incorrects : L1p13(Doc de Sémio Médicale)

A repos, position demi-assise

B servir des aliments chauds uniquement

C donner un récipient pour recueillir et quantifier les crachats

D surveillance des signes hémodynamiques

E Demander au malade de tousser la tête abaissée

F prévoir et effectuer les examens paracliniques

Q21. Le concept de La double protection implique (deux sont bonnes) L1p27-28(Doc de COURS DE VIH SIDA)

A L'utilisation de trois méthodes de protection

B L'utilisation de deux méthodes de protection

C L'utilisation d'une seule méthode de protection

D La prévention contre les IST et les grossesses non désirées

Q22. Les IST transmises qu'une femme enceinte peut transmettre à son enfant au cours de la grossesse sont (Trois sont bonnes) :

A Gonococcie B chlamydiae **C VIH/sida**

D Candidose **E Hépatite B** **F Syphilis**

Q23. Parmi les propositions suivantes trois correspondent à la prévention par voie sexuelle (trois sont bonnes) L2p40(Doc de COURS DE VIH SIDA)

A port de préservatifs B port de blouse et habit de protection **C PreP** (Prophylaxie pré exposition)

D TARV E prophylaxie ARV au nouveau-né F dépistage VIH+Syphilis+Hépatite B

Q24. Associez les pathologies (a, b,c,d) à leur agent vecteur (1,2, 3,4) puis cochez la bonne proposition de combinaison en A, B, C ou D

a) Fièvre jaune – b) Paludisme – c) Onchocercose –d) Trypanosomiase humaine africaine

1-Anophèle femelle 2- la simule 3-la glossine 4- Aedes aegypti

A : (a-4)_(b-1)_(c-2)_(d-3)

B : (a-3)_(b-4)_(c-1)_(d-2)

C : (a-2)_(b-3)_(c-4)_(d-1)

D : (a-1)_(b-2)_(c-3)_(d-4)

Q25. Dans l'angor on note : cocher la proposition juste

A une douleur constrictive à type d'étau de serrement, de broiement, de griffe, de douleur intense angoissante.

B une dyspnée à type de polypnée avec battement des ailes du nez et des sueurs abondantes.

Q26. Chez un sujet déclarant une morsure de serpent, les gestes de premiers secours consistent en : Cochez les deux gestes à ne pas faire L1p164(Doc de Maladie infectieuse)

A Rassurer le patient et son entourage,

B Mettre en place une pierre noire adhésive pour aspirer le venin dans les meilleurs délais

C Nettoyer la morsure et rechercher les traces de crochets puis

D Donner à boire de l'eau à la demande du patient

E Faire un examen général pour évaluer la gravité.

F Distinguer les signes de stress et les symptômes d'envenimation

Q27. Le cycle de vie de l'insecte hématophage qui transmet le virus de la dengue, comporte : Cocher la bonne proposition (Doc de COURS PDF de LA DENGUE)

A 2 phases (aquatique et aérien)

B 3 phases (terrestre, aquatique et aérien)

C 4 phases (méditerranéen, terrestre, aquatique et aérien)

Q28. Les signes cliniques de l'insuffisance cardiaque gauche associent : cocher les deux intrus L2p23(Doc de Médecine)

A une dyspnée d'effort, B une toux, **C des vomissements**

D des expectorations, E une cyanose **F une hémoptysie**

Q29. Dans la bilharziose urinaire la phase d'état est marquée par : Cochez la proposition juste L1p18(Doc de Maladie infectieuse)

A L'hématurie macroscopique qui est une hématurie initiale, capricieuse, douloureuse, intermittente, récidivante, pouvant évoluer pendant plusieurs mois.

B L'hématurie macroscopique qui est une hématurie totale, capricieuse, douloureuse, intermittente, récidivante, pouvant évoluer pendant plusieurs mois.

C L'hématurie macroscopique qui est une hématurie terminale, capricieuse, douloureuse, intermittente, récidivante, pouvant évoluer pendant plusieurs mois.

Q30. Lorsque la personne n'est pas en état d'exprimer sa volonté, une procédure collégiale doit être appliquée selon les modalités suivantes : Cocher les deux actions non appropriées (1 point) L3p5(Doc soins palliatifs)

- A chercher quelle était la volonté que le patient aurait antérieurement exprimée en consultant les directives anticipées lorsqu'elles existent ;
- B prendre en compte l'avis de la personne de confiance ou, à défaut, la famille ou les proches ;
- D prendre l'avis d'un autre médecin qui engage sa responsabilité;**
- E obtenir un consensus au sein de l'équipe médicale et paramédicale;
- F éviter de transcrire la procédure dans le dossier médical car l'acte n'engage que le patient.**

Q31. Le rôle de l'infirmière durant les dernières heures de vie de la personne malade est centré sur : Cocher l'activité non recommandée (1 point) L3p38(Doc soins palliatifs)

- A le soulagement des symptômes (douleurs, dyspnée, encombrement...) ; le dégagement des voies aériennes ;
- B l'humidification et les soins de la bouche ; le positionnement et le soin des escarres ;
- C les soins des yeux ; l'atténuation des odeurs ; l'accompagnement de la personne malade et de ses proches ;
- D la prise d'une voie veine de sûreté, l'administration des solutés appropriés, les gestes de réanimation infirmières**

Q32. Dans le rôle de l'infirmier auprès de la famille du patient, le but des interventions infirmières est d'aider les familles des patients en fin de vie, à : Cocher l'action inappropriée L3p56(Doc soins palliatifs)

- A gérer leurs sentiments,
- B prendre leurs propres décisions
- C informer sur le pronostic vital**
- D réajuster leurs attitudes.

Q33. Le coma est un état : Compléter la phrase par : cocher la bonne proposition L3p33(Doc de MT SI Spécialisés)

- A irréversible qu'elle que soit la stimulation.**
- B réversible qu'elle que soit la stimulation.
- C passer qu'elle que soit la stimulation.

Q34. Le bilan d'hémostase simplifiée du diabétique comprend l'évaluation de : Cocher l'intrus. L3p65-66(Doc de MT SI Spécialisés)

- A Taux de prothrombine (TP),
- B Temps de céphaline kaolin (TCK) ou Temps de céphaline avec activateur (TCA).
- C Taux d'urée et de glycémie**
- D Numération plaquettaire

Q35. On appelle pied diabétique...: Cocher la meilleure proposition L3p77(Doc de MT SI Spécialisés)

A toute Infection, ulcération ou destruction des tissus profonds du pied non associé à une neuro et néphropathie et/ou une artériopathie périphériques des membres inférieurs chez le diabétique.

B toute Infection, ulcération ou destruction des tissus profonds du pied associé à une neuropathie et/ou une artériopathie périphériques des membres inférieurs chez le diabétique.

C toute Infection, ulcération ou destruction des tissus profonds du pied non associé à une neuropathie et/ou une artériopathie périphériques des membres inférieurs chez le diabétique.

Q36. La douleur épigastrique sans irradiation rythmée par les repas est une caractéristique de l'une des affections suivantes. Laquelle : L2p68(Doc de médecine)

A La gastrite B Le reflux gastro-œsophagien **C Le syndrome ulcéreux typique**

Q37. L'HTA primaire serait la conjugaison de plusieurs facteurs : Cocher les deux bonnes propositions L2p4(Doc de médecine)

A Facteurs modifiables B Facteurs indéterminés **C Facteurs non modifiables**

D Facteurs d'origine congénitale E Facteurs iatrogènes

III- ETUDES DE CAS

Vous recevez pendant votre garde, Mme PLIPLA Georgette, 42 ans, aux urgences médicales de L'EPHR de Bondoukou. Son poids avant la présente crise est de 79 kg. A son admission la température est de 36°9 C et un poids à 73,5 kg, associée à une diarrhée et des vomissements qui durent depuis deux jours. Les pertes hydriques ont occasionné une déshydratation aiguë et une pâleur des conjonctives. La prise du pouls, radial donne 51 pulsations / mn, la TA est à 65/43 mm Hg. Groupe sanguin AB négatif

La diarrhée est faite de selles abondantes, aqueuses, afécales en jet avec un aspect riziforme.

A l'examen, on note un tableau de collapsus cardio-vasculaire avec une soif intense, une sueur profuse, une anurie, une cyanose, un pli cutané persistant, des troubles de la conscience.

QUESTIONS

Q38. A partir des signes décrits dans le texte, identifiez parmi les pathologies suivantes, celle qui convient à votre hypothèse diagnostic L1p115(Doc de Maladie Infectieuse)

A Méningite purulente B Fièvre typhoïde C Syndrome dysentérique **D Cholera**

Q39. La pathologie du patient est : Cocher la bonne proposition L1p114(Doc de Maladie Infectieuse)

A une infection intestinale, contagieuse, endémique, à déclaration obligatoire

B une infection intestinale, contagieuse, endémique, à déclaration non obligatoire

C une toxi-infection intestinale, contagieuse, endémique, à déclaration non obligatoire

D une toxi-infection intestinale, contagieuse, endémique, à déclaration obligatoire

Q40. Le réservoir de germes de cette pathologie est constitué par : Cocher la bonne proposition L1p114(Doc de Maladie Infectieuse)

A L'homme malade, le cadavre, l'homme sain et les fruits de mer

B: Les animaux C: Les insectes D: Les mollusques d'eau douce

Q41. Dans la prise en charge de cette pathologie les éléments d'évaluation de la déshydratation portent sur : choisir la bonne proposition

A Perte de poids, diurèse, état de conscience, yeux, pli cutané, extrémité, pression artérielle, amplitude du pouls

B Perte de poids, couleur des selles, aspect des selles, odeurs des selles, la perte hydrique, pli cutané, la tension artérielle, la température

C Perte de poids, l'aspect des selles, la perte hydrique, pli cutané, la tachycardie, la fièvre, pouls filant, le caractère des vomissements

Q42. La déshydratation de Madame PLIPLA est évaluée à une perte de poids corporel de : cocher la bonne proposition

A : 3,96 % **B : 6,96 %** C : 10,96% D : 15,96%

$$\% = \frac{P(\text{initial}) - P(\text{morbide})}{P(\text{initial})} \times 100 = \frac{79 - 73,5}{79} \times 100$$

Q43. Vous estimez que le patient a une déshydratation de type : Cocher la bonne proposition

A : léger **B : moyen** C : Sévère

Déshydratation < à 5% (Légère) → **SRO**
 Déshydratation entre 5% et 10% (Moyen) } Voie parentérale
 Déshydratation > à 10% (Sévère)

Q44. La réhydratation correcte de ce patient se fera par : Cocher la bonne proposition

A voie orale : SRO, ou (1 litre d'eau pour 8 carreaux de sucre + 1 C à C de sel de cuisine + ½ tranche de citron).

B voie parentérale : le Ringer Lactate, SSI = 2/3 + 1/3 de sérum bicarbonaté à 1,4%

Q45. Dans cette affection la prophylaxie collective repose principalement sur : Cocher la meilleure proposition

A la lutte contre le péril fécal

B L'hygiène individuelle

C La mobilisation communautaire

D la vaccination

Q46. Après exeat, le médecin revoit le patient dix jours après, avec un poids morbide conservé et décide de corriger l'anémie de 4g d'Hb. Quelle quantité de produit sanguin labile (concentré érythrocytaire) disponible doit-on commander sachant que le taux d'Hb attendu est de 12g/dl. Cocher la bonne réponse.

A : 1764 ml B : 1896 ml **C : 3528 ml** D : 3792 ml

$$Q = (Hb_{\text{souhaité}} - Hb_{\text{actuel}}) \times \text{poids} \times 6$$

$$Q = (12 - 4) \times 73,5 \times 6$$

$$Q = 3528$$

Q47. Quel est le nombre de poches de sang correspondant si une poche contient 450ml de culot globulaire : Cocher la bonne réponse

A : 4 B : 5 **C : 8** D : 9

$$\text{Nbre de poches de sang} = \frac{3528}{450} = 7,96 \cong 8$$

Q48. Quel groupe de sang à transfuser chez ce patient, les poches de sang disponibles étant : Cocher la bonne réponse.

A : A positif B : O positif C : AB positif **D : O négatif**

Considérant son poids de 73,5 note IMC = 20,88. Vous contrôlez la glycémie capillaire qui revient à 3,43 g/l.

Q49. Indiquez la dose appropriée à la situation du patient devant ce tableau clinique, le traitement étant le rajout d'unités d'insuline rapide L3p87(Doc de MT SI Spécialisés)

A 2 UI B 3 UI **C 5 UI** D 7 UI

3UI entre 2,5 et 3 g/l

5UI entre 3 et 3,5 g/l

7UI entre 3,5 et 4 g/l

Le médecin institue une CAT par un remplissage vasculaire avec un soluté de Ringer Lactate 500 cc à faire passer à un débit moyen de 75 minutes.

Q50. Indiquez le débit moyen par défaut de cette perfusion

- A 2 gouttes/mn
B 3 gouttes/mn
C 133 gouttes/mn
D 134 gouttes/mn

$$D = \frac{Q \times 20}{T} = \frac{500 \times 20}{75} = 133,33 \text{ gouttes/min}$$

Q51. Le deuxième soluté est un sérum salé isotonique de 540 ml à régler à 30 gouttes / minute. Indiquez la durée de cette perfusion

A : 2h B : 4h **C : 6h** D : 8h

$$D = \frac{Q \times 20}{T \times 60} \Rightarrow T = \frac{Q \times 20}{D \times 60} = \frac{540 \times 20}{30 \times 60}$$

Q52. Pour ajuster la glycémie du patient il vous est demandé de faire passer un certain volume de SG 5% en 4 heures à raison de 41 gouttes / minute. Indiquez le volume pratique de SGI à passer dans ce temps.

A : 392 ml **B : 492 ml** C : 592 ml

$$D = \frac{Q \times 20}{T \times 60} \Rightarrow Q = \frac{D \times T \times 60}{20} = \frac{41 \times 4 \times 60}{20}$$

Q53. Tenant compte des données, précisez à votre patient sa taille : cochez la bonne proposition

A : 1,77 m **B : 1,87m** C : 1,97 m

$$IMC = \frac{P}{T^2} \Rightarrow T = \sqrt{\frac{P}{IMC}} = \sqrt{\frac{73,5}{20,88}}$$

Q54. L'insuline étant administrée à raison de 0,1 UI / Kg, Quel est le volume en ml de ce produit à injecter à notre patient toujours moribide sachant qu'une dose de 100 UI correspond à 1 ml (2 points)

A : 0,735 ml **B : 0,0735 ml** C : 0,00735 ml

1Kg	→	0,1UI		100UI	→	1ml
73,5Kg	→	x= 7,35UI		7,35UI	→	y= 0,0735

Déterminez pour le cas de Mme PEPLA, un diagnostic infirmier correct :

Q55. En rapport avec sa pathologie :

- a) Déshydratation due à la perte hydrique**
- b) Selles afécales due à la diarrhée
- c) Malaises dus à l'incontinence digestive

Q56. Proposez un objectif de soins en vue de sa satisfaction en rapport avec la maladie :

- a) Adopter des attitudes visant la prévention des complications**
- b) Amener le malade à suivre son traitement
- c) Éliminer les signes de la maladie

Q57- Dans la démarche de soins, le diagnostic infirmier se détermine au niveau :

- a. De la collecte des données
- b. De L'analyse et l'interprétation des données**
- c. De la planification de l'intervention
- d. Du plan de soins

Q58. Pour le malade en question, dans l'épisode de la déshydratation, indiquer le besoin fondamental selon Virginia Henderson à satisfaire parmi les propositions suivantes :

- A manger et boire**
- B éviter le danger
- C être propre et protéger ses téguments
- D éliminer les déchets biologiques

Dans la recherche des pathologies associées, la médecine envisage de demander des examens en lien avec le VIH.

Q59. Plusieurs méthodes de diagnostics biologiques existent. Sur quelle méthode est basée la sérologie VIH (Les tests rapides) ? (Une réponse est bonne) L1p65 (Doc de COURS VIH SIDA)

- a- Méthode mixte
- b- Méthode indirecte**
- c- Méthode directe
- d- Dry Blood Spot (DBS)

Q60. Parmi les classifications de l'infection VIH. Laquelle correspond la classification CDC ? Cocher la bonne réponse. L1p60-61 (Doc de COURS VIH SIDA)

- a- la classification clinique en 4 stades
- b- la classification immunitaire
- c- la classification clinique en 3 catégories
- d- la classification clinique en 3 catégories associé à la classification immunitaire**

**DIPLOME D'ETAT BLANC DE SOINS INFIRMIERS EN MEDECINE - Licence 3-
IDE 2025**

COMPOSITION Sujet Version A Groupe 2 Durée : 1h 30 min

I-QCD

Répondre par A pour la proposition juste et B pour la proposition fausse
(une réponse juste = 1 point – une réponse fausse = - 1 point – une question sans réponse = 0)

- Q1.** La prévention primaire des IST prévient la survenue du VIH **A**
- Q2.** Chez le patient diabétique, la glycosurie reflète le taux de glycémie du moment et donne une information cumulative. **B** « l'hémoglobine glyquée »
- Q3.** Dans la méningite purulente, les signes fonctionnels sont représentés par la raideur méningée et l'hyperesthésie cutanée **B**
- Q4.** Le troisième objectif des stratégies 95-95-95 de l'ONUSIDA vise le counseling de 95 PVVIH sur 100. **B** « suppression de la charge virale »
- Q5.** Dans l'infection à VIH, l'approche de prise en charge qui implique un laboratoire est l'approche syndromique. **B** « approche étiologique »
- Q6.** Les soins du mal perforant plantaire consiste en un assèchement médical jusqu'à l'os et à l'articulation. **B** « chirurgicale »
- Q7.** La dyspnée laryngée est une difficulté respiratoire ou détresse respiratoire à type de bradypnée inspiratoire avec tirage sus sternal accompagnée de cornage et de trouble de la voix. **A**
- Q8.** Chez le malade comateux l'on observe une préservation de la vie de relation. **B**
- Q9.** L'intubation est un soin réalisé par l'anesthésiste réanimateur. **A**
- Q10.** L'aspiration trachéale est l'acte de soins visant à éliminer les sécrétions des voies aériennes chez le patient intubé ou trachéotomisé afin d'en assurer son indépendance. **A**
- Q11.** La décision de limitation ou d'arrêt de thérapeutique active ne constitue en rien une pratique d'euthanasie mais vise à restituer son caractère naturel à la mort. **A**
- Q12.** Les soins palliatifs sont des soins actifs dans une approche globale de la personne atteinte d'une maladie grave, évolutive ou primitive. **B** « terminale »
- Q13.** Dans le paludisme, à la phase asexuée, la replication des mérozoïtes, des parasites sexués mâles et femelles (gamétocytes) sont formés à l'intérieur des globules rouges. **B** « la phase sexuée »
- Q14.** Chez le sujet atteint de dengue fébrile on observe une thrombocytopénie et une leucopénie. **A**
- Q15.** En cas d'envenimation, l'injection du venin est suivie de troubles cliniques après 6h environ. **B**

II- QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES

Hachurez les alvéoles correspondant aux bonnes réponses sachant qu'une bonne réponse vaut 1 et une mauvaise réponse 0 point.

Choisir la lettre correspondant à la bonne réponse

Q16. Associez les pathologies (a, b,c,d) à leur agent vecteur (1,2, 3,4) puis cochez la bonne proposition de combinaison en A, B, C ou D

- a) Fièvre jaune – b) Paludisme – c) Onchocercose – d) Trypanosomiase humaine africaine

1-Anophèle femelle 2- la simulie 3-la glossine 4- Aedes aegypti

A : (a-4)_(b-1)_(c-2)_(d-3)

B : (a-3)_(b-4)_(c-1)_(d-2)

C : (a-2)_(b-3)_(c-4)_(d-1)

D : (a-1)_(b-2)_(c-3)_(d-4)

Q17. Dans la bilharziose urinaire la phase d'état est marquée par : Cochez la proposition juste

A L'hématurie macroscopique qui est une hématurie initiale, capricieuse, douloureuse, intermittente, récidivante, pouvant évoluer pendant plusieurs mois.

B L'hématurie macroscopique qui est une hématurie totale, capricieuse, douloureuse, intermittente, récidivante, pouvant évoluer pendant plusieurs mois.

C L'hématurie macroscopique qui est une hématurie terminale, capricieuse, douloureuse, intermittente, récidivante, pouvant évoluer pendant plusieurs mois.

Q18. Lorsque la personne n'est pas en état d'exprimer sa volonté, une procédure collégiale doit être appliquée selon les modalités suivantes : Cocher les deux actions non appropriées (1 point)

A chercher quelle était la volonté que le patient aurait antérieurement exprimée en consultant les directives anticipées lorsqu'elles existent ;

B prendre en compte l'avis de la personne de confiance ou, à défaut, la famille ou les proches ;

D prendre l'avis d'un autre médecin qui engage sa responsabilité ;

E obtenir un consensus au sein de l'équipe médicale et paramédicale ;

F éviter de transcrire la procédure dans le dossier médical car l'acte n'engage que le patient.

Q19. Le rôle de l'infirmière durant les dernières heures de vie de la personne malade est centré sur : Cocher l'activité non recommandée (1 point)

A le soulagement des symptômes (douleurs, dyspnée, encombrement...) ; le dégagement des voies aériennes ;

B l'humidification et les soins de la bouche ; le positionnement et le soin des escarres ;

C les soins des yeux ; l'atténuation des odeurs ; l'accompagnement de la personne malade et de ses proches ;

D la prise d'une voie veine de sûreté, l'administration des solutés appropriés, les gestes de réanimation infirmières

Q20. Dans le rôle de l'infirmier au-près de la famille du patient, le but des interventions infirmières est d'aider les familles des patients en fin de vie, à : Cocher l'action inappropriée

A gérer leurs sentiments,

B prendre leurs propres décisions

C informer sur le pronostic vital

D réajuster leurs attitudes.

Q21. Le coma est un état : Compléter la phrase par : cocher la bonne proposition

A irréversible qu'elle que soit la stimulation.

B réversible qu'elle que soit la stimulation.

C passer qu'elle que soit la stimulation.

Q22. Le bilan d'hémostase simplifiée du diabétique comprend l'évaluation de : Cocher l'intrus

A Taux de prothrombine (TP),

B Temps de céphaline kaolin (TCK) ou Temps de céphaline avec activateur (TCA).

C Taux d'urée et de glycémie

D Numération plaquettaire

Q23. On appelle pied diabétique...: Cocher la meilleure proposition

A toute Infection, ulcération ou destruction des tissus profonds du pied non associé à une neuro et néphropathie et/ou une artériopathie périphériques des membres inférieurs chez le diabétique.

B toute Infection, ulcération ou destruction des tissus profonds du pied associé à une neuropathie et/ou une artériopathie périphériques des membres inférieurs chez le diabétique.

C toute Infection, ulcération ou destruction des tissus profonds du pied non associé à une neuropathie et/ou une artériopathie périphériques des membres inférieurs chez le diabétique.

Q24. L'HTA primaire serait la conjugaison de plusieurs facteurs : Cocher les deux bonnes propositions

A Facteurs modifiables

B Facteurs indéterminés

C Facteurs non modifiables

D Facteurs d'origine congénitale

E Facteurs iatrogènes

Q25- La phase d'incubation de la Schistosomiase est marquée par un signe dominant : Cochez-le :

A Une hématurie

B Une dermatite cercarienne

C Une fièvre

Q26. A la phase d'état de la fièvre typhoïde les signes cutanés sont marqués par : Cocher les deux bonnes propositions

A les tâches rosées lenticulaires,

B un érythème maculoprurigineux fugace

C l'angine de Duguet

D les lésions vésiculaires prurigineuses

E un dessèchement de la peau

Q27. Les pathologies en rhumatologie peuvent se signaler par un prodrome fait de signes généraux : Cochez la bonne proposition

A douleurs articulaires, tuméfaction, pâleur, rougeur, névralgie

B raideur, instabilité, boiterie, claudication

C fièvre, sueur, céphalée, asthénie, tachycardie, anémie

D Douleurs abdominales, vomissements et diarrhée intermittente

Q28. Pour administrer le traitement du paludisme à un patient l'OMS recommande : Cocher la bonne proposition

A TDR et Goutte épaisse positifs

B TDR ou Goutte épaisse positif

C TDR et Goutte épaisse négatifs mais tous les signes fonctionnels et physiques présents

Q29. En Cote d'Ivoire, la vaccin contre la paludisme en vigueur dans le PEV s'administre chez l'enfant à partir de l'âge de : cocher la bonne proposition

- A la naissance
- B 3mois
- C 6 mois**

Q30. L'utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action(MILDA) consiste à dormir : Cocher la bonne proposition

- A toutes les nuits sous la MILDA .**
- B toutes les nuits à partir de 22h, sous la MILDA
- C toutes les nuits sous la MILDA, en saison pluvieuse

Q31. Le concept de La double protection implique (deux sont bonnes)

- A L'utilisation de trois méthodes de protection
- B L'utilisation de deux méthodes de protection**
- C L'utilisation d'une seule méthode de protection
- D La prévention contre les IST et les grossesses non désirées**

Q32. Les IST transmises qu'une femme enceinte peut transmettre à son enfant au cours de la grossesse sont (Trois sont bonnes) :

- A Gonococcie
- B chlamydie
- C VIH/sida**
- D Candidose
- E Hepatite B**
- F Syphilis**

Q33. Parmi les propositions suivantes trois correspondent à la prévention par voie sexuelle (trois sont bonnes)

- A port de préservatifs**
- B port de blouse et habit de protection
- C PreP**
- D TARV**
- E prophylaxie ARV au nouveau-né
- F dépistage VIH+Syphilis+Hepatite B

Q34. Dans l'angor on note : cocher la proposition juste

- A une douleur constrictive à type d'étau de serrement, de broiement, de griffe, de douleur intense angoissante.**
- B une dyspnée à type de polypnée avec battement des ailes du nez et des sueurs abondantes.

Q35. Chez un sujet déclarant une morsure de serpent, les gestes de premiers secours consistent en : Cochez les deux gestes à ne pas faire

- A Rassurer le patient et son entourage,
- B Mettre en place une pierre noire adhésive pour aspirer le venin dans les meilleurs délais**
- C Nettoyer la morsure et rechercher les traces de crochets puis
- D Donner à boire de l'eau à la demande du patient**
- E Faire un examen général pour évaluer la gravité.
- F Distinguer les signes de stress et les symptômes d'envenimation

Q36. Le cycle de vie de l'insecte hématophage qui transmet le virus de la dengue, comporte : Cocher la bonne proposition

- A 2 phases (aquatique et aérien)**
- B 3 phases (terrestre, aquatique et aérien)
- C 4 phases (méditerranéen, terrestre, aquatique et aérien)

Q37. Les signes cliniques de l'insuffisance cardiaque gauche associent : cocher les deux intrus

- A une dyspnée d'effort, B une toux, C des vomissements
D des expectorations, E une cyanose F une hémoptysie

III- ETUDES DE CAS

Vous recevez pendant votre garde, M. KONE Tiéfi, 51 ans, aux urgences médicales de L'EPHR de Katiola. Son poids avant la présente crise est de 83 kg. A son admission la température est de 38°9 C et un poids à 72 kg, associée à une diarrhée hydrique qui dure depuis 2 jours, caractérisée par des selles glairosanglante avec : - une fièvre, une sensation de malaise, une asthénie, - de violentes douleurs abdominales à type d'épreintes, un ténésme, des vomissements, - l'émission quasi-permanente des selles glairo-sanglantes et purulentes, innombrables (plus de 100 par 24 h). Il en résulte une déshydratation immédiate avec pertes hydroélectrolytiques et une pâleur des conjonctives.

A l'examen, on note un tableau fait de douleurs abdominales violentes avec épreintes, ténésmes et faux besoins une diarrhée aféciale, glaireuse et mucopurulente, parfois sanglante et une altération de l'état général, de la fièvre.

QUESTIONS

Q38. A partir des signes décrits dans le texte, identifiez parmi les pathologies suivantes, celle qui convient à votre hypothèse diagnostic

- A Méningite purulente B Fièvre typhoïde C Syndrome dysentérique D Cholera

Q39. La pathologie du patient est : Cocher la bonne proposition

- A une maladie du péril fécal, éruptive et contagieuse
B une maladie du péril fécal, contagieuse, endémique due à des vibrions
C une maladies du péril fécal dues à des entérobactéries.

Q40. Le réservoir de germes de cette pathologie est constitué par : Cocher les deux bonnes propositions

- A Les animaux sauvages
B Les insectes
C L'homme
D Les mollusques d'eau douce
E L'environnement

Q41. Cette affection est également sexuellement transmissible : choisir la bonne proposition

- A OUI B FAUX

Q42. La déshydratation de M. KT est évaluée à une perte de poids corporel de : cocher la bonne proposition

- A: 4,25 % B: 7,25 % C: 11,25% D: 13,25%

$$\% = \frac{P(\text{Initial}) - P(\text{Morbide})}{P(\text{Initial})} \times 100 = \frac{83 - 72}{83} \times 100$$

Q43. Vous estimez que le patient a une déshydratation de type : Cocher la bonne proposition

A: Léger B: Moyen **C: Sévère**

Déshydratation < à 5% (Légère) → SRO	Voie Parentérale
Déshydratation entre 5% et 10% (Moyen)	
Déshydratation > à 10% (Sévère)	

Q44. La réhydratation correcte de ce patient se fera par : Cocher la bonne proposition

A voie orale : SRO, ou (1 litre d'eau pour 8 carreaux de sucre + 1 C à C de sel de cuisine + ½ tranche de citron).

B voie parentérale : le Ringer Lactate, SSI = 2/3 + 1/3 de sérum bicarbonaté à 1,4%

Q45. Dans cette affection la prophylaxie collective repose principalement sur : Cocher la meilleure proposition

- A L'hygiène individuelle
- B La mobilisation communautaire
- C la vaccination
- D la lutte contre le péril fécal**

Q46. Après exeat, le médecin revoit le patient dix jours après, avec un poids morbide conservé et décide de corriger l'anémie de 3g d'Hb. Quelle quantité de produit sanguin labile (Sang total) disponible doit-on commander sachant que le taux d'Hb attendu est de 11g/dl. Cocher la bonne réponse.

A: 1728 ml B: 1826 ml C: 3456 ml D: 3556 ml

$$Q = (Hb_{souhaité} - Hb_{actuel}) \times \text{poids} \times 3$$

$$Q = (11 - 3) \times 72 \times 3$$

$$Q = 1728$$

Q47. Quel est le nombre de poches de sang correspondant si une poche contient 350ml de sang total : Cocher la bonne réponse

A: 4 **B: 5** C: 8 D: 9

$$\text{Nbre de poches de sang} = \frac{1728}{350} = 4,93 \approx 5$$

Q48. Quel groupe de sang à transfuser chez ce patient, les poches de sang disponibles sont : A positif - AB positif - O négatif. Cocher la bonne réponse.

A : O négatif B : A positif C : B négatif D : AB positif

Considérant son poids de 72 kg, note IMC = 18,75. Vous contrôlez la glycémie capillaire qui revient à 2,43 g/l.

Q49. Indiquez la dose appropriée à la situation du patient devant ce tableau clinique, le traitement étant le rajout d'unités d'insuline rapide. L3p87(Doc de MT SI Spécialisés)

A 2 UI **B 3 UI** C 5 UI D 7 UI

3UI entre 2,5 et 3 g/l
5UI entre 3 et 3,5 g/l
7UI entre 3,5 et 4 g/l

Le médecin institue une CAT par un remplissage vasculaire avec un soluté de Ringer Lactate 1000 cc à faire passer à un débit moyen de 180 minutes.

Q50. Indiquez le débit moyen par défaut de cette perfusion

A 111 gouttes/mn

$$D = \frac{Q \times 20}{1000} = \frac{1000 \times 20}{1000} = 111,11 \text{ gouttes/min}$$

- B 2 gouttes/mn
C 133 gouttes/mn
D 6 gouttes/mn

$$\frac{\quad}{T} \quad \frac{\quad}{180}$$

Q51. Le deuxième soluté est un sérum salé isotonique de 540 ml à régler à 30 gouttes / minute. Indiquez la durée de cette perfusion

- A. 2h B. 4h **C. 6h** D. 8h

$$D = \frac{Q \times 20}{T \times 60} \Rightarrow T = \frac{Q \times 20}{D \times 60} = \frac{540 \times 20}{30 \times 60}$$

Q52. Pour ajuster la glycémie du patient il vous est demandé de faire passer un certain volume de SG 5% en 6 heures à raison de 30 gouttes / minute. Indiquez le volume pratique de SGI à passer dans ce temps.

- A 540 ml** B 500 ml C 600 ml

$$D = \frac{Q \times 20}{T \times 60} \Rightarrow Q = \frac{D \times T \times 60}{20} = \frac{30 \times 6 \times 60}{20}$$

Q53. Tenant compte des données, précisez à votre patient sa taille : cochez la bonne proposition

- A 1,75 m B 1,85m **C 1,95 m**

$$IMC = \frac{P}{T^2} \Rightarrow T = \sqrt{\frac{P}{IMC}} = \sqrt{\frac{72}{18,76}}$$

Q54. L'insuline étant administrée à raison de 0,1 UI / Kg, Quel est le volume en ml de ce produit à injecter à notre patient toujours morbidement sachant qu'une dose de 100 UI correspond à 1 ml (2 points)

- A 0,0072 ml B 0,72 ml **C 0,072 ml**

$$\begin{array}{lcl} 1\text{Kg} & \longrightarrow & 0,1\text{UI} \\ 72\text{Kg} & \longrightarrow & x = 7,2\text{UI} \end{array} \quad \left| \quad \begin{array}{lcl} 100\text{UI} & \longrightarrow & 1\text{ml} \\ 7,2\text{UI} & \longrightarrow & y = 0,072 \end{array} \right.$$

Déterminez pour le cas de M. KT, un diagnostic infirmier correct :

Q55. En rapport avec sa pathologie :

- d) Selles afécales due à la diarrhée
e) Malaises dus à l'incontinence digestive
f) Déshydratation due à la perte hydrique

Q56. Proposez un objectif de soins en vue de sa satisfaction en rapport avec la maladie :

- d) Adopter des attitudes visant la prévention des complications**
e) Amener le malade à suivre son traitement
f) Éliminer les signes de la maladie

Q57- Dans la démarche de soins, le diagnostic infirmier se détermine au niveau :

- e. De la collecte des données
f. De L'analyse et l'interprétation des données
g. De la planification de l'intervention
h. Du plan de soins

Q58. Pour le malade en question, dans l'épisode de la déshydratation, indiquer le besoin fondamental selon Virginia Henderson à satisfaire parmi les propositions suivantes:

A manger et boire

B éviter le danger

C être propre et protéger ses tégument

D éliminer les déchets biologiques

Dans la recherche des pathologies associées, la médecine envisage de demander des examens en lien avec le VIH.

Q59. Plusieurs méthodes de diagnostics biologiques existent. Sur quelle méthode est basée la sérologie VIH (Les tests rapides) ? (Une réponse est bonne)

e- Méthode indirecte

f- Méthode directe

g- Dry Blood Spot (DBS)

h- Méthode mixte

Q60. Parmi les classifications de l'infection VIH . Laquelle correspond la classification CDC ? Cocher la bonne réponse.

a- la classification clinique en 4 stades

b- la classification immunitaire

c- la classification clinique en 3 catégories

d- la classification clinique en 3 catégories associé à la classification immunitaire

INFAS ABIDJAN ECOLE DE BASE
VERSION A

EXAMEN BLANC EXAMEN BLANC LICENCE 3 IDE GROUPE 1
SI EN PEDIATRIE

SUJET N°1

CONSIGNE
MN

Durée : 90

QUESTIONS A CHOIX DOUBLE (QCD) :

Pour les QCD cochez la lettre correspondante à la réponse correcte (A= Vrai et B= Faux), sachant qu'une réponse correcte vaut +1 point et une réponse incorrecte -1 point et aucune réponse 0 point.

QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES (QCM) :

Pour répondre aux QCM, cochez-la ou les case(s) correspondante(s) à la ou les bonnes réponses, en sachant qu'une réponse correcte vaut +1 point et une réponse incorrecte 0 point et aucune réponse 0 point.

QCD

1. Le paludisme est une maladie virale due à des hématozoaires du genre plasmodium ? **B**

2. Le vecteur de la maladie est plasmodium falciparum **B**

3. Plasmodium falciparum est l'espèce responsable des formes graves du paludisme. **A**

4. Le cycle exo érythrocytaire se fait au niveau des globules rouges **B**

5. NA est né à 40 semaines + 6 jours d'aménorrhée avec un poids de 3900 g, une taille de 51 cm et un périmètre crânien de 35 cm. Ce jour à J7 de vie au premier contrôle il pèse 3700g, son périmètre crânien est à 35 cm et sa taille à 51 cm. Selon la mère il tète bien et à votre examen il ne présente aucun signe anormal. NA a-t-il perdu plus de 10% de son poids de naissance ?

A= OUI

B= NON

6. Le nouveau-né KS de sexe féminin (né à 38 semaines d'aménorrhée + 4 jours) a reçu 1 mg de vitamine K en intramusculaire à la naissance. A 3 jours de vie KS présente un écoulement vaginal sanguinolant mêlé à une substance gluante blanchâtre de petite quantité. Le premier diagnostic évoqué est la maladie hémorragique du nouveau-né. Le diagnostic est -il correct ?

A= OUI.

B= NON

7. En salle de naissance, pour décider de la réanimation d'un nouveau-né, le principal élément à évaluer est sa respiration. **A**

8. L'enfant DA âgé de 26 mois vous est amené en urgence pour paludisme grave forme convulsions répétées avec une crise convulsive en cours. Quel sera le soin délégué que vous ferez en premier ?

A- Injecter un antipaludique

B- injecter du diazépam

9. La souffrance néonatale est un facteur favorisant des crises convulsives. **A**

10. Vous faites une injection de paracétamol en cas d'hyperthermie chez l'enfant de moins de 5 ans. Est-ce un soin propre à l'agent de santé ? **B**

11. La bradypnée chez le nouveau-né à terme est marquée par une fréquence respiratoire est supérieure à 60 Cycles par minute. **B**

12. La maladie des membranes hyaline (déficit en surfactant) est une cause fréquente de détresse respiratoire chez le nouveau-né à terme **B**

13. Lors de la réanimation du nouveau-né en salle d'accouchement, l'aspiration débute par l'aspiration des fosses nasales avant l'aspiration de la cavité buccale. **B**
14. Vous recevez lors de votre garde un nourrisson de 8 mois présentant une température de 38°5C. Vous installez le nourrisson sur la table d'examen, vous le déshabillez et vous aérez la salle d'examen. Ces gestes que vous faites sont des soins délégués ? **B**
15. La ration alimentaire de l'enfant c'est le nombre de bol de lait donné à l'enfant par jour **B**
16. La ration alimentaire peut être obtenue seulement en tenant compte de l'âge de l'enfant **B**
17. La ration alimentaire d'un enfant de J0 à J2 est de 30ml pour 6 repas **A**
18. L'allaitement est contraignant cependant le lait maternel disponible **A**
19. UN enfant de 6kg a une ration alimentaire de 850g **A**
20. La règle d'appert est utilisée pour obtenir la ration alimentaire d'un enfant dont on ne connaît l'âge. **A**
21. Pendant l'examen du nouveau -né il faut rechercher les réflexes archaïques au nombre de 7. **B**
22. Les soins ombilicaux à la Chlorhexidine sont ceux recommandés en côte d'Ivoire. **A**
23. Dans les soins ombilicaux à la Chlorhexidine il n'est pas nécessaire de faire un pansement. **A**
24. l'examen du nouveau-né en salle de naissance permet de déceler et corriger les anomalies susceptibles d'entraver ou influencer son développement harmonieux **A**

QCM

25. les facteurs favorisant les intoxications aiguës chez l'enfant sont les suivants sauf un, lequel ?

- a- Age > 7 ans**
- b- Ignorance des parents
- c- Manque de surveillance de l'enfant
- d- Bas niveau socio-économique

26. les problèmes posés par l'intoxication chez l'enfant sont (cochez les bonnes réponses)

- a- La fièvre
- b- Les convulsions**
- c- La détresse respiratoire**
- d- L'anémie aiguë

27. les facteurs ci-dessous sont des facteurs environnementaux de l'asthme sauf un, lequel ?

- a- Exposition aux allergènes.
- b- Occidentalisation du mode de vie
- c- Asthme chez les parents**
- d- Tabagisme passif

28. les mécanismes en jeu au cours de l'asthme sont les suivants (cochez les bonnes réponses)

- a- L'inflammation**
- b- La saturation
- c- L'obstruction**
- d- La vasoconstriction

29. Les complications à long terme de l'asthme sont (cochez les bonnes réponses)

- a- Le retard scolaire**
- b- La tuberculose
- c- La pneumonie
- d- L'insuffisance respiratoire**

30. Les facteurs de risque de la maladie hémorragique du nouveau-né sont les suivants sauf 02 lesquels ?

- a- Hypotrophie
- b- Asphyxie périnatale
- c- Certains médicaments
- d- Hépatite aigüe

31. Cocher parmi ces signes, ceux en rapport avec un nouveau- né post terme

- a- Petit poids de naissance
- b- Peau desquamant
- c- Teint rouge vif
- d- Présence de lanugo
- e- Ongles longs
- f- Crâne dur

32. Les situations à risque de détresse respiratoire chez le nouveau-né sont les suivantes sauf une laquelle ?

- a- Souffrance cérébrale
- b- Malformation
- c- Prématurité
- d- Nouveau-né de mère asthmatique

33. Au cours de la réanimation d'un nouveau-né en salle de naissance, il y a des gestes à proscrire, lesquels ?

- a- Taper sur les fesses du bébé
- b- Pincer le mamelon
- c- Aspirer la cavité buccale
- d- Couper le cordon ombilical

34. Parmi les facteurs ci-dessous, quels sont ceux qui favorisent la survenue d'une otite moyenne aigüe chez l'enfant ? cochez la bonne réponse

- a- les rhinites
- b- la rougeole
- c- la saison de pluie
- d- la malnutrition

35. Les signes cliniques suivant sont ceux de l'otite moyenne aigüe de l'enfant sauf un lequel ?

- a- La fièvre
- b- Les ganglions
- c- L'otorrhée
- d- La rhinite

36. les symptômes de la rhinopharyngite aigüe sont : cochez les réponses justes

- a- La toux
- b- Les céphalées
- c- La fièvre
- d- La rhinorrhée

37. Le nouveau-né hypotrophe est un nouveau-né (entourez la bonne réponse)

- a- de petit poids de naissance
- b- né à terme
- c- dont le poids est inférieur à l'âge

38. ces signes sont en rapport avec l'hypotrophe sauf un, lequel ?

- a- retard pondéral
- b- membres grêles
- c- peau fripée

d- somnolence

39. Le post terme est un nouveau-né (entourez les réponses fausses)

a- né après 36 SA + 6j

b- dont le poids est insuffisant par rapport à l'âge

c- né après 42 SA

d- de petit poids de naissance

40. Vous recevez le nourrisson TD âgé de 14 mois, lors de l'évaluation de son état nutritionnel, vous trouvez que TD a une malnutrition aigüe sévère, son Z score Poids/taille est donc de :

a- $0 < Z \text{ score} < -1$

b- $-1 < Z \text{ score} < -2$

c- $-2 < z \text{ score} < -3$

d- $Z \text{ score} < -3$

41. Un nourrisson de 13 mois qui a une malnutrition aigüe sévère compliquée d'œdème et d'infection pulmonaire sera (cochez la réponse exacte) :

a- Pris en charge avec du lait F75, du lait F100 et des Aliments thérapeutiques prêts à l'emploi (ATPE) en milieu hospitalier

b- Pris en charge avec des Aliments thérapeutiques prêts à l'emploi (ATPE) uniquement et en milieu hospitalier

c- Pris en charge avec du lait F75, du lait F100 et des Aliments thérapeutiques prêts à l'emploi (ATPE) en ambulatoire (en communauté)

d- Pris en charge avec des Aliments thérapeutiques prêts à l'emploi (ATPE) en ambulatoire (en communauté).

42. La rhinopharyngite est fréquente chez le nourrisson. Le germe le plus rencontré dans cette affection est : (choisissez la réponse exact)

a- Champignon

b- Virus

c- Bactérie

d- Parasite

43. Lors de la prise en charge d'un nourrisson présentant une Infection staphylococcie pleuropulmonaire, Vous injectez des antibiotiques. Quel est le type de soin que vous exécutez dans ce cas.

a- Soins préventifs

b- Soins propres

c- Soins délégués

d- Soins de collaboration

44. L'anémie du nouveau-né peut-être due à des prélèvements itératifs. Cette pratique est un facteur favorisant liés à : (choisissez la réponse correcte)

a- Lié à la communauté

b- Lié à l'agent de santé

c- Lié à l'enfant

d- Lié à la mère

45. Devant une anémie chez l'enfant vous prélevez du sang pour des examens de laboratoire. Quel est le type de soin que vous avez exécuté ?

a- Soins préventifs

b- Soins propres

c- Soins délégués

d- Soins de collaboration

46. Pour la présentation de la maladie hémorragique du nouveau-né, vous lui injectez un médicament. Identifiez le médicament dans la liste ci-dessous.

a- Vitamine ADEC

b- Vitamine K

c- Vitamine D

d- Vitamine C

47. Vous êtes en salle de naissance, madame KS âgée de 28 ans vient d'accoucher de son premier enfant à 39 SA. KS n'a reçu que 2 doses de vaccin antitétanique. La première dose à 20 semaines d'aménorrhée et la 2e dose à 38 semaines d'aménorrhée. Que faites-vous au nouveau-né pour la prévention du tétanos néonatal ?

a- Vous injectez un antibiotique

b- Vous injectez un vaccin antitétanique au nouveau-né

c- Vous injectez du sérum antitétanique

d- Vous ne faites rien car le nouveau-né est déjà protégé

48. Ces différents items permettent d'apprécier le score d'APGAR sauf un lequel ?

a- A : Aspect, couleur de la peau

b - P: Pouls (fréquence cardiaque)

c- G : Grimace, qualité du cri

d- A : aréflexie

e- R : Respiration (Mouvement respiratoire)

49. L'objectif de la PCIMNE est de contribuer à la réduction de la morbidité et la mortalité des enfants de <5 ans en s'appuyant sur 3 composantes :

a- Composante N°1: Renforcement du système de santé

b- Composante N°2: Amélioration des compétences des agents de santé

c- Composante N°3: Promotion des Pratiques Familiales Essentielles dans les familles et communautés

Choisir la bonne réponse

50. Parmi les principes de la PCIMNE ci-dessous, choisir la bonne réponse

a- Utilisation des signes spéciaux pour la classification de la maladie

b- Approche rationnelle pour classer la maladie

c- Conseiller la mère;

d- Organiser le quand revenir

Choisir la bonne réponse

51. Parmi les signes suivants un seul fait partie de l'infection bactérienne néonatale grave. Lequel ?

a- Omphalite rouge

b- Stridor

c- Incapable de s'alimenter

d- Hypothermie modérée

52. Le nouveau-né est bien tenu par la mère lors de la tétée lorsque :

a. Tête et le corps du nouveau-né sont dans le même axe

b. Le nouveau-né doit faire face au sein, et son nez en face du mamelon

c. Le corps du nouveau-né doit être proche du corps de la mère

d. La mère doit soutenir seulement le corps et les épaules du nouveau-né

Choisir la mauvaise réponse

53. Les principales causes de mortalité dans la PCIMNE sont :

a- Le tétanos néonatal

b- La rougeole

c- Le Paludisme

d- La malnutrition

Choisir la mauvaise réponse

54. Le lait maternel est un aliment complet :

- a- Il contient des éléments nutritifs idéaux
- b- Il est facile à digérer
- c- Il protège contre les affections
- d- Il rend intelligent**

Choisir la mauvaise réponse

55. Parmi les réponses ci-dessous, une seule est un avantage pour la mère au niveau de l'allaitement maternel exclusif, lequel ?

- a- Moins de dépenses en frais médicaux
- b- Relation, affective entre la mère et le bébé**
- c- Réduit le risque de cancer de l'utérus
- d- C'est un aliment complet

56. Pour affirmer la prématurité (âge gestationnel), on peut se baser sur les propositions suivantes sauf une. Laquelle ?

- a- Date des dernières règles
- b- Hauteur utérine
- c- Echographie précoce (< 12 SA) pendant la grossesse
- d- Critères cliniques
- e- Poids de naissance**

57. Ce schéma représente les stries plantaires d'un nouveau-né. Choisir les bonnes réponses

- a- Nouveau-né prématuré
- b- Nouveau-né prématuré hypotrophe
- c- Nouveau-né à terme hypotrophe
- d- Nouveau-né à terme eutrophe**

58. Au cours d'une séance de CCC, pendant la grossesse, vous citez les facteurs favorisant la prématurité aux parturientes. L'une de ces propositions est fausses, laquelle ?

- a- Age > 18 ans et < 35 ans**
- b- Tabagisme
- c- Multiparité
- d- Fatigue liée au travail professionnel ou familial

59. Pour la sécurité d'un accouchement prématuré, il faut :

- a- Une personne
 - b- Une bonne chaîne de froid
 - c- Asepsie rigoureuse**
 - d- Aspiration douce si nécessaire
- Choisir la ou les bonnes réponses.

60. Concernant l'hypotrophie (ou RCIU) harmonieux,

- a- Le poids, la taille et le périmètre crânien sont toujours diminués
- b- Seuls le poids et la taille sont diminués**
- c- La peau est fripée

d- La vigilance est parfaite

e- La cause est tardive

Choisir les réponses fausses

INFAS ABIDJAN ECOLE DE BASE
VERSION C

EXAMEN BLANC EXAMEN BLANC/LICENCE 3 SFM-IDE GROUPE 2
SI EN PEDIATRIE

SUJET N°2

CONSIGNE

Durée :

90 MN

QUESTIONS A CHOIX DOUBLE (QCD) :

Pour les QCD cochez la lettre correspondante à la réponse correcte (A= Vrai et B= Faux), sachant qu'une réponse correcte vaut +1 point et une réponse incorrecte -1 point et aucune réponse 0 point.

- 1) L'examen paraclinique clé auquel vous collaborer pour affirmer le déficit en vitamine K1 est le Temps de Quick. **A**
- 2) Les selles de la diarrhée aigue provoquée par Shiguelle sont pâteuses avec de la glaire et du sang. **A**
- 3) L'enveloppement humide est un des moyens physiques recommandés dans la prise en charge de la fièvre. **B**
- 4) Dans la démarche de soins, les données de l'identification du patient sont habituellement des données de dépendance. **B**
- 5) Le streptocoque B est le principal agent infectieux responsable d'infection bactérienne néonatale tardive. **B**
- 6) Le lait mature est produit par la mère après la première semaine post-partum. **B**
- 7) Les infections vagino-utérines sont des causes médicales de prématurité. **B**
- 8) Le mélange II de l'INSP d'Adjamé utilisé pour la réhabilitation nutritionnelle de l'enfant malnutri est composé de 6 volumes de lait entier en poudre + 2 volumes de sucre + 1 volume d'huile végétale. **B**
- 9) Il existe 18 Pratiques Familiales Essentielles en Côte d'Ivoire **B**
- 10) La toux fait partie des 7 maladies cibles de la PCIMNE. **B**
- 11) Le contact peau à peau favorise la mise en route de l'allaitement. **A**
- 12) L'entérocolite est un problème digestif lié à la prématurité. **A**
- 13) Le cartilage du lobule de l'oreille mou est un signe de prématurité. **A**
- 14) Participer à la réalisation de bilan biologique chez le nouveau-né prématurité est un soin de collaboration. **A**
- 15) Dans la physiologie de la lactation, la prolactine est l'hormone de sécrétion du lait. **A**
- 16) Exerçant dans un ESPC, vous recevez le nouveau-né BB, J4 de vie, pesant 1800g pour une hématomèse et un saignement en nappe au niveau du cordon ombilical. Vous administrez au nouveau-né BB avant la référence 1 mg de vitamine K1 en IVD **B**
- 17) Dans la démarche de soins, le problème de dépendance est fourni par l'analyse et l'interprétation des données collectées. **A**
- 18) Dans la démarche de soins, le manque de connaissance, peut-être dû à un manque de confiance. **B**

- 19) L'enfant classé dans la bande rose a besoin de traitement spécifique comme un antibiotique avant son transfert. **A**
- 20) En l'absence de sérum glucosé 5% pour la réhydratation, je peux utiliser du sérum glucosé 10% en remplacement. **B**
- 21) Le nourrisson présentant une diarrhée aiguë sans signe déshydratation boit avec avidité. **B**
- 22) Au cours de la diarrhée, il est recommandé de mettre l'enfant à la diète. **B**
- 23) La diarrhée persistante est une diarrhée qui évolue depuis plus de 21 jours **B**
- 24) La PCIMNE est la prise en charge intégrale des maladies du nouveau-né et de l'enfant **B**
- 25) Le nouveau-né âgé de moins de 24 H avec une coloration jaune de la peau et des muqueuses est atteint d'un ictère pathologique **A**

QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES (QCM) :

Pour répondre aux QCM, cochez-la ou les case(s) correspondante(s) à la ou les bonnes réponses, en sachant qu'une réponse correcte vaut +1 point et une réponse incorrecte 0 point et aucune réponse 0 point.

26) Le nouveau-né normal a un âge gestationnel compris entre :

- A- [37-42] semaines d'aménorrhée
- B-]37-42] semaines d'aménorrhée
- C-]37-42[semaines d'aménorrhée
- D- [37-42[semaines d'aménorrhée**

27) Votre examen du nourrisson ZA, présentant la diarrhée, retrouve des larmes absentes, un pli cutané qui s'efface lentement, une langue sèche et une agitation. Pour la réhydratation de ZA, vous optez pour un :

- A- Plan D
- B- Plan C
- C- Plan B**
- D- Plan A

28) L'administration de Zinc comprimé dans le traitement de la diarrhée chez le nourrisson 8 mois est de :

- A- Demi comprimé/jour pendant 10 jours
- B- Un comprimé/jour pendant 10 jours**
- C- Un quart de comprimé/jour pendant 10 jours
- D- Deux comprimés /jour pendant 10 jours

29) L'enfant né à terme avec une surface corporelle de 0,2 m2 et correctement nourri double sa surface corporelle à :

- A- 9 mois**
- B- 12 mois
- C- 24 mois
- D- 36 mois

30) A 15 mois un nourrisson avec un bon développement psychomoteur est capable de :

- A- Jeter un objet derrière lui**
- B- Parle constamment
- C- Tourne les pages d'un livre**
- D- Marche à reculons

31) La mise en incubateur du nouveau-né prématuré en détresse vitale est un soin :

- A- Propre**
- B- Collaboration
- C- Conseil et prévention
- D- Délégué

32) L'un des critères qui indique une bonne prise du sein est :

- A- Lèvre inférieure rentrée
- B- Menton éloigné du sein
- C- Bouche largement ouverte**
- D- Succion rapide, peu profonde

33) Les structures cibles de l'ocytocine pour provoquer l'éjection du lait sont :

- A- Cellules galactophores**
- B- Cellules myoépithéliales**
- C- Cellules adipeuses
- D- Cellules épithéliales

34) L'état de mal convulsif désigne une crise convulsive qui dure plus de :

- A- 05 minutes
- B- 10 minutes
- C- 20 minutes
- D- 30 minutes**

35) Pour la reconstitution de l'eau sucrée à 10% administrée à l'enfant malnutri à l'admission, j'utilise 2 carreaux de sucre pour :

- A- 200 ml d'eau potable
- B- 150 ml d'eau potable
- C- 100 ml d'eau potable**
- D- 50 ml d'eau potable

1 Carreau de sucre	→	5g
2 Carreaux de sucre	→	10g

Or l'eau sucrée 10%
10g → 100ml

36) Nourrisson KB fillette de 18 mois, présente des pleurs incessants, et un refus de téter. Elle n'est pas à jour de ses vaccins. A l'examen physique, la fontanelle antérieure est bombée, et la température de 40° Celsius. KB souffre d'une méningite purulente. KB a :

- A- 1 données au niveau de sa réalité personnelle
- B- 2 données au niveau de sa réalité personnelle
- C- 3 données au niveau de sa réalité personnelle**
- D- 4 données au niveau de sa réalité personnelle

37) Nourrisson KB fillette de 18 mois, présente des pleurs incessants, et un refus de téter. Elle n'est pas à jour de ses vaccins. A l'examen physique, la fontanelle antérieure est bombée, et la température de 40° Celsius. KB souffre d'une méningite purulente. KB a :

- A- 4 données de dépendance
- B- 5 données de dépendance
- C- 6 données de dépendance**
- D- 7 données de dépendance

38) KB fillette de 18 mois, présente des pleurs incessants, et un refus de téter. Elle n'est pas à jour de ses vaccins. A l'examen physique, la fontanelle antérieure est bombée, et la température de 40° Celsius. KB souffre d'une méningite purulente. KB a :

- A- 3 données d'indépendance**
- B- 4 données d'indépendance
- C- 5 données d'indépendance
- D- 6 données d'indépendance

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Nom : KB • Sexe : féminin • Age : 18 mois |
|---|

39) KB fillette de 18 mois, présente des pleurs incessants, et un refus de téter. Elle n'est pas à jour de ses vaccins. A l'examen physique, la fontanelle antérieure est bombée, et la température de 40° Celsius. KB souffre d'une méningite purulente.

L'interprétation des données de KB met en évidence :

- A- Infection bactérienne des méninges et absence de protection**
- B- Hypertension intracrânienne fébrile et absence de protection
- C- Trouble de la régulation thermique et menace sur l'intégrité physique et psychique
- D- Immaturité cérébrale et cutanée et absence de protection

40) KB fillette de 18 mois, présente des pleurs incessants, et un refus de téter. Elle n'est pas à jour de ses vaccins. A l'examen physique, la fontanelle antérieure est bombée, et la température de 40° Celsius. KB souffre d'une méningite purulente. L'un de vos objectifs de soins est :

A- KB doit être capable dans une heure de ramener sa température dans les limites de la normale

B- doit être capable dans une heure d'avoir une pression intracrânienne dans les limites de la normale

C- KB doit être capable dans une heure d'avoir une absence de bactéries dans son liquide cébrospinal

D- KB doit être avoir dans une heure d'avoir un carnet de vaccination à jour et de ne plus pleurer

41) Les propositions suivantes sont des examens paracliniques à prescrire devant une fièvre aigue, sauf une. Cochez cette proposition

A- Examen cyto bactériologique des urines

B- Intradermoréaction à la tuberculine

C- Goutte épaisse/frottis sanguin

D- Hémoculture répétée

42) La quantité de SRO à fournir, selon le plan A de réhydratation, pour le traitement à domicile du nourrisson faisant la diarrhée est :

A- 500 ml / jour

B- 1000 ml / jour

C- 1500 ml / jour

D- 2000 ml / jour

43) Les signes généraux de dangers dans la PCIMNE sont :

A- L'hyperthermie

B- La léthargie

C- La somnolence

D- L'hypoglycémie

Choisir la bonne réponse

44) Dans la PCIMNE, l'agent de santé conseille la mère en :

A- La saluant

B- La félicitant

C- Répétant ses mots

Choisir la bonne réponse

45) Les différentes couleurs de bandes de la PCIMNE sont :

A- La bande verte

B- La bande jaune

C- La bande violette

D- La bande rose

Choisir la mauvaise réponse

46) Les principaux symptômes dans la PCIMNE sont :

A- Les vomissements

B- La toux

C- Le rhume

D- Les problèmes dentaires

Choisir la bonne réponse

47) Lors du traitement dans la PCIMNE, les principes suivants sont à respecter :

A- La gratuité

B- La rapidité

C- Amélioration de l'accessibilité financière

D- La source de revenu des parents

Choisir la bonne réponse

48) Le meilleur moment pour commencer l'allaitement après la naissance est :

A- Dans les 6 heures

B- Dès le retour à la maison

C- Dans la première heure

D- Dès le lendemain

49) Vous recevez aux urgences pédiatriques pour des convulsions, PM pesant 17 kg. La dose journalière de Diazépam à ne pas dépasser chez PM est :

A- 51 mg / jour

B- 5,1 mg / jour

C- 8,5 mg / jour

D- 17 mg / jour

Dose journalière : 3mg/Kg

1Kg → 3mg

17Kg → 51mg

50) Les propositions suivantes sont des paramètres de surveillance de la croissance somatique de l'enfant, sauf une. Cochez cette proposition :

A- Le périmètre crânien

B- La taille

C- La fontanelle

D- Le périmètre brachial

51) PM, 14 mois, est amené par sa mère inquiète pour absence d'éruption dentaire :

A- Je recommande à la mère de consulter un dentiste

B- Je prescris à la mère un traitement à base de Fluor

C- Je rassure la mère et lui donne un rendez-vous pour la surveillance

D- Je réfère la mère dans un centre de référence

52) Le nouveau-né est dit grand prématuré lorsque l'âge gestationnel est compris dans l'intervalle suivant :

A- [33 - 35[

B- [28 - 33[

C- [28 - 33]

D-]33 - 35]

53) Les propositions suivantes sont des maladies qui influencent le développement psychomoteur de l'enfant, sauf une. Cochez cette proposition.

A- Phénylcétonurie

B- Maladie de Kawasaki

C- Ictère nucléaire

D- Méningite purulente

54) A l'âge de 3 ans, un enfant avec un développement psychomoteur normal a l'acquisition suivante :

A- S'habille seul, mais ne met pas les boutons

B- Copie un carré

C- Fait de la bicyclette

D- Nomme les jours de la semaine

55) Accompagner chez le neurologue, un enfant qui présente une anomalie dans le développement psychomoteur est un soin :

A- Délégué

B- Collaboration

C- Conseil et prévention

D- Propres

56) AB est né à 11h51min. Les propositions suivantes sont des gestes à réaliser chez AB entre 11h52min et 12h51min vie, sauf une. Cochez cette proposition.

A- Prendre la température de AB quatre fois

B- Surveiller la respiration de AB

C- Aider la mère à mettre au sein AB

D- Prendre les mensurations de AB

57) A 5 minutes de vie, le nouveau-né VI était totalement cyanosé, une hypotonie généralisée, une respiration irrégulière avec des geignements. La fréquence cardiaque était à 89 battements par minute. Son score d'Apgar à 1 minute de vie était de :

A- 2

B- 3

C- 4

D- 5

58) Durant la première minute de vie, les gestes suivants sont réalisés chez le nouveau-né qui pleure et respire :

a) Essuyer le bébé avec un linge sec ; b) Porter un bonnet au bébé ; c) Déposer le sur un linge sec posé sur le ventre de la mère ; d) Remplacer le linge mouillé par un linge sec ; e) Vérifier la respiration ; f) Clamper et sectionner le cordon.

Cochez la proposition, correspondant à l'ordre normal dans lequel ces gestes sont réalisés.

A- c; a; d; b; e; f

B- d; a; f; e; c; b

C- a; b; c; d; e; f

D- f; e; a; d; b; c

59) Les soins propres dans la prise en charge des vomissements chez l'enfant sont les suivants, sauf un. Cochez ce soin :

A- Nettoyer l'enfant

B- Aider à alimenter l'enfant

C- Administrer du vogalène

D- Surveiller l'enfant

60) La complication redoutable à prévenir en urgence chez tout enfant sévèrement malnutri est

A- Hypoglycémie

B- Déshydratation

C- Anémie sévère

D- Défaillance cardiaque.

INFAS-ANTENNE ABIDJAN

VERSION A

EVALUATION SANTE PUBLIQUE LICENCE 3

SUJET N°1

Durée : 60 MN

I. QUESTIONS A CHOIX DOUBLE (QCD) :

Pour les questions numérotées de 1 à 15, cochez la lettre correspondante à la réponse correcte (A= Vrai et B= Faux), sachant qu'une réponse correcte vaut +1 point et une réponse incorrecte -1 point et aucune réponse 0 point.

1. Le monitoring des activités peut être comparé au suivi des activités. **A L2p74**
2. Les sources de données de la disponibilité des ressources sont les registres de vaccination. **B L3p11**
3. Le taux général de fécondité (TGF) est un indicateur démographique. **A**
4. Les déterminants de couverture sont aussi appelés critères dans le cadre du monitoring. **A L2p75**
5. Le taux de mortalité maternelle est une proportion. **B L1p83**
6. En Côte d'Ivoire, le monitoring des activités se fait au moins deux fois dans l'année. **B L2p74**
7. Les indicateurs de santé à tendance négative mesurent la maladie et les décès. **A L2p28**
8. Le calcul de l'accessibilité géographique dans le cadre du monitoring tient compte des populations résidant dans un rayon de 5km du centre et celles des villages ayant bénéficié d'au moins une stratégie avancée. **A**
9. Un Cas suspect de COVID-19, est une personne chez qui il y a apparition soudaine de fièvre et de toux avec ou sans anosmie. **A L2p72**
10. Sur le tracé du diagramme de couverture la ligne verticale héberge les valeurs des indicateurs calculés et la ligne horizontale les déterminants de couverture. **B L2p79**
11. L'accroissement annuel indique le mouvement général de la population sur une année. **A**
12. Pour réaliser un monitoring, deux éléments sont essentiels à savoir les déterminants de couverture et les indicateurs. **A L2p26**
13. La projection de population permet d'obtenir la population exacte d'une localité. **B L2p27**
14. Dans la mesure des déterminants de couverture, il est possible de calculer l'utilisation de service sans mesurer au préalable l'accessibilité géographique. **A**
15. L'approche épidémiologique a pour objet le malade. **B L1p82**

II. QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES (QCM) :

Elles sont numérotées de 16 à 45 questions. Pour répondre à chacune de ces questions, cochez-la ou les case(s) correspondante(s) à la ou les bonnes réponses, en sachant qu'une réponse correcte vaut +1 point et une réponse incorrecte 0 point et aucune réponse 0 point.

16. Parmi les tâches suivantes, indiquez celle qui se déroule dans la zone d'entrée au cours d'une séance de vaccination : L3p60

- A. Le pointage sur les fiches
- B. Le remplissage des registres
- C. La vérification des carnets et des rendez-vous**
- D. L'administration du vaccin
- E. La fixation des rendez-vous

17. Quel est l'ordre normal des classifications de cas suivants en vue d'un diagnostic ? L2p64

- 1. cas confirmé.
- 2. cas probables
- 3. cas suspects

A. (1,2,3)

B. (2.3.1)

C. (3.2.1)

18. Identifier parmi les tâches suivantes, celles qu'il faut exécuter à l'évaluation d'une séance de vaccination. L3p63

- A. Compter le nombre de doses de chaque type de vaccin administré**
- B. Ranger les vaccins non utilisés
- C. Compter le nombre de doses restantes pour chaque type de vaccin**
- D. Etiqueter les flacons ouverts et réutilisables ;
- E. Etablir la liste de ceux qui n'ont pas répondu à leur rendez-vous.**
- F. Détruire les déchets.

19. Parmi les tâches exécutées lors d'une séance de vaccination, indiquez celles qui font partir de l'étape de l'enregistrement : L3p61

- A. Vérifier les carnets de santé mère/enfant documents de vaccination.
- B. Inscrire les informations de la cible dans le registre de vaccination ;**
- C. Informer les populations cibles sur les gestes à proscrire après un acte vaccinal
- D. Recenser tous les vaccins que le nourrisson peut recevoir :
- E. Noter les numéros de lot des différents vaccins.**
- F. Indiquer aux cibles les jours de rendez-vous.

20. L'éradication d'une maladie représente :

- A. L'ensemble des mesures visant à la réduction durable du nombre de nouveaux cas d'une maladie.
- B. L'ensemble des mesures visant à l'élimination totale de la maladie et de son germe**
- C. L'ensemble des mesures visant à la réduction durable du nombre de nouveaux cas, sans pour autant éradiquer la maladie.

21. L'accroissement annuel (AA) est égal :

- A. Population de départ + Population d'arrivée
- B. Population de départ - Population d'arrivée
- C. Population d'arrivée - Population de départ**

22. Parmi les propositions suivantes, cochez la population totale qui correspond à deux séances par semaine : L3p59

- A. De 8000 à 11999**

- B. De 4000 à 7999
- C. De 2000 à 3999
- D. De 0 à 1999

23. Parmi les pratiques à risques d'une injection, choisir celles à risques pour le client : (cocher les bonnes réponses) L3p65-66

- A. Récapuchonner les aiguilles
- B. Détacher l'aiguille avec la main
- C. Charger les seringues avec des doses multiples et faire des injections à plusieurs personnes.**
- D. Appuyer sur le point d'injection avec du matériel usagé ou le doigt.**
- E. Placer les aiguilles sur une surface et les transporter sur une certaine distance avant de les jeter.
- F. Réutiliser une seringue ou une aiguille**

24. A la fin d'une séance de vaccination que vous venez de réaliser, vous obtenez sur la fiche de pointage 25 femmes enceintes vaccinées du Td pour 40 attendues, la couverture vaccinale du vaccin Td est donc de :

- A. 72%
- B. 68,18%
- C. 62,50%**
- D. 16,50%

FE : Femmes Enceintes

$TCV = (\text{Nbre de FE vaccinées} / \text{Nbre de FE attendus}) \times 100$

$TCV = (25 / 40) \times 100 = 62,50\%$

ETUDE DE CAS N°1

Les données sanitaires du CSR d'AKOUNOUGBE, une localité située dans le district sanitaire d'ADIAKE, dans la région sanitaire du SUD-COMOE sont :

- La population au 01 Janvier 2022 : 49 650 habitants ;
- La population au 31 Décembre 2022 : 53 446 habitants ;
- Nombre de naissances vivantes pour l'année 2022 : 2 138
- Nombre total d'accouchements pour l'année 2022 est de 2 300 dont :
 - 2 000 accouchements effectués par la sage-femme
 - 200 accouchements effectués par l'accoucheuse traditionnelle du village
 - 100 accouchements à domicile
- Nombre d'accouchements attendus pour l'année 2022 : 2 672
- Nombre de cas de Paludisme pour l'année 2022 : 400 cas dont
- 257 décès répartis comme suit :
 - 105 chez les enfants de 0 à 11 mois
 - 70 chez les enfants de 1 à 4 ans et
 - 82 chez les adultes ;
- Nombre total de maladie pour l'année 2022 : 1925
- Nombre total de décès pour l'année 2022 : 457

Calculer les indicateurs de santé de la localité d'AKOUNOUGBE pour l'année 2022.

25. Le Taux d'Accouchement Assisté de la localité d'AKOUNOUGBE :

- A. 82,33%**
- B. 74,85%
- C. 86,08%
- D. 90,79%

$$TAA = \frac{\text{Nbre de femmes enceintes ayant été assistée pdt l'accouchement par un professionnel de santé ou par une accoucheuse traditionnelle}}{\text{Nbre d'accouchements attendus}} \times 100$$

$$TAA = \frac{2000 + 200}{2672} \times 100 = 82,33\%$$

26. La prévalence du paludisme de la localité d'AKOUNOUGBE est :

- A. 0,65%
- B. 1,13%
- C. 0,77%**
- D. 0,18%

$$TP = \frac{\text{Nbre de cas de paludisme}}{\frac{Pt \text{ ou } Pmoy}{Pf + Pd}} \times 100 \quad \left| \quad TP = \frac{400}{51548} \times 100 \right.$$

$$Pmoy = \frac{2}{53446 + 49650} = 51548 \quad \left| \quad TP = 0,77\% \right.$$

27. La population des enfants de 1 à 4 ans de la localité d'AKOUNOUGBE est :

- A. 9257 enfants**
- B. 10690 enfants
- C. 2673 enfants
- D. 2138 enfants

$$P (1 \text{ à } 4 \text{ ans}) = 17,32\% \times Pt = 17,32\% \times 53446 = 9257$$

28. Le Taux Brut de Morbidité de la localité d'AKOUNOUGBE est :

- A. 8,40%
- B. 3,73%**
- C. 3,88%
- D. 3,85%

$$TBMorbidité = \frac{\text{Nbre de maladie}}{Pmoy} \times 100$$

$$TBMorbidité = \frac{1925}{51548} \times 100 = 3,73\%$$

29. Le Taux d'Accroissement Naturel de la localité d'AKOUNOUGBE est :

- A. 4,15%
- B. 3,57%**
- C. 5,03%
- D. 0,90%

$$TAN = \frac{\text{Naissance} - \text{Décès}}{Pmoy} \times 100 = \frac{2300 - 457}{51548} \times 100 = 3,57\%$$

30. Le Taux de mortalité juvénile du paludisme de la localité d'AKOUNOUGBE est :

- A. 0,75%**
- B. 1,13%
- C. 0,19%
- D. 0,18%

$$TMJ = \frac{\text{Décès des enfants 1 à 4 ans}}{\text{Nbre d'enfants 1 à 4 ans}} \times 100$$

$$TMJ = \frac{70}{9257} \times 100 = 0,75\%$$

ETUDE DE CAS 2

Le tableau ci-dessous présente la répartition des villages desservies par le Centre de Santé Rural du village A (CSRA) en fin d'année 2022. Les recettes brutes pour le dernier semestre de l'année du centre sont estimées à 1 500 000 f CFA et la vente des médicaments essentiels à 350.000f CFA. Les dépenses obligatoires représentent 1/5 des ressources propres et les dépenses de fonctionnement local sont égales à 500000F

N°	Localités	Populations (habitants)	Distances par rapport CSR (km)
1.	A	4580	0
2.	A1	1500	8
3.	A2	710	16,5
4.	A3	3250	5
5.	A4	1100	3,5

6.	A5	1335	10
7.	A6	985	4

QUESTIONS

Consignes

A partir des informations du CSRA, hachurez l'alvéole de la lettre correspondant à la bonne réponse. Une réponse juste : 01 point, une réponse fausse ou pas de réponse : 0 point

31. Quelle est la population de l'aire sanitaire en fin d'année 2022 ?

- A. 13460 habitants
- B. 15270 habitants
- C. 17570 habitants
- D. 13440 habitants

$$Pt = 4580 + 1500 + 710 + 3250 + 1100 + 1335 + 985$$

$$Pt = 13460 \text{ hbts}$$

32. Quelle est l'estimation de la population pour une stratégie fixe ?

- A. 710 habitants
- B. 2835 habitants
- C. 6085 habitants
- D. 6665 habitants

$$\text{Stratégie fixe} = \text{moins de 5km}$$

$$P_{SF} = 4580 + 1100 + 985 = 6665 \text{ hbts}$$

33. Quelle est l'estimation de la population pour une stratégie avancée ?

- A. 2835 habitants
- B. 6085 habitants
- C. 6665 habitants
- D. 710 habitants

$$\text{Stratégie avancée} = \text{entre 5 – 15km}$$

$$P_{SA} = 1500 + 3250 + 1335 = 6085 \text{ hbts}$$

34. Quelle est l'estimation de la population pour une stratégie mobile ?

- A. 4580 habitants
- B. 2835 habitants
- C. 6085 habitants
- D. 710 habitants

$$\text{Stratégie mobile} = \text{sup 15km}$$

$$P_{SM} = 710 \text{ hbts}$$

35. Quelle est l'estimation de la population cible des enfants de 12 à 23 mois de l'aire sanitaire de CSR A ?

- A. 284 enfants
- B. 447 enfants
- C. 825 enfants
- D. 918 enfants

$$\text{Nbtre d'enfants 12 à 23 mois} = 3,32\% \times Pt$$

$$\text{Nbtre d'enfants 12 à 23 mois} = 3,32\% \times 13460 = 447$$

36. Quelle est l'estimation de la population cible des femmes enceintes pour une stratégie avancée ?

- A. 305 femmes enceintes
- B. 229 femmes enceintes
- C. 35 femmes enceintes
- D. 496 femmes enceintes

$$\text{Pop en stratégie avancée} = 6085$$

$$\text{Pop des femmes enceintes} = 5\% \times 6085$$

$$\text{Pop des femmes enceintes} = 305$$

37. La quantité théorique mensuelle du vaccin Tétanos/diphtérie du CSRA pour la stratégie avancée si un flacon contient 20 doses est :

- A. 2 flacons
- B. 3 flacons
- C. 4 flacons
- D. 5 flacons**

$$BT = (PC \times OV \times NC \times FP \times P) / 12$$

$$BT = (305 \times 0,95 \times 3 \times 1,11 \times 1) / 12 = 81$$

1 flacon $\longrightarrow$ 20 doses

$X = 81/20 \longleftarrow$ 81 doses

X = 5 flacons

38. Quelle est la valeur du SPS payé au dernier semestre de la l'année 2022 par cette structure de santé ?

- A. 500 000 F
- B. 300 000 F**
- C. 150 000 F
- D. 50 000 F

$$SPS = 20\% \times RB$$

$$SPS = 20\% \times 1500000$$

$$SPS = 300000$$

39. Le total des dépenses du CSRA s'élèvent à :

- A. 150 000F
- B. 275 000F
- C. 675 000F**
- D. 450 000F

$$\text{Total des dépenses} = 45\% \times RB$$

$$\text{Total des dépenses} = 45\% \times 1500000$$

$$\text{Total des dépenses} = 675000$$

40. Le montant des ressources propre est de :

- A. 200 000F
- B. 450 000F
- C. 550 000F
- D. 825 000F**

$$RP = 55\% \times RB$$

$$RP = 55\% \times 1500000$$

$$RP = 825000$$

41. Les dépenses obligatoires locale (DO) sont égales à :

- A. 200 000F
- B. 140 000F
- C. 440 000F
- D. 165 000F**

$$DO = (1/5) \times RP$$

$$DO = (1/5) \times 825000$$

$$DO = 165000$$

42. Le montant de la somme à budgétiser est de :

- A. 825 000F
- B. 650 000F
- C. 665 000F**
- D. 200 000F

$$SAB = DO + DFL$$

$$SAB = 165000 + 500000$$

$$SAB = 665000$$

43. La somme allouée aux imprévus et frais de réparation éventuelle (immeuble) est :

- A. 99 000F
- B. 75 000F**
- C. 54 750F
- D. 37 000F

$$\left. \begin{array}{l} \text{Imprévus} = 5\% \times DFL = 5\% \times 500000 = 25000 \\ \text{Immeuble} = 10\% \times DFL = 10\% \times 500000 = 50000 \end{array} \right\} 75000$$

44. La recette issue du cout des actes de santé est de :

- A. 275 000F
- B. 315 000F**
- C. 475 000F
- D. 550 000F

$$SAB = RVME + RCAS$$

$$RCAS = SAB - RVME = 665000 - 350000 = 315000$$

45. Quelle est la valeur de l'intéressement du personnel au dernier semestre de l'année 2022 par cette structure de santé ?

A. 225000F

B. 150000F

C. 300000F

$$IP = 15\% \times RB$$

$$IP = 15\% \times 1500000$$

$$IP = 225000$$

INFAS-ANTENNE ABIDJAN

VERSION A

EVALUATION SANTE PUBLIQUE LICENCE 3 SUJET N°2

Durée : 60 MN

QUESTIONS A CHOIX DOUBLE (QCD) :

Pour les questions numérotées de 1 à 15, cochez la lettre correspondante à la réponse correcte (A= Vrai et B= Faux), sachant qu'une réponse correcte vaut +1 point et une réponse incorrecte -1 point et aucune réponse 0 point.

1. Le monitoring est une activité qui mesure les résultats. **B L2p74**
2. Un cas confirmé de fièvre jaune est un phénomène de masse. **A L2p70**
3. Le monitoring des activités permet de réadapter les stratégies identifiées pour corriger les goulots d'étranglement. **A L2p75**
4. Le taux de létalité permet d'évaluer la qualité de la prise en charge des malades. **A L2p30**
5. Dans le monitoring d'une activité le respect de l'alignement des déterminants de couverture de la population cible à la couverture effective est obligatoire. **A L2p75**
6. Les décès influencent l'accroissement naturel. **A L2p26**
7. Les périodes du monitoring exprimées en jour pour l'année sont de 182 et 183. **A L2p74**
8. La couverture adéquate est le dernier dans la hiérarchisation des déterminants de couverture. **B L2p75**
9. L'un des buts de l'épidémiologie est de mesurer les risques individuels et collectifs. **A L2p80**
10. Dans le monitoring des activités, les indicateurs ne mesurent pas les déterminants de couverture. **B L2p75**
11. Le Seuil épidémique est la valeur attendue de cas qui une fois franchi doit attirer l'attention du personnel sur l'émergence d'un phénomène épidémique nécessitant des interventions urgentes. **A L2p64**

12. En Côte d'Ivoire, le monitoring se fait dans les mois de Juin pour les activités du 01 Juin au 30 Novembre d'une année donnée et Décembre pour les activités du 01 Décembre d'une année X au 31 Mai de l'année X+1. **B L3p12**
13. L'accroissement annuel ignore l'émigration. **B L2p26**
14. L'utilisation des services a pour sources de données la cartographie de l'aire sanitaire. **B L3p11**
15. L'approche clinique recherche les causes d'apparition de la maladie chez le sujet. **A L1p82**

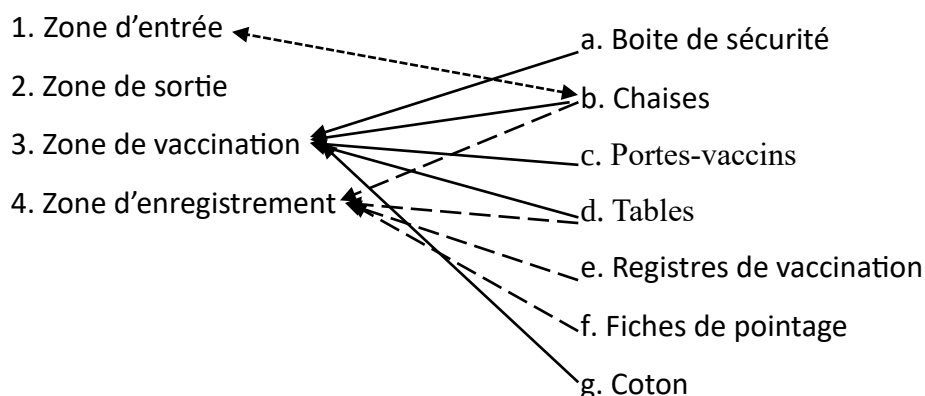
II. QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES (QCM) :

Elles sont numérotées de 16 à 45 questions. Pour répondre à chacune de ces questions, cochez-la ou les case(s) correspondante(s) à la ou les bonnes réponses, en sachant qu'une réponse correcte vaut +1 point et une réponse incorrecte 0 point et aucune réponse 0 point.

2. L'espace réservé à la vaccination doit être : (Cocher les trois bonnes réponses) **L3p60**

- A. Facile d'accès pour les utilisateurs ;**
- B. Aménagé de sorte à éviter l'agglutination des populations ;**
- C. Situé dans un endroit exposé directement au soleil, à la pluie et à la poussière ;
- D. Incommode pour l'agent de santé qui prépare et administre le vaccin ;
- E. Suffisamment calme pour une bonne communication avec les femmes.**

3. La liste ci-dessous contient les zones d'un poste de vaccination et les dispositions des matériels de vaccination. **L3p60**



Trouvez les bonnes combinaisons entre les zones et les dispositions des matériels de vaccination

- A. (1, b, d)
D. (3, a, b, d, c, g)

- B. (2, f, a)
 E. (4, g)

- C. (1, b)**
F. (4, b, d, e, f)

4. PNLT signifie : **L1p37**

- A-Programme National de Lutte contre la Tuberculose**
- B-Programme National de lutte contre la Trypanosomiose
- C-Programme National de Lutte contre les Traumatismes

19. Quelles sont les deux phases qui interviennent dans le processus d'évacuation des ordures ménagères. L1p65-66

A- L 'élimination

B- Le stockage

C- L 'incinération

D- Le ramassage

E- Le compostage

F- Le traitement.

20. Selon les propositions suivantes, choisissez deux méthodes de lutte contre les moustiques adultes. L1p72

A. Dormir sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide

B. Comblir les flaques d'eau

C. Enlever tous les récipients pouvant contenir de l'eau

D. Drainer les endroits où l'eau peut stagner

E. Déposer des grillages aux portes et aux fenêtres

21. On distingue trois types de dispositif pour assurer la sécurité des injections : lesquels ? L3p65

A. Dispositif de gestion

B. Dispositif d'injection

C. Dispositif de collecte des déchets

D. Dispositif d'hygiène

E. Dispositif de destruction des déchets issus des activités de soins

F. Dispositif de sécurité

22. Parmi les propositions suivantes, cochez la population totale qui correspond à une séance par semaine : L3p59

A. De 8000 à 11999

B. De 4000 à 7999

C. De 2000 à 3999

D. De 0 à 1999

23. Parmi les pratiques à risques d'une injection, choisir celles à risques pour l'agent de santé : (cocher les bonnes réponses). L3p66

A. Recapuchonner les aiguilles

B. Détacher l'aiguille avec la main

C. Charger les seringues avec des doses multiples et faire des injections à plusieurs personnes.

D. Appuyer sur le point d'injection avec du matériel usagé ou le doigt

E. Placer les aiguilles sur une surface et les transporter sur une certaine distance avant de les jeter.

F. Réutiliser une seringue ou une aiguille

24. A la clôture d'une séance de vaccination que vous venez de réaliser, vous obtenez sur la fiche de pointage 75 femmes enceintes vaccinées du Td pour 110 attendues, alors la couverture vaccinale du vaccin Td est donc de :

A. 72,14%

B. 68,18%

C. 62,50%

D. 25,50

FE : Femmes Enceintes

$$TCV = \left(\frac{\text{Nbre de FE vaccinées}}{\text{Nbre de FE attendus}} \right) \times 100$$

ETUDE DE CAS N°1

Les données sanitaires du CSR d'AKOUNOUGBE, une localité située dans le district sanitaire d'ADIAKE, dans la région sanitaire du SUD-COMOE sont :

- La population au 01 Janvier 2022 : 49 650 habitants ;
- La population au 31 Décembre 2022 : 53 446 habitants ;
- Nombre de naissances vivantes pour l'année 2022 : 2 138
- Nombre total d'accouchements pour l'année 2022 est de 2 300 dont :
 - 2 000 accouchements effectués par la sage-femme
 - 200 accouchements effectués par l'accoucheuse traditionnelle du village
 - 100 accouchements à domicile
- Nombre d'accouchements attendus pour l'année 2022 : 2 672
- Nombre de cas de Paludisme pour l'année 2022 : 400 cas dont
- 257 décès répartis comme suit :
 - 105 chez les enfants de 0 à 11 mois
 - 70 chez les enfants de 1 à 4 ans et
 - 82 chez les adultes ;
- Nombre total de maladie pour l'année 2022 : 1925
- Nombre total de décès pour l'année 2022 : 457

Calculer les indicateurs de santé de la localité d'AKOUNOUGBE pour l'année 2022.

25. Le Taux Brut de Natalité de la localité d'AKOUNOUGBE :

- A. 4,14%
- B. 4,31%
- C. 4,00%
- D. 9,33%

26. Le Taux de mortalité infantile du paludisme de la localité d'AKOUNOUGBE est :

- A. 4,91%
- B. 0,20%
- C. 5,14%
- D. 9,99%

27. Le Taux Général de Fécondité de la localité d'AKOUNOUGBE est :

- A. 25%
- B. 20%
- C. 2%
- D. 0,25%

28. Le Taux d'Accroissement Annuel de la localité d'AKOUNOUGBE est :

- A. 7,64%
- B. 4,15%
- C. 5,03%
- D. 3,26%

29. Taux Brut de Mortalité de la localité d'AKOUNOUGBE est :

- A. 0,98%
- B. 0,92%
- C. 0,88%**
- D. 0,19%

30. Taux de Létalité du paludisme de la localité d'AKOUNOUGBE pour l'année 2022 est :

- A. 64,25%**
- B. 62,01%
- C. 61,94%
- D. 51,81%

ETUDE DE CAS N°2

Le tableau ci-dessous présente la répartition des villages desservies par le Centre de Santé Rural du village A (CSRA) en fin d'année 2023. Les ressources brutes pour le dernier semestre de l'année du centre sont estimées à 1800 000 f CFA. La vente des médicaments essentiels à 400 000f CFA. Les dépenses obligatoires représentent 1/5 des ressources propres.

N°	Localités	Populations (habitants)	Distances par rapport CSR (km)
8.	A	5000	0
9.	B	1500	10
10	C	690	16
11	D	2950	5
12	E	1100	2,5
13	F	1215	15
14	G	985	4

QUESTIONS

Consignes

A partir des informations du CSRA, cochez la lettre correspondant à la bonne réponse.

Une réponse juste : 01 point, une réponse fausse ou pas de réponse : 0 point

31. Quelle est la population de l'aire sanitaire en fin d'année 2023 ?

- A. 12750 habitants
- B. 11535 habitants
- C. 8935 habitants
- D. 13440 habitants**

32. Quelle est la population du bassin de desserte du CSRA en fin d'année 2023 ?

- A. 12750 habitants**
- B. 11535 habitants
- C. 8935 habitants
- D. 13440 habitants

33. Quelle est l'estimation de la population pour une stratégie fixe ?
- A. 3405 habitants
 - B. 5665 habitants
 - C. 7085 habitants
 - D. 10035 habitants
34. Quelle est l'estimation de la population pour une stratégie mobile ?
- A. 3405 habitants
 - B. 1215 habitants
 - C. 1905 habitants
 - D. 690 habitants
35. Quelle est l'estimation de la population cible des jeunes filles de 9 ans du bassin de desserte du CSRA ?
- A. 167
 - B. 238
 - C. 215
 - D. 250
36. Quelle est l'estimation de la population cible des enfants de 0 à 23 mois pour une stratégie avancée
- A. 227
 - B. 387
 - C. 409
 - D. 178
37. La quantité théorique mensuelle du vaccin contre le papilloma virus humain du bassin de desserte du CSRA est : (supposons que toutes les jeunes filles sont séronégatives)
- A. 14 doses
 - B. 18 doses
 - C. 20 doses
 - D. 21 doses
38. Quelle est la valeur du FAS payé au cours de l'année 2022 par cette structure de santé. ?
- A. 500 000 F
 - B. 180 000 F
 - C. 50 000 F
 - D. 110 000 F
39. Le total des dépenses du CSRA s'élèvent à
- A. 200 000F
 - B. 450 000F
 - C. 810 000F
 - D. 610 000F
40. Le montant des ressources propre est de :
- A. 450 000F
 - B. 590 000F

C. 990 000F

D. 1 000 000F

41. Le montant de la somme à budgétiser est de :

A. 990 000F

B. 590 000F

C. 450 000F

D. 1 000 000F

42. La recette du COGES est de :

A. 990 000F

B. 590 000F

C. 450 000F

D. 1 000 000F

43. Les dépenses obligatoires locale (DO) sont égales à :

E. 200 000F

F. 212 700F

G. 198 000F

H. 90 000F

44. Les dépenses de fonctionnement local :

A. 792 000F

B. 403500F

C. 340000F

D. 440000F

45. La somme allouée aux autres dépenses en dehors des imprévus et des frais de réparation éventuelle (immeuble) est :

A. 993 000F

B. 342 975F

C. 289 500F

D. 673 200F

ABOISSO

EXAMEN BLANC DIPLÔME D'ETAT N°2
ABOISSO 16 OCTOBRE 2025
CHIRURGIE 1H30
VERSION A

I-QUESTIONS À CHOIX DOUBLE (QCM)

- ❖ Choisir la ou les bonne (s) réponse (s)
- Un élément de réponse juste = +1pt
- Un élément de réponse fausse = 0pt

1- Indiquer deux (02) causes d'ischémie de l'AVC parmi celles citées ci-dessous

- A. Malformations vasculaires
- B. Artériosclérose diabétique
- C. Embolies artérielles cérébrales

- D. Traumatismes crâniens
- E. Hypertension artérielle

2- Dans la clinique de l'hémiplégie en cas d'AVC on observe : (Cocher les 2 bonnes réponses)

- A. Une raideur de la nuque
- B. Une paralysie faciale
- C. Un signe de Kernig
- D. Des vomissements
- E. Une hypotonie des membres paralysés

3- Un parmi les examens ci-dessous énumérés peut affirmer ou infirmer la présence d'un hématome cérébral en cas d'AVC : Lequel ?

- A. Les angiographies
- B. L'Echoencéphalogramme
- C. L'Electroencéphalogramme.

4- Un encombrement trachéobronchique peut faire suite dans les soins à un malade trachéotomisé : (Cocher la bonne réponse). L3p14(Doc MT SI SPECIALISE)

- A. Aux fractures multiples des côtes
- B. A une tumeur maligne
- C. A un spasme de la glotte (tétanos).

} Lésion laryngées

5- Dans la technique de soin à un malade trachéotomisé, relever le geste nécessaire à faire après l'intervention parmi ceux indiqués ci-dessous : L3p14(Doc MT SI SPECIALISE)

- A. Préparer le matériel d'aspiration → pdt l'intervention
- B. Nettoyer la canule interne plusieurs fois dans la journée
- C. Mettre le malade dans une position facilitant la respiration. → Avant l'intervention

6- Indiquer deux (02) accidents allergiques parmi ceux énumérés ci-dessous de la transfusion sanguine.

- A. Fébricule
- B. Eruption cutanée
- C. Douleurs dorsolombaires
- D. Dyspnée
- E. Sensation d'angoisse.

7- Le rôle de l'infirmier dans le traitement préventif du malade atteint d'une insuffisance rénale aigue consiste à : (Cacher la bonne réponse).

- A. Faire un remplissage vasculaire sous contrôle de la diurèse.
- B. Appliquer le traitement anti-infectieux prescrit par le médecin.
- C. Corriger les états de choc.

8- Indiquer un geste infirmier le jour de l'examen dans la ponction biopsique du Foie

A. Vérifier le dossier du malade s'il est au complet

B. Rassurer le malade

C. L'informer sur le but de l'examen.

9. Enoncer deux (02) causes en faveur d'une dyspnée chez l'enfant parmi celles énumérées ci-dessous : L3p5(Doc MT SI SPECIALISE)

A. Cancer du larynx → chez l'adulte

B. Laryngite aiguë

C. Paralysie des cordes vocales → chez l'adulte

D. Tumeur laryngée

E. Obstruction du larynx.

10- Les thèmes ci-dessous mentionnés sont abordés dans le rangement d'une armoire à pharmacie exceptée deux (02) : Lesquels ?

A. La tolérance du médicament

B. La surveillance clinique

C. Le coût et la disponibilité du médicament

D. Les règles d'asepsie.

E. L'ordonnance est individuelle.

11- Un rôle de l'infirmier dans la surveillance du malade atteint d'insuffisance rénale aiguë pour son traitement symptomatique.

A. Limiter les apports liquidiens au maximum 500 cc par jour.

B. Eviter une alimentation trop carnée.

C. Peser le malade.

12- L'hémianopsie est : (Cocher la bonne réponse)

A. La perte de la vue dans une moitié du champ visuel

B. La perte de la compréhension et de l'usage du langage parlé ou écrit

C. La perte de la mémoire :

13- La leucémie est : (Cocher la bonne réponse)

A. La destruction des globules rouges par éclatement.

B. L'anémie par excès d'hémolyse

C. La maladie due à la prolifération des globules blancs dans le sang :

14- Dans le système A.B.O. on distingue des sujets : (Cocher la bonne réponse),

A. A, B, AB et O

B. A, AB et O

C. A, B, A.B.O

15- Le traitement de l'AVC est : (Cocher la bonne réponse)

A- A la fois symptomatique et étiologique

B. Essentiellement étiologique

C. Essentiellement symptomatique.

16- Indiquer une étiologie de la hernie discale parmi celles citées ci-dessous :

A. Tumeurs bénignes

B. Lésions traumatiques

C. Lésions articulaires.

17. La contamination du Mal de Pott se fait essentiellement : (cocher la bonne réponse)

A. Par la voie endogène,

L3p31(Doc neurochirurgie)

B. Par la voie exogène.

C. Par la voie hématogène

18. Deux (02) signes physiques du Mal de Pott parmi ceux indiqués ci-dessous.

A. Asthénie

B. Gibbosité

L3p32(Doc neurochirurgie)

C. Raideur marquée du rachis

D. Fièvre vespérale

F. Altération de l'état général.

19. Deux (02) buts du traitement du Mal de Pott parmi ceux indiqués ci-dessous :

A. Eviter les récurrences,

B. Préserver la stabilité rachidienne

L3p34(Doc neurochirurgie)

C. Calmer la douleur

D. Lever l'irritation rachiculaire.

E. Eviter les complications.

20. Lequel des trois (03) hématomes cités ci-dessous, présente l'intervalle libre le plus long.

A. Hématome extradural

B. Hématome intracérébral

C. Hématome sous dural,

21. Les étiologies énumérées ci-dessous sont consécutives aux fractures du rachis, exceptée une ; laquelle ?

L3p13(Doc neurochirurgie)

A. Chute d'un lieu élevé

B. Accident de la voie publique

C. Traumatisme balistique

D. Accident de travail.

22. La douleur déclenchée à la palpation des massifs articulaires postérieurs au cours de la sciatalgie est : (cocher la bonne réponse).

L3p28(Doc neurochirurgie)

A. La lombalgie

B. Le signe de la sonnette

C. La manœuvre de Lasègue

23. Le signe paraclinique en cas de fracture du rachis permet d'évaluer l'importance du comblement du canal vertébral, de mêmes que les lésions médullaires parmi ceux indiqués ci-dessous ; Lequel ?

L3p17(Doc neurochirurgie)

A. La radiographie du rachis dorsolombaire

B. L'imagerie par résonnance magnétique (IRM)

C. La tomodensitométrie (TDM) ou scanner.

24. L'examen de la motricité dans les fractures du rachis objective chez le patient : (cocher les 2 bonnes réponses)

L3p16(Doc neurochirurgie)

A. Une anesthésie

B. Une paraplégie

C. Une paresthésie

D. Une parésie

E. Une hypoesthésie

25. Les critères de MASTER s'observent dans la classification des traumatismes crâniens : (cocher la bonne réponse)

L3p5(Doc neurochirurgie)

A. Graves

B. Bénins et modérés

C. Bénins

D. Graves et modérés :

26-Indiquer l'étiologie commune au traumatisme du thorax et à la fracture de l'humérus, parmi celles énumérées ci-dessous.

A. Choc direct

B. Accident de la voie publique

C. Accident de sport

27- Le traitement en cas de syndrome de Wolkman dans les fractures des deux (02) de l'avant-bras consiste à : (Cocher la bonne réponse)

A. Déchoquer le blessé

B. Faire une découverte de l'artère humérale

C. Faire un plâtre brachio-palmaire.

28- Deux (02) éléments ci-dessous indiqués obéissent aux soins préopératoires au centre chirurgical en cas de fractures de la diaphyse du fémur ; Lesquels ? L2p45(Doc chirurgie)

A. Surveillance de l'état de conscience

B. Surveillance des culots globulaires

C. Préparation de la chambre du malade

D. Préparation du champ opératoire

E. Surveillance de la thérapeutique.

29. Indiquer parmi les fractures ci-dessous citées, celle qui représente la forme type d'une fracture fermée de la jambe. L2p51(Doc chirurgie)

A. Fracture transversale

B. Fracture longitudinale

C. Fracture comminutive.

30. Enumérer les deux (02) complications secondaires parmi celles indiquées ci-dessous des fractures des 2 os de la jambe : L2p51(Doc chirurgie)

A. Œdème malléolaire

B. Embolies pulmonaires (phlébites)

C. Atteinte tibio-tarsienne avec ankylose

D. Hydarthrose réactionnelle

E. Décalage entraîne une déformation de la marche.

31- Les complications indiquées ci-dessous sont secondaires aux traumatismes du bassin exceptée une ; Laquelle ? L2p68(Doc chirurgie)

A. Lésion de l'urètre

B. Infection

C. Thromboembolie

32- La lutte contre la détresse circulatoire obéit aux éléments ci-dessous cités, sauf un (01) ; Lequel ?

A. Ventilation par intubation trachéale

B. Surveillance de la pression veineuse centrale

C. Prélèvements sanguins.

33. Ces différentes positions variables sont celles de L'appendicite sauf deux (02), lesquelles ?

A. Retro sternale

B. Latéro-coecale

L2p106(Doc chirurgie)

C. Sous hépatique

D. Entéro-coecale

E. Retrocoecale

34- Les formes évolutives de l'appendicite aigue sont en faveur (choisir les 2 bonnes réponses) : L2p110(Doc chirurgie)

A. Cholécystite aigue

B. Abscess appendiculaire

C. Stercorite

D. Pyélonéphrite droite

E. Péritonite appendiculaire.

35-Les objectifs des soins infirmiers pour le client qui doit subir une appendicectomie sont les suivants sauf un (01), lequel ? L2p113(Doc chirurgie)

A. Apporter un soulagement physique pendant la période périopératoire

B. Administrer le traitement prescrit

C. Réduire l'anxiété ou le stress précédant l'opération en fournissant des informations au client sur la période périopératoire.

II- QUESTIONS A CHOIX DOUBLE (QCD)

❖ Choisir A = VRAT, B = FAUX

- Une réponse juste équivaut à +0, 5pt
- Une réponse fausse équivaut à - 0,5pt
- Une absence de réponse = 0pt.

36- L'hypertension artérielle est une cause d'hémorragie de l'AVC. **A**

37- L'échoencéphalogramme peut infirmer la présence d'un hématome cérébral chez le patient présentant un AVC. **A**

38- Dans la technique de soins à un malade trachéotomisé, la canule interne sera nettoyée plusieurs fois dans la journée avant l'intervention. **B** L3p15(Doc MT SI SPECIALISE) (après l'intervention)

39- L'intervention sur le cœur est une indication chirurgicale de la transfusion sanguine. **A**

40- On surveille le débit de la transfusion pour détecter un épanchement de sang dans une cavité naturelle dû à une rupture de vaisseaux. **A**

41- La chirurgie orthopédique est une indication majeure de la transfusion sanguine. **A**

42- L'abcès du foie est une indication à la ponction biopsique du foie. **B**

43- L'examen général du client fait partie de l'approche thérapeutique dans l'établissement en urgence d'un plan de soins valide en cas de dyspnée laryngée. **A** L3p6(Doc MT SI SPECIALISE)

44- Chez le patient atteint d'une insuffisance rénale aigue, le traitement curatif consiste à corriger les états de choc. **A**

45- Le sang est une suspension de cellules dans un liquide complexe appelé plasma. **A**

46- Le contenant renferme le parenchyme cérébral recouvert par 3 enveloppes dans le traumatisme crânien. **B** L3p2(Doc neurochirurgie) (le contenu)

47- Le coma d'emblée est un signe physique du traumatisme crânien. **B** L3p3(Doc neurochirurgie)

48- L'un des buts de la conduite thérapeutique en cas de traumatisme du thorax est d'éviter les complications. **A** L2p11(Doc Chirurgie)

49- Dans les signes de souffrance respiratoire, le sujet présente une lésion du nerf récurrent (trouble phonique). **A** L2p10(Doc Chirurgie)

50- La luxation incomplète est une subluxation. **A** L2p17(Doc Chirurgie)

51- En rétention chronique ou complète se traduit par l'impossibilité brutale et totale d'émettre des urines. **B** L2p162(Doc Chirurgie)

52- La hernie inguinale est la plus fréquente de toutes les hernies. **B** L2p93(Doc Chirurgie)

53- Dans l'appendicite aigue, la NFS montre une hyperleucocytose de 20.000ml. **B** L2p109(Doc Chirurgie)

54- Les occlusions inflammatoires peuvent rencontrer au cours des péritonites aigues ou chroniques. **A** L2p116(Doc Chirurgie)

55- L'urètre chez l'homme est un conduit de 8 à 9 cm de long et de 10 à 12 cm de diamètre. **B** L1p144(Doc Anatomie)

EXAMEN BLANC N°2 MEDECINE L3
IDE
INFAS ABOISSO 15 OCTOBRE 2025

VERSION A

I. QCD : (+1 réponse juste et -1 pour une réponse fausse)

- 1) En cas de traumatisme oculaire par projection d'un produit chimique, la mesure de l'acuité visuelle n'est pas indispensable. **B**
- 2) Face à toute brûlure causée par un agent caustique, le lavage doit être pratiqué en urgence. **A**
- 3) La trinitrine est administrée sublinguale. **A L3p1(Doc de Cardiologie)**
- 4) L'aspirine est utilisée dans angor stable. **A L2p18(Doc de médecine)**
- 5) L'héparine est utilisée dans angor stable. **B (Angor instable)**
- 6) L'angor instable apparaît progressivement. **B (apparaît brutalement)**
- 7) Le traitement des Cancers est basé sur la chimiothérapie et ou la radiothérapie. **A**
- 8) La radiothérapie est une méthode de traitement loco régional des cancers. **A**
- 9) Les éléments suivants sont toujours retrouvés chez tous les cancéreux : l'anxiété, la dépression. **A**
- 10) Dans les soins palliatifs il faut tenir compte seulement des besoins du patient et non ceux de sa famille. **B**
- 11) Le malade est à la diète absolue car souffre de troubles digestifs depuis 2 mois et a du sang dans les selles. Cette phrase est une donnée d'indépendance **B**
- 12) Le diaphragme n'est pas considéré comme une composante de l'appareil respiratoire. **B**
- 13) L'artère pulmonaire éjecte le sang non hématosé dans les poumons, jusqu'aux capillaires pulmonaires. **A (le sang non hématosé = le sang non oxygéné)**
- 14) La bronchectasie est un processus irréversible. **A**
- 15) La circulation systémique permet d'approvisionner les cellules en O₂ et de récupérer le CO₂ qu'elles produisent. **A**
- 16) L'artère aorte récupère le sang hématosé et l'envoie vers les tissus. **A (le sang hématosé = le sang oxygéné)**
- 17) La bronchoconstriction est une manifestation de la bronchite aigue. **A**
- 18) Le traitement de la crise d'asthme nécessite une antibiothérapie à base de bétalactamines ou de macrolides. **A L1p90 (Doc Sémio Médicale)**
- 19) Les mucolytiques sont utiles dans le traitement de la crise d'asthme. **A L1p90 (Doc Sémio Médicale)**
- 20) La cyanose est un signe de gravité de l'asthme. **A L1p91 (Doc Sémio Médicale)**
- 21) Les gaz du sang permettent d'analyser l'hématose (transformation du sang veineux en sang artériel au niveau des poumons). **A**
- 22) Le cancer broncho-pulmonaire est indissociable du cancer de la plèvre. **B L1p91 (Doc Sémio Médicale) (cancer du poumon)**
- 23) Un seul crachat avec un filet sanglant chez un fumeur est un signe évocateur de cancer. **B**
- 24) La Lutte contre le péril fécal est un moyen efficace de prévention de l'ankylostomose. **A L1p26(Doc maladie infectieuse)**
- 25) La Quinine est strictement contre-indiquée au premier trimestre de grossesse. **B L1p11(Doc maladie infectieuse)**
- 26) La Duodénite est une complication de l'ankylostomose. **A**
- 27) L'ingestion d'eau de boisson et d'aliments souillés par des œufs non embryonnés d'ascaris peut être à l'origine de l'ascaridiose. **B L1p21(Doc maladie infectieuse)**

- 28) L'acide folique stimule l'action de la sulfadoxine + pyriméthamine en cas de prise concomitante des dites molécules.
- 29) Le porteur sain de *Entamoeba histolytica* présente un syndrome dysentérique sévère avec ténésme et épreinte. **B**
- 30) En cas de paludisme grave l'artésunate injectable est administré à la dose de 2,4 mg/kg toutes les 12h du deuxième au septième jour. **B**
- 31) La contamination par ankylostomaduodénale se fait exclusivement par voie transcutanée. **B** **L1p21(Doc maladie infectieuse)**
- 32) L'OXYUROSE est une affection due à la présence dans le rectum et l'anus d'un ver nématode (ver rond) *Entérobius Vermicularis*. **A** **L1p30-31(Doc maladie infectieuse)**

II. QCM : 1 réponse juste = 0.5 point et 1 réponse fausse = 0 point

33. La NFS permet de détecter :

- A. Une anémie
- B. Une infection
- C. Un cancer du foie
- D. Une hypercalcémie

34. Une CRP élevée indique généralement :

- A. Une inflammation aiguë
- B. Une infection virale uniquement
- C. Une inflammation chronique uniquement
- D. Un syndrome hémorragique

35. Dans la conjonctivite, on note les signes fonctionnels suivants : L3p11(Doc Ophtalmologie)

- A. Une impression de corps étrangers dans les yeux
- B. Une tuméfaction des paupières
- C. des prurits

36. Vous recevez en consultation M. Tchum 63 ans qui signale que depuis plusieurs mois, sa vision se dégrade progressivement au point où il voit de plus en plus flou aux 2 yeux avec accentuation à l'œil gauche dont l'acuité visuelle est de 4/10. Il a l'impression de fumée devant les yeux. Il signale un antécédent de traumatisme à cet œil il y a 2 ans. A quelle affection

Pensez-vous ? : L3p20(Doc Ophtalmologie)

- A. Glaucome primitif
- B. Cataracte juvénile
- C. Lymbo conjonctivite (fréquente chez l'enfant)
- D. Cataracte sénile
- E. Glaucome aigu

37. Le rôle de l'infirmier(e) dans la phase pré-analytique inclut :

- A. La validation du résultat final
- B. Le prélèvement selon les règles d'asepsie
- C. L'étiquetage des échantillons
- D. L'analyse en laboratoire

38. Une TSH très basse peut indiquer :

- A. Une hypothyroïdie
- B. Une hyperthyroïdie
- C. Un trouble pancréatique
- D. Une grossesse extra-utérine

39. Dans la prise en charge du rhumatisme articulaire aigu, l'infirmier(ère) doit :

- A. sensibiliser sur l'observance du traitement prescrit
- B. prescrire uniquement des antibiotiques
- C. uniquement administrer des antibiotiques
- D. faire une éducation sanitaire et apporter un soutien psychologique à l'enfant et à sa famille.

40. Dans l'exécution de la biopsie, l'infirmier(ère) :

- A. réalise l'examen diagnostic
- B. assure la préparation du patient en vue de l'examen
- C. réalise les soins post- opératoires
- D. prévient les complications par une surveillance continue

41. Parmi les propositions suivantes concernant la pression artérielle, cochez la proposition fausse : L2p4(Doc de médecine)

- A. L'hypertension artérielle correspond à une PAS ≥ 140 mm Hg
- B. L'hypertension artérielle correspond à une PAD ≥ 80 mm Hg
- C. L'hypertension artérielle correspond à une PAD ≥ 90 mm Hg
- d. La pression artérielle correspond au débit cardiaque multiplié par les résistances périphériques

42. Parmi les propositions concernant le traitement de l'hypertension artérielle, cochez la réponse exacte :

- A. Il augmente le risque d'accident vasculaire cérébral Il augmente
- B. Il a pour objectif une pression artérielle inférieure à 140-90 mm Hg
- C. Il permet une réduction de 20% de mortalité cardiaque dès une baisse de 1 mm Hg de la PAS
- D. Il est indiqué uniquement en cas de symptômes gênants tels que maux de tête et vertiges
- E. Il est arrêté après stabilisation de la pression artérielle

43) Le traitement non médicamenteux de l'hypertension artérielle repose sur : L3p7(Doc de Cardiologie)

- A. La perte de poids
- B. La diminution des apports en sel, $< 6\text{g}$ de NaCl / jour
- C. Le repos et l'absence d'activités physiques
- D. Le repos et l'absence d'activités physiques
- E. La diminution de la consommation d'alcool

44. Parmi les signes cliniques suivants, (03) doivent faire évoquer une thrombose veineuse profonde d'un membre inférieur. Lesquels ?

- A. une augmentation de la chaleur locale
- B. une abolition du pouls
- C. un œdème unilatéral du mollet
- D. une diminution de la sensibilité superficielle
- E. une dilatation veineuse superficielle

45) Le rétrécissement mitral :

- A. est une complication rare du rhumatisme
- B. entraîne souvent des troubles du rythme cardiaque
- C. est presque toujours héréditaire

46. Quels examens diagnostiquer une peuvent insuffisance cardiaque

- A. Echocardiographie
- B. Electrocardiogramme (ECG)
- C. Radiographie thoracique
- D. Épreuve d'effort
- E. Cathétérisme cardiaque (exploration du cœur à l'aide de sonde)

47. VD vit avec sa mère à Bouaké et n'a pas d'extrait d'acte de naissance. Selon la mère VD est âgé de 3 ans. Elle l'amène aux urgences parce que VD est très encombré et respire difficilement. Le pédiatre pense à une rhinopharyngite. Le problème infirmier de VD est :

- A. Infection des voies aériennes supérieures
- B. Perturbation des échanges gazeux
- C. Dégagement inefficace des voies respiratoires
- D. Insuffisance d'apport de nutriment

48. Le nourrisson GG est âgé de 4 mois. Il vit avec sa mère à Abidjan. GG est à l'allaitement prépondérant. La mère est inquiète car GG est amaigri. Le médecin pense à un début de dénutrition. L'analyse des données du nourrisson GG conclue à :

- A. 2 données d'indépendance
- B. 3 données d'indépendance
- C. 4 données d'indépendance
- D. 5 données d'indépendance

49. Le nourrisson GG est âgé de 4 mois. Il vit avec sa mère à Abidjan. GG est à l'allaitement prépondérant. La mère est inquiète car GG est amaigri. Le médecin pense à un début de dénutrition. L'analyse des données nourrisson GG conclue à :

- A. 2 données de dépendance
- B. 3 données de dépendance
- C. 4 données de dépendance
- D. 5 données de dépendance

50. Un objectif de soin est :

- A. un sujet unique
- B. une fin que l'on veut atteindre pour le client
- C. un idéal pour le malade
- D. une recommandation de l'institution de soin.

51. Un objectif de soins infirmiers relève :

- A. De la fin que l'on veut atteindre pour le client.
- B. De l'indépendant du client dans la satisfaction de ses besoins
- C. De la personne soignée et du diagnostic infirmier

ANTENNE INFAS ABOISSO

ENAMEN BLANC 2025
MATIERE : PEDIATRE

QCM

➤ Consignes

- Une réponse juste donne droit à + 1 point
- Une réponse fausse donne droit à 0 point
- Une absence de réponse donne droit à 0 point

1) Nourrisson JK, sexe féminin, est âgée de 5 mois et nourri au sein avec un peu d'eau pour mouiller sa gorge. JK est correctement vacciné et vie avec sa mère à Bouaké. JK a

A. 1 donnée de dépendance

B. 2 données de dépendance

C. 3 données de dépendance

D. 4 données de dépendance

2) Nourrisson JK, sexe féminin, est âgée de 5 mois et nourri au sein avec un peu d'eau pour mouiller sa gorge. JK est correctement vacciné et vie avec sa mère à Bouaké. JK a dans sa réalité personnelle

A. 1 donnée d'indépendance

B. 2 données d'indépendance

C. 3 données d'indépendance

D. 4 données d'indépendance

3) Nourrisson JK, sexe féminin, est âgée de 5 mois et nourri au sein avec un peu d'eau pour mouiller sa gorge. JK est correctement vacciné et vie avec sa mère à Bouaké. JK a dans sa réalité personnelle

A. 1 donnée d'indépendance

B. 2 données d'indépendance

C. 3 données d'indépendance

D. 4 données d'indépendance

4) PB, sexe masculin, 19 mois, vie avec ses parents à Bonoua, Il est sevré définitivement du sein depuis l'âge de 18 mois. PB présente 5 selles glaireuses et sanglantes par jour depuis 2 jours, A l'examen PB est grognon, refuse la nourriture et a des ulcérations suintantes sur la fesse et la cuisse. PB souffre d'une malnutrition aiguë. PB a son identification

A. 3 données

B. 4 données

C. 5 données

D. 6 données

5) PB, sexe masculin, 19 mois, vie avec ses parents à Bonoua. Il est sevré définitivement du sein depuis l'âge de 18 mois, PB présente 5 selles glaireuses et sanglantes par jour depuis 2 jours. A l'examen PB est grognon, refuse la nourriture et a des ulcérations suintantes sur la fesse et la cuisse. PB souffre d'une malnutrition aiguë. Parmi les propositions suivantes cochez celle en lien avec le diagnostic médical

A. PB est grognon

B. PB refuse la nourriture

C. PB a des ulcérations sur les fesses

D. PB a une malnutrition aiguë

6) PB, sexe masculin, 19 mois, vie avec ses parents à Bonoua. Il est sevré définitivement du sein depuis l'âge de 18 mois. PB présente 5 selles glaireuses et sanglantes par jour depuis 2 jours. A l'examen PB est grognon, refuse la nourriture et a des ulcérations suintantes sur la fesse et la cuisse. PB souffre d'une malnutrition aigüe. L'interprétation des données de dépendance de PB révèle les trois problèmes suivants sauf un. Cochez l'intrus

A. Malnutrition aigüe

B. Apport insuffisant en nutriments

C. Risque d'infection

D. Apport insuffisant en liquide

7) PB, sexe masculin, 19 mois, vie avec ses parents à Bonoua. Il est sevré définitivement du sein depuis l'âge de 18 mois. PB présente 5 selles glaireuses et sanglantes par jour depuis 2 jours. A l'examen PB est grognon, refuse la nourriture et a des ulcérations suintantes sur la fesse et la cuisse. PB souffre d'une malnutrition aigüe. L'agent infectieux bactérien probable de la diarrhée de PB est

A. Vibron cholérique

B. Rotavirus

C. Shiguelle

D. Staphylocoque aureus

8) PB, sexe masculin, 19 mois, vie avec ses parents à Bonoua. Il est sevré définitivement du sein depuis l'âge de 18 mois. PB présente 5 selles glaireuses et sanglantes par jour depuis 2 jours. A l'examen PB est grognon, refuse la nourriture et a des ulcérations suintantes sur la fesse et la cuisse. PB souffre d'une malnutrition aigüe. Les prescriptions suivantes sont nécessaires chez PB sauf une. Cochez l'intrus

A. Metronidazole sitop

B. Amoxicilline sirop

C. Zinc comprimé

D. SRO modifié (Resomal)

9) PB, sexe masculin, 19 mois, vie avec ses parents à Bonoua. Il est sevré définitivement du sein depuis l'âge de 18 mois. PB présente 5 selles glaireuse et sanglantes par jour depuis 2 jours. A l'examen PB est grognon, refuse la nourriture et a des ulcérations suintantes sur la fesse et la cuisse. PB souffre d'une malnutrition aigüe. L'évaluation du poids de PB a donné 12kg. La quantité totale de lait thérapeutique F75 a donné en une journée en urgence est de

A. 1260 ml

B. 1360 ml

C. 460 ml

D. 500 ml

10) PB, sexe masculin, 19 mois, vie avec ses parents à Bonoua. Il est sevré définitivement du sein depuis l'âge de 18 mois. PB présente 5 selles glaireuses et sanglantes par jour depuis 2 jour. A l'examen PB est grognon, refuse la nourriture et a des ulcérations suintantes sur la fesse et la cuisse. PB souffre d'une malnutrition aigüe. L'évaluation du poids de PB a donné 12kg. Les paramètres suivants sont surveillés chez PB pendant le traitement sauf un. Cochez l'intrus

A. Appétit

B. Poids

C. Œdème

D. Taille

11) PB, sexe masculin, 19 mois, vie avec ses parents à Bonoua. Il est sevré définitivement du sein depuis l'âge de 18 mois. PB présente 5 selles glaireuses et sanglantes par jour depuis 2 jour. A l'examen PB est grognon, refuse la nourriture et a des ulcérations suintantes sur la fesse et la cuisse. PB souffre d'une malnutrition aigüe. Pour prévenir l'hypoglycémie a l'admission j'administre à PB de l'eau sucré à 10%. J'utilise pour cela

- A. 4 carreaux de sucre pour 50 ml d'eau
- B. 3 carreaux de sucre pour 50 ml d'eau
- C. 2 carreaux de sucre pour 50 ml d'eau
- D. 1 carreaux de sucre pour 50 ml d'eau**

12) PB, sexe masculin, 19 mois, vie avec ses parents à Bonoua. Il est sevré définitivement du sein depuis l'âge de 18 mois. PB présente 5 selles glaireuses et sanglantes par jour depuis 2 jour. A l'examen PB est grognon, refuse la nourriture et a des ulcérations suintantes sur la fesse et la cuisse. PB souffre d'une malnutrition aigüe. Les propositions suivantes sont des complications de la maladie de KB vue au cours sauf une. Cochez cette proposition

- A. infection
- B. Convulsions
- C. Déshydratation
- D. Anémie**

13) PB, sexe masculin, 19 mois, vie avec ses parents à Bonoua. Il est sevré définitivement du sein depuis l'âge de 18 mois. PB présente 5 selles glaireuses et sanglantes par jour depuis 2 jour. A l'examen PB est grognon, refuse la nourriture et a des ulcérations suintantes sur la fesse et la cuisse. PB souffre d'une malnutrition aigüe. La maladie de PB est due à un déficit en nutriment de type 2. Cochez ce nutriment dans la liste ci-dessous

- A. Fer
- B. Vitamine A**
- C. Protide
- D. Calcium

14) L'administration de Zinc comprimé dans le traitement de la diarrhée chez le nourrisson 5mois est de

- A. Demi comprimé / jour pendant 10 jours**
- B. Un comprimé / jour pendant 10 jours
- C. Un quart de comprimé / jour pendant 10 jours
- D. Deux comprimés / jour pendant 10 jour

15) L'enfant né à terme avec une surface corporelle de $0,2 \text{ m}^2$ et correctement nourri triple sa surface corporelle a :

- A. 9 mois
- B. 12 mois
- C. 24 mois
- D. 36 mois**

16) A 15 mois un nourrisson avec un bon développement psychomoteur est capable :

- A. Faire des gribouille**
- B. Parler constamment
- C. Jeter un objet dernier lui**
- D. Marche à reculons

17) Placer la perfusion de sérum glucose à 10% à un nouveau-né prématuré en détresse vitale dans une couveuse est un soin

- A. Un Propre
- B. Collaboration

C. Conseil et prévention

D. Délégué

18) Nourrisson KP est au sein. Le critère qui indique la bonne prise du sein de KP est :

A. Lèvre intérieure rentrée

B. Bouche largement ouverte

C. Menton éloigné du sein

D. Succion rapide, peu profonde

19) Les structures cibles de la prolactine pour provoquer l'éjection du lait sont :

A. Cellules galactophores

B. Cellules myoépithéliales

C. Cellules adipeuses

D. Cellules épithéliales

20) La mise au sein est dite précoce quand elle débute :

A. Dans la première heure de vie

B. Dans les deux premières heures de vie

C. Dans les six premières de vie

D. Dans les douze premières heures de vie

21) Vous recevez aux urgences pédiatriques pour des convulsions, GG pesant 10 kg. La dose journalière de Diazépam à ne pas dépasser chez GG est :

A. 51 mg / jour

B. 5,1 mg / jour

C. 30 mg / jour

D. 17 mg / jour

Dose journalière : 3mg/Kg/J

1Kg —————→ 3mg

10Kg —————→ $x = \frac{(10 \times 3)}{1} = 30\text{mg}$

22) Pour surveiller la maturation du nourrisson j'utilise. Cochez cette proposition :

A. L'éruption des dents

B. La taille

C. Le poids

D. Le périmètre brachial

23) Un nourrisson de 16 mois est amené par sa mère inquiète à votre consultation car son enfant n'a aucune dent en bouche :

A. Je recommande à la mère de consulter un médecin

B. Je prescris à la mère un traitement à base de Fluor

C. Je rassure la mère et lui donne un rendez-vous pour la surveillance

D. Je demande à la mère d'aller voir le grand guérisseur du village

24) Le nouveau-né grand prématuré à un âge gestationnel de :

A. [28 - 32] SA

B. [28 - 33] SA

C. [33 - 35] SA

D.]33 - 35] SA

➤ Extrême Prématuré : [22 - 28[ou [22 - 27]

➤ Grand Prématuré : [28 - 33[ou [28 - 32]

➤ Moyen Prématuré : [33 - 35[ou [33 - 34]

➤ Petit Prématuré : [35 - 37[ou [35 - 36]

25) Les propositions suivantes sont des maladies qui influencent le développement psychomoteur de l'enfant, sauf une Cochez cette proposition.

A. Neuropaludisme

B. Eczéma

C. Ictère nucléaire

D. Encéphalite virale

26) HP est âgé de 36 mois. Il est capable de

A. S'habiller seul, mais ne met pas les boutons

B. Copier un carré

C. Faire de la bicyclette

D. Nommer les jours de la semaine

27) Administrer de la vitamine K au nouveau-né en salle de naissance est pour l'agent de santé un soin :

A. Conseil et prévention

B. Collaboration

C. Délégué

D. Propres

28) LG est né à 11h51min. Les propositions suivantes sont des gestes à réaliser chez LG entre 11h52min et 12h51min vie, sauf une. Cochez cette proposition.

A. Prendre la température de LG quatre fois

B. Surveiller la respiration de LG

C. Aider la mère à mettre au sein LG

D. Faire l'examen clinique de LG

29) A 5 minutes de vie, le nouveau-né de dame JK avec une cyanose généralisée, une hypotonie généralisée, une respiration irrégulière, un geignement audible à distance, une fréquence cardiaque de 110 battements par minute. Le score d'Apgar à 5 minute de vie de ce nouveau-né est de :

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

30) Les soins propres dans la prise en charge des vomissements chez l'enfant sont les suivants, sauf un. Cochez ce soin :

A. Administrer un médicament

B. Aider à alimenter l'enfant

C. Nettoyer l'enfant

D. Surveiller l'enfant

31) La complication redoutable à prévenir en urgence chez tout enfant sévèrement malnutri est

A. Hypoglycémie

B. Déshydratation

C. Anémie sévère

D. Défaillance cardiaque

32) L'état de mal convulsif désigne une crise convulsive qui dure plus de :

A. 05 minutes

B. 10 minutes

C. 20 minutes

D. 30 minutes

33) Pour la reconstitution de l'eau sucrée à 10% administrée à l'enfant malnutri à l'admission, j'utilise 3 carreaux de sucre

A. 200 ml d'eau potable

B. 150 ml d'eau potable

C. 100 ml d'eau potable

D. 50 ml d'eau potable

1 Carreau de sucre → 5g

3 Carreaux de sucre → 15g

Or l'eau sucrée 10%

10g → 100ml

15g → **150ml**

34) Nourrisson JK fillette de 18 mois, présente des pleurs incessants, et un refus de téter. Elle est à jour de ses vaccins. A l'examen physique, fontanelle antérieure est bombée, et la température de 40° Celsius. JK souffre d'une méningite purulente. JK a :

- A. 1 données au niveau de sa réalité personnelle
- B. 2 données au niveau de sa réalité personnelle
- C. 3 données au niveau de sa réalité personnelle**
- D. 4 données au niveau de sa réalité personnelle

35) Nourrisson JK fillette de 18 mois, présente des pleurs incessants, et un refus de téter. Elle est à jour de ses vaccins. A l'examen physique, la fontanelle antérieure est bombée, et la température de 40° Celsius. JK souffre d'une méningite purulente. JK a :

- A. 4 données de dépendance
- B. 5 données de dépendance**
- C. 6 données de dépendance
- D. 7 données de dépendance

36) JK fillette de 18 mois, présente des pleurs incessants, et un refus de téter. Elle est à jour de ses vaccins. A l'examen physique, la fontanelle antérieure est bombée, et la température de 40° Celsius. JK souffre d'une méningite purulente. JK a :

- A. 3 données d'indépendance**
- B. 4 données d'indépendance
- C. 5 données d'indépendance
- D. 6 données d'indépendance

37) JK fillette de 18 mois, présente des pleurs incessants, et un refus de téter. Elle est à jour de ses vaccins. A l'examen physique, la fontanelle antérieure est bombée, et la température de 40° Celsius. JK souffre d'une méningite purulente. L'interprétation des données de JK met en évidence :

- A. Immaturité et Infection bactérienne des méninges et absence de protection**
- B. Immaturité et Hypertension intracrânienne fébrile et absence de protection
- C. Immaturité cérébrale et cutanée et absence de protection
- D. Immaturité et dysrégulation thermique et menace sur l'intégrité physique et psychique

38) Les propositions suivantes sont des examens paracliniques à prescrire devant une fièvre aigue, sauf une. Cochez cette proposition

- A. Examen cytot bactériologique des urines
- B. Sérodiagnostic de Vidal et Felix**
- C. Protéines C réactive (CRP)
- D. Goutte épaisse et frottis sanguin

39) Le nourrisson HG est âgé de 14 mois et pèse 9 kilogrammes. Il souffre d'une diarrhée aiguë avec des signes sévère déshydratation. La quantité totale de liquide à perfusé à HG en trois heures est :

- A. 270 ml / jour
- B. 630 ml / jour
- C. 675 ml / jour
- D. 900 ml / jour**

Signe sévère de déshydratation « Plan C »

- En 30min : 30ml/kg
 1kg $\longrightarrow$ 30ml
 9kg $\longrightarrow$ $X_1 = 9 \times 30 = 270\text{ml}$
- En 2h30min : 70ml/kg
 1kg $\longrightarrow$ 70ml
 9kg $\longrightarrow$ $X_2 = 9 \times 70 = 630\text{ml}$

$$X_1 + X_2 = 270 + 630 = 900 \text{ ml}$$

QCD

➤ Consignes

- Une réponse juste donne droit à + 1 point
- Une réponse fausse donne droit à - 1 point
- Une absence de réponse donne droit à 0 point

40. Le staphylocoque doré est le principal agent infectieux responsable d'infection bactérienne néonatale tardive. **A L3p19**
41. Le colostrum est produit par la mère durant la première semaine post- partum. **A L1p34**
- 42) Les infections vagino-utérines sont des causes spontanées de prématurité. **A L2p12**
- 43) Le contact peau à peau favorise la mise en route de l'allaitement. **A**
- 44) L'entérococolite est un problème digestif lié à la prématurité. **A L2p14**
- 45) Le cartilage du lobule de l'oreille ourlée est un signe de prématurité. **B L1p17**
- 46) Réaliser le bilan biologique chez le nouveau-né prématurité est un soin propre de l'agent de santé. **B L3p16**
- 47) En l'absence de sérum glucosé 5% pour la réhydratation, je peux utiliser du sérum glucosé 10% en remplacement. **B**
- 48) Le nourrisson présentant une diarrhée aigue sans signe déshydratation boit avec avidité. **B L3p47**
- 49) Au cours de la diarrhée, il est recommandé de ne pas mettre l'enfant a la diète. **A**
- 50) Dans la physiologie de la lactation, l'ocytocine est l'hormone de sécrétion du lait. **B**
- 51) Les selles de la diarrhée aigue invasive sont d'aspect glaireuse et sanglante. A**
- 52) Le mélange I de l'INSP d'Adjamé utilisé pour la réhabilitation nutritionnelle de l'enfant malnutri est composé de 6 volumes de lait entier en poudre + 2 volumes de sucre + 1 volume d'huile végétale. **A**
- 53) Exerçant dans un ESPC, vous recevez le nouveau-né BB, J4 de vie, pesant 2000g pour une hématomé et un saignement en nappe au niveau du cordon ombilical. Vous administrez au nouveau-né BB avant la référence 10 mg de vitamine KI en IVD. **A**
- 54) Je réalise le test de TP-TCK pour affirmer le déficit en vitamine K 1 chez l'enfant. **A**
- 55) Les selles de la diarrhée aiguë provoquée par Shiguelle liquide sans matière fécale. **B**
- 56) L'enveloppement humide est un moyen physique non recommandé pour traiter la fièvre de l'enfant. **A**
- 57) Dans la démarche de soins, les données de l'identification du patient sont toujours des données d'indépendance. **A**
- 58) Dans la démarche de soins, pour identifier le problème de santé, je me sers de l'interprétation des données de dépendance collectés. **A**
- 59) Dans la démarche de soins infirmiers, le sous chapitre diagnostic médical se place avant celui des signes de la maladie. **B**

ANTENNE INFAS ABOISSO**ENAMEN BLANC 2025
MATIERE : SANTE PUBLIQUE**POPULATION CIBLE : LSIO 3 IDE/SF
30 mn

DURER : 1heure

VERSION D

I. QCD

○ Choisir la bonne réponse. NB : A= VRAI

B= FAUX

1. L'insuffisance de supervision dans un centre de santé peut être à l'origine d'un goulot d'étranglement entre couverture adéquate et la couverture effective. **A**
2. L'information est le résultat de la transformation des données en faits utiles pour les décideurs. **A L3p27**
3. La collecte des données sanitaires est aussi appelée enregistrement des données sanitaires dans les registres d'activités. **A L3p29**
4. Les délais de transmission des rapports A et A3 sont respectivement le 5 du mois suivant et le 30 janvier de l'année en cours. **B L3p29**
6. Le programme porte en général sur des objectifs d'une envergure nationale. **A L3p50**
7. L'évaluation initiale aussi appelée analyse situationnelle. **A L3p53**
8. Les pollutions industrielles sont les déchets de la vie humaine qui sont déversés dans les rivières, les lacs, les mers, les lagunes par les eaux de ruissellement. **B L1p59**
9. Les pollutions diffuses ou collectives sont les pollutions provoquées par les détergents, les hydrocarbures et les huiles de vidanges. **A L1p59**
10. La fosse septique permet d'éviter la contamination des eaux de surface et des eaux souterraines. **A L1p69**
11. Le fond de la latrine doit être situé au moins à 1,5 mètre en-dessous de la nappe aquifère. **B L1p68 (au-dessus)**
12. La santé communautaire introduit une notion d'engagement de chaque individu membre de la communauté. **A L1p8**
13. La priorité de la santé publique est la promotion de la sante. **B L1p8 (la protection de la santé de la population)**
14. Un agent de santé communautaire peut utiliser la communication de masse pour mener son activité de sensibilisation dans le village. **A L2p13**

II. QCM : Instructions : 1 bonne réponse = +1 ; 1 mauvaise réponse = -1 ; Pas de réponse = 0**ETUDE DE CAS N°1**

Les dates de dépôt des rapports mensuels de morbidité du premier semestre de l'année 2021 des centres de santé de Songori et de Kouassi N'Dawa sont consignés dans le tableau ci-dessous

Structures Sanitaires	Date de dépôt du rapport mensuel de morbidité					
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
CSU Songori	05/02/2021	06/03/2021	04/04/2021	05/05/2021	04/06/2021	06/07/2021
CSR Kouassi N'Dawa	11/02/2021	07/03/2021	05/04/2021	11/05/2021	05/06/2021	07/07/2021

14. Calculez le taux de promptitude des rapports mensuels de morbidité du CSR de Kouassi N'Dawa.

A. 33%

B. 77%

C. 66%

D. 55%

$$Tp = \frac{\text{Nbre de rapports mensuels d'activités reçus dans un délai requis}}{\text{Nbre de rapports d'activités attendus}} \times 100 = \frac{2}{6} \times 100 = 33$$

15. Calculez le taux de complétude des rapports mensuels de morbidité de CSU de Songori

A. 90%

B. 66%

C. 100%

D. 57%

$$Tp = \frac{\text{Nbre de rapports mensuels d'activités reçus par le CSE}}{\text{Nbre de rapports d'activités attendus}} \times 100 = \frac{6}{6} \times 100 = 100$$

16. A partir de la liste ci-dessous choisir deux éléments clés requis pour estimer vos besoins en vaccins contre la rougeole pour l'année prochaine dans votre centre de santé :

A. Nombre de cas de rougeole de l'année actuelle ;

B. Nombre de doses requises pour la vaccination contre la rougeole conformément au calendrier vaccinal.

C. Population totale de l'aire de santé.

D. Nombre d'enfants de la maternelle.

E. Niveau désiré de couverture vaccinale contre la rougeole pour la prochaine année.

17. Quelle est l'année de dédoublement d'une localité dont la population totale est estimée en 2020 à 4500 habitant et dont le taux d'accroissement est de 2%.

A. 2053

B. 2054

C. 2055

$$AD = AR + TD \text{ Avec } TD = \frac{70}{TAA} = \frac{70}{2} = 35$$

$$AD = 2020 + 35 = 2055$$

18. Parmi les propositions relatives aux objectifs de la surveillance des maladies du PEV, deux ne sont pas exactes. Coches. Les bonnes réponses

A. Estimer la prévalence des différentes maladies

B. Identifier les problèmes de santé en vue de les résoudre ;

C. Repérer les facteurs qui freinent la survenue de certaines maladies.

D. Améliorer la santé des populations.

19. Les dimensions d'une latrine sont : Cochez la bonne réponse. L1p67

A. Diamètre=1,80 cm ; profondeur =30 m

B. Diamètre=120 cm ; profondeur= 2,5 m

C. Diamètre=90 cm ; profondeurs 1,20cm

D. Diamètre=90 cm à 120 cm ; profondeur=1,80 à 2,50 m

20. Les SSP ont été mises en œuvre en CI effectivement en (Cochez la bonne réponse) : L1p76

A. 1990

B. 1993

C. 1995

D. 1991

21. Parmi les propositions ci-dessous, cochez celle qui n'est pas une caractéristique du budget d'un ESPC niveau rural. Cochez-les L3p15

A. Le budget est élaboré chaque semestre ;

B. Le budget est prévisionnel

C. Le budget est disponible

22. La période 1960 À 1980. La prestation des services était organisée selon deux (02) volets ; lesquels ? Cochez les bonnes réponses L1p33

A. Un volet orienté sur les soins curatifs avec pour caractéristique essentielle, la gratuité des soins.

B. Un volet orienté sur la promotion de la santé

C. Un Volet préventif basé sur une assistance médicale visant la lutte contre les grandes endémies (pian, trypanosomiase, lèpre, onchocercose etc.) d'où la notion de grandes endémies.

23. Parmi les propositions ci-dessous, cochez celles qui ne font pas partir des étapes du processus de génération de l'information sanitaire, Cochez les bonnes réponses L3p29

A. La complétude des données

B. La compilation des données sanitaires

C. La collecte des données sanitaires

D. La promptitude des rapports

24. Parmi les indicateurs de santé ci-dessous, cochez ceux qui sont à tendance positive. Cochez les bonnes réponses L2p25-26

A. Taux brut de morbidité

B. Taux d'incidence

C. Taux de létalité

D. Taux d'accroissement annuel

E. Taux d'accouchement assisté

25. A la base de la pyramide alimentaire nous avons : Cochez la bonne réponse L1p23

A. Les aliments à consommer chaque jour

B. Les aliments à consommer à volonté.

C. Les aliments à consommer à chaque repas

26. Les flacons de DTC-HépB+Hib, Td, PCV 13 ainsi que les solvants sont placés :

A. Près des accumulateurs de froid dans la glacière ou du porte vaccin

B. Au centre de la glacière ou du porte vaccin ;

C. Au-dessus de la glacière ou du porte vaccin ;

D. Au fond de la glacière ou du porte vaccin

27. Quels sont parmi les vaccins ci-dessous ceux qui peuvent être utilisés au-delà de 06 heures ou pendant les séances de vaccination suivantes si certaines conditions sont remplies (la date péremption n'est pas dépassée, la PCV n'a pas atteint le point de rejet : L2p48

A. VPO

B. Rougeole

C. Td

D. VAA

E. DTCHépB+Hib

F. HPV

28. A la fin du mois d'avril 2019, 220 enfants de 0 à 11 mois ont reçu la première dose du DTCHép B + Hib et 333 enfants de la même tranche d'âge ont reçu la troisième dose de ce même antigène. Le taux d'abandon spécifique de cet antigène est estimé à :

A. 51,36 %

B. -51,36%

C. 52%

D.

$$TAS = \frac{\text{Penta 1} - \text{Penta 3}}{\text{Penta 1}} \times 100 = \frac{220 - 333}{220} \times 100$$

$$TAS = -51,36\%$$

29. Déterminer la population cible de 0-11 mois qui a permis de réaliser le monitoring sur l'activité de vaccination de routine, premier semestre de l'année 2019 dont les résultats figurent ci-dessous dans une population estimée au 31/12/2019 à 6400 habitants. NB (pop 0-11 mois = 4%)

- A. 228
- B. 128**
- C. 158
- D. 280

$$P(0 \text{ à } 11) = 4\% \times P_t = 4\% \times 6400 = 256$$

$$PC \text{ du monitoring} = 256 / 2 = 128$$

30. Le principal goulot d'étranglement se situe entre : CE=17% CA=17% US=20% AG=30 % DR=80% cocher la bonne réponse

- A. AG - DR**
- B. AG- US
- C. US- CA
- D. CA-CE

E. Aucune de ces réponses



31. La première activité à mener devant un cas suspect de rougeole, il faut : Cochez la bonne réponse L2p69

A. Faire un prélèvement de sang entre le 4ème et le 28ème Jour après le début de l'éruption

A. Faire un prélèvement de gorge des cas entre J4 à 17.

C. Recueillir 2 échantillons de selles (8-10g) à un intervalle d'au moins 24-48 heures.

32. Trois phases interviennent dans le processus d'Évacuation des ordures ménagères, Lesquelles ? L1p65-66

- A. Le stockage**
- B. Le ramassage**
- C. Le traitement**
- D. Le brulage
- E. Les déchets

33. Parmi les modes de transmission des maladies par les vecteurs, l'une est fausse ; Laquelle ? L1p71

- A. Transmission biologique
- B. Transmission mécanique
- C. Transmission génétique**

ETUDE DE CAS N°2

Vous êtes infirmier ou sage-femme au centre de santé de Goulapleu. Votre aire sanitaire qui est peuplée de 5500 habitants en 2013. A connu une épidémie au cours de l'année 2015. Les ressources brutes pour le dernier semestre de l'année du centre sont estimées à 1.000.000 FCFA et la vente des médicaments essentiels à 350.000FCFA. Les dépenses obligatoires représentent 1/5 des ressources propres.

Vous disposez par ailleurs des données suivantes sur l'aire sanitaire au titre de la même année 2015.

- Naissances vivantes enregistrées : 93
- Décès de femmes enceintes : 02
- Décès de femmes accouchées : 03 dont un Survenu 15 Jours après l'accouchement, un autre, 01 mois après l'accouchement et le dernier, 39 jours après l'accouchement.
- Décès toutes causes confondues (TTC) : 61.
- Taux d'accroissement annuel (TAA) : 2,7%.

34. La population de l'année 2015 est :

- A. 5801 hbts
- B. 5800 hbts
- C. 5799 hbts

$$P(2015) = P(2013) \times (1 + (TAA/100))^2$$

$$P(2015) = 5500 \times (1 + (2,7/100))^2$$

$$P(2015) = 5801$$

35. La population moyenne en 2015 est :

- A. 5823
- B. 5725
- C. 5724

$$P(2014) = P(2013) \times (1 + (TAA/100))^1$$

$$P(2014) = 5500 \times (1 + (2,7/100))^1$$

$$P(2014) = 5649 \text{ hbts}$$

$$\text{Pop au 31/12/14} = \text{Pop au 01/01/15} = 5649$$

$$P_{\text{moy}} = \frac{P_d + P_f}{2} = \frac{5649 + 5801}{2} = 5725$$

36. Le taux brut de natalité est :

- A. 0,56%
- B. 0,57%
- C. 0,55%

$$TBN = \frac{NV}{P_{\text{moy}}} \times 100 = \frac{93}{5725} \times 100 = 1,62\%$$

37. Le taux brut de mortalité est :

- A. 1,1%
- B. 1,06%
- C. 1,05%

$$TBM = \frac{\text{Décès}}{P_{\text{moy}}} \times 100 = \frac{61}{5725} \times 100 = 1,06\%$$

38. Le taux brut de mortalité maternel est :

- A. 5,38%
- B. 5,37%
- C. 5,27%

$$TBM = \frac{\text{Décès des femmes pdt la grossesse, l'accouchement et 42jrs après accouchements ni accidentel ni fortuite}}{NV} \times 100 = \frac{5}{93} = 5,37\%$$

39. Le taux de mortalité spécifique de la maladie est :

- A. 0,15%
- B. 0,16%
- C. 0,16%

40. Le taux de létalité de cette affection est :

- A. 35,90%
- B. 36%
- C. 35,97%

41. Les éléments d'intérêt de l'épidémiologie analytique sont :

- A. Les facteurs favorisants
- B. Le mode de transmission de la maladie
- C. La chaîne épidémiologique et les facteurs de risque

42. Un indicateur de santé est :

- A. une mesure qui permet quantifier les états de santé.
- B. une mesure qui permet décrire une situation sanitaire à une période donnée
- C. une mesure destinée à évaluer les programmes de santé.

43. Un indicateur de santé figure parmi les propositions suivantes ; lequel ?

- A. La prévalence
- B. Indicateurs positifs

C. Indicateurs de santé à tendance négative

44. Le décès maternel c'est : **L2p31**

A. Tout décès de femme enceinte et au cours de l'accouchement

B. Tout décès de femme en grossesse, au cours de l'accouchement ou dans les suites de couches au-delà de 42 jours.

C. Tout décès de femme en grossesse, au cours de l'accouchement ou dans les suites de couches jusqu'à 42 jours sauf d'accident.

45. Un cas de maladie qui débute dans une période est :

A. un cas spécifique pour la période

B. un nouveau cas pour la période

C. un nouveau cas déterminant pour la période

46. Un nouveau cas de maladie se détermine par rapport à :

A. son début par rapport à une période

B. sa durée dans la période

C. sa persistance dans une période

47. Les dépenses du CSRA en lettre s'élèvent à

A. Aucune dépense

B. Cent mille francs

C. Cent cinquante mille francs

D. Deux cents mille francs

E. Quatre cent cinquante mille francs

$$\text{Dépenses} = 45\% \times \text{RB} = 45\% \times 1000000 = 450000$$

48. La sommes à budgétiser en chiffre est de :

A. 200.000F

B. 450.000F

C. 550.000F

D. 1.000.000F

$$\text{RP} = 55\% \times \text{RB} = 55\% \times 1000000 = 550000$$

49. La recette du COGES est de :

A. 200.000F

A. 350.000F

B. 450.000F

C. 550.000F

$$\text{RP} = \text{SAB} = 550000$$

$$\text{SAB} = \text{RVME} + \text{RCAS}$$

$$\text{RCAS} = \text{SAB} - \text{RVME}$$

$$\text{RCAS} = 550000 - 350000 = 200000$$

50. Les dépenses de fonctionnement locale (DFL) sont égales à

A. 200.000F

B. 140.000F

C. 110.000F

D. 90.000F

$$\text{SAB} = \text{DO} + \text{DFL}$$

$$\text{DFL} = \text{SAB} - \text{DO} \quad \text{Avec } \text{DO} = \text{RP} / 5 = 550000 / 5 = 110000$$

$$\text{DFL} = 550000 - 110000 = 440000$$

51. La somme allouée aux autres dépenses en dehors des imprévus et des frais de réparation éventuelle (immeuble) est :

A. 474.000F

B. 374.000F

C. 274.000F

D. 174.000F

$$\text{AUTRES} = 85\% \times \text{DFL}$$

$$\text{AUTRES} = 85\% \times 440000$$

$$\text{AUTRES} = 374000$$

AGBOVILLE 1

DE BLANC CHIRURGIE AGBOVILLE 2025

Questions à choix double

1. La diaphyse est une portion d'un os plat. **B** L1p35 (Doc anatomie) « diaphyse=os long »
2. L'appendicite aigue est la plus fréquente des urgences abdominales. **A** L2p106 (Doc chirurgie)
3. Le traitement de fracture avec au moins deux (02) traits de fracture se fait par ostéosynthèse. **A**
4. Le traitement de fracture avec au moins deux (02) traits de fracture se fait par ostéosynthèse. **A**
5. Lorsque le traitement d'une fracture est couronné de succès ; on parle alors de cal vicieuse. **B** L1p64 (Doc sémio chirurgicale) « fracture est couronné de succès= cal osseux »
6. De dehors en dedans les trois feuillets de la méninge se composent comme suit : la dure mère, l'arachnoïde et la pie mère. **A**
7. Les méninges recouvrent le cerveau y compris la moelle épinière. **A**
8. Le scalp est un lambeau du cuir chevelu arraché ensemble avec les cheveux suite à un traumatisme crânien. **A**
9. Le scalp est un fragment osseux crânien arraché lors d'un traumatisme crânien. **B**
10. L'embarrure est un enfoncement d'un fragment osseux crânien dans la boîte crânienne d'origine traumatique. **A**
11. Le jéjunum est la première portion de l'intestin grêle. **B** « le Duodénum »
12. L'appendicite aigue est la plus fréquente des urgences abdominales. **A**
13. Les plaies sont définies comme étant une solution de continuité (lésion) de la peau, simple ou associée à d'autres lésions des tissus sous-jacents. **A** L1p54 (Doc Sémio Chirurgicale)
14. Les malléoles sont situées au niveau du poignet. **B** « cheville »
15. Lorsque le score de GLASGOW part de 3 et 8 cela signifie que le traumatisme crânien est très grave. **A** L3p4 (Doc neurochirurgie)
16. Le score de GLASGOW permet d'apprécier l'état de conscience du traumatisé crânien. **A**
17. L'un des signes physiques du traumatisme crânien est l'hématome crânien. **A** L3p3 (Doc neurochirurgie)
18. En cas de luxation la compression vasculaire(vaisseau) n'est pas une Complication. **B** L1p68 (Doc Sémio Chirurgicale)
19. L'entorse est un traumatisme fermé d'un ligament articulaire. **A** L1p66 (Doc Sémio Chirurgicale)
20. Le diabète est un facteur favorisant la survenue des panaris. **B** L1p38 (Doc Sémio Chirurgicale) « des furoncles »
21. L'IDE dans un centre de santé rural avant toute évacuation doit prendre une bonne voie d'abord. **B**
22. Dans un centre de santé rural avant d'évacuer un fracturé de l'avant-bras, l'agent de santé doit poser un plâtre d'abord. **B**
23. De dedans en dehors les trois feuillets de la méninge se composent Comme suit : la dure mère, la pie mère et l'arachnoïde. **B**
24. L'amnésie est un signe fonctionnel du traumatisme crânien. **A** L3p3 (Doc Neurochirurgie)
25. La moelle épinière s'arrête au niveau de la vertèbre lombaire L2. **A** L3p13 (Doc Neurochirurgie)

Questions à choix multiple

CAS PRATIQUE : Une ménagère, du nom de Fodjo Viviane à l'approche de midi, soucieuse de terminer la préparation du repas se fait ébouillanter par l'eau chaude de la marmite, par précipitation. La famille l'ayant transportée à l'hôpital de la ville, le médecin traitant constate : une brûlure du visage (moitié de la tête), de la moitié du bras gauche, de la moitié du tronc antérieur, et des deux mains. Cette dame est âgée de 40ans, pèse 60kg et séropositive.

AGE \ LOCALISATION	ADULTE
Tête	7%
Tronc antérieur	13%
Un bras	4%
Une main	2.50%

Servez-vous de ce tableau ci-dessus pour répondre aux questions suivantes

26. Quelle est sa surface corporelle brûlée :

- A. 8%
B. 20%
C. 17%
D. 12%

SCB = moitié de la tête + moitié du bras gauche + moitié du tronc antérieur + 2 mains

$$SCB = \frac{7}{2} + \frac{4}{2} + \frac{13}{2} + (2 \times 2,5)$$

$$SCB = 3,5 + 2 + 6,5 + 5$$

27. Le médecin traitant donne son pronostic vital : choisir la bonne réponse

- A. La mort est quasi certaine
B. La dame a une chance sur deux de guérir L1p79 (Doc Sémio chirurgicale)
C. Sa guérison est quasi certaine

28. Pour sa réanimation hydro électrolytique le premier jour, le médecin utilise la règle de BAXTER : donner la bonne réponse

- A. POIDS (mg)X4XSCB L1p83 (Doc Sémio chirurgicale)
B. POIDS (kg)X4XSCB
C. TAILLE (m)X4XSCB

29. La quantité de soluté requise pour sa perfusion le premier jour est la suivante :

- A. 150ml
B. 200ml
C. 4080ml
D. 180ml

$$QJ1 = \text{POIDS (kg)} \times 4 \times \text{SCB}$$

$$QJ1 = 60 \times 4 \times 17$$

30. La moelle épinière part de la vertèbre C1 : une réponse juste, laquelle ?

- A. Jusqu'à la vertèbre D12
B. Jusqu'à la vertèbre C7 L3p13 (Doc Neurochirurgie)
C. Jusqu'à la vertèbre L2

31. La tétraplégie est la paralysie : une seule réponse juste laquelle ?

- A. Des deux membres inférieurs
B. Des deux membres latéraux L3p16 (Doc Neurochirurgie)
C. Des quatre membres, supérieurs et inférieurs

32. La formule de l'Indice de Beau qui va servir à établir son pronostic vital est la suivante :

A. $IB = SCB + AGE$

B. $IB = SCB + POIDS$

C. $IB = SCB + AGE + 15$

L1p16 (Doc Sémio chirurgicale)

Mme Fodjo Viviane est séropositive

Donc existence de tare

33. Après calcul son Indice de Beau donne ceci :

A. $IB = 50$

B. $IB = 72$

C. $IB = 40$

D. $IB = 80$

$$IB = SCB + AGE + 15$$

$$IB = 17 + 40 + 15$$

34. Le disque intervertébral est logé :

A. Entre les apophyses transverses

B. Entre deux vertèbres

C. Entre les apophyses épineuses

L3p12 (Doc Neurochirurgie)

35. Le traitement de l'hématome suite à un traumatisme crânien consiste à : (deux possibilités de traitement selon la situation)

A. Faire un pansement compressif en première intention

B. Faire immédiatement une suture

C. Poser un drain pour évacuer le contenu sanguin

D. Faire une incision si échec du pansement compressif

E. Faire une antibiothérapie exclusivement

L3p6 (Doc Neurochirurgie)

36. En cas d'embarrure le traitement est :

A. Médical

B. Chirurgical

C. De laisser l'organisme faire son travail

37. Le traumatisé du rachis doit être déplacé :

A. Rapidement peu importe sa posture

B. En position de Fowler

C. En décubitus latéral

D. De façon monobloc

L3p15 (Doc Neurochirurgie)

38. Les examens radiologiques suivants sont requis pour un traumatisé du rachis entre autres, sauf un : lequel ?

A. L'abdomen sans préparation (ASP)

B. Le scanner (TDM)

C. L'IRM

L3p17 (Doc Neurochirurgie)

39. La parésie après un traumatisme du rachis est : L3p16 (Doc Neurochirurgie)

A. Une paralysie d'un membre inférieur

B. Une paralysie des deux membres supérieurs

C. Présence de mouvements mais d'intensité faible ou diminuée

40. En cas de traumatisme du rachis l'on recourt à deux types de traitement : sauf un lequel ?

A. Le traitement orthopédique

B. Le médical exclusif

C. La chimiothérapie

D. L'ostéosynthèse

L3p18 (Doc Neurochirurgie)

41. Le lavement évacuateur du traumatisé du rachis permet d'éviter :

A. Un fécalome

B. Une diarrhée profuse

C. Un méléna

D. Un cancer du rectum

L3p23 (Doc Neurochirurgie)

42. Le fécalome en cas de traumatisme du rachis peut occasionner :

A. Une occlusion intestinale

B. Une hémorragie digestive

C. Une péritonite aigue

D. Un volvulus des anses du colon

43. Lors d'un pansement le plateau se dispose toujours sur le chariot au : une réponse juste

A. 3^{ème} étage

B. 2^{ème} étage

C. 1^{er} étage

44. Lors d'un pansement l'agent de santé fait usage des produits suivants sauf un : lequel ?

A. La bétadine jaune

B. Le sérum glucosé

L1p61 (MT Soins Infirmiers)

C. La bétadine rouge

D. Le dakin

45. Le baudens est un bandage

A. De la cheville

L1p63 (Doc MT Soins Infirmiers)

B. Du poignet

C. Du genou

46. Le bandage spica du pouce est réalisé en cas de : (deux réponses justes)

A. Plaie du pouce

B. Fracture du pouce

L1p63 (Doc MT Soins Infirmiers)

C. Section du pouce

D. Ecrasement total du pouce

47. L'inflammation se caractérise par les signes suivants sauf un lequel ?

A. La douleur

B. La pâleur

L1p15 (Doc semio chirurgicale)

C. La chaleur

D. La tuméfaction

E. La rougeur

48. Parmi ces éléments cités ci-dessous choisir deux (02) facteurs prédisposant aux infections

A. L'immunodépression

B. La tonicité musculaire

C. Le diabète

D. La fatigue

49. Parmi ces éléments cités, deux (02) sont des germes pathogènes

A. Noyau de l'atome

B. Corona virus

C. Mitochondrie d'une cellule

D. Rétrovirus

E. Ribosome d'une cellule

50. Il y a septicémie lorsque l'infection se généralise dans : donner la bonne réponse

A. Le tissu musculaire

B. Le tissu osseux

L1p21 (Doc semio chirurgicale)

C. Le sang

51. En cas de rétention aigue des urines il faut : (une réponse juste)

A. Poser une sonde naso-gastrique

B. Poser une sonde urinaire

L2p164 (Doc chirurgie)

C. Poser un drain

D. Alimenter le malade

52. Après une pose de plâtre à un fracturé du radius et du cubitus ces deux signes sont à surveiller

A. Nausée et vomissements

B. Fièvre

C. Froideur des extrémités

D. Douleur sous plâtre

E. Soif et vertige

53. Le mal de pott est occasionné par :

A. Le candida Albicans

B. Le streptocoque

L1p35 (Doc semio chirurgicale)

C. Le bacille de koch

54. L'autoclave stérilise par :

A. La chaleur sèche

B. La chaleur humide

L1p15 (Doc semio chirurgicale)

C. La radiation

D. Procédés chimiques

55. Le traumatisme du rachis peut concerner ces organes sauf un : lequel ?

A. Les méninges

B. La moelle épinière

C. Le disque intervertébral

D. La boîte crânienne

56. Parmi ces éléments ci-dessous cocher deux (02) buts de l'immobilisation provisoire

A. Eviter l'aggravation des lésions

L1p65 (Doc MT Soins Infirmiers)

B. Permettre la cicatrisation de la lésion

C. Poser un plâtre

D. Eviter tout déplacement osseux pendant l'évacuation du malade

57. Parmi les matériels cités ci-dessous deux (02) sont nécessaires dans une immobilisation provisoire

L1p66 (Doc MT Soins Infirmiers)

A. La gouttière

B. Le marteau

C. La seringue

D. Un antibiotique

E. Une bande

58. Le dakin est un antiseptique utilisé en cas de : donner la réponse juste

A. Plaie linéaire propre

B. Plaie non suppurée

C. Plaie suppurée

59. La péritonite aigue peut-être causée par :

A. Une salpingite

B. Une appendicite aigue non traitée à temps

L2p123 (Doc chirurgie)

C. Diarrhée profuse

D. Un jeûne prolongé

E. Une obésité morbide

DE BLANC MEDECINE AGBOVILLE 2025**I. OCD**

Q1. L'énurésie est une miction incontrôlée qui survient au cours du sommeil. **B L1p39(Doc de Sémio Médicale)**

Q2. Le diagnostic de la lipothymie se fait par constat d'une perte de connaissance brève et spontanée suivie de convulsions. **B L1p23(Doc de Sémio Médicale)**

Q3. Le VIH se transmet par les baisers, même avec la langue. **B**

Q4. Le préservatif, le dépistage, et les traitements comme la PrEP : sont les trois méthodes principales pour se protéger du VIH. **A**

Q5. Le syndrome vipérin provoque des saignements internes ou externes dus à des troubles de la coagulation. **A**

Q6. Les effets des venins de serpents vipéridés et élapidés sont très différents. **A**

Q7. Le traitement antituberculeux standard la phase initiale dure 4mois. **B**

Q8. La phase initiale comprend Rifampicine + Isoniazide + Pyrazinamide + Ethambutol. **A**

Q9. L'infarctus myocardique est une douleur angineuse intolérable d'irradiation multiple insensible à la nitroglycérine sublinguale. **A**

Q10. La chylurie est la présence de lymphes dans les urines donnant un aspect laiteux liée à une affection parasitaire ou consécutive à une intervention chirurgicale. **A**

Q11. Le rapport vaginal, anal et la fellation peuvent transmettre le virus. **A**

Q12. Le cunnilingus, les caresses et la masturbation ne transmettent pas le VIH. **B**

Q13. La pilule contraceptive protège contre le VIH. **B**

Q14. La pilule protège contre les grossesses, et les infections sexuellement transmissibles. **B**

Q15. Le liquide céphalo-rachidien a pour rôle d'assurer la protection mécanique du cerveau et de la moelle épinière. **A**

Q16. Le liquide céphalo-rachidien a pour rôle d'assurer le maintien de l'homéostasie cérébrale. **A**

Q17. Le solde hydrique est **la somme** des entrées et des sorties lors d'une hydratation vasculaire. **B** (la différence)

Etude de cas 1 : *Monsieur K. 28 ans, est admis aux urgences pour fièvre persistante depuis 7 jours, céphalées, douleurs abdominales et diarrhée nauséabonde d'aspect jus de papaye. Il revient d'un séjour dans une zone rurale où l'accès à l'eau potable est limité. Durant son séjour il a subi de jour comme de nuit les piqures de moustiques. À l'examen : température à 39,5°C, langue saburrale, splénomégalie modérée, douleurs à la palpation abdominale.*

Questions à choix multiple : Bonne réponse : 1 point et mauvaise réponse : 0 point

Q18. Quelle est l'affection principal dont souffre Monsieur K ?

A- Fièvre typhoïde

B- B-Paludisme

C- Amibiase intestinale

Q19. Quels sont les signes cliniques physiques typiques de l'affection de Monsieur K ?

A. Fièvre prolongée

B. Langue saburrale

C. Céphalées

D. Douleurs abdominales

E. Diarrhée ou constipation

F. Splénomégalie

Q20. Parmi les pathogènes suivants, lequel entraîne une infection la plus grave au cours de votre affection de Monsieur K ?

A - Plasmodium falciparum

B- Bacille d'Eberth

C- Salmonella paratyphi

D- Bacille tétanie

Q21. Quels sont parmi les suivants les examens éventuels que demanderiez-vous pour confirmer votre diagnostic ?

A - Hémoculture

B- Goutte épaisse

C- Coproculture

D. Sérodiagnostic de Widal et Félix

Q22. Quels examens complémentaires sont utiles pour le diagnostic de la maladie de Monsieur K ?

A- Sérologie de Widal

B- NFS

C- CRP, VS

D- Ionogramme sanguin

Q23. Parmi les suivantes, quelles sont les maladies réalisant un diagnostic différentiel avec l'affection de Monsieur K ?

A- Paludisme en présence d'une goutte épaisse positive

B- Diabète sucré

C- Méningites infectieuses

D- Hépatites virales

E- HTA

Q24. Relever parmi les suivants, les éléments composites du rôle que joue l'infirmier dans la prise en charge l'affection de Monsieur K.

A- Surveillance des constantes vitales

B- Administration des traitements

C- Education du patient sur l'hygiène et la prévention

D- Initiation des examens biologiques de contrôle

E- Prévention des complications

Q25. Les articulations du protocole de traitement recommandé sont les suivants : choisir les propositions justes.

A- Antibiothérapie adaptée à la céphalosporine selon la sensibilité

B- Mise au sport

C- Réhydratation orale ou Intraveineuse

D- Surveillance clinique et biologique

E- Alimentation liquide puis semi-liquide

F- Isolement si nécessaire

Dix jours après la sortie de Monsieur K., il est réadmis au service des urgences pour douleur abdominale intense et fièvre élevée depuis 2 heures avec un état général altéré, température à 39,8°C, abdomen très douloureux avec défense généralisée, absence de transit depuis 24h, pouls à 120 bpm. Une radiographie abdominale montre un pneumopéritoine.

Q26. Quel diagnostic évoquez-vous ?

A. Perforation intestinale sur fièvre typhoïde

B. Appendicite typique

C. Rupture de la rate

Q27. Quels sont parmi ceux-ci, les examens qui doivent être réalisés en urgence ?

A - Radiographie thoraco-abdominale

B- Bilan biologique

C- Sérodiagnostic de widal et Félix

D- Groupe sanguin

E- ECG, TP-TCA

F. Echographie abdominale

II. QCM

Q28. Retrouver parmi les suivantes les IST pouvant être transmises par fellation non protégée ?

A - Aucune

B- VIH, syphilis, herpes, chlamydia

C- Grippe

D- Hépatite A uniquement

Q29. Les principales situations à risque d'apparition d'un coma hypoglycémique incluent les éléments suivants excepté un : seules les bonnes réponses sont attendues

A- Jeûne prolongé ou alimentation insuffisante

B- Effort physique intense sans apport glucidique suffisant

C. Consommation d'alcool

D- Consommation incontrôlée de la viande rouge

E- Pathologies du foie, reins ou des glandes endocrines

F- Erreurs thérapeutiques ou interactions médicamenteuses

Q30. Un accident est rencontré au cours du lavage d'estomac ; lequel ?

A- Fausse route

B- Nausées

C- Impossibilité d'introduire le tube chez les sujets nerveux

Q31. Parmi les activités infirmières ci-dessous citées, en cas d'hémorragies digestives, lesquelles ?

A- Reconnaître le type d'hémorragie

B- Surveiller la transfusion

C- Administrer le traitement prescrit par le médecin

D- Allonger le patient tête basse sur le côté pour éviter toute inhalation

E- Prendre deux voies veineuses de gros calibre et placer un soluté à grosse molécule sur avis médical.

Q32. Au cours d'un coma hypoglycémique, la phase neuro-végétative est caractérisée par les signes cliniques suivants : seules les bonnes réponses sont attendues

A- Transpiration abondante

B- Palpitations

C- Tremblements

D- Confusion mentale

E- Faim intense

F- Trouble visuel

Q33. Face à un coma hypoglycémique, le bilan biologique comprend les éléments suivants sauf un : seules les bonnes réponses sont attendues

A- Glycémie capillaire ou veineuse très élevée

B- Augmentation éventuelle du taux d'insuline dans le cadre d'un insulinome ou d'un surdosage

C- Hypokaliémie, acidose lactique dans certains cas

Q34. La prise en charge du patient en hypoglycémie conscient se fait comme suit

A. Administration orale de sucre

B. Evacuation vers un centre spécialisé

C. Injection intraveineuse de glucose hypertonique

Q35. Quels sont parmi les suivants trois accidents pouvant survenir lors d'une ponction d'ascite.

- A- Ponction d'un organe
- B- Choc hypovolémique par évacuation trop rapide.
- C- Douleur transitoire après la ponction
- D- Hémoperitoïne

Q36. Parmi les affirmations suivantes, quelle(s) est (sont) celle(s) qui concerne(nt) le plasma ? Le plasma :

- A. Est le liquide qui reste lorsqu'on a retiré les éléments figurés du sang
- B. Est constitué de sérum et de fibrinogène
- C. Est un mélange de leucocytes et d'alumine
- D. Renferme de l'eau, de sels minéraux, de glucides, de liquides et protides

37. La réalimentation de costrectomisé de type partiel aorés la première semaine, compose : cocher la bonne

- A- Des aliments semi-liquides
- B- Des aliments solides
- C- Des jus de viande

Q38. Peut-on transmettre une IST sans pénétration ?

- A- Non
- B- Oui, par simple contact cutané avec des lésions
- C- Seulement par la salive
- D- Uniquement par le sang

Q39. Existe-t-il des vaccins contre certaines IST ?

- A- Non
- B- Oui, contre le VIH et la syphilis
- C- Oui, contre l'hépatite B et le papillomavirus
- D- Oui, contre toutes les IST

Q40. Le syndrome ulcéreux typique 30% associe : cocher la bonne réponse

- A - Une douleur
- B- Une dyspepsie
- C- Une notion de poussées

Q41. Quel est la conduite thérapeutique salvatrice immédiate ?

- A- Laparotomie avec suture de la perforation suivie de lavage péritonéal
- B- Vacciner le malade immédiatement
- C- Remplissage IV, antibiothérapie à large spectre
- D- Isoler le malade pour éviter la contamination
- E- Surveillance post-opératoire intensive

Q42. Les éléments constitutifs du rôle infirmier dans ce contexte sont les suivants ?

- A- Prise en charge en soins intensifs
- B- Education des parents pour la surveillance en post-opératoire
- C- Surveillance des constantes et de la douleur
- D- Pose de voie veineuse + perfusions
- E- Préparation au bloc opératoire

Q43. Dans les propositions suivantes, quel est le meilleur moyen de savoir si on a une IST ?

- A- Regarder son sexe
- B- Se faire dépister
- C- Chercher sur Internet

D- Attendre les symptômes

Q44. Le calcul de volume globulaire moyen est le rapport de :

- A- l'hématocrite sur le nombre de globules rouges,
- B- l'hémoglobine sur le nombre de globules rouges,
- C- l'hémoglobine sur l'hématocrite

Q45. Parmi les infections sexuellement transmissibles suivantes, laquelle est la plus fréquente chez les jeunes

- A- VIH
- B- Chlamydia
- C- Herpès génital
- D- Syphilis

Vous recevez un patient à votre garde et le médecin vous joint au téléphone et vous informe que le patient souffre d'une pneumonie ;

Q46. Relever parmi les conduites suivantes, celles adoptées en présence d'un coma hypoglycémique chez un patient inconscient :

- A- Injection intraveineuse de glucose hypertonique
- B- Injection intramusculaire de glucagon si accès IV difficile
- C- Surveillance discontinue de la glycémie après la correction
- D- Identifier et traiter la cause sous-jacente

Q47.

- A-
- B- Vomissement incoercible
- C- Toux productive, avec des expectorations parfois purulentes ou teintées de sang.
- D- Ballonnement abdominal
- E- Douleur thoracique augmentée à la respiration, souvent de type pleurétique,

Q48. Relevez les principales étiologies des pneumonies à partir des propositions ci-après ?

- A- Bactériennes
- B- Virales
- C- Pneumonie nosocomiale
- D- Fongiques
- E- Pneumonie d'aspiration
- F- Parasitaire

Vous êtes infirmier à l'EPHR Agboville disposant d'un laboratoire d'analyses médicales et d'un service de radiologie. Le médecin s'est absenté pour 24 heures. Vous recevez un malade sur lequel vous posez le diagnostic d'une colique néphrétique.

Q49. Décrivez votre conduite infirmière en insistant sur les premières mesures urgentes :

- A- Installer le patient en position antalgique, souvent semi-assise.
- B- Administrer un antalgique selon protocole en vigueur ou sur prescription anticipée
- C- Surveiller les constantes
- D- Prélever pour analyse urinaire et biologique pour bilan rénal, NFS, CRP.
- E- Informer le médecin dès son retour ou par téléphone en cas de signes de gravité

Q50. Les signes négatifs de la vie ou arrêt des grandes fonctions sauf deux : 3 réponses justes sont attendues

- A- Arrêt cardiaque, respiratoire ;
- B- Rigidité cadavérique, les lividités
- C- Abolition de toute conscience, toute sensibilité, aréflexie,
- D- Perte du tonus musculaire et mydriase,
- E- Refroidissement cadavérique

Q51. Les principaux virus responsables des pneumonies sont les suivants :

- A- SARS-CoV-2
- B- Streptococcus pneumoniae
- C- Virus respiratoire syncytial

Q52. Trois activités infirmières sont à reconnaître dans le rôle de l'infirmier en cas d'hépatite virale ; lesquelles ?

- A- Accueillir et installer le patient
- B- Ecouter avec empathie les problèmes du patient
- C- Observer et enregistrer les divers degrés de l'ictère
- D- Evaluer et apprécier l'importance du saignement
- E- Participer à l'examen médical
- F -Cancer de l'abdomen

Q53. Les Signes cliniques de l'état de choc sont les suivants sauf un, lequel ?

- A- Hypotension artérielle
- B- Bradycardie régulière
- C- Marbrures cutanées, extrémités froides
- D- Trouble de la conscience
- E- Diminution du débit urinaire

Q54. Les signes biologiques de l'état de choc sont les suivants sauf deux : 3 bonnes réponses attendues

- A- Acidose métabolique
- B- Réduction du lactate sanguin
- C- Insuffisance rénale
- D- Hypokaliémie possible
- E- Hypoxie tissulaire

Q55. Les limites des soins à domicile sont les suivantes : Choisir les 3 bonnes réponses

- A - Prendre en compte toutes les situations
- B- Difficultés à contrôler à domicile certains symptômes.
- C- Sentiment de sécurité à domicile.
- D- Incapacité à gérer une situation d'urgence
- E- Facilité et enthousiasme de l'entourage à supporter certaines complications
- F- Epuisement des soignants naturels

Q56. Les principales questions d'éthique à domicile chez une personne atteinte de VIH/sida sont les suivantes : choisir les 3 réponses justes

- A- La confidentialité,
- B- L'implication des différents membres de la famille à tous les niveaux des soins
- C- Le respect de l'autonomie du malade,
- D- Discretion autour du prendre soin

Q57. Quels sont parmi les suivants les trois signes cliniques fonctionnels de l'insuffisance cardiaque gauche

- A- Dyspnée d'effort
- B- Rales crépitants aux bases pulmonaires
- C- Orthopnée

D- Toux nocturne et expectoration mousseuse rosée

E- Tachycardie, bruit de galop

Q58. Les affections citées ci-dessous sont les contre-indications des aspirations digestives sauf deux (2) : lesquelles ?

A- Occlusion intestinale

B- Cancer de l'estomac

C- Perforation de l'estomac

D- Hémorragies digestives

Q59. Ces pathologies énumérées ci-dessous constituent des contre-indications du cathétérisme sus-pubien exceptées deux (2) ; lesquelles ?

A- Rétention urinaire aigüe

B- Infection urinaire

C- Troubles de l'hémostase

D- Rétention urinaire chronique

E- Tumeurs de la vessie

F- Couper les ongles du patient pour éviter les lésions de grattage

Q60. Quel est le but de la réalisation de La ponction d'ascite ? : Une seule réponse attendue

A- Thérapeutique

B- Diagnostic

C- Diagnostic et thérapeutique

DE BLANC PEDIATRIE AGBOVILLE 2025**OCD**

1- En cas de menace d'accouchement prématuré avant 33 semaines d'aménorrhée, vous en tant qu'agent de santé suivant la grossesse vous injectez 12 mg de bétaméthasone en

Intramusculaire (deux injections espacées de 24h) à la gestante. Cette thérapeutique a pour but de prévenir un accouchement prématuré. **B**

2- En salle de naissance, pour décider de la réanimation d'un nouveau-né, le principal élément à évaluer est sa respiration. **A**

3- L'allaitement exclusif est le fait de ne donner que du lait maternel et de l'eau au nouveau-né jusqu'à 6 mois ? **B**

4- L'attitude de la grand-mère est-elle une attitude correcte ? (Libellé de la question 7) **B**

5- La mise au sein précoce, est une recommandation forte de l'Organisation Mondiale de la santé. Elle consiste à mettre le nouveau-né au sein dans les 3 heures qui suivent la naissance.

B

6- Le nouveau-né KS de sexe féminin (né à 38 semaines d'aménorrhée + 4 jours) a reçu 1 mg de vitamine K en intramusculaire à la naissance. A 3 jours de vie KS présente un écoulement vaginal sanguinolant mêlé à une substance gluante blanchâtre de petite quantité. Le premier diagnostic évoqué est la maladie hémorragique du nouveau-né. Le diagnostic est-il correct ?

B

7- Le nouveau-né KY de J3 de vie, de sexe masculin a une tuméfaction bilatérale de deux seins, sans inflammation locale. La mère est très inquiète et la grand-mère exige l'expression des seins, car selon elle, il faut y extraire le lait. S'agit-il d'une crise génitale ? **A**

8- Le prématuré YX né à 33 SA, avec un poids de 1700g, une taille de 45 cm et un PC de 30 cm. Une fréquence respiratoire de 40 cycles/mn, une fréquence cardiaque de 124 bat / mn et une température de 36°C peut être pris en charge par les soins mère kangourou parce qu'il est stable ? **A**

9- Les infections respiratoires aiguës hautes sont très fréquentes chez les enfants de moins de 5 ans, la première cause est constituée des infections bactériennes. Cette assertion est-elle correcte ? **B**

10- NA est né à 40 semaines + 6 jours d'aménorrhée avec un poids de 3900 g, une taille de 51 cm et un périmètre crânien de 35 cm. Ce jour à J7 de vie au premier contrôle il pèse 3700g, son périmètre crânien est à 35 cm et sa taille à 51 cm. Selon la mère il tète bien et à votre examen il ne présente aucun signe anormal. NA a-t-il perdu plus de 10% de son poids de naissance ? **B**

$$10\% \text{ de } 3900 = 390$$

$$3900 - 390 = 3510g$$

11- L'enfant DA âgé de 26 mois vous est amené en urgence pour paludisme grave forme convulsions répétées avec une crise convulsive en cours. Quel sera le soin délégué que vous ferez en premier ?

A- Injecter un antipyrétique

B- injecter du diazépam

12- Un enfant de 4 ans qui présente les signes suivants : - Assoiffé, boit avec avidité - Effacement lent du pli cutané. Est classé dans le plan C. **B**

13- Offrir à boire à l'enfant de plus de 6 mois le plus souvent possible est un moyen physique de lutte contre la fièvre. **A**

14- Lors de la réanimation du nouveau-né en salle d'accouchement, l'aspiration débute par l'aspiration des fosses nasales avant l'aspiration de la cavité buccale. **B**

15- Les gouttes ophtalmiques ne doivent pas être instillées dans l'œil de l'enfant pendant qu'il dort. **B**

16- Les déshydratations aiguës graves peuvent occasionner la fièvre. **A**

- 17- Les causes d'échec d'une ventilation efficace au ballon auto-gonflable lors de la réanimation du nouveau-né en salle de naissance sont la flexion du cou, l'obstruction des voies respiratoire supérieur et le mauvais positionnement du masque à ventiler. **A**
- 18- Les battements des ailes du nez, l'entonnoir xiphoïdien, le balancement thoraco-abdominal sont des signes de lutte respiratoires utilisés pour évaluer la gravité de la détresse respiratoire du nouveau par le score de Silverman. **A**
- 19- Le syndrome de détresse respiratoire fait partie des signes de gravité du paludisme selon la classification de l'OMS ? **A**
- 20- La voie de contamination la plus fréquente lors de l'infection bactérienne néonatale est le passage de la filière génitale maternelle. **A**
- 21- La souffrance néonatale est un facteur favorisant des crises convulsives. **A**
- 22- La prise en charge de l'hyperthermie majeure chez l'enfant de moins de 5 ans par des soins propres à l'agent de santé et des soins délégués est une urgence car elle peut entraîner des convulsions et une atteinte cérébrale souvent irréversible. **A**
- 23- La maladie des membranes hyaline (déficit en surfactant) est une cause fréquente de détresse respiratoire chez le nouveau-né à terme. **B**
- 24- La diarrhée persistante est une diarrhée qui évolue depuis plus de 21 jours. **B**
- 25- La date d'apparition du saignement dans la maladie hémorragique du nouveau-né par rapport à la naissance est habituellement située entre le 10^{ème} et 145 jour. **B**
- 26- L'enfant âgé de 1 mois a droit à 100 ml de Ration par Repas. **B**
- 27- En cas de Tachypnée chez le nouveau-né, la fréquence respiratoire est supérieure à 60 Cycles par minute. **A**

OCM

- ❖ *Le nouveau-né OJ (né à 39 SA) est âgé de 2 heures de vie et n'a pas tété depuis sa naissance, Il est posé sur la paillasse par la sage-femme non habillé et recouvert d'un morceau-de pagne. Sa mère a accouché par voie basse, elle est installée en suite de couche sans problème particulier. Elle réclame son nouveau-né.*

28- Quels sont les besoins (selon Virginia Henderson) non couverts de ce nouveau-né ? identifiez-les parmi les éléments de cette liste.

- a- Besoin de se mouvoir et maintenir une bonne posture
- b- Besoin de maintenir sa température dans les limites d la normale
- c- Besoin de boire et de manger
- d- Besoin de respirer
- e- Besoin d'éliminer

- ❖ *Le nourrisson BA âgé de 8 mois poids 8,5kg. Émet depuis 48 heures 7 selles liquides et fétides par jour. Sa mère, de peur qu'il continue à émettre les selles liquides ne lui donne pas à boire de l'eau. Arrivé à l'hôpital BA a une température de 38°5 C. A l'examen physique, il a les yeux enfoncés, la langue sèche. Un pli de déshydratation qui s'efface lentement, il est fatigué mais conscient. Vous lui proposez à boire et là il boit avec avidité.*

29- Quel est votre diagnostic ?

- a- Diarrhée fébrile
- b- Diarrhée aigue + signes de déshydratation sévère
- c- Diarrhée aigue + signes évidents de déshydratation
- d- Déshydratation fébrile

30- Où se fera la prise en charge de l'état d'hydratation de BA ?

- a- Exclusivement à l'hôpital
- b- A l'hôpital et à la maison
- c- A la maison exclusivement
- d- A l'hôpital ou à la maison

31- Quels sont les besoins fondamentaux non couverts par BA ?

- a- Besoin de respirer
- b- Besoin de maintenir sa température dans les limites de la normale
- c- Besoin de manger et de boire
- d- Besoin d'être propre, soigner et protéger ses téguments
- e- Besoin d'éviter le danger
- f- Besoin d'éliminer

32- Quel est le soin propre à l'agent de santé que vous allez administrer à BA ?

- a- Faire baisser la température de BA par des mesures physiques
- b- Prescrire un antipyrétique aux parents pour faire baisser la température
- c- Donner à boire une solution de réhydratation à BA
- d- Faire des prélèvements pour identifier la cause de la maladie
- e- Faire mettre BA au sein.

33- La prise en charge de l'état d'hydratation de BA se fera avec quel médicament selon les recommandations nationales ?

- a- Le Ringer lactate par voie parentérale
- b- La solution de réhydratation par voie orale (OMS)
- c- Le sérum glucosé avec des électrolytes
- d- Le ReSomal (solution de réhydratation pour malnutri)

❖ *Il s'agit du nourrisson DN âgé de 7 mois (nourri au sein exclusivement jusqu'à 6 mois et la mère a débuté la diversification alimentaire selon vos recommandations) vivant dans la localité nommée LOGO, qui est amené par sa mère parce qu'il tousse et fait de la fièvre depuis 2 jours. A votre examen son poids est à 8,4kg, sa température est à 38,3°C, sa fréquence respiratoire 60 cycles par minutes, sa fréquence cardiaque est à 120 battements par minute. Sa saturation en oxygène est à 99%. Vous pensez à une infection respiratoire aigüe.*

34- Identifiez dans cette liste les données d'indépendance présents dans le texte.

- a- Age
- b- Sexe
- c- Température : 38,3°C
- d- Poids : 8,4kg
- e- Adresse : LOGO

35- Identifiez dans cette liste ci-dessous les données de dépendance présentent dans le texte au-dessus.

- a- Nourri exclusivement au sein jusqu'à 6 mois
- b- Poids 8,4 kg
- c- Température : 38,3°C
- d- Fréquence respiratoire 60 cycles/mn
- e- Saturation en oxygène à 99% « valeur normale $\geq 95\%$ »

36- Identifiez dans la liste ci-dessous l'éléments lié à une atteinte de l'intégrité physique et psychique (les eux associés) de BA

- a- Fièvre (température 38,3°C)
- b- Fréquence respiratoire 60 cycles /mn
- c- Poids 8,4 kg
- d- Nourri exclusivement au sein jusqu'à 6 mois puis diversification selon les recommandations.

37- Identifiez dans cette liste ci-dessous les étapes dans l'ordre de la démarche de soins infirmiers en pédiatrie.

- a- Collecte des données - interprétation des données - diagnostic médical - besoins fondamentaux non satisfaits- planifications des soins
- b- Collecte des données - interprétation des données - diagnostic infirmier - besoins fondamentaux non satisfaits- planifications des soins
- c- Collecte des données - analyse et interprétation des données - diagnostic infirmier- besoins fondamentaux non satisfaits- planifications des soins**
- d- Collecte des données - analyse des données - diagnostic infirmier – besoins fondamentaux non satisfaits- planifications des soins

❖ *Nouveau-né TS né à 37 SA avec un poids de 2900g, n'a pas reçu de vitamine K1 à la naissance mais a reçu le vaccin contre l'hépatite B. A 3 jours de vie, lors de sa vaccination (BCG, Polio 0) présente un saignement au point d'injection et une rectorragie constatée par la sage-femme. Sa température est de 36°8C, sa fréquence respiratoire 48 cycles/mn et sa Fréquence cardiaque à 130 bat/mn. Le diagnostic retenu par l'équipe de soins est la maladie hémorragique du nouveau-né.*

NB : libellé des question 38 et 39

38- Quel est le principal besoin fondamental non satisfaisant de TS

- a- Besoin de respirer
- b- Besoin de manger et boire
- c- Besoin d'éviter le danger**
- d- Besoin d'éliminer

39- Pour sa prise en charge la prescription du médecin que vous devez exécuter est la suivante (choisissez la réponse exacte en rapport avec l'état de TS) :

- a- Vitamine K**
- b- La transfusion sanguine
- c- Vitamine ADEC
- d- Fer + vitamine K

❖ *Nouveau-né TD né à 33 SA, vivant à Agboville quartier résidentiel, le contact de sa mère est 27 00 01 02 03. Il est nourri exclusivement au lait maternel, TD n'a pas reçu de vitamine K1 à la naissance, aujourd'hui il a 5 jours de vie et présente une hématurie et une hématurie. Il pèse 2200g et à une température de 35°C. le diagnostic médical est la maladie hémorragique du nouveau-né. L'analyse des données de TD révèle des données indépendantes (DI) et des données dépendantes (DD).*

40- Choisir la réponse exacte parmi les éléments de cette liste.

- a- 5 DI et 6 DD
- b- 4 DI et 7 DD
- c- 7 DI et 4 DD
- d- 6 DI et 5 DD**

41- Vous êtes agent de santé, dans le cadre de la prévention de l'infection néonatale vous faites ces recommandations à la mère sauf une, laquelle ?

- a. Sensibilisez la mère à effectuer au minimum 4 CPN;
- b. Sensibilisez la mère à réaliser le bilan prénatal prescrit ;
- c. Référez précocement en milieu spécialisé les infections génitales pendant la grossesse;**
- d. Référez précocement en milieu spécialisé toutes les grossesses à risque

42- Retrouvez dans cette liste les deux principaux problèmes liés aux diarrhées aiguës de l'enfant

a- Déshydratation

b- Infectieux

c- Respiratoires

d- Dénutrition

e- Hématologiques

43- La bronchiolite est fréquente :

a. Chez le nouveau-né

b. Chez le nourrisson de 6 mois à 2 ans

c. Chez l'enfant de 2 ans à 5 ans

d. Chez l'enfant de 5 ans à 15 ans

44- Vous recevez le nourrisson TD âgé de 14 mois, lors de l'évaluation de son état nutritionnel, vous trouvez que TD a une malnutrition aigüe modérée, son Z score

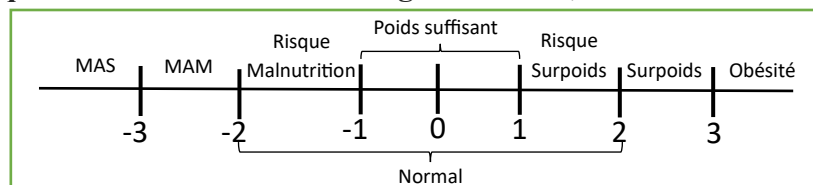
Poids/taille est donc de :

a- $0 < Z \text{ score} < -1$

b- $-1 < Z \text{ score} < -2$

c- $-2 < z \text{ score} < -3$

d- $Z \text{ score} < -3$



45. Un nourrisson de 14 mois qui a une malnutrition aigüe sévère compliquée d'œdème et d'infection pulmonaire sera (cochez la réponse exacte) :

a- Pris en charge avec du lait F75, du lait F100 et des Aliments thérapeutiques prêts à l'emploi (ATPE) en milieu hospitalier

b- Pris en charge avec des Aliments thérapeutiques prêts à l'emploi (ATPE) uniquement et en milieu hospitalier

c- Pris en charge avec du lait F75, du lait F100 et des Aliments thérapeutiques prêts à l'emploi (ATPE) en ambulatoire (en communauté)

d- Pris en charge avec des Aliments thérapeutiques prêts à l'emploi (ATPE) en ambulatoire (en communauté).

46- Nouveau-né KM de sexe Masculin vivant avec sa mère à Tiassalé, né 33 Semaines d'aménorrhée. Poids de naissance 2250g. Taille de naissance à 45 Cm et Périmètre Crânien à 31 cm. Apgar : 8 et 9 (1 minute et 5 minutes). KM est nourri exclusivement au lait maternel et bénéficie de la position Kangourou, il n'a pas reçu de vitamine K1 à la naissance et présente à J5 de vie un Saignement en nappe au niveau de l'ombilic. Sa température est de 36°8C. Le médecin pense à une maladie hémorragique du nouveau-né. La réalité personnelle favorable de KM comprend :

a. 2 favorables

b. 3 favorables

c. 4 favorables

d. 5 favorables

47- Nouveau-né KM de sexe Masculin vivant avec sa mère à Tiassalé, né 33 Semaines d'aménorrhée. Poids de naissance 2250g. Taille de naissance à 45 Cm et Périmètre Crânien à 31 cm. Apgar : 8 et 9 (1 minute et 5 minutes). KM est nourri exclusivement au lait maternel et bénéficie de la position Kangourou, il n'a pas reçu de vitamine K1 à la naissance et présente à J5 de vie un Saignement en nappe au niveau de l'ombilic. Sa température est de 36°8C. Le médecin pense à une maladie hémorragique du nouveau-né. La réalité personnelle défavorable de KM comprend :

a. 2Défavorables

b. 3Défavorables

c. 4Défavorables

d. 5Défavorables

48- Le prématuré est également un enfant à risque la gravité de son état est lié à l'âge gestationnel. C'est pourquoi le grand prématuré est entre

- a. [28 -32 SA]
- b. [27 - 30 SA]
- c. [22 - 27]

49- On parle de Risque de Surpoids quand le :

- a. Z-Score est $< - 3$;
- b. $-3 < \text{Z-score} < - 2$;
- c. $-2 < \text{Z-score} < - 1$;
- d. $+1 < \text{Z-score} < + 2$;

VOIR TABLEAU QUESTION 44

50- La solution de Chlorhexidine s'applique sur le cordon frais de la manière suivante :

- a. A la pointe du cordon, sur le moignon et à la base du cordon
- b. A la base du cordon
- c. Sur le moignon
- d. A la pointe du cordon

51 - L'asthme est :

- a. Une maladie inflammatoire aigue des bronchies ;
- b. Une maladie inflammatoire chronique des bronches ;
- c. Une maladie inflammatoire chronique des bronchioles ;
- d. Une maladie inflammatoire aigue des bronchioles ;

52- Parmi les propositions suivantes entourez celles qui sont en faveur de l'otite chronique :

- a. Évolue depuis moins de 15 jours ;
- b. Évolue depuis plus de 15 jours ;
- c. Évolue depuis moins de 7 jours ;
- d. Évolue depuis plus de 7 jours ;

53- Les facteurs de risque de la Détresse Respiratoire liés à la mère sont :

- a. Insuffisance respiratoire aigüe ;
- b. CPN suffisante ;
- c. Accouchement à domicile ;
- d. Accompagnée des troubles métaboliques chez le nouveau-né.

54- On parle de Malnutrition Aigüe sévère lorsque le :

- a. Z-Score est $< - 3$;
- b. $-3 < \text{Z-score} < - 2$;
- c. $-2 < \text{Z-score} < - 1$;
- d. Z-score $> - 1$;

VOIR TABLEAU QUESTION 44

55- Le devenir d'un nourrisson souffrant d'anorexie est L2p122

- a. Retard de croissance ;
- b. Cassure de la courbe de croissance ;
- c. Régression psychomotrice ;
- d. Dépression ;

56- Le réflexe de MORO s'obtient par :

- a. La plante des pieds posées sur un plan froid ;
- b. L'excitation de la paume de la main de l'enfant ;
- c. Un grand bruit auprès du nouveau-né ;

57- Les examens para cliniques pour une fièvre aigue sont :

- a. Goutte épaisse/frottis sanguin
- b. Sérodiagnostic de Widal et Félix

- c. IDR tuberculine
- d. Radiographie pulmonaire

DE BLANC SANTE PUBLIQUE AGBOVILLE 2025

QCD

1. Le vaccin Matrix R21 respecte la politique des vaccins multidoses. **A**
2. 134 pays du sud et 67 organisations des Nations-Unies se sont réunis du **8 au 12 septembre** 1978 à la conférence d'Alma Ata pour décider de la stratégie des SSP. **B L1p74 (6 au 12 sept)**
3. Le taux de PFA est dit non poliomyélitique lorsque le nombre de cas de **PFA est ≤ 2** pour 100000 enfants de moins de 15 ans. **B L2p66 (PFA est ≥ 2)**
4. Le vaccin Rougeole et Rubéole (RR) est un vaccin lyophilisé. **A L2p48**
5. Les doses jetées avec les flacons de vaccins reconstitués en fin de séance sont des doses gaspillées. **A**
6. Pour décider de la référence, le prestataire de soins de l'ESPC se sert de **l'organigramme**. **B L3p18 (ordinogramme)**
7. Un coefficient de majoration supérieur à 1,5 indique que les services sont financièrement inaccessibles pour la majorité. **A L 3p9**
8. Un taux d'utilisation de vaccins élevé est synonyme d'une bonne gestion des stocks de vaccins. **B**
9. Un vaccin dont la PCV à virée et qui ne peut plus être utilisé est **un vaccin sacrifié**. **B L2p38(vaccin sacrifié est une dose administrée aux pop hors cibles)**
10. Une recette moyenne par cas de 1245 FCFA avec un coût moyen de 855 FCFA donne un coefficient de majoration de 1,5. **B ($\frac{1245}{855} = 1,45 \neq 1,5$)**
11. Vous constatez dans votre centre que le coût moyen par cas est supérieur à la recette moyenne par cas, votre centre est **excédentaire**. **B L3p9(Non viable)**
12. Dans un monitoring, les indicateurs sont mesurés par les déterminants de couverture retenus. **A L3p4**
13. L'information sanitaire est utilisée pour le monitoring des activités des structures de santé. **A L3p27**
14. La CCSC réalise un but social commun à travers les efforts et les contributions de tous. **A**
15. La promotion de la santé consiste à permettre aux individus de mieux maîtriser les déterminants de la santé et d'améliorer leur santé. **A L1p7**
16. Le budget d'un ESPC **est prévisionnel**. **B L3p15 (n'est pas prévisionnel)**
17. Le district est l'unité sanitaire décentralisée regroupant tous les services sanitaires publics tant en milieu urbain que rural. **A**
18. **Le seuil d'alerte** est le niveau à partir duquel la riposte doit être déclenchée face à une menace d'épidémie. **B L1p84(Le seuil d'action)**
19. Le système d'information et de gestion est **un outil d'analyse** des données des activités de santé et de gestion dans les ESPC. **B L3p34 (un outil de collecte continue)**

ETUDE DE CAS 1 : L'ESPC de Akakro dessert 6 800 habitants dans un rayon de 10 km. $\frac{1}{4}$ de la population résidente à moins de 5km.

Le personnel de santé organise chaque semaine une séance de vaccination. Malgré une forte mobilisation communautaire, on note des ruptures fréquentes de DN Hep, RR, Td ; VAP des erreurs d'enregistrement ; une négligence de l'IEC/CCSC et des plaintes des parents concernant l'accueil et l'attente.

20. Cocher le lieu de rangement du vaccin DN Hep dans un réfrigérateur horizontal

- A. Etagère supérieur
- B. Etagère du milieu

C. Etagère du Bas

21. Cocher les deux vaccins vivants atténués dans cette liste

A. DN Hep

B. BCG

C. RR

D. Td

E. VAP

22. Cocher le nombre de séance de vaccination recommandé pour l'ESPC de Akakro

L 3p59

A. Une séance par quinzaine

B. Une séance par semaine

C. Deux séances par semaine

D. Trois séances par semaine

Inf 2000hbts = 01 Séance / Mois

Inf 4000hbts = 01 Séance / Quinzaine

Inf 8000hbts = 01 Séance / Semaine

Inf 12000hbts = 02 Séances / Semaine

Inf 20000hbts = 03 Séances / Semaine

**Or la population de
Akakro est de**

23. Dans l'ESPC de Akakro, quel élément compromet le plus directement la qualité des indicateurs de suivi vaccinal ?

A. La mobilisation communautaire élevée mais non structurée

B. Les erreurs fréquentes dans l'enregistrement des données

C. Les ruptures récurrentes de vaccins

D. Les délais prolongés liés à l'attente des parents

24. La voie d'administration du vaccin Matrix R21

A. Intra Dermique

B. Intra veineuse

C. Intra Musculaire

D. Sous Cutanée

25. Cocher le besoin théorique annuel du vaccin VAP pour une stratégie avancée dans l'ESPC de Akakro. Stock existant 1 flacons de deux doses.

A. 1389 flacons

B. 463 flacons

C. 695 flacons

D. 232 flacons

$$Pt = \frac{6800 \text{ hbts}}{4} ; Psf = \frac{1}{4} \times Pt = \frac{6800}{4}$$

$$Psf = \frac{1700 \text{ hbts}}{4}$$

$$Psa = Pt - Psf = 6800 - 1700 = 5100 \text{ hbts}$$

$$P(0-23m) = 6,82\% \times Psa = 6,82\% \times 5100$$

$$P(0-23m) = 348 \text{ Enfts}$$

$$BT = PC \times OV \times NC \times Fp = 348 \times 0,95 \times 4 \times 1,05$$

$$BT = 1389 \text{ doses}$$

$$X = \frac{1389}{2} \quad \begin{array}{c} \xrightarrow{1 \text{ flacon} \rightarrow 2 \text{ doses}} \\ \xleftarrow{1389 \text{ doses}} \end{array}$$

$$X = 695 \text{ flacons}$$

26. A la fin de votre monitoring, vous constatez que votre goulot d'étranglement se situe entre utilisation des services et la couverture adéquate. Identifier deux causes qui justifierais cette situation dans cette liste L2p80

A. Manque d'information

B. Rendez-vous non mentionné

C. Mauvaise gestion des ressources

D. La cherté du coût des actes de santé

E. Absence de supervision

F. Considération sociale

27. Cocher le calendrier vaccinal correct du vaccin VAP (Matrix R21)

A. 4 sem - 6 mois - 1an - 15 mois

B. 4 sem - 6 sem - 14sem - 15 mois

C. 14 sem - 6mois - 1an - 15 mois

D. 6 mois - 8 mois - 9 mois - 15 mois

28. La négligence de l'IEC/CCSC est particulièrement préoccupante car elle :

A. Favorise l'augmentation rapide du nombre d'enfants vaccinés

B. Limite la compréhension des enjeux et réduit l'adhésion des familles

C. Garantit une meilleure fluidité en diminuant le temps d'attente

D. Compense les ruptures de vaccins par une meilleure organisation

29. Les ruptures de vaccins constatées à l'ESPC de Akakro peuvent être interprétées comme :

A. Une contrainte logistique isolée, sans impact sur les objectifs globaux

B. Un obstacle majeur à la couverture vaccinale et à la confiance communautaire

C. La preuve que la communauté utilise les vaccins avec excès

D. Un signe que l'IEC/CCSC est inutile

30. En consultant le cahier de vaccination, l'on constate que seulement 248 enfants ont été correctement et complètement vaccinés en 2025. La couverture vaccinale de l'ESPC de Akakro en 2025 est de :

A. 93%

B. 63%

C. 53%

D. 23%

$$Pt = 6800 \text{ hpts} \quad P(0 \text{ à } 23m) = 6,82\% \times pt = 6,82\% \times 6800 = 464 \text{ Enfts}$$

$$TCV = \frac{248}{464} \times 100 = 53,44\%$$

QCM

31. Cocher les deux rôles d'un agent de santé communautaire dans cette liste :

A. Faire l'éducation sanitaire

B. Faire des soins curatifs

C. Faire la rééducation

D. Faire des visites à domicile

32. A partir de la définition des SSP, cocher les deux propositions incorrectes : L1p7

A. Soins socialement accessibles

B. Soins scientifiquement valables

C. Universellement acceptable

D. Soins technologiquement pratiques

33. L'ampleur d'un problème de santé fait allusion à deux indicateurs de santé. Lesquels ?

A. La létalité

B. L'incidence

C. Le taux de mortalité

D. La prévalence

34. Un système de santé efficient à la capacité L1p30

A. D'offrir la qualité des prestations et l'obtenir des résultats escomptés

B. D'obtenir les meilleurs résultats possibles pour le plus faible coût possible.

C. De faire le meilleur usage possible des ressources disponibles

D. De répondre effectivement aux besoins de la population

35. Le Système National de Santé Ivoirien se caractérise par sa forme pyramidale avec

A. Deux versants et trois niveaux

B. Deux niveaux et trois versants

C. Trois niveaux et trois versants

D. Deux niveaux et deux versants

36. Lequel de ses items fait partie des huit composantes essentielles des SSP. L1p77

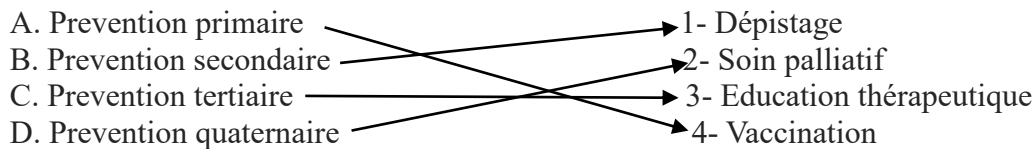
A. Vaccination contre les principales maladies endémiques

B. Prévention et lutte contre les épidémies locales

C. Promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles

D. Traitement des maladies infectieuses et lésions courantes

37. Cocher la bonne combinaison en associant chaque type de prévention l'exemple correspondant Types de prévention Exemples



A. A1- B2-C4-D3

B. A2-B3-C1-D4

C. A3-B4-C2-D1

D. A4-B1-C3-D2

38. Parmi les événements suivants, un seul correspond à l'an 1996. Lequel ? L1p76

A. L'adoption du 1^{er} PNDS par le gouvernement Ivoirien

B. La réorganisation du Système National de Santé Ivoirien

C. L'adoption de la stratégie des SSP par le gouvernement

D. Le démarrage des activités de mise en œuvre des stratégies des SSP

39. Laquelle des assertions ci-dessous renvoie à la caractéristique adaptée des SSP :

A. Des soins répondant aux besoins fondamentaux de l'être humain « **soins essentiels** »

B. Des soins mis à la portée de tous au plan géographique et social « **soins accessibles** »

C. Des soins intimement liés aux secteurs socio-économiques « **soins intégrés** »

D. Des soins conformes aux besoins de santé des populations « **soins adaptée** »

40. Parmi les critères relatifs aux besoins indiquez celui correspondant à la possibilité d'assurer l'hygiène du logement : L1p64

A. Critères relatifs à la protection contre la contagion

B. Critères relatifs aux besoins physiologiques

C. Critères relatifs aux besoins psychologiques

D. Critères relatifs aux besoins de sécurité

41. Cochez les deux phases du processus de traitement des ordures ménagères. L1p66

A. Le stockage

B. Le ramassage

C. L'incinération

D. Le stockage familial

E. Le compostage

F. Le stockage communautaire

42. L'une des méthodes ci-dessous permet de corriger les défauts physiques de l'eau à domicile. Lequel ? L1p62

A. L'ébullition

B. L'ionisation

C. La filtration

D. La chloration

43. Le moyen physique utilisé pour la communication est : L1p87

A. Le message

B. Le codage

C. Le canal

D. Le décodage

44. L'analyse des données sanitaires consiste à : L3p27

A. Présenter les données en tableaux et graphiques

B. Ajouter un sens à l'information et des comparaisons

C. Transformer les données brutes en information utile

D. Mener des actions à partir de l'information produite

45. Les produits livrables du programme ou projet sont : L3p51

A. Les intrants

B. Les extrants

- C. Les impacts
D. Les processus

46. Toutes les composantes d'un programme/projet ci-dessous peuvent être suivi, sauf une. Laquelle ? L3p52

- A. Les extrants
B. Les effets
C. Les intrants

D. Les impacts

- E. Les processus

47. Lequel des critères ci-dessous doit être respecté pour un bon système d'évacuation des excréta : L1p67

- A. La latrine doit être située en aval de toute source d'eau
B. L'installation adoptée doit être très simple et peu coûteux
C. L'emplacement de la latrine doit être dans un endroit sec
D. La latrine doit être située au moins à 6 mètres de tout habitat

48. Cochez la maladie à transmission mécanique : L1p71

A. La fièvre typhoïde

- B. L'onchocercose
C. La trypanosomiasse
D. Le paludisme

Transmission biologique

49. Cochez dans la liste ci-dessous la méthode à la lutte biologique : L1p73

- A. L'utilisation des pièges
B. L'utilisation du chat
C. La disparition des ordures ménagères

D. L'emploi de germes microbiens

50. L'une des composantes essentielles des SSP suivantes est préventive. Laquelle ? L1p78

- A. Promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles
B. Vaccination contre les principales maladies infectieuses
C. Traitement des maladies et lésions courantes
D. Fourniture en médicaments essentiels (modernes et traditionnels)

ETUDE DE CAS 2 : Vous êtes infirmier ou sage-femme diplômé d'état nouvellement affecté au centre de santé rural de M'bro où travaillent deux (2) infirmiers et une sage-femme diplômée (es) d'état.

Après une étude du milieu, vous disposez des informations suivantes : la population totale de la localité est estimée à 5700 habitants au 1^{er} janvier 2024 et 5917 habitants au 1^{er} janvier 2025 avec un taux de croissance annuelle constant (TAA). Le dispensaire et maternité disposent de 18 lits et le ratio personnel infirmier, lits du dispensaire est de 0,2 ; 140 naissances vivantes enregistrés dans le village ; La morbidité liée au paludisme est de 2680 cas dont 30% d'anciens cas ; Le nombre total de décès pour la même période est égal à 58 décès dont 32 dus au paludisme ; Les registres d'activités mal tenus par votre prédécesseur avec un taux de promptitude de rapports mensuels d'activités de 75%.

Calculez pour l'année 2024

51. Le taux de prévalence du paludisme.

A. 13,84%**B. 45,29%****C. 32,29%****D. 46,13%**

$$TP = \frac{\text{Nbre de Cas}}{\text{Pt} / \text{Pmoy}} \times 100 = \frac{2680}{5917} \times 100$$

52. Le taux de mortalité dû au paludisme.

- A. 1,19%
B. 0,54%
 C. 0,55%
 D. 55,17%

$$TMS = \frac{\text{Nbre de Décès dû au paludisme}}{\text{Pt / Pmoy}} \times 100 = \frac{32}{5917} \times 100$$

53. Le nombre de rapports mensuels d'activité transmis dans le délai requis au district par votre prédécesseur.

- A. 6 rapports
 B. 7 rapports
 C. 8 rapports
D. 9 rapports

$$\begin{array}{lcl} 100\% & \longrightarrow & 12 \text{ rapports} \\ 75\% & \longrightarrow & X = \frac{75 \times 12}{100} \end{array}$$

54. Le nombre de lits disponibles à la maternité du village.

- A. 6 lits
 B. 8 lits
C. 10 lits
 D. 12 lits

$$\begin{aligned} \text{Ratio} &= \frac{\text{Infirmier}}{\text{Lit dispensaire}} = 0,2 \Rightarrow \text{Lit disp} = \frac{\text{Infirmier}}{0,2} = \frac{2}{0,2} = 10 \\ \text{Lit dispensaire} + \text{Lit maternité} &= 18 \\ \text{Lit maternité} &= 18 - \text{Lit dispensaire} \\ \text{Lit maternité} &= 18 - 10 \end{aligned}$$

55. Le taux brut de natalité à M'brou.

- A. 2,36%**
 B. 2,39%
 C. 2,41%
 D. 2,45%

$$TBN = \frac{NV}{\text{Pt / Pmoy}} \times 100 = \frac{140}{5917} \times 100$$

56. L'année de dédoublement de la population à partir de 2024.

- A. 2042
B. 2043
 C. 2044
 D. 2045

$$\begin{aligned} TAA &= \frac{Pf - Pd}{Pd} \times 100 = \frac{5917 - 5700}{5700} \times 100 = 3,8\% \\ AD &= AR + TD \text{ avec } TD = \frac{70}{TAA} = \frac{70}{3,8} = 19 \text{ans} \\ AD &= 2024 + 19 = 2043 \end{aligned}$$

57. Quels conseils comptez-vous donner à la population pour lutter, contre les larves de moustiques. L1p72

- A. Pulvériser l'intérieur des maisons d'insecticides.
B. Eliminer ou réduire les gîtes de reproduction par le désherbage.
 C. Dormir sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide.
 D. Déposer des grillages aux portes et fenêtres des locaux d'habitations.
E. Vider et enlever tous les récipients pouvant contenir de l'eau.

BOUAKE

EXAMEN BLANC DU DIPLOME D'ETAT DES INFIRMIERS (ERES)

Session du 01 au 05 Octobre 2025

EPREUVE DE : SOINS INFIRMIERS EN CHIRURGIE**DUREE** : 01heure 30 minutes

VERSION A

BOUAKE

Pour les QCD : 1 réponse juste = 0,5 point, 1 réponse fausse = -0,5 point, Sans réponse = 0 point Répondre par A = VRAI ou B = FAUX

Pour les QCM : 1 réponse juste = 0,5 point, 1 réponse fausse ou 1 absence de réponse = 0 point

I. QCD (20 Questions)

1. La luxation de l'épaule est une perte de contact plus ou moins importante de deux surfaces articulaires, l'une par rapport l'autre. **B L2p17**
2. Les lésions vasculo-nerveuses sont **complications secondaires** des fractures du membre inférieur. **B L2p41 / L2p51 « complication immédiate »**
3. Le mal de pott est une infection disco-vertébrale due au bacille de Koch. **A L3p31 (NEUROCHIRURGIE)**
4. Le polytraumatisé est tout malade ayant au moins deux traumatismes. **B L2p81**
5. La fracture de l'enfant est dite fracture en « bois vert ». **A L2p30**
6. **Le choc** est une défaillance circulatoire aiguë qui entraîne un apport insuffisant en oxygène aux cellules de l'organisme. **B L2p70 « L'état de choc »**
7. Dans les traumatismes crâniens, le blessé est dans un état d'inconscience pendant l'intervalle de temps libre. **A L 3p9 (TD CHIRURGIE)**
8. L'intervalle libre correspond au coma. **B**
9. L'amnésie constitue un signe fonctionnel en cas de traumatisme crânien. **A L3p3**
10. La commotion cérébrale est un dysfonctionnement cérébral. **A L3p2**
11. L'embarrure est une fracture de la boîte crânienne caractérisée par l'enfoncement d'un ou plusieurs fragments osseux. **A**
12. La notion d'intervalle libre est déterminée par la cotation de Glasgow. **B**
13. La précipitation est un geste approprié lorsqu'il s'agit de prendre en charge une victime de AVP. **B**
14. Plus le score de Glasgow est élevé plus l'état du malade est grabataire. **B**
15. Les fractures de la base du crâne sont considérées comme des fractures ouvertes. **A**
16. Les occlusions hautes siègent sur l'œsophage. **B**
17. Les occlusions hautes siègent uniquement sur l'intestin grêle. **A**
18. Les occlusions basses siègent uniquement sur le côlon. **A**
19. L'adénome de la prostate est une affection qui touche les hommes de plus de 50 ans. **A L2p154**
20. Après adénectomie, cette tumeur peut récidiver. **B**

II. QCM (10 Questions)

21. Quels sont les éléments de l'échelle de Glasgow pour évaluer un traumatisme crânien ? (3 réponses) L3p3-4 (NEUROCHIRURGIE)

- A. La couleur des yeux
- B. La coloration de la peau
- C. L'ouverture des yeux**
- D. L'aspect de la peau

E. La réponse verbale

F. La réponse motrice

22. Parmi les signes ci-dessous énumérés, lesquels sont des signes spécifiques du mal de Pott ? (2 réponses) L3p32 (NEUROCHIRURGIE)

A. Raideur marquée du rachis

B. Fièvre vespérale

C. Gibbosité

D. Altération de l'état général

E. Douleurs dorso-rachidiennes

23. Parmi les causes de la péritonite, quelles sont celles qui sont les plus fréquentes ? (3 réponses)

A. Perforation appendiculaire

B. Perforation d'ulcère gastroduodénal

C. Perforation du grêle d'origine typhique

D. Salpingite

E. Pancréatite aiguë

F. Cholécystite aiguë

24. Quels sont les signes fonctionnels de l'adénome de la prostate parmi ceux-ci ? (4réponses) L2p155

A. Prolongement de la durée de l'éjaculation

B. Pollakiurie nocturne et/ou diurne

C. Impériosité mictionnelle

D. Miction retardée

E. Diminution de la force et du calibre du jet

F. Rétention urinaire aiguë

25. Quels sont les signes physiques de l'adénome de la prostate parmi ceux-ci ? (3 réponses) L2p155

A. Toucher rectal (vessie vide) pour apprécier le volume de la prostate

B. Palpation des deux fosses lombaires pour rechercher un gros rein (hydronéphrose ou tumeur)

C. Percussion pour rechercher un globe vésical par matité

D. Pollakiurie diurne et/ou nocturne

E. Jet urinaire haché et/ou faible

F. Impression de vidange vésicale incomplète

26. Quels conseils peut-on donner à une personne pour prévenir l'apparition d'un panaris ? (3 réponses)

A. Porter des faux ongles

B. Désinfecter systématiquement toute plaie des mains

C. Éviter de se ronger les ongles

D. Porter des gants lors des travaux manuels à risque

E. Ne jamais tremper les mains dans de l'eau

F. Ne plus serrer la main en se saluant

27. Le crochet digital semi-fléchi est un signe physique de l'une des pathologies ci-dessous, laquelle ?

A. Le phlegmon

B. La lymphangite

C. L'abcès lymphatique

D. Le panaris péri-unguéal

28. Quelles sont les étiologies du phlegmon parmi celles qui sont énumérées en dessous ? (2 réponses)

- A. Le manque d'hygiène
- B. La macération
- C. Les dermatoses prurigineuses
- D. Plaie contuse négligée**
- E. Piqûre hyper septique**

29. En quoi consiste la prise en charge du furoncle ? (2 réponses) L1p41

- A. Faire une antibiothérapie systématique
- B. Presser le furoncle
- C. Faire un antibiogramme
- D. Rechercher systématiquement un diabète**
- E. Faire un pansement avec un antiseptique**

30. Quelle est la malformation congénitale parmi celles énumérées ci-dessous est une déviation des Jambes en dehors et des genoux en dedans (Jambes en X) (1 réponse)

L1p74

- A. Syndactylie
- B. Genu valgus**
- C. Genu varus

III. CAS CLINIQUE N°1

Un homme de 45 ans, sans antécédents médicaux, consulte aux urgences pour Douleurs abdominales intenses à "**coups de poignard**" évoluant depuis 24 heures.

La douleur a débuté de manière diffuse puis est devenue intense au niveau de la fosse iliaque droite. Il décrit également des nausées, une anorexie et une fièvre

- Nausées et vomissements - TA : 100/60 mm Hg - FC : 110 bpm - Fièvre à 39°C

- Patient en mauvais état général - Anémie légère

Après un examen clinique minutieux, le chirurgien décide de l'opérer dans deux (02) jours et lui prescrit :

- 1 flacon de sang de 500 ml
- Une réanimation hydroélectrolytique

Questions

31. Quel est votre diagnostic ? (1 réponse)

- A. Hernie étranglée
- B. Appendicite aiguë
- C. Péritonite aiguë**
- D. Occlusion intestinale aiguë

32. Quelles sont les causes probables de cette affection parmi celles-ci ? (2 réponses)

- A. Ulcère gastroduodénal perforé**
- B. Obésité
- C. Appendicite perforée**
- D. Vers intestinaux
- E. Surpoids

33. Quels sont les éléments de la prise en charge avant l'intervention chirurgicale ? (3 réponses)

- A. Pose de voie veineuse**
- B. Prise régulière des constantes**
- C. Mise en place d'une sonde nasogastrique et vésicale**
- D. Lavage péritonéal

- E. Faire la préparation physique de la zone d'intervention chirurgicale
- F. Vérifier que l'auxiliaire administre des soins de qualité

34. Quelles sont les précautions à prendre avant la pose de la poche de sang ? (3 réponses)

- A. Faire le test de compatibilité
- B. Vérifier la concordance de la poche de sang avec le sang prescrit
- C. Voir l'aspect du sang
- D. Bien régler le débit de la transfusion
- E. Vérifier l'écoulement du sang
- F. Rechercher le donneur source

35. Lors de la pose de cette transfusion, vous vous êtes piqué(e) avec l'aiguille souillée usagée. Que faites-vous ? (3 réponses)

- A. Faire saigner la plaie
- B. Nettoyer la plaie avec une solution antiseptique et continuer les soins
- C. Informer le Major et vous rentrer chez vous
- D. Faire le test de sérologie virale
- E. Demander à l'Aide-Soignant de vous suppléer
- F. Faire une déclaration d'AES chez le médecin référent

36. Quels sont les éléments de surveillance pendant l'aspiration digestive ? (2 réponses)

- A. Apport liquidien oral pour compenser les pertes liquidiennes
- B. Surveiller l'aspect et la quantité du liquide aspiré
- C. Mobiliser la sonde pour qu'elle n'adhère pas à la paroi gastrique
- D. Contrôler la bonne marche de l'aspirateur
- E. Vérifier l'état général du patient

37. Quel sont les éléments de préparation physique la veille de l'intervention ? (3 réponses) L2p121

- A. Faire la toilette générale
- B. Faire un rasage de l'abdomen et de pubis
- C. Désinfecter la zone d'intervention chirurgicale
- D. Contrôler le réveil physiologique du malade
- E. S'assurer que le patient est à jeun la veille de l'intervention
- F. Prescrire la prémédication

38. Quel est le besoin prioritaire non satisfait ? (1 réponse)

- A. Besoin de maintenir la température du corps dans les limites normales
- B. Besoin de s'occuper de façon à se sentir utile
- C. Besoin d'éliminer les déchets métaboliques

39. Sachant que les sérums tests Anti-A, Anti-B, Anti-AB agglutinent son sang sauf l'Anti-D. Quel est le groupe sanguin de ce patient ? (1 réponse)

- A. O négatif
- B. AB négatif
- C. O positif
- D. AB positif

40. Quel est le débit de la transfusion si elle doit passer en 3 heures ? (1 réponse)

- A. 40 gites/min
- B. 42 gttes/min
- C. 45 gites/min

$$D = \frac{Q \times 15}{T \times 60} = \frac{500 \times 15}{3 \times 60} = 42$$

IV. Cas clinique N°2 :

AGADOU Simon, jeune footballeur de 26 ans, pesant 58kg a reçu un choc violent à la jambe gauche au cours d'un match. Il se plaint de vives douleurs avec une impotence fonctionnelle totale. Admis aux urgences chirurgicales du CHR de Bouaké où vous êtes en service, l'équipe soignante le reçoit et note les éléments suivants : - Pouls = 98 pulsations/min - TA = 10/7 CmHg - T° = 37°2 C

L'inspection objective une déformation en angulation au tiers moyen du tibia, un œdème important de la région atteinte.

QUESTIONS

41. Quel est votre diagnostic de présomption ? (1 réponse)

A. Une fracture fermée de tibia

B. Une fracture ouverte du tibia

C. Une fracture du tibia en bois vert

42. Quel examen couramment utilisé doit confirmer votre diagnostic en fonction de la localisation de la fracture ? (1 réponse)

A. L'échographie

B. La radiographie

C. La tomodensitométrie

D. L'imagerie par résonance magnétique

43. De quel type est le mécanisme d'installation de la fracture ? (1 réponse)

A. De type direct

B. De type indirect

C. De type parallèle

44. Deux parmi les éléments suivants sont les complications immédiates des fractures des os de la jambe. Lesquelles ? (2 réponses)

A. La pseudarthrose

B. Les lésions vasculaires

C. Le cal vicieux

D. Le retard de consolidation

E. Les lésions nerveuses

F. L'ostéite

45. Lequel parmi ces appareillages plâtrés est indiqué dans l'immobilisation de la jambe ? (1 réponse)

A. Le delbet de marche

B. Le plâtre pelvi-pédieux

C. Le plâtre pelvi-crural

EXAMEN BLANC DU DIPLOME D'ETAT DES INFIRMIERS(ERES)

Session du 18 au 19 Octobre 2025

EPREUVE DE : SOINS INFIRMIERS EN MEDECINE
30 minutes

DUREE : 01heure

VERSION A

BOUAKE

I. QCD consignes : une réponse juste = 1 point, une réponse fausse = - 1 point, une question sans réponse = 0 point

1. L'insuline est une hormone qui régule la concentration de sucre dans le sang. **A**
2. Le diabète a des conséquences sur le cœur, les yeux, les reins et les nerfs et les vaisseaux sanguins. **A**
3. La voie conjonctivale est l'une des voies dans la transmission des maladies infectieuses. **A**
4. Les exotoxines sont sécrétées par les bactéries vers l'extérieur. **A L1p84 (Doc maladie infectieuse)**
5. Les signes de la fièvre Typhoïde au premier septénaire sont : Céphalées, Insomnie, Vomissement, Epistaxis, Température élevée. (CIVET) **B L1p89 (Doc maladie infectieuse)**
6. Trichomas Vaginalis est l'un des germes en cause de la méningite purulente. **B L1p99 (Doc maladie infectieuse)**
7. La maladie de bouillaud est pratiquement le fait d'un streptocoque hémolytique du groupe A. **A L1p104 (Doc maladie infectieuse)**
8. L'examen des sujets contacts est un élément du traitement préventif de la diphtérie. **A L1p152 (Doc maladie infectieuse)**
9. En cas de Pré Exposition PrEP continue, l'arrêt du traitement est possible que 21 jours après la dernière prise de risque. **B**
10. Le lavage gastrique est indiqué si le délai d'ingestion du toxique dure moins de : 6h. **A**
11. L'ankylostomose ou ankylostomiase est une parasitose cosmopolite causée par un trématode. **B L1p89 (Doc maladie infectieuse)**
12. Les enfants sont beaucoup plus touchés par la bilharziose parce qu'ils urinent dans la piscine lors de la baignade. **B « rivière, marigot, lacs »**
13. L'anémie est un signe essentiel de l'Ankylostomiase. **A L1p25 (Doc maladie infectieuse)**
14. L'oxyurose est une parasitose de la vie en famille et en collectivité. **A L1p31 (Doc maladie infectieuse)**
15. **Les épreintes** sont des contractions douloureuses du sphincter anal. **B L1p89 (Doc sémio médicale) « ténesme »**
16. La gravité de la lèpre réside dans l'atteinte des nerfs profonds. **A**
17. Un malade lépreux se reconnaît facilement par sa plus grande transpiration. **B**
18. La dracunculose est une maladie parasitaire causée par un nématode appelé ver de Guinée. **A**
19. Tout TDR positif au paludisme doit faire l'objet d'un traitement. **A**
20. La goutte épaisse permet de déterminer la densité parasitaire. **A L1p8 (Doc maladie infectieuse)**

II. QCM : une réponse juste = 1 point, une réponse fausse ou une question sans réponse = 0 point

21. Dans la phase tertiaire du pian, la destruction totale du massif facial est appelée :

L1p70 (Doc maladie infectieuse)

A. Lame de sabre

B. Gangosa

C. Pian crabe

22. Dans la lèpre, le steppage d'un membre inférieur traduit l'atteinte d'un nerf.

Lequel ?

A. nerf cubital externe

B. nerf facial

C. nerf sciatique poplité

23. Les pièges à glossines sont des moyens de lutte contre : L1p56 (Doc maladie infectieuse)

A. La Trypanosomiase Humaine Africaine (THA) «maladie du sommeil, transmise par la mouche tsé-tsé»

B. La dengue

C. L'onchocercose

24. Pour le traitement de l'oxyurose, quel que soit le médicament prescrit, Il faut administrer :

L1p31 (Doc maladie infectieuse)

A. Une cure puis une 2ème cure à J15.

B. Une cure pendant 3 jours

C. Une cure d'un jour suffit

25. Après le traitement du paludisme, si GE/FS positifs, malgré une observance optimale après J14

A. Il s'agit d'une recrudescence

B. Il s'agit d'une ré-infestation

C. Il s'agit d'une autre affection

D. Il s'agit d'un échec de traitement

26. Après le traitement, si GE/FS positifs, malgré une observance optimale après J14 pour un paludisme simple :

A. Prescrire le traitement de 2ème intention quinine injectable

B. Prescrire le traitement de 2ème intention quinine orale

C. Reprendre le traitement initial 1 ère intention CTA

27. Le genre du virus de la rage est : L1p120 (Doc maladie infectieuse)

A. Enterovirus

B. Lyssavirus

C. Flavivirus

D. Rhabdovirus

28. Après le traitement, si GE/FS positif, malgré une observance optimale avant J14 pour un paludisme simple, prescrire :

A. Quinine inj+ clindamycine.

B. Quinine orale

C. CTA

29. Chez la femme enceinte souffrant d'un paludisme simple il faut prescrire : L1p9 (Doc maladie infectieuse)

A. Quinine : 25 mg/kg/j en 3 prises orales pendant 5 jours.

B. Quinine : 2,5 mg/kg/j en 3 prises orales pendant 5 jours.

C. Quinine : 0.25 mg/kg/j en 3 prises orales pendant 7 jours.

D. Quinine : 25 mg/kg/j en 3 prises orales pendant 3 jours.

30. La forme "furieuse" de la rage se caractérise par : L1p122 (Doc maladie infectieuse)

- A. Une paralysie complète
- B. Des troubles du comportement et hydrophobie
- C. Une toux sèche
- D. Une éruption cutanée

31. Une fois les symptômes apparus, la rage est : L1p121 (Doc maladie infectieuse)

- A. Guérissable avec des antiviraux
- B. Toujours mortelle
- C. Non mortelle chez les enfants
- D. Toujours guérissable par vaccination

32. Parmi les propositions suivantes, indiquez les bonnes réponses. Les maladies cardiovasculaires constituant un ensemble de troubles affectant le cœur et les vaisseaux sanguins, qui comprennent : (03 réponses)

- A. Les Cardiopathies Coronariennes
- B. Les Cardiopathies Rhumatismales
- C. Les Cardiopathies Périphériques
- D. Les Artériopathies Centrales
- E. Les Artériopathies Périphériques
- F. Les Artériopathies Rhumatismales

33. Les signes suivants traduisent la définition de l'asthme. Lesquels ? (03 réponses)

- A. Une difficulté à respirer,
- B. Une hyperventilation
- C. Une production de mucus et une toux.
- D. Une difficulté à inspirer,
- E. Une respiration sifflante,
- F. Une hyperaération des bronches

34. Parmi les propositions suivantes, indiquez. Les bonnes réponses. Les symptômes du diabète de type 1 sont : (03 réponses) L3p37 (Doc Endocrinologie)

- A. Polyurie (excrétion excessive d'urine)
- B. Dysphagie
- C. Faim constante ➡ (Polyphagie)
- D. Prise de poids
- E. Polydipsie (sensation de soif)
- F. Pollakiurie

35. Parmi les examens biologiques suivants, un seul fait appel à l'examen de certitude dans la fièvre Typhoïde. Lequel ? L1p91 (Doc maladie infectieuse)

- A. Coproculture
- B. Hémoculture
- C. Sérodiagnostic de Widal et Félix
- D. (1er intention hémoculture, 2eme intention coproculture)

36. Les signes du syndrome méningé sont caractérisés par le trépied méningitique. Lesquels ? (03 réponses) L1p100 (Doc maladie infectieuse)

- A. Diarrhée
- B. Raideur de la nuque
- C. Vomissement en jet
- D. Constipation
- E. Céphalée en casque
- F. Insomnie

37. L'atteinte cardiaque est la plus fréquente et la plus redoutable des localisations de la maladie de Bouillaud marquée par : (03 réponses) L1p105 (Doc maladie infectieuse)

A. Myocardite

B. Péricardite

C. La pleurésie rhumatismale

D. Le Meynert

E. Endocardite

F. Thyroïdite

38. Parmi les propositions suivantes identifiez les types de cycles de transmission de la fièvre jaune : (03 réponses)

A. Cycle forestier (ou selvatique)

B. Cycle savanicole

C. Cycle urbain

D. Cycle rural

E. Cycle aquatique

39. Dans la fièvre jaune, la phase jaune est marquée par des hémorragies diverses caractérisées par (03 réponses)

A. Des méléna

B. Des épistaxis

C. Des gingivorragies

D. Des hématémèses

E. Des Hémoptysies

F. Rectorragies

40. Parmi les propositions suivantes identifiez celles qui sont conformes aux différentes formes de la dengue ? (03 réponses) (Doc pdf)

A. Dengue fébrile

B. Dengue frusque

C. Dengue sévère

D. Dengue fébrile hémorragique

E. Dengue du syndrome de choc

41. Un patient naïf aux ARV est :

A. Un patient sous traitement ARV

B. Un patient n'ayant jamais pris d'ARV

C. Un patient ayant arrêté son traitement ARV

42. La contamination de la tuberculose se fait par :

A. Voie aérienne indirecte ou par voie aérienne directe

B- Le sang

C- Voie digestive

D. Les excoriations de la peau

E- La voie sexuelle

CAS PRATIQUE 1

En tant qu'infirmier Diplômé d'Etat chef de centre, vous recevez enfant SV de 05 ans en consultation dans votre centre de santé rural.

A l'interrogatoire sa mère vous dit que son enfant vomit et présente une fièvre depuis 03 jours qui ne cède pas malgré les sachets d'Effergal 250 mg qu'elle lui donne régulièrement. Elle l'a lavé avec des décoctions de feuilles car ses yeux s'étaient révulsés

A l'examen physique, vous relevez une T° 39.5C ; des conjonctives et paumes très pales ; poids 13kg ; une toux modérée sans tirage costales ; absence des battements des ailes du nez.

43. A quoi pensez-vous

- A. Cas d'anémie
- B. Cas de paludisme
- C. Cas pneumonie
- D. Cas suspect de paludisme**

Vous réalisez un TDR qui s'avère positif.

44. Quel est votre diagnostic ?

- A. Paludisme simple
- B. Paludisme grave**
- C. Cas présumé de paludisme

45. Quels sont les arguments qui sous-tendent votre diagnostic ? (3 réponses)

- A. T° 39.5 ;
- B. Conjonctives et paumes très pales ;**
- C. Yeux révilés**
- D. TDR positif ;**
- E. une toux modérée sans tirage costales ;
- F. Fièvre depuis jours depuis 02 jours

46. Quelle est votre conduite à tenir ?

- A. Débuter rapidement le traitement antipalustre
- B. Référer l'enfant dans la structure de référence la plus proche**
- C. Mettre l'enfant en observation avec un traitement adéquat

47. Selon votre décision, précisez le traitement

- A. Artéméther + Luméfantrine à la posologie de 4mg/kg/j d'Artéméther + 24 mg/kg/j de Luméfantrine en 1 à 2 prises orales/jour
- B. Artésunate IM ou IV (une dose de 3mg/Kg) ou Artéméther IM (3,2 mg/kg) dose unique + paracétamol**
- C. Quinine base par voie orale : 25 mg/kg par jour en 3 prises espacées de 8 heures

48. Comment appelle-t-on ce traitement ?

- A. Traitement de première intention
- B. Traitement de pré- transfert**
- C. Traitement d'attaque

CAS PRATIQUE 2

Un garçon de 10 ans, de retour de l'école a été **mordu par un chien errant**. Il est amené en consultation par ses parents 8 heures de temps après. La morsure est située sur la jambe gauche avec une plaie saignante. Ses vaccinations de routine sont à jour. Le chien n'a pas été retrouvé.

49. A quelle maladie cet enfant est-il exposé ?

- A. Morsure de chien
- B. Rage**
- C. Envenimation
- D. Tétanos

50. Quelle est la conduite à tenir immédiate ?

- A. Couvrir la plaie et attendre 24 h
- B. Appliquer un pansement sec
- C. Laver abondamment à l'eau et au savon + désinfecter**
- D. Suturer immédiatement sans lavage

51. Cette morsure représente :

A) Aucun risque car l'enfant est vacciné contre le tétanos

B) Une exposition à haut risque pour l'enfant

C) Une exposition à faible risque car la plaie saigne

D) Une exposition sans risque car la morsure est sur la jambe

52. Quel schéma vaccinal recommandé préconisez-vous pour cet enfant ?

A) Une seule injection de vaccin rabique

B) Vaccination post-exposition complète

C) Pas de vaccination si la plaie est nettoyée

D) Attendre 10 jours pour observer le comportement du chien

53. Quelles sont les autres mesures à prendre ? (2 réponses)

A) Abattre tous les chiens de la localité

B) Administrer antibiotique si nécessaire

C) Observer l'animal 10 jours s'il est retrouvé

D) Ne rien faire de plus

CAS PRATIQUE 3

Enfant Bobby 6 ans, non vacciné, est amené en consultation pour fièvre depuis 4 jours, associée à une toux sèche, **un catarrhe oculo nasal**.

Depuis hier, sa mère a remarqué l'apparition de petites **taches blanchâtres sur la muqueuse buccale** et ce matin, **une éruption maculo-papuleuse rouge est apparue**, et s'étendant au visage, puis au tronc.

À l'examen :

- Température : 39,5 °C

- Conjonctivite bilatérale

- Éruption en cours d'extension vers les membres

- Pas de signe de gravité (pas de dyspnée, pas de troubles neurologiques)

54. Quelle est la maladie dont souffre Bobby ?

A) la grippe

B) la rougeole

C) la rubéole

D) la varicelle

55. Quel est l'agent causal de cette maladie ?

A) Virus influenzae

B) Virus morbillieux

C) Virus de la rubivirus

D) virus de la covid 19

56. Une triade classique caractérise cette maladie. Laquelle ?

A) Fièvre, toux, coryza

B) Toux, coryza, conjonctivite

C) Rash, diarrhée, toux

D) Fièvre, céphalée, photophobie

57. Un signe pathognomonique de cette maladie est relevé dans le texte. Lequel ?

A. kerning

B. Köplik

C. Brudzinski

58. Quelle est la complication la plus fréquente à laquelle Bobby est exposée ?

A) Encéphalite

B) Pneumonie

C) Panencéphalite subaigue sclérosante

D) Hépatite virale

59. Quelle mesure de prévention préconisez - vous pour Bobby :

- A) Isolement du malade
- B) Antibiothérapie préventive
- C) Vaccination**
- D) Traitement antiviral

60. Quelle la durée de contagiosité de cette maladie :

- A) 1 jour avant l'éruption jusqu'à 1 jour après
- B) 4 jours avant l'éruption jusqu'à 4 jours après**
- C) Seulement pendant la phase éruptive
- D) Après la disparition de l'éruption

EPREUVE DE PEDIATRIE
INFAS_BOUAKE_Licence 3 BLOC D

QCM**Consignes**

1. Une réponse juste donne droit à + 1 point
2. Une réponse fausse donne droit à 0 point
3. Une absence de réponse donne droit à 0 point

1. PM est un nourrisson de 18 mois. Cette fillette présente des pleurs incessants et refuse de téter. A l'examen physique, la fontanelle antérieure est bombée et la température de 40° Celsius, PM souffre d'une méningite purulente. PM a :

- A. Infection bactérienne des méninges et absence de protection**
- B. Hypertension intracrânienne fébrile et absence de protection
- C. Trouble de la régulation thermique et menace sur l'intégrité physique et psychique
- D. Immature cérébrale et cutanée et absence de protection

2. Les propositions suivantes sont des examens paracliniques à prescrire devant une fièvre aiguë, sauf une. Cochez cette proposition

- A. Examen cyto bactériologique des urines
- B. Intradermoréaction à la tuberculine**
- C. Goutte épaisse/frottis sanguin
- D. Hémoculture répétée

3. PM est un nourrisson de 18 mois. Cette fillette présente des pleurs incessants et refuse de téter. A l'examen physique, la fontanelle antérieure est bombée et la température de 40° Celsius. PM souffre d'une méningite purulente. Votre objectif de soins est :

- A. GG doit être capable dans une heure de ramener sa température dans les limites de la normale
- B. GG doit être capable dans une heure d'avoir une pression intracrânienne dans les limites de la normale**
- C. GC doit être capable dans une heure d'avoir une absence de bactéries dans son liquide cébrospinal
- D. GG doit être capable avoir dans une heure d'avoir une fontanelle normotendue

4. La quantité de SRO à fournir, selon le plan B de réhydratation, pour le traitement d'un nourrisson de 10 kg faisant la diarrhée durant les 4 premières heures de prise en charge est :

- A. 500 ml / jour
- B. 750 ml / jour**
- C. 1500 ml / jour
- D. 2000 ml / jour

Plan B : 75ml/Kg en 4heures

1Kg → 75ml

10Kg → $x = \frac{(10 \times 75)}{1} = 750\text{ml}$

5. GK souffre d'une diarrhée aigue. A l'examen : larmes absentes, pli cutané abdominal s'efface lentement, une langue sèche et une agitation. Je corrige l'état d'hydratation de GK en utilisant le

- A. Plan A de traitement
- B. Plan B de traitement**
- C. Plan C de traitement
- D. Plan D de traitement

6) L'administration de Zinc comprimé 20 mg dans le traitement de la diarrhée chez le nourrisson de 4 mois est de :

- A. Demi comprimé/jour pendant 10 jours**
- B. Un comprimé/jour pendant 10 jours
- C. Un quart de comprimé/jour pendant 10 jours
- D. Deux comprimés /jour pendant 10 jours

- 0 à 6mois : Demi comprimé / Jour Pdt 10jours (10mg)
- 6 à 5ans : Un comprimé / Jour Pdt 10jours (20mg)

7. L'enfant né à terme avec une surface corporelle de 0,2 m² et correctement nourri triple sa surface corporelle à :

- A. 9 mois
- B. 12 mois
- C. 24 mois
- D. 36 mois**

Surface Corporelle

- 9 mois : SC x 2
- 36 mois (3ans) : SC x 3

8. A 15 mois un nourrisson avec un bon développement psychomoteur est capable de :

- A. Jeter un objet derrière lui**
- B. Parle constamment
- C. Tourne les pages d'un livre**
- D. Marche à reculons

9. La mise en incubateur du nouveau-né prématuré en détresse vitale est un soin :

- A. Délégué
- B. Collaboration
- C. Conseil et prévention
- D. Propre**

10. L'un des critères qui indique une bonne prise du sein est :

- A. Bouche largement ouverte**
- B. Menton éloigné du sein
- C. Lèvre inférieure rentrée
- D. Succion rapide, peu profonde

11. Les cellules ciblées au niveau du sein par la prolactine pour produire le lait maternel sont les :

- A. Cellules galactophores**
- B. Cellules myoépithéliales
- C. Cellules adipeuses
- D. Cellules épithéliales**

12. Le meilleur moment pour commencer l'allaitement après la naissance est :

- A. Après la 6^{ème} heure de vie
- B. Dès le retour à la maison
- C. Avant la première heure de vie**
- D. Dès le lendemain de la naissance

13. Le nouveau-né normal a un âge gestationnel compris entre

- A. [37-42] semaines d'aménorrhée
- B.]37-42] semaines d'aménorrhée

C.]37-42[semaines d'aménorrhée

D. [37-42[semaines d'aménorrhée

14. Vous recevez aux urgences pédiatriques pour des convulsions, TT pesant 20 kg. La dose journalière de Diazépam à ne pas dépasser chez TT est :

A. 10 mg / jour

B. 51 mg / jour

C. 20 mg / jour

D. 60 mg / jour

Dose journalière : 3mg/Kg/J

1Kg → 3mg

$$20\text{Kg} \longrightarrow x = \frac{(20 \times 3)}{1} = 60\text{mg}$$

15. Parmi les propositions suivantes cocher la seule proposition qui concerne la croissance qualitative :

A. Périmètre crânien

B. Poids et taille

C. Eruption dentaire

D. Périmètre brachial

Croissance somatique ou quantitative

Taille ; Surface Corporelle

Poids ; PC ; PB

Croissance qualitative ou maturation

Fontanelle ; Eruption dentaire

Apparition des points d'ossification

16. GG, 14 mois, est amené par sa mère inquiète pour absence d'éruption dentaire :

A. Je recommande à la mère de consulté un dentiste

B. Je prescris à la mère un traitement à base de Fluor et calcium

C. Je réfère la mère dans un centre de référence

D. Je rassure la mère et lui donne un rendez-vous dans 1 mois

17. Le nouveau-né est dit grand prématuré lorsque l'âge gestationnel est compris dans l'intervalle suivant :

A. [33 - 35[

B. [28 - 33[

C. [28 - 33]

D.]33 - 35]

➤ Extrême Prématuré : [22 - 28[ou [22 - 27]

➤ Grand Prématuré : [28 - 33[ou [28 - 32]

➤ Moyen Prématuré : [33 - 35[ou [33 - 34]

➤ Petit Prématuré : [35 - 37[ou [35 - 36]

18. Les propositions suivantes sont des maladies qui influencent le développement psychomoteur de l'enfant, sauf une. Cochez cette proposition.

A. Colique du nourrisson

B. Phénylcétonurie

C. Ictère nucléaire

D. Méningite purulente

19. A l'âge de 3 ans, un enfant avec un développement psychomoteur normal a l'acquisition suivante :

A. Nomme les jours de la semaine

B. Copie un carré

C. Fait de la bicyclette

D. S'habille seul, mais ne met pas les boutons

20. Accompagner un enfant présentant une anomalie du développement chez un pédopsychiatre est un soin :

A. Délégué

B. Propres

C. Conseil et prévention

D. De Collaboration

21. LG est né à 12h30min. Les propositions suivantes sont des gestes à réaliser chez. LG entre 12h30min et 13h30 min vie, sauf une. Cochez cette proposition.

A. Prendre la température de LG toutes les 15 min

B. Surveiller la respiration de LG

C. Aider la mère à mettre au sein LG

D. Prendre le poids de LG

22. A 5 minutes de vie, le nouveau-né de dame JK avait une cyanosé des extrémités, une hypotonie généralisée, une respiration irrégulière avec des geignements. La fréquence cardiaque était à 90 battements par minute. Son score d'Apgar à 1 minute de vie était de :

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

23. Durant la première minute de vie, les gestes suivants sont réalisés chez le nouveau-né qui pleure et respire :

- a) Essuyer le bébé avec un linge sec ;
- b) Porter un bonnet au bébé ;
- c) Déposer le sur un linge sec posé sur le ventre de la mère ;
- d) Remplacer le linge mouillé par un linge sec ;
- e) Vérifier la respiration ;
- f) Clamper et sectionner le cordon.

Cochez la proposition, correspondant à l'ordre normal dans lequel ces gestes sont réalisés.

A. f ; e ; a ; d ; b ; c

B. d ; a ; f ; e ; c ; b

C. a ; b ; c ; d ; e ; f

D. c ; a ; d ; b ; e ; f

24. Les soins propres dans la prise en charge des vomissements chez l'enfant sont les suivants, sauf un. Cochez ce soin :

A. Administrer du vogalène

B. Aider à alimenter l'enfant

C. Nettoyer l'enfant

D. Surveiller l'enfant

25. La complication redoutable à prévenir en urgence chez tout enfant sévèrement malnutri est

A. Hypoglycémie

B. Déshydratation

C. Anémie sévère

D. Défaillance cardiaque.

26. L'état de mal convulsif désigne une crise convulsive qui dure plus de :

A. 05 minutes

B. 10 minutes

C. 20 minutes

D. 30 minutes

27. Pour la reconstitution de l'eau sucrée à 10% administrée à l'enfant malnutri à l'admission, j'utilise 2 carreaux de sucre pour :

A. 200 ml d'eau potable

B. 150 ml d'eau potable

C. 100 ml d'eau potable

D. 50 ml d'eau potable

1 Carreau de sucre → 5g

2 Carreaux de sucre → 10g

Or l'eau sucrée 10%

10g → 100ml

28. PM est un nourrisson de 18 mois. Cette fillette présente des pleurs incessants, et un refus de téter. A l'examen physique, la fontanelle antérieure est bombée et la température de 40° Celsius. PM souffre d'une méningite purulente. PM a :

A. 1 données au niveau de sa réalité personnelle

B. 2 données au niveau de sa réalité personnelle

C. 3 données au niveau de sa réalité personnelle

D. 4 données au niveau de sa réalité personnelle

Réalité personnelle porte sur :

La mesure des paramètres vitaux ; L'aspect corporel ;
La gestuelle ; La posture ; Les plaintes ; La mimique ;
Les pleurs et l'environnement

29. PM est un nourrisson de 18 mois. Cette fillette présente des pleurs incessants, et un refus de téter. A l'examen physique, la fontanelle antérieure est bombée et la température de 40° Celsius. PM souffre d'une méningite purulente. PM a :

- A. 4 données de dépendance
- B. 5 données de dépendance**
- C. 6 données de dépendance
- D. 7 données de dépendance

30. PM est un nourrisson de 18 mois. Cette fillette présente des pleurs incessants, et un refus de téter. A l'examen physique, la fontanelle antérieure est bombée et la température de 40° Celsius. PM souffre d'une méningite purulente. PM a :

- A. 3 données d'indépendance**
- B. 4 données d'indépendance
- C. 5 données d'indépendance
- D. 6 données d'indépendance

QCD

Consigne

1. Une réponse juste donne droit à + 1 point
2. Une réponse fausse donne droit à -1 point
3. Une absence de réponse donne droit à 0 point

31. L'enveloppement humide est un des moyens physiques recommandés dans la prise en charge de la fièvre.

- A. Vrai
- B. Faux**

32. Dans la démarche de soins, les données de l'identification du patient sont habituellement des données de dépendance.

- A. Vrai
- B. Faux**

33. Dans la démarche de soins, le problème de dépendance est fourni par l'analyse et l'interprétation des données collectées.

- A. Vrai**
- B. Faux

34. Dans la démarche de soins lorsqu'il y a plus de données de dépendance que de données d'indépendance cela signifie que l'enfant est en bonne santé et que l'agent de santé doit maintenir cette santé.

- A. Vrai**
- B. Faux

35. Le streptocoque B est le principal agent infectieux responsable d'infection bactérienne néonatale tardive.

- A. Vrai
- B. Faux**

36. Le fait colostrum est produit par la mère après la première semaine post-partum.

- A. Vrai
- B. Faux**

37. Les infections vagino-utérines sont des causes spontanées de prématurité.

- A. Vrai
- B. Faux

38. Le contact peau à peau favorise la mise en route de l'allaitement.

- A. Vrai**
- B. Faux

39. L'entérococolite est un problème digestif fréquent lié à la prématurité

A. Vrai

B. Faux

40. Le cartilage du lobule de l'oreille mou est un signe de prématurité.

A. Vrai

B. Faux

41. Participer à la réalisation du bilan biologique chez nouveau-né prématurité est un soin propre de l'agent de santé.

A. Vrai

B. Faux

42. En l'absence de sérum glucosé 5% pour la réhydratation, je peux utiliser du sérum glucosé 10% en remplacement.

A. Vrai

B. Faux

43. Le nourrisson présentant une diarrhée aiguë sans signe de déshydratation boit avec avidité.

A. Vrai

B. Faux

44. Au cours d'une diarrhée, il est recommandé de mettre l'enfant à la diète.

A. Vrai

B. Faux

45. Dans la physiologie de la lactation, la prolactine est l'hormone de sécrétion du lait maternel

A. Vrai

B. Faux

46. La diarrhée persistante est une diarrhée qui évolue depuis plus de 21 jours

A. Vrai

B. Faux

47. Le mélange PASLOC 2 du programme national de nutrition utilisé pour la réhabilitation nutritionnelle de l'enfant malnutri est composé de 6 volumes de lait entier en poudre + 2 volumes de sucre + 1 volume d'huile végétale.

A. Vrai

B. Faux

48. Exerçant dans un ESPE, vous recevez le nouveau-né BB, J4 de vie, pesant 1800g pour une hématomie et un saignement en nappe au niveau du cordon ombilical. Vous administrez au nouveau-né BB avant la référence 1 mg de vitamine K1 en IVD :

A. Vrai

B. Faux

49. L'examen paraclinique clé auquel vous collaborer pour affirmer le déficit en vitamine K1 est le Temps de Quick.

A. Vrai

B. Faux

50. Les selles de la diarrhée aiguë provoquée par Shigelle sont pâteuses avec de la glaire et du sang

A. Vrai

B. Faux

EXAMEN BLANC DU DIPLOME D'ETAT D'ÉTAT DES INFIRMIERS (ERES)
--

Session : 15 au 16 Octobre 2025 BOUAKE

ÉPREUVE : SANTE PUBLIQUE N°1
01h30

Durée :

VERSION D

BOUAKE

I. QUESTIONS À CHOIX DOUBLES (QCD)**Consignes :**

Hachurez l'Alvéole A pour les réponses justes et B pour celles qui sont fausses. Bonne réponse = 0,5 Mauvaise réponse = -0,5 Absence de réponse = 0

1. Le niveau décisionnel de la santé publique se situe au niveau étatique. **A L1p8**
2. Le marasme et l'obésité sont des maladies liées à l'excès alimentaire. **B L1p25**
3. Un système de santé efficient est toujours efficace. **A L1p30**
4. Dans son rôle de gestion des ressources humaines, le comité de gestion doit veiller au savoir-faire du personnel de santé. **A L3p22**
5. Le génocide n'est pas une catastrophe naturelle. **A L3p39**
6. En matière de supervision, la correction peut se faire en différé. **A L3p47**
7. Le nombre de motos achetées pour les activités est un indicateur d'extrants. **B L3p57**
(d'intrant)
8. Un village où l'on pratique la vaccination peut être considéré comme un site de vaccination. **B**
9. En matière de vaccination, l'intervalle minimum n'existe pas. **B**
10. La tuberculose peut nécessiter le traitement DOTS pendant qu'il est seul dans son environnement. **B**
11. Les eaux de lagunes sont des eaux souterraines. **B L1p58 (eaux de surfaces)**
12. La pyramide sanitaire ivoirienne comprend de bas en haut : le niveau périphérique, le niveau intermédiaire et le niveau central. **A**
13. L'épidémiologie analytique répond à la question : « Combien ? » **B L1p81 (Pourquoi ?)**
14. L'individu constitue une cible du plaidoyer. **B L1p86**
15. Le taux de létalité permet d'évaluer la qualité de la prise en charge des malades. **B L2p30 (la gravité)**
16. La quantité à commander est souvent égale au besoin réel. **A**
17. La gravité d'un problème prioritaire de santé peut se déterminer à partir des séquelles de cette maladie. **A L2p56**
18. L'asthme aigu se manifeste au cours de la phase d'euphorie par des troubles de la parole. **A**
19. En cas de paralysie flasque aiguë, une analyse et des actions correctrices se font entre J10 et J14. **B L2p66 (après J0 et J14)**
20. Il n'y a pas de différence entre un obstacle et une contrainte. **B**
21. Il n'y a pas de différence entre les ressources propres et les ressources brutes d'une structure de santé. **B L3p13**
22. L'ESPC est aussi appelé établissement de premier recours. **B L2p18**

II. ÉTUDE DE CAS : CENTRE DE SANTÉ URBAIN DE BOYA

Contexte : Boya est une sous-préfecture qui compte 15 000 habitants au 31/12/2024. Vous avez pris service le 03 juin 2024 au centre de santé urbain de cette localité dont l'aire sanitaire couvre les villages suivants :

Village	Distance par rapport au centre de santé (en kilomètre)	Population totale en 2024 (en habitants)
Tougboli	08	3000
Nongana	02	8000
Yellé	14	1300
Pinvoro	07	1800
Kafonon	03	2000
Flapihin	11	2200

❖ Informations supplémentaires recueillies en 2024 :

- Pathologies prédominantes : dysenterie amibienne, fièvre typhoïde, malnutrition, paludisme, infections respiratoires aiguës.
- 5 jours de rupture en vaccins au second semestre.
- Pendant 358 demi-journées, la température du réfrigérateur du centre était comprise entre 2°C et 8°C.
- 80 % des femmes enceintes vivant dans un rayon de moins de 5 km ont effectué au moins 4 consultations prénatales.
- Le taux de perte en vaccin Penta est estimé à 4 %.
- La veille du second monitoring de l'année 2024, la somme à la banque était de 500 000 FCFA, y compris intérêts (5 500 FCFA) et non compris agios (2 800 FCFA).

Consignes pour l'étude de cas :

- Les résultats des calculs comportant des virgules sont à arrondir au quart supérieur.
- Les arrondissements ne concernent pas les pourcentages.

Questions 23 à 35 :

23. Parmi les maladies fréquemment rencontrées, indiquez celles qui ont un lien direct avec la consommation d'eau non potable : L1p59

A- dysenterie amibienne

B- paludisme

C- infections respiratoires aiguës

D- fièvre typhoïde

E- malnutrition

24. Quelle est la population totale de l'aire sanitaire du CSU de Boya en 2024 ?

A- 18 300 habitants

B- 33 000 habitants

C- 33 300 habitants

$$P_t = 15000 + 3000 + 8000 + 1300 + 1800 + 2000 + 2200 = 33300 \text{ hbts}$$

25. Population cible des activités de vaccination pour le second semestre :

A- 1 136 enfants

B- 1 126 enfants

C- 625 enfants

$$P(0-23\text{mois}) = 6,82\% \times P_t = 6,82\% \times 33300 = 2272$$

$$\text{Au second semestre : } P_{0-23\text{mois}} = 2272 / 2 = 1136$$

26. Distance totale à parcourir chaque mois pour la vaccination en stratégie avancée :

A- 40 km

B- 60 km

C- 80 km

Distance en stratégie avancée = $8+14+7+11 = 40$ KmDistance totale = $40 \times 2 = 60$ Km

27. Combien de fiches de rapports mensuels d'activité transmettre au district sanitaire en 2024 ?

A- 6 fiches

B- 7 fiches

C- 14 fiches

Prise de service le 03 Juin 2024 au centre de santé urbain
par agent de sante : rapports à transmettre 7 FICHES

28. Pendant combien de jours les vaccins étaient-ils disponibles au CSU au second semestre ?

A- 5 jours

B- 177 jours

C- 178 jours

Au second semestre correspond au monitoring de Décembre 2024
DONC $183 - 5 = 178$ JOURS

29. Disponibilité des vaccins au niveau de l'aire sanitaire au second semestre :

A- 97,26 %

B- 97,72 %

C- 96,80 %

$$DR = (178 / 183) \times 100 = 97,26\%$$

30. Pendant combien de jours la chaîne du froid a-t-elle bien fonctionné au second semestre ?

A- 358 jours

B- 179 jours

C- 178 jours

$$358 / 2 = 179 \text{ JOURS}$$

31. Population totale vivant dans un rayon de moins de 5 km :

A- 25 000 habitants

B- 15 000 habitants

C- 10 000 habitants

Population en stratégie fixe = $15000 + 8000 + 2000 = 25000$

32. Nombre de femmes enceintes vivant dans un rayon de moins de 5 km :

A- 500 femmes

B- 750 femmes

C- 1 250 femmes

Population Femme enceinte = $5\% \times P_{sf} = 5\% \times 25000 = 1250$

33. Combien de femmes enceintes ont effectué au moins 4 consultations prénatales :

A- 1 000 femmes

B- 600 femmes

C- 400 femmes

$$100\% \longrightarrow 1250 \text{ FE}$$

$$80\% \longrightarrow x = (80 \times 1250) / 100 = 1000$$

34. Facteur de perte du Penta :

A- 25

B- 60

C- 1,04

$$F_p = \frac{100}{100 - 4} = \frac{100}{100 - 4} = 1,04$$

35. Somme à la banque après mouvements :

A- 502 700 FCFA

B- 500 000 FCFA

C- 497 300 FCFA

Y compris intérêts , non compris agios

Donc SB = 500000

III. QCM : Questions 36 à 53

36. Parmi les aliments suivants, indiquez ceux qui sont des tubercules : L1p22

A- **Igname**

B- Mil → Céréale

C- Arachide → Matière grasse

D- Manioc

E- Maïs → Céréale

F- Taro

37. Parmi les sigles suivants, indiquez celui qui correspond à la nouvelle appellation de l'hôpital général :

A- EPHN

B- EPHD

C- EPHR

38. L'organisation et le fonctionnement du PNLT se font autour de : L1p51-52

A- deux versants

B- trois versants

C- deux niveaux

D- trois niveaux

39. Un flacon de vaccin liquide déjà ouvert est réutilisable à condition : L2p48

A- qu'il ne soit pas périmé

B- ait été contaminé

C- n'ait pas été exposé à des températures extrêmes

D- ait été immergé dans l'eau

E- ne présente aucun trouble ou précipitation

F- ait sa PCV virée

40. Parmi les critères suivants, indiquez ceux qui permettent de sélectionner un problème prioritaire : L2p59

A- La population totale de la localité

B- L'ampleur du problème

C- La gravité du problème

D- Le niveau d'instruction des populations

E- La vulnérabilité du problème

F- La durée des interventions

41. Parmi les signes suivants, indiquez ceux qui constituent des effets aigus de l'alcool : L2p60

A- Gastrite aiguë

B- Ralentissement des réflexes

C- Polynévrite

D- Cardiopathie

E- Ralentissement du rythme cardiaque

F- Ralentissement du rythme respiratoire

42. Pendant l'organisation de la riposte devant un cas suspect de rougeole, le prélèvement de sang se fait entre : L2p69

A- 1er et 4ème jour après le début de l'éruption

B- 4ème et 28ème jour

C- 14ème et 28ème jour

D- 4ème et 14ème jour

43. L'existence d'un goulot d'étranglement entre accessibilité géographique et utilisation des services signifie : L2p80

A- La population ne fréquente pas le service parce qu'elle n'y accède pas

B- La population a accès au service, mais ne le fréquente pas

C- La population accède difficilement au service, mais le fréquente

44. Les dépenses pour l'immeuble ne doivent pas excéder :

A- 10 % des fonds alloués aux dépenses obligatoires

B- 10 % des fonds alloués aux dépenses de fonctionnement local

C- 5 % des dépenses de fonctionnement local

45. Mandat des membres du COGES d'un établissement sanitaire de premier contact :

L3p21

A- 2 ans renouvelables

B- 3 ans renouvelables

C- 4 ans renouvelables

D- 5 ans renouvelables

46. Identifier les catastrophes naturelles : L3p59

A- La guerre

B- Les cyclones

C- Les tremblements de terre

D- Le tsunami

E- Les graves accidents de circulation

F- Les génocides

47. La supervision proprement dite comprend : L3p46

A- L'observation

B- La correction

C- La sanction

D- Le contrôle

48. Identifier la question qui indique le suivi du processus : L3p52

A- L'intervention prévue est-elle en cours de réalisation ?

B- Les bénéficiaires ont-ils changé de comportements ?

C- Les ressources ont-elles été bien utilisées ?

49. Choisissez deux méthodes de lutte contre les moustiques adultes : L1p72

A- Dormir sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide

B- Combler les flaques d'eau

C- Enlever tous les récipients pouvant contenir de l'eau

D- Poser des grillages aux portes et fenêtres

E- Drainer les endroits où l'eau peut stagner

50. L'initiative de Bamako a été lancée en : L1p75

A- 1987

B- 1985

C- 1978

D- 1977

51. Questions relevant de l'épidémiologie analytique : L1p81

A- Quelle est la cause ?

B- Quand ?

C- Où ?

D- Qui ?

E- Pourquoi ?

52. Le taux de mortalité néonatal tardif concerne : L2p32

A- Décès d'enfants 0 à moins de 8 jours

B- Décès d'enfants 8 à moins de 28 jours

C- Décès d'enfants 28 jours à moins d'un an

53. Stratégies pratiquées pendant la vaccination de routine en Côte d'Ivoire :

A- Stratégie fixe

B- Stratégie avancée

C- Stratégie du porte-à-porte

D- Stratégie mobile

EXAMEN BLANC DU DIPLOME D'ETAT DES SAGE-FEMMES / MAIEUTICIENS
--

Session du 15 au 16 Octobre 2025

EPREUVE DE : SANTE PUBLIQUE N°2**DUREE** : 01heure

30 minutes

VERSION A

BOUAKE

QUESTIONS A CHOIX DOUBLES (QCD)**Consignes**

Hachurez l'alvéole A pour les réponses justes et B pour celles qui sont fausses, sachant qu'une bonne réponse =0,5, une mauvaise réponse= -0,5 et une absence de réponse=0 point.

- Q1. La santé communautaire vise la protection de la population. **B L1p8**
- Q2. Les virus et les parasites sont des facteurs déterminant la santé. **B L1p16**
- Q3. Le riz est un aliment de construction. **B L1p22**
- Q4. Un système de santé peut être efficace sans être efficace. **B**
- Q5. La prématurité est une contre-indication du BCG. **B**
- Q6. Les centres antituberculeux sont situés au niveau périphérique du versant administratif du PNLT. **B L1p51**
- Q7. L'approvisionnement en eau potable et en eau courante est un critère de salubrité de l'habitat relatif à la protection contre la contagion. **A L1p64**
- Q8. La mise en œuvre effective de la politique des soins de santé primaires en Côte d'Ivoire a débuté en 1993. **A L1p76**
- Q9. L'épidémiologie analytique répond à la question : pourquoi ? **A L1p81**
- Q10. Eduquer consiste à collecter, traiter et diffuser des informations. **B**
- Q11. La létalité est le nombre de décès parmi les malades. **A L2p30**
- Q12. Le besoin théorique des vaccins représente 25% du stock de sécurité. **B L2p43**
- Q13. L'approche psychosociologique des besoins en vue du diagnostic communautaire permet de fournir des données qualitatives. **A L2p53**
- Q14. L'effet aigu de l'alcoolisme se manifeste au début par une joie excessive. **B L2p60**
- Q15. En cas de paralysie flasque aiguë une investigation avec fiche se fait après 06 mois. **B L2p66**
- Q16. La population cible du monitoring de l'activité de la CPN est composée des femmes qui ont accouché pendant la période du monitoring. **B L3p4**
- Q17. Les ressources propres dans la gestion financière d'un ESPC constituent 55% des recettes brutes. **A**
- Q18. La contre-référence est le retour du patient dans l'établissement de premier recours pour la poursuite de son traitement. **B L3p18**
- Q19. Le paiement du salaire du personnel journalier de la structure de santé est inscrit dans les dépenses du comité de gestion. **A L3p14**
- Q20. L'épidémie est une conséquence sociale des catastrophes. **B L3p40**
- Q21. La supervision a pour cible le matériel. **B L3p44**
- Q22. Le budget alloué aux activités est un indicateur de résultats. **B L3p57**
- Q23. L'évaluation initiale permet de décrire les facteurs de risque de la population. **A L3p53**

QCM

Cochez les alvéoles correspondant aux bonnes réponses sachant qu'une bonne réponse vaut 0,5 point et une mauvaise réponse ou une absence de réponse vaut 0 point.

Q24. Parmi les facteurs suivants, indiquez ceux qui sont des déterminants de la maladie L1p16

- A. L'eau polluée
- B. Les microbes**
- C. Les parasites**
- D. Les ordures
- E. Les virus**
- F. Les bruits

Q25. Parmi les Sigles suivants, indiquez celui qui correspond à la nouvelle appellation du CHU.

- A. EPHN**
- B. EPHD
- C. EPHR

Q26. Une femme enceinte ayant une protection de 3 ans contre le tétanos aura reçu dans son organisme au moins L1p46

- A. 01 dose de Td
- B. 02 dose de Td**
- C. 03 doses de Td
- D. 04 doses de Td

Q27. Parmi les objectifs suivants, indiquez ceux qui relèvent du niveau central L1p

- A. Augmenter le taux de dépistage à 80% des malades attendus ;
- B. Dépister au moins 70% des TPMP+ ;**
- C. Améliorer le taux de guérison à 85% des malades ;
- D. Guérir au moins 85% des TPM+ nouvellement dépistée ;**
- D. Augmenter la couverture du TDO à 100% sur l'ensemble du territoire national ;**
- E. Réduire le taux de perdu de vue à 0%.

Q28. Selon les propositions suivantes, choisissez deux méthodes de lutte contre les larves de moustiques ? L1p72

- A. Réparer les fosses septiques et les caniveaux**
- B. Pulvériser l'intérieur des maisons d'insecticides
- C. Eliminer ou réduire les gîtes de reproduction**
- D. Porter des vêtements longs et clairs à la tombée de la nuit
- E. Utiliser des crèmes anti-moustiques

Q29. Parmi les composantes essentielles des soins de santé primaire ci-dessous, cochez celles qui sont justes. L1p78

- A. Vaccination contre les maladies courantes
- B. Fourniture en médicaments essentiels**
- C. Promotion de bonnes conditions d'hygiène alimentaire.
- D. Prévention et lutte contre les endémies locales**

Q30. Parmi les actions suivantes, indiquez celle qui relève de l'épidémiologie analytique L1p81

- A. Evaluer l'impact des actions
- B. Expliquer l'état de santé**
- C. Décrire l'état de santé d'une population

Q31. Parmi les éléments suivants, indiquez ceux qui sont les cibles de l'IEC/CCC L1p86

A. Décideurs politiques —————→(Plaidoyer)

B. Individu

C. Communauté

D. La société civile —————→ (Mobilisation sociale)

E. Groupe cible de la population —————→ (Mobilisation communautaire)

Q32. Le taux de mortalité néonatale précoce concerne :

A. Les décès d'enfants de 0 à moins de 08 jours

B. Les décès d'enfants de 08 à moins de 28 jours

C. Les décès d'enfants de 28 jours à moins d'un an.

Q33. Parmi les vaccins suivants, deux sont sensibles à la congélation. Lesquels ?

L2p46

A. VPI

B. VAA

C. RR

D. Td

E. VPO

Q34. L'ampleur d'un problème prioritaire de santé se détermine à partir : L2p56

A. du nombre de cas de cette maladie.

B. du nombre de décès engendrés par cette maladie

C. des séquelles engendrées par cette maladie

Q35. Quelles sont les accidents causés par l'abus des drogues chez la mère.

A. L'endométrieose

B. Les fausses couches

C. Le fibrome

D. Les accouchements prématurés

E. Le kyste de l'ovaire.

Q36. Parmi les indicateurs suivants, indiquez ceux qui permettent de mesurer la disponibilité des ressources pendant le monitoring des activités de vaccination : L3p5 / L3p11

A. Pourcentage de temps sans rupture en vaccins du PEV

B. Pourcentage de temps sans rupture en feuilles de température

C. Pourcentage de temps sans rupture en seringue autobloquante

D. Pourcentage de temps sans rupture en boîtes de sécurité

Q37. Parmi les éléments suivants, indiquez ceux qui constituent les recettes brutes des ESPC. L3p14

A. La vente des vaccins

B. Les actes de santé

C. La vente des carnets de santé

D. La vente des seringues de vaccination

E. La vente des médicaments essentiels

F. La vente des TDR de paludisme

Q38. Le membre du bureau du COGES qui n'est pas élu est :

A. Le président

B. Le trésorier

C. Les commissaires aux comptes

D. Le secrétaire général

Q39. La supervision permet : L3p

A. de déceler chez l'agent supervisé des insuffisances

B. de mesurer les résultats obtenus par l'agent supervisé

C. d'améliorer la qualité du travail accompli par l'agent supervisé

D. d'apprécier la conscience professionnelle de l'agent supervisé

Q40. Identifier parmi les tâches suivantes, celles qu'il faut exécuter à la clôture d'une séance de vaccination : L3p63

A. évaluer la séance de vaccination

B. ranger les flacons utilisés dans le réfrigérateur

C. étiqueter les flacons ouverts et non réutilisables

D. détruire les déchets

ETUDE DE CAS

Bayo est une Sous-Préfecture qui compte 10000 habitants au 31/12/ 2024. Vous avez pris service le 03 Mai 2024 au centre de santé urbain de cette localité dont l'aire sanitaire couvre les villages figurant dans le tableau ci-dessous.

Village	Distance par rapport au centre de santé (en kilomètre)	Population totale en 2024 (en habitants)
Tougboli	09	5000
Nongana	02	8000
Yellé	14	1500
Pinvoro	08	2500
Kafonon	04	1500
Flapihin	12	2500

En 2024, les informations suivantes ont été recueillies au niveau du Centre de santé urbain de Bayo :

- Les pathologies prédominantes de l'aire sanitaire étaient la dysenterie amibienne, la fièvre typhoïde, la malnutrition, le paludisme et les infections respiratoires aiguës ;
- 173 jours sans rupture en vaccins au second semestre ;
- Pendant 8 jours, la température du réfrigérateur du centre de santé urbain de Bayo notée sur les feuilles de température au cours du second semestre était supérieure à 8°C ;
- 90 % des femmes enceintes vivant dans un rayon de moins de 5 km du centre de santé urbain de Bayo ont effectué au moins 4 Consultations prénatales ;
- Le taux d'utilisation en vaccin Penta du Centre de santé urbain est estimé à 95% ;
- La veille du second monitoring de l'année 2024, la somme à la banque était de 800000 fcfa y compris les intérêts et les agios qui étaient respectivement 5500 fcfa et 2800 fcfa.

Consignes

- Les résultats des calculs comportant des virgules sont à arrondir au quart supérieur quel que soit la valeur des chiffres après la virgule.
- Les arrondissements ne concernent pas les pourcentages.

En vous servant des informations du texte ci-dessus répondez aux questions suivantes.

Q41. Parmi les maladies fréquemment rencontrées au centre de santé urbain de Bayo, indiquez celles qui ne sont pas dues à la consommation de l'eau non potable. L1p59

A. La dysenterie amibienne

B. Le paludisme

C. Les infections respiratoires aiguës

D. La fièvre typhoïde

E. La malnutrition

Q42. Quelle est la population totale l'aire sanitaire du CSU de Bayo en 2024 ?

Pt= 10000+5000+8000+1500+2500+1500+2500 = 31000
hbts

A. 31000 habitants

B. 21500 habitants

C. 21000 habitants

Q43. Quelle est la population cible des activités de vaccination pour ce second semestre ?

A. 2115 enfants

B. 1467 enfants

C. 1058 enfants

$$P0-23\text{mois} = 6,82\% \times P_t = 6,82\% \times 31000 = 2115$$

$$\text{Au second semestre : } P0-23\text{mois} = 2115 / 2 = 1058$$

Q44. Quelle est la distance totale à parcourir chaque mois pour réaliser les activités de vaccination en stratégie avancée au niveau de l'aire sanitaire du centre de santé urbain de Bayo ?

A. 49 Kilomètres

B. 43 kilomètres

C. 86 Kilomètres

D. 98 kilomètres

$$\text{Distance en stratégie avancée} = 9+14+8+12 = 43 \text{ Km}$$

$$\text{Distance totale} = 43 \times 2 = 86 \text{ Km}$$

Q45. Combien de fiches de rapports mensuels d'activité devez-vous commander au district sanitaire pour la gestion de l'information sanitaire en 2024 ?

A. 8 fiches

B. 16 fiches

C. 24 fiches

Prise de service le 03 Mai 2024 au centre de santé urbain
par agent de sante : rapports commander $8 \times 2 = 16$

Q46. Quelle est la durée de la période de rupture en vaccins au centre de santé urbain de Bayo au second semestre ?

A. 9 jours

B. 10 jours

C. 11 jours

Au second semestre correspond au monitoring de Décembre 2024
 $\text{DONC } 183 - 173 = 10 \text{ JOURS}$

Q47. Quel est la disponibilité des vaccins au niveau de l'aire sanitaire du centre de santé urbain de Bayo pendant le second semestre de l'année 2024 ?

A. 95,05%

B. 95,53 %

$$DR = (173 / 183) \times 100 = 94,53\%$$

C. 94,53%

Q48. Pendant combien de jours, la chaîne du froid du centre de santé urbain de Bayo a-t-elle bien fonctionné au second semestre de l'année 2024 ?

A. 176 jours

B. 175 jours

C. 174 jours

$$183 - 8 = 175 \text{ JOURS}$$

Q49. Quelle est la population totale de l'aire sanitaire dont les femmes enceintes bénéficient des activités du centre de santé urbain de Bayo en stratégie fixe au cours de l'année 2024 ?

A. 9500 habitants

B. 11500 habitants

C. 19500 habitants

$$\text{Population en stratégie fixe} = 10000 + 8000 + 1500 = 19500$$

Q50. Combien de femmes enceintes bénéficient des activités du centre de santé urbain de Bayo en stratégie fixe en 2024 ?

A. 475 femmes enceintes

B. 575 femmes enceintes

C. 975 femmes enceintes

$$\text{Population Femme enceinte} = 5\% \times P_{sf} = 5\% \times 19500 = 975$$

Q51. Combien de femmes enceintes vivant dans un rayon de moins de 5 km du centre de santé urbain de Bayo sont-elles effectuées au moins 4 consultations prénatales en 2024 ?

A. 878 femmes enceintes

B. 518 femmes enceintes

$$100\% \longrightarrow 975 \text{ FE}$$

$$90\% \longrightarrow x = (90 \times 975) / 100 = 878$$

C. 428 femmes enceintes

Q52. Quel est le facteur de perte du Penta pendant l'année 2024 ?

A. 1,11

B. 1,10

C. 1,05

$$F_p = 100 / TU = 100 / 95 = 1,05$$

Q53. Quelle est la somme à la banque après les mouvements bancaires ?

A. 802700 FCFA

B. 800000 FCFA

C. 797200 FCFA

$$SB = 800000 - 2800 = 797200$$

DALOA EN LIGNE

DIPLOME D'ETAT BLANC 2025 : EPREUVE DE SOINS INFIRMIER EN CHIRURGIE

/ VERSION B / DUREE 1H30

QCD : Réponse fausse – 1Pt réponse juste + 1Pt aucune réponse 0Pt

N°	Libeller des questions	A	B
1.	Parmi les matériels à réunir pour les soins de colostomie figurent un gant de toilette et une serviette de toilette propres	VRAI	FAUX
2.	Le besoin d'apprendre dans la colostomie peut se justifier par le caractère éducatif du soin pour le patient.	VRAI	FAUX
3.	La colostomie est l'abouchement définitif ou provisoire d'un segment du jéjunum à la peau	VRAI	FAUX
4.	L'irrigation vésicale bien conduite dans l'adénomectomie prévient les infections et les retentions urinaires postopératoire	VRAI	FAUX
5.	Dans l'occlusion intestinale le lavement baryté s'effectue en cas de perforation intestinale	VRAI	FAUX
6.	La péritonite est dite secondaire en absence de lésion intraabdominale responsable de l'infection	VRAI	FAUX
7.	La péritonite se manifeste par une triade de signe fonctionnelle et un signe physique	VRAI	FAUX
8.	La péritonite et l'occlusion présentent les mêmes signes fonctionnels	VRAI	FAUX
9.	Le signe physique de l'occlusion est la contracture abdominale alors que celui de la péritonite est le météorisme abdominal	VRAI	FAUX
10.	La péritonite tuberculeuse est une péritonite secondaire	VRAI	FAUX

CAS CLINIQUE N° 2

Infirmier au CHR de MAN, vous recevez aux urgences chirurgicales au cours d'une garde, l'enfant Agnéro Esmel, **diabétique** âgé de 10 ans et pesant 30KG pour brûlure. Le médecin s'appuyant la table de Lund et Browder et la règle de Baxter prescrit une réanimation hydroélectrolytique. Le liquide de réanimation ordonné par le médecin est de 25200 ml à perfuser en 48 heures

11. Indiquer parmi les propositions ci-dessous la quantité de liquide à perfuser dans les dernières 24 heures.

A. 25200 ml

En 48h la quantité de la perfusion est 25200ml
 Donc : $QJ1 + QJ2 = 25200$ Avec $QJ1 = 2 \times QJ2$
 $2 \times QJ2 + QJ2 = 25200$
 $3 \times QJ2 = 25200$
 $QJ2 =$

- B. 12600 ml
C. 8400 ml
 D. 4200 ml

$$\frac{25200}{3}$$

12. Indiquer parmi les propositions ci-dessous la quantité de liquide à perfuser dans les 24 premières heures.

- A. 16800 ml**
 B. 12600 ml
 C. 8400 ml
 D. 6300 ml

En 48h la quantité de la perfusion est 25200ml

$$QJ1 + QJ2 = 25200$$

$$QJ1 = 25200 - QJ2$$

$$QJ1 = 25200 - 8400$$

13. Indiquer parmi ces propositions ci-dessous la formule de Baxter à J2.

- A. $Q = 4 \times \text{Poids (Kg)} \times \text{SCB}$
 B. $Q = 8 \times \text{poids (Kg)} \times \text{SCB}$
C. $Q = 2 \times \text{poids (Kg)} \times \text{SCB}$
 D. $Q = \frac{1}{2} \times \text{poids (Kg)} \times \text{SCB}$

$$QJ1 = 4 \times \text{Pds} \times \text{SCB}$$

$$QJ2 = \frac{QJ1}{2}$$

$$QJ2 = \frac{4 \times \text{Pds} \times \text{SCB}}{2}$$

$$QJ2 = 2 \times \text{Pds} \times \text{SCB}$$

14. En vous réfèrent aux formules précédentes indiquer parmi ces propositions l'étendu de la brûlure de l'enfant Agnéro.

- A. 21%
 B. 7%
 C. 42%
 D. 10%
E. 14%

$$QJ2 = 2 \times \text{Pds} \times \text{SCB}$$

$$\text{SCB} = \frac{QJ2}{2 \times \text{Pds}}$$

$$\text{SCB} = \frac{8400}{2 \times 30} = 140$$

15. Ces événements ci-dessous se sont succédé lors de la brûlure de l'enfant Agnéro. Classer les par ordre chronologique de survenu en cochant la lettre de la combinaison correspondante

L1p78(Doc sémio)

1. Exsudation plasmatique
2. Anoxie tissulaire
3. Hypovolémie
4. Trouble de la perméabilité capillaire

Indiquer votre classification parmi ces propositions ci-dessous.

- A. 1-2-3-4
B. 4-1-3-2
 C. 4-3-2-1
 D. 1-4-3-2

16. Sachant que vous êtes témoin de l'accident. Indiquer parmi ces propositions trois actions à accomplir en votre qualité de premier secouriste en cochant la lettre de la correspondant à la réponse juste

L1p83(Doc sémio)

- A. Refroidissement de la victime à l'eau froide**
 B. Rupture des phlyctènes
C. Couvrir la victime par un drap propre
 D. Prévention du tétanos par injection de SAT
E. Isolation thermique de la victime
 F. Pansement avec topique traditionnels
 G.

17. Indiquer parmi ces propositions trois facteurs qui peuvent prédisposer l'enfant Agnéro à des complications infectieuses en cochant la lettre correspondant à la réponse juste

L1p79(Doc sémio)

- A. La rupture de la barrière cutanée**
- B. L'œdème pulmonaire
- C. La translocation bactérienne**
- D. L'inhalation de fumées
- E. La dépression immunitaire marquée**
- F. Les troubles de l'hémostase

18. En vous appuyant sur texte indiquer parmi ces propositions le terrain sur lequel est survenu cette brûlure en cochant la lettre correspondant à la réponse juste

- A. Insuffisance cardiaque
- B. Insuffisance hépatique
- C. Diabétique**
- D. Insuffisance rénale

19. Calculer l'indice de Baux de l'enfant Agnéro en vous appuyant sur les données cliniques et indiquer votre réponse parmi les propositions ci-dessous en cochant la lettre correspondant à la réponse juste.

- A. 67
- B. 32
- C. 46
- D. 39**
- E. 35

$$\begin{aligned} \text{IB} &= \text{SCB} + \text{AGE} + 15 \\ \text{IB} &= 14 + 10 + 15 \end{aligned}$$

20. Indiquer le pronostic vital de l'enfant Agnéro parmi ces propositions en cochant la lettre correspondant à la réponse juste.

- A. Guérison infiniment probable**
- B. Une chance sur deux de guérison
- C. Mort quasi certaine

QCM : Réponse juste + 1 pt réponse fausse 0 pt aucune réponse 0 Pt

21. Indiquer parmi ces propositions les deux signes que peut rapporter la victime en cas de fracture

L1p62(Doc sémio)

- A. Une douleur vive**
- B. Une déformation
- C. Une mobilité anormale
- D. Une impotence fonctionnelle**
- E. Une crépitation osseuse

22. Indiquer parmi ces propositions trois signes que peut rechercher le praticien en cas de fracture

L1p62(Doc sémio)

- A. Une déformation**
- B. Une douleur vive
- C. Une mobilité anormale**
- D. Une impotence fonctionnelle
- E. Une crépitation osseuse**

23. Indiquer parmi ces propositions l'examen de confirmation d'une fracture

L1p62(Doc sémio)

- A. L'échographie
- B. L'EEG
- C. La radiographie**
- D. L'ECG

24. Indiquer parmi ces propositions trois signes que peut mettre en évidence l'examen de confirmation d'une fracture.

- A. La déformation
- B. Le type de fracture**
- C. La mobilité anormale
- D. Le déplacement des fragments osseux**
- E. La crépitation osseuse
- F. Les lésions associées**

L1p62-63(Doc sémio)

25. Indiquer les types de fractures parmi les propositions ci-dessous.

- A. Fracture fermée
- B. Fracture incomplète**
- C. Fracture ouverte
- D. Fracture en bois vert**
- E. Fracture complète**

L1p62-63(Doc sémio)

26. Indiquer une variété de fracture incomplète parmi ces propositions

- A. Fracture simple
- B. Fracture à étage**
- C. Fracture en bois vert**
- D. Fracture comminutive

L1p63(Doc sémio)

27. Indiquer la variété de déplacement qui traduit un chevauchement parmi ces propositions.

- A. Déplacement transversal
- B. Déplacement angulaire
- C. Déplacement longitudinal**
- D. Déplacement rotatoire

L1p63(Doc sémio)

28. Indiquer la traduction sémiologique du déplacement horizontal en cas de fracture parmi ces propositions.

- A. Déplacement en baïonnette**
- B. Déplacement angulaire
- C. Déplacement longitudinal
- D. Déplacement rotatoire

L1p63(Doc sémio)

29. Indiquer l'ordre chronologique de la prise en charge orthopédique d'une fracture

- A. Rééducation / Réduction / Contention
- B. Réduction / Rééducation / Contention
- C. Contention / Rééducation / Réduction
- D. Contention / Réduction / Rééducation
- E. Réduction / Contention / Rééducation**

L1p64(Doc sémio)

30. Indiquer parmi ces propositions l'implication lésionnelle du tiroir postérieur.

- A. Lésion du ligament patellaire
- B. Lésion du ligament croisé postérieur**
- C. Lésion du ligament collatéral fibulaire
- D. Lésion du ligament croisé antérieur

31. Indiquer parmi ces propositions l'implication lésionnelle du tiroir antérieur.

- A. Lésion du ligament patellaire
- B. Lésion du ligament croisé postérieur
- C. Lésion du ligament collatéral fibulaire
- D. Lésion du ligament croisé antérieur**

CAS CLINIQUE N° 1 Réponse juste + 1 pt réponse fausse 0 pt aucune réponse 0 Pt
 Stagiaire au CHR de MAN, pendant votre permanence alors que l'infirmier s'est retiré pour sa pause déjeuner vous recevez monsieur Gbê. Voici les faits rapportés par celui-ci à l'interrogatoire : « Docteur depuis près de dix jours, je ne fais pas de selle ni de vent. En tous cas je sens un inconfort au ventre avec des douleurs vive. Vraiment docteur aider moi ça ne va, je ne veux pas mourir ! S'exclame-t-il tout en larme ».

32. Selon les faits rapportés par M. Gbê indiquer votre première conduite à tenir vis-à-vis de celui-ci parmi les propositions suivantes.

- A. Examiner le malade
- B. Informer l'infirmier

- C. Prendre les constantes
D. Préparation psychologique
- 33. Indiquer deux contenus de cette première conduite tenue plus haut parmi ces propositions**
A. Inspecter le patient
B. Rassurer le malade
C. Appel téléphonique de l'infirmier
D. Mettre le malade en confiance
E. Inscire les constantes dans le dossier
- 34. Indiquer parmi ces propositions l'affection dont souffre M. Gbê**
A. Appendicite aiguë
B. Péritonite aiguë
C. Occlusion intestinale
D. Hernie étranglée
- 35. Indiquer selon le texte les signes fonctionnels de cette affection rapportés par M. Gbê parmi les propositions suivantes**
A. Douleur à la fosse iliaque droite
B. Vomissement bilieux fécaloïde
C. Douleur abdominale vive
D. Météorisme abdominal
E. Température élevée
F. Arrêt des matières et des gaz
- 36. Indiquer parmi ces propositions un signe physique de cette affection que vous pouvez rechercher chez M. Gbê.**
A. Douleur à la fosse iliaque droite
B. Vomissement bilieux fécaloïde
C. Douleur abdominale vive
D. Météorisme abdominal
E. Température élevée
F. Arrêt des matières et des gaz
- 37. Indiquer parmi ces propositions deux moyen que vous disposez pour mettre évidence ce signe physique**
A. Auscultation
B. L'inspection
C. L'interrogatoire
D. L'ASP
E. La palpation
- 38. En vous appuyant sur les signes rapportés par le malade indiquer le siège de cette affection parmi les propositions suivantes**
A. La fosse iliaque droite
B. La fosse iliaque gauche
C. L'intestin grêle
D. Le côlon
- Informez des résultats de vos investigations l'infirmier vous demande de prescrire des examens complémentaires
- 39. Indiquer les examens radiologiques que vous pouvez prescrire à M. Gbê parmi ces propositions**
A. L'ASP
B. L'échographie abdominale
C. Ionogramme sanguin
D. Lavement baryte
E. Numération formule sanguine
- 40. Indiquer parmi ces propositions les résultats éventuels des examens radiologiques**
A. Colon partiellement injecté de baryte
B. Désordre hydroélectrolytique
C. Hématocrite élevé
D. Côlon totalement injecté
E. Niveau hydroaérique

41. L'infirmier vous demande d'entamer la prise en charge médicale de M. Gbê. Indiquer les soins médicaux délégués que vous pouvez poser parmi les propositions suivantes.
- A. Préparation physique du malade
 - B. Pose d'une perfusion
 - C. Pose d'une sonde nasogastrique
 - D. Préparation de la chambre du malade
 - E. Installation du malade
 - F. Prélèvement sanguin
42. Indiquer parmi ces propositions les soins propres de l'infirmiers que vous pouvez réaliser.
- A. Prise d'une voie veineuse
 - B. Préparation physique du malade
 - C. Pose d'une sonde nasogastrique2
 - D. Préparation de la chambre du malade
 - E. Prélèvement sanguin
 - F. Installation du malade
43. L'infirmier vous demande de préparer le champ opératoire. Indiquer l'ordre chronologie de cette préparation physique parmi ces propositions.
- A. Rasage / Détersion / Désinfection
 - B. Rasage / Désinfection / Détersion
 - C. Détersion / Désinfection / Rasage
 - D. Détersion / Rasage / Désinfection
44. Le chirurgien décide de réaliser une laparotomie. Indiquer deux buts visés par le chirurgien en réalisant ce type d'intervention.
- A. But de réaliser une hémostase
 - B. But diagnostic
 - C. But de réaliser une ponction
 - D. But de réaliser une endoscopie
 - E. But thérapeutique
 - F. But de poser une sonde d'aspiration
45. Indiquer les actes à accomplir dans la période peropératoire parmi les propositions ci-dessous
- A. Surveillance de drains
 - B. Elaboré une fiche de surveillance
 - C. Surveillance du pansement
 - D. Réfection du lit du malade
 - E. Favoriser le lever précoce
 - F. Installer le matériel d'oxygénothérapie
46. Indiquer les actes à accomplir dans la période postopératoire de M. Gbê parmi les propositions ci-dessous.
- A. Surveillance de drains
 - B. Elaboré une fiche de surveillance
 - C. Surveillance du pansement
 - D. Réfection du lit du malade
 - E. Favoriser le lever précoce
 - F. Installer le matériel d'oxygénothérapie
47. Indiquer parmi ces propositions l'intérêt de surveiller le pansement et les drains
- A. Prévenir les phlébites
 - B. Prévenir le syndrome de Mendelson
 - C. Prévenir les hémorragies
 - D. Déceler une hémorragie
48. Indiquer parmi ces propositions le phénomène qui témoigne de la réussite de l'intervention
- A. Le réveil du malade
 - B. La perméabilité des drains
 - C. La reprise du transit intestinal
 - D. L'absence d'hémorragie

VERSION D

Diplôme d'Etat blanc
EPREUVE MEDECINE 2025 DALOA

Lorsque vous soumettez ce formulaire, il ne collecte pas automatiquement vos détails, tels que le nom et l'adresse e-mail, sauf si vous le fournissez vous-même.

I. QCM

1. Parmi les propositions suivantes, deux constituent les facteurs de gravité dans l'infection du tétanos, lesquels ? L1p111 (Doc maladie infectieuse)

- A. Une incubation supérieure à 7 jours
- B. Une porte d'entrée ombilicale, chirurgicale ou utérine**
- C. Une invasion supérieure à deux jours
- D. Une présence de paroxysme**
- E. Une température inférieure à 38°C

2. Parmi les propositions suivantes, deux sont correspondent à la prophylaxie individuelle de la fièvre typhoïde, lesquelles ? L1p92 (Doc maladie infectieuse)

- A. Laver les mains avant chaque repas**
- B. La CCSC.**
- C. La vaccination**
- D. La construction, l'utilisation et l'entretien des latrines
- E. L'assainissement du milieu

3. Parmi les examens suivants, deux sont des examens de certitude de la fièvre typhoïde, lesquels ?

L1p911 (Doc maladie infectieuse)

- A. NFS
- B. Widal et Félix
- C. Coproculture**
- D. PCR.**
- E. Frottis sanguin

4. Parmi les propositions suivantes, laquelle est un signe de la fièvre typhoïde à la phase d'état ?

L1p89 (Doc maladie infectieuse)

- A. Céphalées
- B. Splénomégalie**
- C. Tuphos**

5. Parmi les maladies infectieuses suivantes, deux sont virales, lesquelles ?

- A. Cholera
- B. Diphtérie
- C. Tétanos
- D. Rougeole**
- E. Oreillon**

6. Parmi les propositions suivantes, deux favorisent les escarres, lesquelles ? L1p127(Doc MT de Soins Infirmiers)

- A. La réduction de la mobilité**
- B. Une alternance entre position debout et position couchée**
- C. Un mauvais état nutritionnel**
- D. Le changement de position régulière
- E. La mise en fauteuil précoce

7. Un lavement évacuateur est indiqué L1p102(Doc MT de Soins Infirmiers)

- A. Devant une constipation chronique
- B. Avant une intervention chirurgicale sur le colon
- C. Avant une rectoscopie

D. Toutes les propositions sont justes

8. La tension artérielle est la pression sous laquelle le sang circule dans les vaisseaux et dépend de :

- A. La force d'éjection du cœur
- B. La masse sanguine
- C. L'état des vaisseaux

D. Toutes les réponses sont justes

9. Sur une feuille de surveillance communément appelée feuille de température, une flèche verticale en rouge indique :

- A. Une injection IM
- B. Une transfusion sanguine

C. Une intervention chirurgicale ou une ablation de drain

10. Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond à la technique de la dialyse pratiquée en Côte d'Ivoire ?

- A. Dialyse ultrafiltration

B. Hémodialyse

- C. Dialyse péritonéale

11. Parmi ces propositions, quelle est celle qui répond à l'objectif principal de la dialyse ?

- A. L'augmentation de la production de l'urine

B. L'élimination des déchets métaboliques et de l'excès de fluide

- C. La stimulation de la fonction rénale

12. Les éléments suivants sont les constituants du plasma sauf deux, lesquels ?

- A. Eau
- B. Créatinine
- C. Urée

D. Acide hippurique

E. Ammoniac

13. Les éléments suivants sont les constituants de l'urine sauf deux, lesquels ?

- A. Eau
- B. Glucide
- C. Urée
- D. Chlorure

E. Protide

14. Les éléments suivants constituent la structure de l'appareil urinaire sauf, lequel ?

- A. Le rein

B. Le canal déférent

- C. L'urètre

15. Une personne présente des céphalées, une insomnie, des vertiges avec épistaxis, une température élevée et constante. A quelle affection pensez-vous ?

- A. Paludisme
- B. Grippe

C. Fièvre typhoïde

16. Au regard des signes cliniques cités plus haut, à quelle étape clinique se situe le malade ?

- A. Incubation
- B. Phase d'état

C. Invasion

17. A l'arrivée du médecin, il décide de lancer un examen biologique. A quel examen pensez-vous ?

- A. Goutte épaisse
- B. NFS

C. Coproculture

18. En attendant les résultats de l'examen, le médecin vous demande de lui placer un soluté ordinaire X dont le débit est de 25 gttes/mn en 3 h de temps. Déterminer la quantité d soluté à placer.

A. 225 ml

- B. 300 ml
- C. 350 ml

$$D = \frac{Q \times 20}{Tx60} \Rightarrow Q = \frac{D \times Tx60}{20} = \frac{25 \times 3 \times 60}{20} = 225$$

19. Face à un cas d'hyperthermie, l'infirmier doit :

- A. Habiller le client et le couvrir
- B. Mettre une bouillotte auprès du malade

C. Donner à boire au malade

20. Fièvre typhoïde : à J8, quelles agglutinines apparaissent d'abord ? L1p91 (Doc maladie infectieuse)

- A. Anti-H
- B. Anti-O**
- C. Anti-Vi
- D. Anti-D

- Les agglutinations Anti-O apparaissent à j8 et disparaissent en 2 à 3 mois
- Les agglutinations Anti-H apparaissent à j12 et disparaissent en quelques mois à quelques années

21. Angines pseudo-membraneuses : l'enduit possède toutes les caractéristiques suivantes sauf une, laquelle ?

- A. Adhérent
- B. Cohérent

C. Reproductible

- D. Friable et non extensible

22. Parmi les couleurs suivantes, par convention, laquelle représente les urines sur une feuille de surveillance ?

- A. Vert
- B. Jaune**
- C. Rouge

23. Selon l'indice de masse corporelle, M. Koné est-il :

A. Maigre

- B. Corpulence normale
- C. Obèse

$$IMC = \frac{P}{T^2} = \frac{50}{(1,65)^2} = 18,36$$

24. Vous recevez M. Koné, planteur âgé de 40 ans. Il présente ce jour une anémie sévère, une fièvre de 39°C et n'a reçu aucun soin d'hygiène depuis la veille. M. Koné pèse 50 kg pour une taille de 1,65 m. Parmi les besoins de Virginia Henderson suivants, identifiez les deux besoins prioritaires de M. Koné

- A. Besoin d'éviter les dangers
- B. Besoin de se mouvoir et se maintenir en bonne posture
- C. Besoin d'être propre, soigné et protéger ses téguments et phanères**

D. Besoin de dormir et se reposer

E. Besoin de maintenir la température corporelle dans les limites de la normale

25. La fourchette normale du taux de l'hémoglobine chez un homme est :

A. De 0 à 50g/L

B. De 60 à 90 g/L

C. De 120 à 160 g/L.

26. La valeur en dessous de laquelle une transfusion sanguine s'impose est :

A. 70 à 90g/L

B. 0 à 70g/L

C. 90 à 160g/L

27. Parmi les pathologies suivantes, deux sont à la base de l'anémie de M. Koné, lesquelles ?

A. Paludisme

B. Fièvre typhoïde

C. Méningite

D. Ankylostomiase

E. Grippe

28. Le médecin décide une transfusion sanguine de 360 ml à passer en 3h de temps à M. Koné, quel est le débit de cette transfusion ?

A. 30 gttes/mn

B. 31 gttes/mn

C. 32 gttes/mn

$$D = \frac{Q \times 15}{T \times 60} = \frac{360 \times 15}{3 \times 60} = 30$$

29. Dans le protocole, le médecin a prescrit de l'arthemeter 80mg/ml injectable dont la posologie est de 3,2 mg/kg/j en IM. Quelle est la dose d'arthemeter à administrer en dose de charge à M. Koné ?

A. 3 ml

B. 4 ml

C. 2 ml

$$\begin{array}{lcl} 1\text{Kg} & \longrightarrow & 3,2\text{mg} \\ 50\text{Kg} & \longrightarrow & x = 50 \times 3,2 = 160 \text{ mg} \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} 80\text{mg} & \longrightarrow & 1\text{ml} \\ 160 \text{ mg} & \longrightarrow & y = \frac{160}{80} = 2\text{ml} \end{array}$$

II. QCD

30. Le poulx est la sensation de soulèvement perçue par le doigt qui déprime une veine superficielle sur un plan osseux. B (une artère)

31. La variation de la température corporelle est soit physiologique soit pathologique. A

32. La diurèse normale d'un adulte est comprise entre 1,2L et 1,5L. A

33. La courbe des urines est matérialisée par un histogramme. A

34. La température corporelle varie selon les émotions, l'âge et le climat. A

35. Avec un thermomètre à mercure, la température axillaire marquée se note directement dans le carnet du patient. B « ajout +0,5°C »

36. La feuille de température comporte deux types de trait.

37. L'onchocercose est transmise par la piqûre de la glossine. B « la similie »

38. L'hématémèse est l'émission de sang rouge par la bouche dans un effort de vomissement. A

39. Le venin des vipéridés est neurotoxique et entraîne des paralysies généralisées. B « hémotoxique »

40. Le but du traitement du diabète est de normaliser le taux de sucre dans le sang. A

41. L'un des accidents redoutés dans les lavements évacuateurs est l'irritation de la muqueuse rectale. B « incidents »

42. Le lavement évacuateur est indiqué en cas de fistule vésiculo-vaginale et une occlusion intestinale. B « contre indiqué »

43. Un examen endoscopique est indiqué dans les pathologies digestives hautes. **A**
 44. Le pouls normal d'un adulte est compris entre 60 et 70 pulsations par minute. **B**

Le pansement du cordon frais : a lieu les 3 premiers jours de vie du nné

Le pansement du cordon sec : a partir du 4^{ème} jours de vie du nné jusqu'à la chute du moignon du cordon

Le pansement de la plaie ombilicale : intervient après la chute du moignon du cordon dont la moyenne est de 8 à 10 jours

Version C

Diplôme d'Etat blanc EPREUVE PEDIATRIE 2025 DALOA

Lorsque vous soumettez ce formulaire, il ne collecte pas automatiquement vos détails, tels que le nom et l'adresse e-mail, sauf si vous le fournissez vous-même.

I. QCD

1. Au cours du **pansement de la plaie ombilicale**, le procédé consiste à nettoyer le moignon du cordon ombilical de la base vers l'extrémité. **B** « **pansement du cordon sec** »
2. La photothérapie permet de **potentialiser** le taux de bilirubine par l'exposition de la peau à des longueurs d'onde spécifiques. **B** « **réduire** »
3. Le spina bifida est favorisé par le non-respect de la prophylaxie contre l'anémie. **A**
4. L'enfant triple sa surface corporelle à 36 mois. **A**
5. L'apparition de la bilirubine libre pendant la photothérapie impose l'arrêt du soin. **A**
6. Dame ZY porte une grossesse de 33 semaines et présente une hémorragie du troisième trimestre. Le fœtus est en souffrance et l'obstétricien réalise l'accouchement en urgence. La cause de la prématurité est induite. **A**
7. La prolactine est responsable de la crise génitale du nouveau-né. **A**
8. Pour décider en salle de naissance de la réanimation du nouveau-né ma boussole est **le score d'APGAR**. **B** « **la respiration** »
9. Le poids traduit l'état nutritionnel de l'enfant et renseigne sur son état de santé car il est très sensible aux facteurs internes (maladies). **A**
10. Kolou est née avec un poids de 1950 g et nourri au lait artificiel, son poids peut atteindre 3850 g à 05 mois d'âge. **B**

Enfant nourri au lait artificiel : **PN x 2 à 5mois** et **PN x 3 à 12mois**

Donc : $1950 \times 2 = 3900g \neq 3850$

11. KL a un tétanos ombilical. Le score pronostic de Dakar est de 4. Cela signifie que le tétanos de KL est modéré. **B**

- **Score 0-2 : Tétanos frustré**
- **Score 3 : Tétanos modéré**
- **Score 4-6 : Tétanos grave**

12. Le nourrisson qui présente une fontanelle bregmatique très enfoncée au cours de la diarrhée aiguë a une déshydratation sévère **A**
13. Le nourrisson allaité double son poids de naissance à 3 mois. **A**
14. L'incubateur néonatal permet de maintenir l'enfant dans une température ambiante de variation thermique. **B**
15. L'utilisation des négatoscopes et des robinets est proscrite dans une salle de suivi des nouveau-nés sous surveillance. **A**

16. Dans les soins des organes génitaux externes de la petite fille, il faut nettoyer le méat urinaire avec la compresse imbibée de désinfectant en descendant vers l'anus afin de ne pas ramener les selles vers les organes génitaux. **A**
17. Chez le nouveau-né à terme la striation de la plante du pied est supérieure ou égale au deux tiers antérieurs. **A**
18. Le bain est proscrit chez le nouveau-né dont le cordon n'a pas chuté et dont la plaie n'est pas encore cicatrisée. **A**
19. Les soins des orifices est **facultative** en cas d'hypersécrétion. **B** « absolue »
20. Concernant les types de bain de l'enfant, le bain de propreté, le bain détente, le bain thérapeutique constituent la liste exhaustive. **A**
21. La présence d'un vernix caséosa abondant et du lanugo témoignent d'une immaturité du nouveau-né. **A**
22. Le nouveau-né normal a une **coloration rouge brun**. **B** « coloration rose »
23. La pose d'une sonde gastrique est une contre- indication **relative** de la détresse respiratoire. **B** « absolue »
24. Pour traiter l'asthme aux urgences de pédiatrie, l'agent de santé réalise des soins délégués en administrant une nébulisation de salbutamol solution à 0,5% à la posologie de 0,03 ml/kg. **A**
25. Le nourrisson manifeste de la peur à un visage non familier à 9 mois. **A**
26. Pour recueillir le reflux de l'air ou du lait en cas de vomissements lors de la pose de sonde gastrique à un nouveau-né, il faut prendre soin de maintenir la seringue 30 à 45 cm **en dessous** du niveau de l'estomac. **B** « au-dessus »

II. QCM

27. Dans la phénylcétonurie, le taux de phénylalanine dans le sang est supérieur à :

- A. 55 mg/100 ml
- B. 35 mg/100 ml
- C. 45 mg/100 ml
- D. 25 mg/100 ml**

28. NK, fille, 5mois, diarrhée aiguë avec signes sévères de déshydrations. NK :

- A. Est incapable de boire**
- B. boit avec avidité
- C. est agité
- D. a les yeux enfoncés

29. Le principal agent pathogène de la diarrhée aiguë bactérienne est :

- A. Shiguelle**
- B. Escherichia coli
- C. Salmonelle
- D. Rotavirus

30. BC, sexe masculin, connaît l'utilisation des objets familiers et la notion de haut, bas grand et petit. Il demande, tout énervé et en pleur, à Monsieur ZZ venu rendre visite à sa tante préférée de quitter la chaise de son papa. L'âge de BC est compris entre :

- A. 2 et 3 ans.**
- B. 4 et 5 ans.
- C. 6 et 7 ans
- D. 1 et 2 ans

31. Le nouveau-né JM est né à terme. A une minute de vie, il est bleu de partout, tout mou et ne pleure pas. La respiration est irrégulière et le cœur bat à 75 pulsations par minutes. La mère est très inquiète. Le score de vitalité de JM est coté à :

- A. 4

Aspect : bleu de partout : 0
Pouls : 75puls/min < 100puls/min : 1
Grimace : ne pleure pas : 0
Activité : tout mou : 0
Respiration : irrégulière : 1

- B. 5
- C. 2**
- D. 3

32. CX est né le 15 janvier 2019 en bonne santé. Le cordon ombilical est soigné avec des feuilles traditionnelles depuis la naissance. Le 19 janvier 2019, il a présenté brutalement un refus de téter, une fièvre, une raideur discrète et des pleurs. Le 23 janvier 2019, son état s'est aggravé avec la survenue de contracture généralisée, d'un trismus et des paroxysmes. La température était de 39° et la fréquence cardiaque de 140 pulsations par minutes. Le médecin vous informe que CX a un tétanos. La période d'incubation de la maladie de CX a duré :

- A. 6 jours
- B. 3 jours
- C. 4 jours
- D. 5 jours**

33. Dans le processus des soins essentiels du nouveau-né, l'examen clinique et les soins prophylactiques sont réalisés.

- A. Avant 60 minutes de vie
- B. Entre 60 et 90 minutes de vie**
- C. Entre 90 et 120 minutes de vie
- D. Après 120 minutes de vie

34. CLAUDIA, un garçonnet de 12 mois pesant 10 500 grammes. Sa croissance est normale. Le poids de naissance de CLAUDIA est :

- A. 3500 grammes.**
- B. 3000 grammes
- C. 2500 grammes
- D. 3750 grammes.

12mois : PN x 3

$$PN = \frac{10500}{3}$$

35. Les indications du gavage sont :

- A. L'absence de reflexes de succion et de déglutition
- B. Le comateux
- C. Les maladies infectieuses**
- D. La malnutrition sévère

E. Choisir la réponse inexacte

36. Le matériel spécifique nécessaire pour poser une sonde à gavage est :

- A. Des compresses stériles
- B. Un sérum glucosé 5 ou 10%**
- C. Un petit plateau stérile
- D. Un sérum bicarbonaté 14 pour 1000
- E. Choisir la réponse exacte

37. Lors du gavage continu, il faut surveiller :

- A. L'aspect et les réactions du nouveau-né**
- B. L'aspect, la couleur et le nombre des selles
- C. Les rejets : l'aspect, la couleur et le nombre des vomissements**
- D. la progression de l'aliment

38. La pose de la bouillotte est recommandée en cas de :

- A Hyperthermie chez le nourrisson ou chez l'enfant.
- B. Nouveau-né ictérique
- C. Nouveau-né hypotrophe**
- D. Nouveau-né de mère diabétique

39. Après la photothérapie, l'agent de santé doit :

- A. Surveiller la température toutes les 6 heures
- B. Veiller à l'augmentation de la ration hydrique, voire calorique en cas de diarrhée
- C. Noter le nombre et l'aspect des selles et des urines
- D. Faire des soins des yeux préventifs au sérum physiologique suivis d'instillations de collyre antiseptique.

40. La photothérapie peut provoquer à court terme comme accident ou incident

- A. Une hyperactivité de l'enfant
- B. Des variations de la température corporelle

C. Un ballonnement abdominal.**41. GH est âgé de 60 mois. Il a une diarrhée sans déshydratation. La quantité de SRO à fournir à la mère pour le traitement à domicile est**

- A. 250 ml/jour
- B. 500 ml/ jour
- C. 1000 ml/jour**
- D. 1500 ml/litre

Diarrhée sans déshydratation « **plan A** »

- <2ans : 500ml/J soit 50 à 100ml de SRO
- 2 à 10ans : 1000ml/J soit 100 à 200ml de SRO
- Plus de 10ans : 2000ml/J de SRO

42. GH est âgé de 16 mois et pèse 12 kg. Il a une diarrhée avec signes sévère de déshydratation. La quantité de soluté de réhydratation par voie parentérale a perfusé en 30 minutes

- A. 360 ml**
- B. 500 ml
- C. 250 ml
- D. 460 ml

Diarrhée avec signe sévère de déshydratation « **Plan C** »

1Kg $\longrightarrow$ 30ml
 12Kg $\longrightarrow$ X = 12 x 30

43. KL a un paludisme et n'a aucun signe de danger. Il a vomi deux fois durant toute la journée. Pour le traiter j'utilise en première intention Le mot manquant de la phrase est :

- A. Artémether injectable en IM
- B. Artésunate injectable en IV
- C. Quinine injectable en perfusion

D. Comprimé Artémether + Luméfantrine**44. Le principal germe de la diarrhée aiguë du nourrisson est**

- A. Shiguelle
- B. Enterovirus
- C. Escherichia coli

D. Rotavirus**45. WX né à terme eutrophique, J2 de vie, 2900 grammes, ictère intense, apport liquidien sans photothérapie 80ml/kg/jour. Le médecin décide de le mettre sous photothérapie. La quantité de liquide à administrer à WX sous photothérapie est :**

- A. 250 ml
- B. 245 ml
- C. 255 ml**
- D. 235 ml

2900g = 2,9Kg
 1Kg $\longrightarrow$ 80ml
 2,9Kg $\longrightarrow$ X = 2,9 x 80 = 232ml
 • Apport hydrique 10% ou 15%
 10% x 232 = 23,2
 Donc : 232 + 23,2 = 255

46. LK, garçon, 8 mois, 9 kg signes sévères de déshydratation. J'administre durant la première journée de traitement

- A. 170 ml de soluté
- B. 270 ml de soluté**

Diarrhée avec signe sévère de déshydratation « **Plan C** »

1Kg $\longrightarrow$ 30ml
 9Kg $\longrightarrow$ X = 9 x 30

- C. 370 ml de soluté
D. 470 ml de soluté

47. Un enfant qui émet au moins trois selles molles ou liquide par 24 heures depuis 15 jours présente une :

- A. Diarrhée chronique
B. Diarrhée persistante
C. Diarrhée subaiguë
D. Diarrhée aiguë

- Diarrhée aiguë : 0 à 13 jours
- Diarrhée persistante : 14 à 21 jours
- Diarrhée chronique : sup à 21 jours

48. Pour traiter le syndrome extrapyramidal provoqué par l'antiémétisant, j'administre du Diazépam à la dose de

- A. 0,5 g/kg
B- 0,5 mg/kg.
C. 1 g/kg
D. 1mg/kg

49. Le nouveau-né normal a :

- A. Un lobule de l'oreille ourlée**
B. Un poids de 2400g
C. Une fontanelle bombée
D. Un nodule mammaire de 2 mm

50. Les causes suivantes sont responsables de vomissements chronique ou habituel sauf une. Quelle est cette cause ?

- A. psychogène
B. Occlusion intestinale
C. Sténose hypertrophique du pylore
D. erreur diététique

51. La principale complication métabolique du nouveau-né prématuré est

- A. hyponatrémie
B. hypokaliémie
C. Hypomagnésémie
D. hypoglycémie

52. Le nouveau-né de sexe masculin normal a :

- A. Nodule mammaire en dessous de 3 mm
B. Température rectale 35°5 Celsius
C. fréquence respiratoire 55 cycles/min
D. Fréquence cardiaque 80 battements/min

VERSION B

Diplôme d'Etat blanc
EPREUVE SANTE PUBLIQUE 2025 DALOA

Lorsque vous soumettez ce formulaire, il ne collecte pas automatiquement vos détails, tels que le nom et l'adresse e-mail, sauf si vous le fournissez vous-même.

I. QCM

1. Le bureau du Coges comprend : L3p21

- A. Président
- B. 01 Responsable de la gestion financière
- C. 01 Responsable de la gestion administrative et technique
- D. Aucune réponse

2. Parmi les problèmes suivants causés par l'abus des drogues, indiquez ceux qui sont d'ordre sanitaire : L2p61

- A. L'absentéisme scolaire
- B. L'hallucination
- C. Les accidents de la voie publique
- D. Le délire
- E. Le suicide
- F. L'asthénie

3. Parmi les propositions suivantes, cocher celles qui sont les missions assignées à un district sanitaire.

- A. Evaluation des agents de santé
- B. Promotion des soins de santé primaires
- C. Suivi et évaluation des activités
- D. Coordination des activités sanitaires

4. Parmi les problèmes suivants causés par l'abus des drogues, indiquez ceux qui sont d'ordre sanitaire. L2p61

- A. L'absentéisme scolaire
- B. L'hallucination
- C. Les accidents de la voie publique
- D. Le délire
- E. Le suicide
- F. L'asthénie

5. SIMR signifie : L2p63

- A. Système intégré de la maladie et la riposte
- B. Surveillance intégrée de la maladie et la riposte
- C. Système intégré de la morbidité et la riposte
- D. Surveillance intégrée de la morbidité et la riposte

6. Selon le rythme des activités de monitoring en Côte d'Ivoire, précisez les périodes de monitoring ? L2p12

- A. Décembre 2023 à Mai 2024
- B. Janvier 2023 à Juin 2023
- C. Juin 2024 à Novembre 2024
- D. Juillet 2023 à Décembre 2023

7. Parmi les antigènes ci-dessous, cochez ceux qui ont pour site d'administration la cuisse. L1p40-41

- A. BCG; Td; PCV 13.
- B. VPI; Rota;
- C. DN hépatite; VPI; Men A ; VAP**
- D. VPO; HPV ; RR

8. Combien de doses de l'antigène de l'hépatite B reçoit un enfant de 0 à 11 mois correctement vacciné ? L1p46

- A. 1 dose
- B. 3 doses.
- C. 4 doses**

9. En cas de paralysie flasque aigue un prélèvement des selles se fait : L2p66

- A. Entre J10 et J14
- B. Entre J14 et J60**
- C. Entre J61 et 06 mois
- D. Après 06 mois.

10. Parmi les indicateurs suivants, indiquez ceux qui sont à tendance positive L2p25-26

- A. Le taux de mortalité
- B. Le taux de natalité**
- C. Le taux général de fécondité**
- D. Le taux de morbidité

11. La population cible du monitoring de la CPN est : L3p4

- A. Femme en âge de reproduction de la période du monitoring
- B. Femmes enceintes pendant la période du monitoring**
- C. Femmes ayant accouchées pendant la période du monitoring

12. Parmi ces antigènes suivants, lequel est vivant atténué ? L1p41

- A. Td.
- B. VPO**
- C. VPI

13. Parmi les sources de données pour le monitoring des activités de vaccination, indiquez celles qui sont des sources de l'accessibilité géographique. L3p11

- A. Rapports de vaccination
- B. Cartographie de l'aire sanitaire**
- C. Rapports SIG**
- D. Registre des données démographiques**
- E. Feuille de relevé de la température du réfrigérateur
- F. Fiche de stock vaccins

14. Lorsque la somme à la banque comprend les agios et les intérêts, pour calculer le montant du fond de réserve :

- A. On n'y ajoute rien**
- B. On y retire les agios**
- C. On y ajoute les intérêts
- D. On y ajoute les agios
- E. On n'y retire rien

15. Parmi les éléments suivants, identifier ceux qui constituent des différentes catastrophes naturelles : L3p39

- A. La guerre
- B. Les cyclones**
- C. Les tremblements de terre**
- D. Le tsunami**

- E. Les graves accidents de circulation
- F. Les génocides

16. Les vaccins du PEV qui sont sensibles à la lumière sont : L2p45

- A. BCG
- B. RR
- C. VAA
- D. Penta

17. Parmi les éléments suivants, identifiez les deux qui indiquent un processus.

- A. Le taux d'utilisation des contraceptifs
- B. Le dénombrement des populations cible
- C. Le commande des contraceptifs
- D. Le nombre de femmes sensibilisées
- E. Le nombre de sages-femmes recrutées
- F. Les fiches de stock des contraceptifs

18. Les différentes stratégies vaccinales du PEV ivoirien de routine appliquée dans un CSR sont

- A. La stratégie hyper avancée
- B. La stratégie du porte à porte
- C. La stratégie fixe
- D. La stratégie avancée
- E. La stratégie mobile.

19. Parmi les objectifs suivants, indiquez ceux qui relèvent du niveau périphérique

- A. Augmenter la couverture du TDO à 100% sur l'ensemble du territoire national.
- B. Améliorer le taux de guérison à 85% des malades dépistés.
- C. Réduire le taux de perdu de vue à 0%.
- D. Dépister au moins 70% des TPMP+.
- E. Impliquer la communauté dans les activités de lutte contre la tuberculose.
- F. Augmenter le taux de dépistage à 80% des malades attendus.

20. Quel est l'ordre normal d'administration de ces groupes d'antigènes conformément au calendrier de vaccination du PEV ivoirien ? L1p46

- 1. 1-Penta 3+VPO-3+PCV-13-3+VPI
 - 2. 2-Penta 2+VPO-2+PCV-13-2+Rota 2
 - 3. 3-VPO-0+BCG+DN-HepB
 - 4. 4-Penta1+VPO-1+PCV13-1+Rota 1
 - 5. 5-RR+VAA+Men A
- A. (1,2,3,4,5).
 - B. (3,4,2,1,5).
 - C. (3,4,1,2,5).
 - D. (4,3,2,1,5).

21. Parmi les maladies suivantes, indiquez celles qui sont sous surveillance en Côte d'Ivoire.

- A. Le cholera
- B. Le paludisme.
- C. La fièvre hémorragique virale
- D. La dracunculose
- E. Les infections respiratoires aiguës
- F. Les infections urinaires

22. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a adopté la stratégie des soins de santé primaire en : L1p76

A. 1981

B. 1991

C. 1993

D. 1994

ETUDE DE CAS

Après votre formation, vous êtes affecté au centre de santé d'Attokro dont la population totale a été estimée à 5000 habitants au 31/12/2019 et à 5100 habitants au 1er/01/2021. Pendant l'année 2021, les données sanitaires suivantes ont été relevées dans ce village :

- 25 naissances enregistrées dont 04 mort-nés ;
- 105 cas de paludisme et 35 cas de diarrhées ;
- 03 décès des femmes enceintes dont 01 à la suite d'une chute sur la route du champ ;
- 06 femmes décédées dont 04 après 5 semaines de suites de couches et 02 après 7 semaines de suites de couches.

A la fin de l'année 2021, le responsable CSE du district sanitaire se plaint du fait qu'il a reçu 25 rapports mensuels d'activités dans le délai requis sur 96 attendus. Le centre de santé de ce village dispose à la banque de la somme de 800 000 f y compris les intérêts et les agios qui sont respectivement de 15000f et 10000 f. Les recettes issues de la vente des médicaments essentiels se chiffrent à 150.000f. **Celles issues du coût des actes de santé représentent le tiers des recettes des médicaments essentiels.** A partir du texte ci-dessus répondre aux questions ci-dessous

23. Quel est le taux d'accroissement annuel de la population d'Attokro ?

A. 0,02%

B. 2%

C. 0,2%

Pop du 31/12/2019 = Pop du 01/01/2020 = 5000 hbts

Pop du 01/01/21 = Pop du 31/12/2020 = 5100 hbts

$TAA = ((5100 - 5000) / 5000) \times 100 = 2\%$

24. Quelle est la population totale en 2021 ?

A. 5100

B. 5200

C. 5202

$P_{2021} = P_{2020}(1 + (TAA/100)) \exp 1$

$P_{2021} = 5100 (1 + (2/100)) \exp 1 = 5202 \text{ hbts}$

25. Quelle est la population moyenne en 2021 ?

A. 5151

B. 5150

C. 5050

$P_{moy} = ((\text{Pop début} + \text{Pop fin}) / 2)$

$P_{moy} = ((5100 + 5202) / 2) = 5151 \text{ hbts}$

26. Quel est le nombre de femmes en âge de reproduction en 2021 ?

A. 1020

B. 1030

C. **1041**

Nbre de femme en âge de reproduction = 20% x Pt

Nbre de femme en âge de reproduction = 20% x 5202 = 1041

27. Quel est le nombre des enfants de 0 à 23 mois en 2021

A. 352

B. 256

C. 351,30

Nbre des enfants de 0 à 23 mois = 6,82% x Pt

Nbre de femme en âge de reproduction = 6,82% x 5202 = 355

28. Quel est le nombre de structures sanitaires que compte le district sanitaire dont dépend le CSR d'Attokro ?

- A. 08
- B. 96
- C. 192
- D.

$$92 \text{ rapports attendus} / 12 = 8$$

29. Quelle est la somme à la banque après mouvement bancaire ?

- A. 790000 FCFA
- B. 785000 FCFA
- C. 775000 FCFA

$$SB \text{ après mouvement bancaire} = 800000 - 10000 = 790000$$

30. Quel est le montant des recettes issues du coût des actes de santé ?

- A. 50.000 FCFA
- B. 55000 FCFA
- C. 45000 FCFA

$$RCAS = RMVE / 3 = 150000 / 3 = 50000$$

31. Quelle est la somme à budgétiser ?

- A. 205000 FCFA
- B. 200000 FCFA
- C. 195000 FCFA

$$SAB = RVME + RCAS$$

$$SAB = 150000 + 50000 = 200000$$

QCD

32. Le niveau périphérique de la pyramide sanitaire de la Côte d'Ivoire est chargé de L'élaboration de la politique sanitaire. **B** « le niveau centrale »

33. L'accessibilité aux soins consiste à mettre les soins de santé à proximité des populations et à un prix non exorbitant. **A** **L1p30**

34. Le non-respect de la politique du flacon entamé est un facteur évitable de perte de vaccins. **A** **L2p42**

35. L'Epidémiologie analytique répond à la question combien ? **B** **L1p81**

36. La perte de l'appétit est l'une des contre-indications de l'administration du Rotarix. **B**

37. Le goître endémique est une maladie causée par l'excès de l'iode dans l'eau de consommation. **B** **L1p59** « manque ou insuffisance d'iode »

38. En Côte d'Ivoire la politique des SSP comprend deux composantes préventives et trois composantes curatives. **B** **L1p78**

39. On peut administrer le VPI à tous les enfants ayant un âge compris entre 0 et 23 mois sans exception. **A**

40. Les doses de vaccins perdues pour que la vaccination ait lieu sont considérées comme des doses sacrifiées. **A** **L2p38**

41. Plus le taux de perte est élevé, moins le facteur de perte est élevé. **B**

42. Dans le cas de la poliomyélite à virus de type sauvage, l'excrétion virale dans les selles augmente au-delà de deux semaines après le début de la paralysie. **B** **L2p67**

43. Pendant le monitoring de Décembre 2024, on fait la budgétisation de Décembre 2024 à Mai 2025. **B** **L3p12**

44. En matière de vaccination, l'intervalle minimum existe. **A**

45. La population cible des consultations et soins curatifs est la population totale pendant la période monitorée. **A** **L3p4**

46. Le superviseur ayant le style autocratique cherche à tout comprendre. **A** **L3p44**

47. L'évaluation est similaire au monitoring. **B** **L2p74**

48. Le taux de mortalité maternelle est une proportion. **B** **L1p83**

49. Le taux de létalité permet d'évaluer la qualité de la prise en charge des malades. **A L2p30**
50. Faire la vaccination en stratégie avancée est une solution pour réduire les populations hors de portée. **B L2p38 « les populations hors accès**
51. L'absence d'humidité dans le logement est un critère de salubrité de l'habitat relatif aux besoins physiologiques. **A L1p64**
52. La quantité à commander est inscrite sur les fiches de stock des vaccins. **A L2p44**
53. 2-Le système de santé qui s'adapte constamment à l'évolution des besoins de la population est dit efficace. **B L1p30 « réactif »**
54. L'élaboration d'un plan d'action permet de pérenniser le projet en la rendant plus autonome. **B**
55. La supervision s'inscrit dans les activités de gestion des Soins de Santé Primaires (SSP) **A**
56. Les membres du COGES sont désignés pour une durée de deux ans renouvelables **B**

KORHOGO

ANTENNE : INFAS KORHOGO**EXAMEN BLANC DU DIPLOME D'ETAT INFIRMIERS ET INFIRMIERES****EPREUVE DE SOINS INFIRMIERS EN CHIRURGIE****SESSION : OCTOBRE 2025/ DUREE : 1H30 mn****CONSIGNE** : Répondez aux questions Q1 à Q60 en cochant la ou les bonnes réponses.

ATTENTION : Pour les QCD, cochez A pour la bonne réponse et B pour la mauvaise. Ainsi, une réponse juste vous octroie un (1) point et une fausse vous retranche un (-1) point ; une question sans réponse équivaut à zéro (0) point.

Pour les QCM, une réponse juste équivaut à un (1) point et une mauvaise réponse, 0 point.

VERSION A**I- QUESTIONS A CHOIX DOUBLE (QCD)**

- 1- L'anorexie, les vomissements alimentaires et la constipation sont des signes annonciateurs ou prodromes de l'appendicite. **A L2p108**
- 2- La septicémie à perfringens succède à un avortement provoqué. **A L1p22**
- 3- L'invagination intestinale est l'une des causes mécaniques de l'occlusion intestinale. **A L2p115**
- 4- La hernie inguinale est un épanchement liquidien dans le scrotum des testicules. **B L2p96**
- 5- Le pic de fréquence dans l'appendicite aiguë se situe entre 10 et 3 ans et concerne-les deux sexes. **B L2p106**
- 6- Les amphithroses sont des articulations immobiles. **B L3p5 (Doc TD en Chirurgie)**
- 7- Les occlusions inflammatoires sont la combinaison des occlusions mécaniques et celles qui sont fonctionnelles. **A L2p116**
- 8- Les panaris du tissu cellulaire sous cutané sont des panaris superficiels. **B L1p26**
- 9- L'adénome de la prostate est une tumeur maligne qui se traduit par une hypertrophie de la glande prostatique. **B L3p154**
- 10- La gangrène est un phlegmon nécrosant du tissu musculaire à évolution rapide et extensive. **A L1p47**
- 11- La voie rhinopharyngée est une porte d'entrée du germe de l'ostéomyélite aiguë. **A L1p51**
- 12- Si l'abcès froid n'est pas fistulisé, il est nécessaire de procéder à l'incision large avec effondrement et destruction de la paroi à la curette. **B L1p36**
- 13- Le spina-bifida occulta ne se traite qu'en cas d'anomalies neurologiques graves. **A L2p182**
- 14- Les occlusions fonctionnelles sont le fait du dérèglement du système nerveux intestinal. **A L2p116**
- 15- Plus le score de Glasgow est élevé plus l'état du malade est grabataire. **B L3p5 (Doc neurochirurgie)**
- 16- Une fracture est une solution de continuité au niveau d'un os. **A L1p62**
- 17- Lors d'un accident, la luxation antéro-interne est la variété la plus fréquente des luxations de l'épaule. **A**
- 18- La péritonite peut avoir pour cause le bacille de Koch. **A**
- 19- La température du scrotum est plus élevée que celle de l'abdomen. **B L2p171**
- 20- La cryptorchidie est une anomalie de la descente du testicule due à un défaut de sécrétion de testostérone. **A L2p171**

II- QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES (QCM)

21- Parmi les structures suivantes indiquez les deux qui sont affectées par le germe en cas de mal de Pott. L3p32 (Doc neurochirurgie)

- A. Les vertèbres
- B. Les bronchioles
- C. Les alvéoles pulmonaires
- D. Les disques intervertébraux

22- Indiquez les trois signes qui marquent la phase terminale d'une péritonite. L2p124

- A. Douleurs abdominales avec diffusion progressive (période initiale)
- B. Vomissements bilieux, porracés et fécaloïdes
- C. Températures et pouls variables (période initiale)
- D. Hoquet
- E. Immobilité diaphragmatique (période initiale)
- F. Occlusion paralytique

23- Des quatre symptômes essentiels du syndrome occlusif, un seul signe physique caractérise l'occlusion, lequel ? L2p117

- A. Douleurs abdominales
- B. Arrêt des matières et des gaz
- C. Météorisme abdominal
- D. Vomissement

24- Les soins préopératoires pour la laparotomie consistent à : L2p127

- A. Prévenir l'hypovolémie à cause des pertes de liquides dues aux vomissements
- B. Préparer la salle et le lit du malade
- C. Préparer le champ opératoire
- D. Contrôler le réveil physiologique

25- Toutes ces causes aboutissent à une occlusion mécanique, sauf une, laquelle ? L2p115

- A. Corps étrangers
- B. Dérèglement du système nerveux intestinal
- C. Torsion d'une anse intestinale sur elle-même
- D. Invagination intestinale

26- Deux de ces signes physiques indiquent une péritonite aiguë, lesquels ? L2p124

- A. Douleurs de la fosse iliaque droite
- B. Contracture abdominale
- C. Défense abdominale
- D. Immobilité diaphragmatique
- E. Accélération modérée du pouls
- F. NFS à 10 000 éléments par mm³ de sang.

27- Parmi les propositions suivantes, indiquez celle qui se rapporte à la notion d'intervalle de temps libre chez le traumatisé crânien. L3p9 (Doc TD en Chirurgie)

- A. Le temps qui s'écoule entre la survenue de l'accident et la prise en charge du patient
- B. Le temps qui sépare la perte de connaissance initiale et la réapparition des troubles de la conscience
- C. La durée des troubles de la conscience occasionnée par le traumatisme crânien

28- Parmi les éléments suivants indiquez les trois signes d'une atteinte du rachis cervical supérieur, en cas de traumatisme du rachis. L3p14 (Doc neurochirurgie)

- A. Les troubles sphinctériens
- B. Les vertiges**
- C. La paresthésie
- D. Les céphalées**
- E. Le torticollis
- F. Les troubles neurovégétatifs**

29- Parmi les propositions suivantes indiquez celle qui correspond à la durée moyenne du temps de guérison d'un patient sous traitement en cas de mal de POTT. L3p34(Doc neurochirurgie)

- A. 4 à 6 mois
- B. 6 à 8 mois
- C. 8 à 12 mois**

30- Parmi les hernies suivantes, indiquez les deux qui sont des hernies de l'aîne. L2p39

- A. La hernie ventrale latérale
- B. La hernie inguinale**
- C. La hernie crurale**
- D. La hernie de la ligne blanche

31- Indiquez selon la règle de Baxter, le poids d'un brûlé à 50% de sa surface corporelle qui reçoit 9300 ml de soluté les deux premiers jours. L1p83

- A. 15,5 kg
- B. 31 kg**
- C. 46,5 kg

32- Parmi les paramètres suivants, indiquez les trois qui sont utilisés dans l'échelle de Glasgow. L3p3-4 (Doc neurochirurgie)

- A. La coloration de la peau
- B. L'ouverture des yeux**
- C. La réponse verbale**
- D. Le mouvement des yeux
- E. La réponse motrice**
- F. La sensibilité

33- Parmi les actions suivantes, indiquez les deux à effectuer en urgence chez un patient qui souffre de rétention urinaire. L2p164

- A. L'adénomectomie
- B. La cystectomie
- C. La Ponction sus-pubienne**
- D. Le Sondage urétral**

34- Parmi les éléments suivants, indiquez les deux qui sont des formes anatomopathologiques de l'appendicite aigue. L2p107

- A. L'appendicite catarrhale**
- B. Le plastron appendiculaire
- C. Les péritonites appendiculaires
- D. Les appendicites gangreneuses**

35- Parmi les propositions suivantes indiquez les deux avantages du lever précoce pendant les suites opératoires.

- A. La prévention des chocs hémodynamiques
- B. La lutte contre l'infection
- C. L'accélération de la reprise du transit
- D. La prévention des hémorragies
- E. La prévention de la stase et l'obstruction bronchique

36- Calculez le volume d'une poche de sang de concentré érythrocytaire devant passer en 2 heures avec un débit de 60 gouttes/min.

- A. 360 ml
- B. 480 ml
- C. 520 ml
- D. 720 ml

37- Indiquer parmi ces propositions deux éléments pouvant être mis en évidence par l'ASP en cas d'occlusion. L2p118

- A. Gargouillement
- B. Silence abdominal
- C. Niveau hydro-aérique
- D. Matité
- E. Ballonnement abdominal
- F. Siège de l'occlusion

38- Ces événements se succèdent lors d'une brûlure. Classer les par ordre chronologique

1. Exsudation plasmatique
2. Anoxie tissulaire
3. Hypovolémie
4. Trouble de la perméabilité capillaire

Indiquer votre classification parmi ces propositions. L1p78

- A. 1-2-3-4
- B. 4-3-2-1
- C. 1-4-3-2
- D. 4-1-3-2

II- ETUDE DE CAS N°1

Infirmier(ère) Diplômé(e) d'Etat en service au centre de santé d'Assiè Akpessé, district sanitaire de M'Batto, vous êtes requis(e) par la brigade de gendarmerie de ladite ville pour un constat d'accident de la voie publique (AVP), ayant fait de nombreux blessés. A votre arrivée sur les lieux, vous suspectez chez monsieur A. S. l'une des victimes, une fracture ouverte de la diaphyse fémorale droite et chez madame B. Y. une fracture fermée des deux os de l'avant-bras droit.

Vous décidez d'évacuer les victimes au service de Chirurgie du CHR de Dimbokro.

A l'hôpital, les premières radiographies confirment le diagnostic de ces fractures ?

39- Déclinez le geste d'urgence à poser avant l'évacuation des victimes. L2p42

- A. Réduction des fractures des victimes
- B. Immobilisation provisoire des fractures des victimes

40- Enumérez trois buts de ce geste. L2p42

- A. Réduire la douleur
- B. Arrêter une hémorragie
- C. Minimiser le risque d'embolie graisseuse
- D. Préparer l'ostéosynthèse
- E. Eviter une ostéosynthèse
- F. Limiter les déplacements des fragments osseux

41- A quel type de squelette appartiennent ces fractures. (Anatomie L1)

- A. Squelette appendiculaire
- B. Squelette principal
- C. Squelette axial

42- Citez deux complications immédiates de la fracture ouverte de monsieur A.S. L3p41

- A. Ouverture du foyer de fracture
- B. Phlébite et embolie
- C. Retard de consolidation
- D. Choc traumatique et hémorragique
- E. Atrophie musculaire
- F. Raideur du genou

43- Quelles sont les deux conséquences de ces complications ? L2p43

- A. Infection
- B. Déshydratation
- C. Amputation
- D. Cal vicieux

44- En votre qualité d'Infirmier(ère) Diplômé(e) d'Etat, que feriez-vous pour minimiser ces complications ? (3 bonnes réponses) L2p43-44

- A. Pas de manœuvres ou de mobilisations intempestives
- B. Faire la toilette générale du patient
- C. Nettoyer la plaie aux antiseptiques soigneusement
- D. Effectuer la prévention des escarres
- E. Transporter rapidement, sans précipitation, le blessé dans un centre chirurgical
- F. Réaliser une bonne prémédication

45- Expliquez le protocole de traitement des fractures de ces deux victimes. (3 bonnes réponses)

- A. Mobilisation
- B. Réduction
- C. Immobilisation provisoire
- D. Education
- E. Contention
- F. Rééducation

46- Dès le retour de madame B.Y. du bloc opératoire, elle porte un plâtre au niveau du membre supérieur fracturé. Quel est le nom et la définition de ce plâtre ? L3p11 (Doc TD en chirurgie)

- A. Delbet de marche
- B. Brachio-palmaire
- C. Botte plâtrée
- D. Minerve plâtrée

47- Enumérez trois (3) éléments de surveillance pour la prévention d'une éventuelle complication due à ce plâtre. L2p34

- A. Main gonflée et violacée
- B. Prurit au niveau du membre atteint
- C. Froideur des extrémités
- D. Irréductibilité primitive du membre
- E. Rotation par décalage des os lésés
- F. Douleur plus ou moins vive dans l'avant-bras

48- Décrivez la conduite à tenir en tant qu'Infirmier(ère) au bloc opératoire avant l'intervention. (3 bonnes réponses)

- A. Réaliser le Nursing
- B. Préparer la chambre et le matériel pour l'hospitalisation
- C. Préparer psychologiquement le client
- D. Surveiller une survenue de syndrome de Wolkman
- E. Faire les prélèvements pour les examens préopératoires et les radiologies
- F. Réaliser la prémédication

49- Identifiez deux (2) activités à réaliser en tant qu'Infirmier(ère) en hospitalisation de chirurgie pendant l'intervention.

- A. Réaliser le Nursing
- B. Préparer la chambre et le matériel pour l'hospitalisation
- C. Préparer psychologiquement le client
- D. Surveiller une survenue de syndrome de Wolkman
- E. Faire les prélèvements pour les examens préopératoires et les radiologies
- F. Rester l'intermédiaire entre les parents et le client

50- Identifiez deux (2) activités à réaliser en tant qu'Infirmier(ère) au bloc opératoire après l'intervention.

- A. Réaliser le Nursing
- B. Préparer la chambre et le matériel pour l'hospitalisation
- C. Préparer psychologiquement le client
- D. Surveiller une survenue de syndrome de Wolkman
- E. Faire les prélèvements pour les examens préopératoires et les radiologies
- F. Réaliser la prémédication

51- La pose de la sonde urinaire se fait dans les cas suivants, sauf deux (02) ; lesquels ?

- A. Rétention d'urines
- B. Douleur sus-pubienne
- C. Infection urinaire
- D. Hypertrophie bénigne de la prostate
- E. Incontinence urinaire

IV- ETUDE DE CAS N° 2

L'équipe de garde dont vous faites partie reçoit deux patients :

- Patient 1 : A.S. 30 ans, pèse 60 kg, est reçu pour des douleurs abdominales accompagnées d'une sensation d'étirement et de gêne fonctionnel. Taux d'Hg = 5g/dl de sang.
- Patient 2 : E.L., 42 ans, 65 kg, vient pour une contusion abdominale. Taux d'hémoglobine = 4 g/dl de sang.

Le chirurgien pratique un examen physique qui révèle une tuméfaction inguinale plus ou moins saillante chez M. A.S. et lui prescrit un traitement orthopédique tout en retardant l'acte chirurgical.

Il préconise avant les interventions chirurgicales, le relèvement des taux d'hémoglobine des deux malades à 10 g/dl de sang, sachant que le temps d'administration est de trois heures et demie avec du concentré érythrocytaire.

52- De quoi souffre A.S. ?

- A. Hernie simple
- B. Hernie étranglée

53- Quelle est la complication majeure de cette affection ?

- A. Péritonite aiguë
- B. Etranglement
- C. Occlusion intestinale

54- Quelle serait la conduite à tenir si vous receviez M. A.S. dans un centre de santé rural en cas de cette complication majeure et si l'accident n'est pas récent ?

- A. Accueillir le client avec bienveillance et l'enregistrer
- B. Réduire la hernie
- C. Prendre les constantes (température, pouls, tension artérielle)
- D. Réaliser l'incision
- E. L'examiner pour s'assurer qu'il s'agit effectivement de l'affection
- F. Faire la prémédication

55- Calculez la quantité et le débit de sang à transfuser à A.S.

- A. 900 ml
- B. 128 gouttes/mn
- C. 1800 ml
- D. 64 gouttes/mn

56- Calculez la quantité et le débit de sang à transfuser à E.L.

- A. 2340 ml
- B. 1170 ml
- C. 84 gouttes/mn
- D. 167 gouttes/mn

57- Énumérez les mécanismes de survenue des contusions abdominales. (3 réponses justes)

- A. Choc direct
- B. Percussion
- C. Par effet explosif
- D. Décélération
- E. Choc indirect
- F. Étirement

58- Expliquez deux (2) précautions à prendre avant la transfusion sanguine chez ces deux patients.

- A. Informer le patient de l'imminence du soin
- B. Surveiller les réactions du patient (calme, agitations, plaintes)
- C. Surveiller son faciès (sudation excessive)
- D. Surveiller la diurèse sur les 24H et l'apparition de Fièvre

E. Réaliser la traçabilité et garder le flacon vide pendant 2 heures au moins

F. Réaliser le test ultime au lit du malade

59- Identifiez deux (2) précautions à prendre pendant la transfusion sanguine chez les deux patients.

A. Informer le patient de l'imminence du soin

B. Réaliser le test ultime au lit du malade

C. Surveiller les réactions du patient (calme, agitations, plaintes)

D. Surveiller son faciès (sudation excessive)

E. Surveiller la diurèse sur les 24H et l'apparition de Fièvre

F. Réaliser la traçabilité

60- Expliquez les précautions à prendre après la transfusion sanguine chez les deux patients.

A. Informer le patient de l'imminence du soin

B. Réaliser le contrôle ultime au lit et régler le débit

C. Surveiller les réactions du patient (calme, agitations, plaintes)

D. Surveiller son faciès (sudation excessive)

E. Surveiller la diurèse sur les 24H et l'apparition de Fièvre

F. Réaliser la traçabilité

SUJET D'EXAMEN BLANC N°1 LICENCE 3 2025
EPREUVE DE SOINS INFIRMIERS EN MEDECINE.

KORHOGO

Consignes de composition

1- Pour les questions QCD, cochez sur la grille, la lettre A si vous estimez que la proposition est VRAIE ou la lettre B si vous estimez qu'elle est fausse.

2- Pour les QCM, cochez sur la grille la ou les lettres correspondant à la ou aux réponses justes

3- Pénalité : QCD=1 si réponse juste ; fausse = -1 sans réponse= 0 QCM : Réponse juste=1 réponse fausse = 0 ; sans réponse juste = 0

QCM CAS CLINIQUE

En service aux urgences médicales du CHR de Korhogo, vous recevez ce jour Mlle Kouassi Eliane 21 ans étudiante en licence 3 département de lettre moderne à l'université peleforgbo pour des douleurs abdominales aiguës depuis trois jours. L'interrogatoire effectué par le médecin révèle les caractéristiques de cette crise à savoir : **douleurs postprandiales à type de brûlure et de crampe, de siège épigastrique** survenant le plus souvent la nuit. Elle précise également qu'en raison de l'intensité de la douleur elle a consommé deux comprimés de diclofenac 50 mg. Depuis lors, **elle émet des selles noirâtres et fétides** parfois des vomissements de sang passagers. **Mlle Kouassi étant hospitalisée est stressée et angoissée** parce qu'elle réfléchit à son examen de fin année dont la date de composition est proche. Aussi, elle pose des questions relatives à sa maladie.

Questions :

1. Choisissez votre hypothèse diagnostique parmi ces pathologies. L2p68 (Doc de médecine) / L1p29 (Doc de sémio médical)

- A. Rupture des varices œsophagiennes
- B. Dysenterie amibienne
- C. Ulcère gastroduodénal**

2. Choisissez parmi ces examens, celui qui est indiqué pour confirmer le diagnostic de cette affection. L2p70 (Doc de médecine) / L1p29 (Doc de sémio médical)

- A. Examen parasitologique des selles
- B. Fibroscopie digestive**
- C. Echographie abdominale

3. Parmi les propositions ci-après, relevez deux rôles de l'infirmier.

- A. Prescrire des hémostatiques
- B. Préparer la patiente pour les examens appropriés**
- C. Prendre rendez-vous auprès du service concerné**
- D. Prescrire des macro molécules pour pallier un état de choc

4. Précisez la nature de l'hémorragie digestive parmi ces propositions. L1p32(Doc de sémio médical)

- A. Haute**
- B. Basse

5. Choisissez parmi ces propositions le terme d'une émission de sang par la bouche.

L1p32(Doc de sémio médical)

A. Une Hématémèse

B. Un Mélaena

C. Une Hémoptysie

6. Relevez parmi les propositions ci-après le besoin prioritaire de Mlle KOUASSI selon le modèle conceptuel de VIRGINIA Henderson.

A. Besoin de communiquer

B. Besoin d'apprendre

C. Besoin de se mouvoir et adopter une position convenable.

7. M. BP 70 ans, hospitalisé depuis 72 heures suite à une intervention chirurgicale présente ce jour une inflammation de la jambe gauche caractérisée par une douleur au mollet, un œdème dur ne prenant pas le godet, la peau est chaude et luisante ;

Choisissez parmi ces pathologies votre hypothèse diagnostique. L2p10 (Doc de médecine)

A. Une sciatique

B. Un abcès chaud

C. Une thrombose veineuse

8. Relevez parmi ces pathologies celle qui se complique souvent en une hémorragie digestive. L2p65 (Doc de médecine)

A. Reflux gastroœsophagien

B. Ulcère gastroduodéal

C. Gastrite

9. Choisissez parmi ces examens paracliniques celui qui permet de diagnostiquer une hépatite. L2p39(Doc de médecine)

A. Echographie du foie

B. Sérologie

C. NFS

10. Parmi les propositions ci-après relevez celle qui est contre-indiquée dans le cas d'une aspiration gastrique.

A. Perforation de l'estomac

B. Cancer de l'estomac

C. Lavage d'estomac

11. Parmi ces trois (3) affections cardiaques, cocher celle du myocarde. L2p16(Doc de médecine)

A. Angine de poitrine

B. Insuffisance ventriculaire gauche

C. Embolie pulmonaire

12. Parmi ces propositions suivantes, relevez celle qui correspond à l'hématurie due à la bilharziose urogénitale. L1p18(Doc de maladie infectieuse)

A. Hématurie Initiale

B. Hématurie Totale

C. Hématurie Terminale

13. Choisissez parmi ces pathologies celle qui est provoquée par Schistosoma Haematobium. L1p14(Doc de maladie infectieuse)

- A. Bilharziose Intestinale avec complications hépatiques
- B. Bilharziose Uro-génitale**
- C. Bilharziose Rectale et génitale

14. Cochez les deux facteurs de risques de la thrombose veineuse profonde des membres inférieurs dans les propositions ci-dessous :

- A. Le surpoids
- B. Immobilisation suite à un accident**
- C. Le diabète
- D. Insuffisance veineuse chronique**
- E. L'œdème des membres inférieurs

15. Relevez 2 signes généraux de la tuberculose pulmonaire parmi les manifestations cliniques ci-après. L1p107(Doc de sémio médical)

- A. Asthénie**
- B. Anorexie
- C. Toux nocturne de plus de 2 semaines
- D. Amaigrissement**

16. Choisissez parmi ces propositions, l'intervalle de temps recommander pour réaliser l'examen bactériologique de suivi après initiation au traitement antituberculeux.

- A. 20 jours à 2 mois après le début du traitement**
- B. 10 à 20 jours après le début du traitement
- C. 15 à 30 jours après le début traitement

17. Choisissez la bonne réponse. Le germe isolé en cas d'une péricardite est : L2p28(Doc de médecine)

- A. Le bacille de koch
- B. La salmonella typhi
- C. Le pneumocoque**

18. Parmi ces propositions, cocher deux moyens de prévention des phlébites dans thrombose veineuse profonde des membres inférieurs. L2p11(Doc de médecine)

- A. Détruire le thrombus
- B. Mobilisation active**
- C. Lever précoce**
- D. Repos strict

19. Choisissez parmi ces propositions celle qui répond au concept de la double protection. L1p27(Doc de COURS DE VIH SIDA)

- A. Contre les grossesses à risque et les IST/VIH/Sida
- B. Contre les grossesses non désirées et les IST
- C. Contre les grossesses non désirées et les IST-VIH/Sida**

20. L'HTA se complique sur trois organes, indiquez la bonne réponse parmi ces propositions. L2p5(Doc de médecine)

- A. Le cerveau, le cœur et les reins**
- B. Le foie, le pancréas et les poumons
- C. Les poumons, le foie et le cœur

21. Choisissez parmi les dates suivantes, celle qui correspond à l'avènement de la gratuité des ARV en Côte d'Ivoire. L1p33(Doc de COURS DE VIH SIDA)

- A. 20 Août 2008
- B. 20 Août 2004
- C. 20 Août 2003

22. Indiquez parmi les propositions suivantes celle qui répond à la définition de l'équilibre entre la production et la perte de température par l'organisme. L1p47(Doc de METHODE ET TECHNIQUE DE SOINS INFIERMIERS)

- A. La thermogenèse « production de la chaleur »
- B. La thermolyse « déperdition de la chaleur »
- C. La thermorégulation

23. Selon la classification européenne, Indiquez le stade de l'évolution des escarres lorsqu'il y a apparition d'ulcération jaunâtre fibrineuse. L1p129(Doc de METHODE ET TECHNIQUE DE SOINS INFIERMIERS)

- A. Stade 1 « érythème »
- B. Stade 2 « atteinte de l'épiderme et le derme »
- C. Stade 3

24. Indiquez le débit d'une perfusion d'un soluté de 500ml à passer en 4 heures parmi ces propositions.

- A. 41 gouttes/min
- B. 50 gouttes/min
- C. 30 gouttes/min

$$D = (Q \times 20) / (T \times 60) \text{ avec le temps moyenne de la perfusion est de 4 heures}$$

$$D = (500 \times 20) / (4 \times 60) = 41,66 = 41 \text{ gouttes/min}$$

25. Indiquez le débit d'une transfusion 450 ml à passer en 2 heures dans cette liste.

- A. 40 gouttes/min
- B. 56 gouttes/min
- C. 30 gouttes/min
- D.

$$D = (Q \times 15) / (T \times 60) \text{ avec le temps moyenne de la transfusion est de 4 heures}$$

$$D = (450 \times 15) / (2 \times 60) = 56,25 = 30 \text{ gouttes/min}$$

26. Parmi ces troubles mictionnels, indiquez celle qui correspond à Une miction fréquente peu abondante. L1p39(Doc de sémio médical)

- A. Une dysurie
- B. Une pollakiurie
- C. Une oligurie

27. Indiquer parmi ces propositions le diagnostic de la rage.

- A. La biologie
- B. La clinique
- C. La biologie et la clinique

28. Indiquez dans cette liste la proposition qui correspond aux différentes formes au cours de la rage. L1p122(Doc de maladie infectieuse)

- A. 3 formes cliniques
- B. 2 formes cliniques
- C. 1 forme clinique

- Forme Spastique (furieuse)
- Forme Paralytique (muette ou tranquille)
- Forme démentielle

29. Parmi ces propositions, choisissez celle qui correspond à la définition de la dysenterie. L1p30 (Doc de sémio médical) / L1p47(Doc de maladie infectieuse)

- A. Sang dans les selles qui sont peu abondantes
- B. Sang et de glaire dans les selles peu abondantes

C. Glaipe peu abondante et de sang dans les selles

30. Choisissez l'indication principale du lavage d'oreille parmi ces éléments. L3p55(Doc de COURS ORL)

A. Bouchon de cérumen

B. Otite suppurée

C. Otalgie (Douleur forte)

31. Choisissez parmi ces propositions celle qui est interdite pour un lavage d'oreille. L3p56(Doc de COURS ORL)

A. Perforation du tympan

B. Acouphène

C. Présence de Corps étranger

32. Choisissez parmi ces signes, celui qui peut survenir au cours du lavage d'oreille. L3p57(Doc de COURS ORL)

A. Vertiges

B. Céphalées

C. Fièvre

33. Indiquez le nom scientifique des vers ronds parmi ces propositions. L1p20(Doc de maladie infectieuse)

A. Nématodes

B. Cestodes

C. Trématodes

34. Choisissez la caractéristique principale de l'ascaris dans cette liste. L1p20(Doc de maladie infectieuse)

A. Ver Plat

B. Ver Rond

C. Ver Ovale

35. Choisissez parmi ces vers, deux qui se contractent en pénétrant la peau. L1p20(Doc de maladie infectieuse)

A. Ascaris

B. Anguillule

C. Ankylostome

D. Le ver de Guinée

36. Choisissez parmi ces vers, celui qui provoque des démangeaisons anales intenses la nuit chez l'enfant. L1p31(Doc de maladie infectieuse)

A. Dracunculose

B. Oxyure

C. Ascaris

37. Cocher une complication de l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs parmi les propositions ci-dessous.

A. Dermite

B. Occlusion artérielle aigue

C. Ongle cassante

38. Madame F, 88 ans, vous demande de l'accompagner à la salle à manger. Elle se déplace avec une canne. Choisissez parmi ces propositions le positionnement de madame F.

- A. La position physiologique
- B. La position antalgique**
- C. La position thérapeutique

39. Choisissez l'installation convenable pour les personnes présentant des difficultés cardio-respiratoires.

- A. Installation Dorsale
- B. Installation Latérale
- C. Installation Assise**

40. Parmi les propositions suivantes choisissez la position dite « Semi-Fowler à 30° »

- A. Tête en hauteur
- B. Tête en bas
- C. Tête et pieds relevés**

QCD

41. La thrombose veineuse profonde des membres inférieurs est la complication de l'embolie pulmonaire. **B**

42. Les signes cliniques de **l'insuffisance ventriculaire gauche** sont dominés par les signes de stases. **B** L2p23(Doc de médecine) « **insuffisance ventriculaire droite** »

43. L'angine de poitrine est une pathologie du myocarde. **A** L2p16(Doc de médecine)

44. Lyser le thrombus est un but de la thrombose veineuses des membres inférieurs. **A**
« **détruit** »

45. L'hépatite A peut se contracter au cours des rapports sexuels. **B** L2p36Doc de médecine)

46. Le mode de contamination de l'hépatite A est direct et indirect. **A**

47. Les complications de la fièvre typhoïde sont présentes à la phase d'invasion de la maladie. **B** L1p90(Doc de maladie infectieuse)

48. Le signe de koplick dans la rougeole se définit comme étant de petites taches blanchâtres à l'intérieur de la joue de l'enfant rougeoleux. **A**

49. La chronologie de l'apparition des boutons au cours de la rougeole est des pieds à la tête. **B**

50. La rage est contagieuse. **A**

51. Les hépatites sont classées en deux catégories. **B** « **Virale, Médicamenteuse, alcoolique** »

52. La journée mondiale du diabète a lieu chaque année du 14 octobre. **B** (14 NOVEMBRE)

53. La journée mondiale de la lutte contre le paludisme a lieu chaque année du 25 Avril. **A**

54. La journée mondiale de lutte contre la faim est célébrée le 15 Juin de chaque année. **A**

55. Les signes de la fièvre Typhoïde au premier septénaire sont : Céphalées, Insomnie, Vomissement, Epistaxis, Température élevée. (CIVET) **B** L1p89(Doc de maladie infectieuse)

56. Le moustique impliqué dans la transmission de la fièvre jaune pique aussi bien la nuit que le jour. **B** L1p127(Doc de maladie infectieuse) « **la journée** »

57. Le tétanos est une toxiinfection **contagieuse et non immunisante**. **B** L1p109(Doc de maladie infectieuse) « **non contagieuse et non immunisante** »

58. L'Opisthotonos s'observe à la période d'état de la méningite purulente. **B** L1p110(Doc de maladie infectieuse)
59. Coronavirus est un virus à ARN. **A** L1p94(Doc de maladie infectieuse)
60. La péricardite aiguë est l'inflammation d'un feuillet du péricarde associé ou non à la présence d'un épanchement liquidien. **B** L2p28(Doc de médecine) « deux feuillets »
- ANTENNE : INFAS KORHOGO**

EXAMEN BLANC DU DIPLOME D'ETAT INFIRMIERS ET INFIRMIERES
EPREUVE DE SOINS INFIRMIERS EN PEDIATRIE
SESSION : OCTOBRE 2025 / DUREE : 1H30 mn
FILERE : IDE / SFM

1ER SUJET DE PEDIATRIE

QCD

➤ **CONSIGNES**

- Réponse juste : 1 point
- Réponse fausse : MOINS 1 point
- Absence de réponse : 0 point

➤ **POUR TOUTES LES PROPOSITIONS SUIVANTES COCHEZ LA BONNE REPONSE**

1. Le marasme est provoqué par une insuffisance d'apport micronutriments. L3p57

A. Vrai

B. Faux

Le marasme est entraîné par un déficit en nutriment de type 2

2. Le sevrage définitif avant 24 mois est un facteur favorisant le déficit en macronutriments.

A. Vrai

B. Faux

C'est un facteur favorisant le déficit en micronutriments(VITAMINE et sel

3. Les cellules épithéliales du sein sont les cibles de l'hormone ocytocine

A. Vrai

B. Faux

L'ocytocine est l'hormone d'éjection du lait maternelle en agissant sur les cellules myoépithéliales

4. Au cours de la malnutrition aiguë, on observe un excès global et homogène en nutriment. L3p57

A. Vrai

B. Faux

On observe un déficit global et homogène en

5. Les aliments énergétiques aident les enfants à effectuer toutes sortes d'activités physiques.

A. Vrai

B. Faux

Aliments énergétiques = glucides et lipides

6. Les aliments de croissance ou de construction protègent contre les maladies.

A. Vrai

B. Faux

Plutôt les aliments de protections protègent contre les

7. BK né à terme est à j2 de vie et présente une infection bactérienne néonatale.

L'infection de BK est d'origine maternelle. L3p17

A. Vrai

B. Faux

Infection bactérienne néonatale précoce ou materno fœtale J0-J7

8. Le nouveau-né BK à une température à 35° Celsius. Il présente une infection.

L'hypothermie est un signe fréquent de l'infection bactérienne néonatale. L3p19

A. Vrai

B. Faux

LES PRINCIPAUX PROBLEMES DU NNE INFECTETE SONT :

Hypothermie, difficulté d'alimentation, résistance des germes aux antibiotiques usuels, décès

9. Pour traiter l'hypothermie du nouveau-né BK, je le place en incubateur (couveuse).

Cet acte de soins fait partie du rôle de conseils et prévention de l'agent de santé. L3p19

A. Vrai

B. Faux

Plutôt un rôle

10. Pendant l'hospitalisation, le nouveau-né BK présente une détresse respiratoire avec un indice de Silverman à 7. Pour la prise en charge, l'infirmier major vous conseille de ne pas le gaver. Ce conseil est pertinent

A. Vrai

B. Faux

Score de Silverman à 7 : détresse respiratoire grave

11. Jusqu'à 2 ans, j'utilise une toise verticale pour la mesure de la taille de l'enfant.

L3p32

A. Vrai

B. Faux

Toise horizontale avant 2ans

Toise verticale après

12. En Côte d'Ivoire, pour traiter le paludisme grave en 2025, les directives nationales préconisent d'utiliser en première intention l'artésunate per os. L3p52

A. Vrai

B. Faux

Plutôt Intraveineuse / Intramusculaire

13. Le nourrisson JC présente un muguet buccal. Pour réaliser ses soins buccaux, j'utilise du sérum bicarbonaté dosé à 14 pour 1000. (L1p18 Soins aux enfants)

A. Vrai

B. Faux

Sérum bicarbonaté à 14 pour 1000 ou 14‰ ou 1,4%

14. Mme ZW doit reprendre le service après son congé de maternité. Pour nourrir son enfant, L'agent de santé conseille la poursuite de l'allaitement exclusif. Le conseil de l'agent de santé est impertinent.

A. Vrai

B. Faux

Plutôt pertinent

15. Le nourrisson KKA souffre d'une malnutrition aigüe sévère. Je lui administre à l'admission de l'eau sucrée dans l'attente du lait thérapeutique.

A. Vrai

B. Faux

QCM**➤ CONSIGNES**

- Réponse juste : 1 point
- Réponse fausse : 0 point
- Absence de réponse : 0 point

➤ POUR TOUTES LES PROPOSITIONS SUIVANTES**16. La période néonatale précoce s'étend de :**

- A. Jour 0 à jour 30
- B. Jour 0 à jour 07**
- C. Jour 0 à jour 28
- D. Jour 0 à jour 17

17. Le vernix caseosa est :

- A. Le fin duvet recouvrant les épaules et le dos du prématuré
- B. Une hypertrophie des glandes sébacées.
- C. Un enduit gras recouvrant presque tout le corps**
- D. Des taches sur le visage du nouveau-né

18. Parmi la liste d'hormone ci-dessous, cochez l'hormone responsable l'éjection du lait dans les seins

- A. L'ocytocine**
- B. La progestérone
- C. L'estrogène
- D. La prolactine

19. Parmi les propositions suivantes, cochez la proposition qui fait partie des critères d'une bonne prise de sein

- A. Le menton touche l'aréole et les suctions sont profondes et lentes entrecoupées de pauses
- B. La bouche est grande ouverte et la lèvre inférieure est éversée vers l'extérieur**
- C. L'aréole est plus visible en-dessous qu'au-dessus de la bouche
- D. On entend l'enfant déglutir le lait maternel

20. Lors d'une séance de diététique, au centre de santé, recommande aux l'agent santé mères, l'ablactation chez le nourrisson à partir de l'âge de :

- A. 6 mois**
- B. 12 mois
- C. 18 mois
- D. 24 mois

21. Dans la malnutrition aigüe sévère avec complications l'enfant

- A. est très éveillé
- B. a un bon appétit
- C. manifeste de l'intérêt
- D. a œdèmes bilatéraux**

22. Agent de santé au service de pédiatrie du CHU D'ANGRE, vous recevez, en urgence un nourrisson présentant des convulsions. Les gestes d'urgence à poser sont :

- A. Mettre le nourrisson en décubitus dorsal et le ventiler
- B. Mettre le nourrisson en position latérale de sécurité et arrêter les crises en lui administrant 0,5mg - 1mg/kg de Diazépam par voie intra rectale
- C. Mettre le nourrisson en position latérale de sécurité et arrêter les crises en lui administrant 2-3 mg/kg de Diazépam par voie intramusculaire
- D. Mettre le nourrisson en décubitus ventral pour libérer les voies aériennes supérieures.

23. Devant la crise convulsive du nourrisson, le soin délégué de l'agent de santé se résume à :

- A. Administrer le traitement prescrit par le médecin
- B. Assister le médecin à la réalisation de la ponction lombaire
- C. Accompagner le nourrisson chez le spécialiste
- D. Acheminer les prélèvements au Laboratoire

24. Pour confirmer le diagnostic du paludisme simple, l'agent de santé

- A. Réalise au lit du patient, un test de diagnostic rapide
- B. Réalise au lit du patient, une goutte épaisse
- C. Réalise au lit du patient, un frottis sanguin
- D. Réalise au lit du patient, une numération formule sanguine

25. BH est né à terme avec un poids de naissance à 3750 grammes, son poids à l'âge de

24 mois est le suivant :

- A. 12Kg
- B. 13Kg
- C. 14Kg
- D. 15 Kg

$$\begin{aligned}
 24\text{mois} &= \text{PN} \times 4 \\
 &= 3,750 \times 4 \\
 &= 15\text{kg}
 \end{aligned}$$

26. Lorsque l'agent de santé est en exercice dans un établissement sanitaire de premier contact, ses soins propres en cas de paludisme grave sont :

- A. Accueillir l'enfant et organiser la référence
- B. Administrer l'antipaludique, et mettre l'enfant en observation
- C. Appeler le médecin pour le traitement à faire
- D. Participer à la réalisation du bilan biologique

27. La malnutrition aigüe sévère sans complication est prise en charge

- A. Unité nutritionnelle thérapeutique
- B. Unité nutritionnelle thérapeutique ambulatoire
- C. Unité nutritionnelle de supplémentation
- D. Unité nutritionnelle thérapeutique et à domicile

28. L'enfant ayant le marasme présente les signes cliniques suivants :

- A. Cheveux roux, cassants clairsemés
- B. Peau sèche, craquelée, et dépigmentée
- C. Un visage creusé, vieillot avec un regard vif et intéressé
- D. Anorexie

29. La prise en charge de la Malnutrition aigüe modérée se fait :

- A. Unité de Nutrition Thérapeutique
- B. Centre Nutritionnel de Supplémentation
- C. Unité de Nutrition Thérapeutique Ambulatoire
- D. Unité de nutrition Thérapeutique au centre hospitalier universitaire

30. La croissance qualitative est surveillée avec le paramètre suivant :

- A. Le périmètre crânien
- B. La taille
- C. Les fontanelles**
- D. Le poids

31. QG a une surface corporelle à la naissance de $0,27\text{m}^2$, quelle est sa surface corporelle à 3 ans

- A. $0,81\text{m}^2$**
- B. $0,54\text{m}^2$
- C. $0,92\text{m}^2$
- D. $1,21\text{m}^2$

$$\begin{aligned} 3\text{ans} &= 36 \text{ mois} = \text{SCN} \times 3 \\ &= 0,27 \times 3 \\ &= 0,81\text{m}^2 \end{aligned}$$

32. Les propositions suivantes sont des avantages de l'allaitement exclusif pour le nouveau-né sauf une. Cochez cette proposition :

- A. Favorise la croissance harmonieuse
- B. Favorise le développement cérébral
- C. Favorise l'attachement à la mère
- D. Favorise les infections respiratoires**

33. Les séquelles neurologiques et neurosensorielles au cours du paludisme et sont les suivantes sauf une, laquelle ?

- A. Paralysie
- B. Hypotonie
- C. Hypoacousie
- D. Mastoïdite**

34. Tous les facteurs suivants inhibent le réflexe ocytocique chez la mère, sauf un. Cocher l'intrus

- A. La vue de son bébé**
- B. La douleur physique
- C. Le manque de confiance en soi
- D. La crise d'anxiété

35. GH, sexe féminin, poids 12 kg présente des convulsions. Pour arrêter ces convulsions j'utilise du Diazépam. La dose maximale de Diazépam que je ne dois pas dépasser en une journée de traitement est de :

- A. 12 mg
- B. 24 mg
- C. 36 mg**
- D. 48 mg

Dose journalière à ne pas dépasser est 3mg/kg

Donc 1kg $\longrightarrow$ 3mg

12kg $\longrightarrow$ $x = 12 \times 3 = 36\text{mg}$

36. Dame ZP vient d'accoucher son premier enfant et vous demande conseil pour avoir une bonne montée laiteuse. Je conseille à dame ZP

- A. de réduire la fréquence de tété du bébé
- B. d'augmenter le nombre de tété de son bébé**
- C. de suivre un régime amaigrissant pour garder la ligne
- D. de confier son bébé à l'aide pour mieux se reposer

37. FH est de 5 mois et orphelin de mère. Pour préparer son bol de lait infantile de 180 ml, j'utilise :

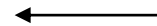
1mesurette $\longrightarrow$ 30ml

$Y = 180 / 30$

180ml

$Y = 6$ mesurettes

- A. 7 mesurettes rase de lait
- B. 6 mesurettes rase de lait**
- C. 5 mesurettes rase de lait
- D. 4 mesurettes rase de lait



38. Vous consultez l'enfant JP âgé de mois. Son Z-score poids pour l'âge est en dessous de moins 1. Cela signifie que JP :

- A. a un poids insuffisant pour son âge
- B. est en surpoids pour son âge
- C. est obèse pour son âge
- D. a un poids normal pour son âge**

39. EP est âgé de 18 mois. Il souffre du Kwashiorkor et pris en charge à l'hôpital. L'allure de sa courbe de poids sous traitement décrit classiquement la forme de la lettre

- A. Y
- B. M
- C. V**
- D. W

40. Dame KJ allaite son nouveau-né depuis la naissance. Parmi les propositions suivantes relatives à l'avantage de l'allaitement pour dame KJ se trouve un intrus. Cochez l'intrus.

- A. Favorise l'hémorragie de la délivrance**
- B. Favorise l'attachement de KJ à son enfant
- C. Favorise l'espacement des naissances
- D. Favorise la contraction utérine du postpartum immédiat

41. La complication redoutable à prévenir en urgence chez tout enfant sévèrement malnutri est

- A. Hypoglycémie
- B. Déshydratation**
- C. Anémie sévère
- D. Défaillance cardiaque

42. L'état de mal convulsif désigne une crise convulsive qui dure plus de :

- A. 05 minutes
- B. 10 minutes
- C. 20 minutes
- D. 30 minutes**

43. Pour la reconstitution de l'eau sucrée à 10% administrée à l'enfant malnutri à l'admission, j'utilise 2 carreaux de sucre po

- A. 200 ml d'eau potable
- B. 150 ml d'eau potable
- C. 100 ml d'eau potable**
- D. 50 ml d'eau potable

1carreau de sucre	→	5g
2 carreaux de sucre	→	10g
or eau sucrée 10% : 10g	→	100ml

44. Nourrisson GG fillette de 18 mois, présente des pleurs incessants, et un refus de téter. Elle n'est pas à jour de ses vaccins. A l'examen physique, la fontanelle antérieure est bombée, et la température de 40° Celsius, poids 10 Kg. GG souffre d'une méningite purulente. GG a :

- A. 1 données au niveau de sa réalité personnelle

B. 2 données au niveau de sa réalité personnelle

C. 3 données au niveau de sa réalité personnelle

D. 4 données au niveau de sa réalité personnelle

45. Nourrisson GG fillette de 18 mois, présente des pleurs incessants, et un refus de téter. Elle n'est pas à jour de ses vaccins. A l'examen physique, la fontanelle antérieure est bombée, et la température de 40° Celsius, poids 10 Kg. GG souffre d'une méningite purulente. GG a :

A. 4 données de dépendance

B. 5 données de dépendance

C. 6 données de dépendance

D. 7 données de dépendance

46. GG fillette de 18 mois, présente des pleurs incessants, et un refus de téter. Elle n'est pas à jour de ses vaccins. A l'examen physique, la fontanelle antérieure est bombée, et la température de 40° Celsius, poids 10 Kg. GG souffre d'une méningite purulente. GG a :

A. 3 données d'indépendance

B. 4 données d'indépendance

C. 5 données d'indépendance

D. 6 données d'indépendance

47. GG fillette de 18 mois, présente des pleurs incessants, et un refus de téter. Elle n'est pas à jour de ses vaccins. A l'examen physique, la fontanelle antérieure est bombée, et la température de 40° Celsius, poids 10 Kg. GG souffre d'une méningite purulente.

L'interprétation des données de GG met en évidence :

A. Infection bactérienne des méninges et absence de protection

B. Hypertension intracrânienne fébrile et absence de protection

C. Trouble de la régulation thermique et menace sur l'intégrité physique et psychique

D. Immaturité cérébrale et cutanée et absence de protection

ANTENNE DE KORHOGO

VERSION C

EXAMEN DU DIPLOME D'ETAT BLANC N°1 2025 SANTE PUBLIQUE

CIBLE : LICENCE 3 IDE /SFM

DUREE : 1H30mn

ETUDE DE CAS 1

Vous êtes infirmier (ère)/sage-femme/maïeuticien nouvellement affecté pour ouvrir le nouveau centre de santé rural de Nangakaha. L'étude effectuée a donné les résultats suivants :

- Population totale du bassin de desserte : 15 500 habitants dont 4 550 habitants pour Nangakaha;
- Le CSR est à 45 km de la Direction Départementale de la Santé et à 150 km de la Direction Régionale de la Santé
- Villages desservis (en dehors de Nangakaha) par le centre : 15 dont 5 à moins de 5 km et 10 entre 5 et 15 km ;

Durant le mois de janvier de votre première année de service vous avez vacciné 15 femmes enceintes en Td1, 10 femmes enceintes en Td2, 92 enfants de 0 à 23 mois dont 46 en Penta1, 19 en Penta2, 10 en Penta3 et 11 en RR1, 06 en RR2 et 18 jeunes filles de 9 ans.

NB : Au début du mois il n'y avait pas de flacons entamés et il y avait 30 doses de Td, 100 doses de vaccins Penta, 30 doses de vaccin anti rougeoleux et 20 doses de vaccins contre le HPV. Et à la fin du mois de janvier aucun antigène n'est resté.

1- D'après les résultats de cette étude, quel est le nombre de femmes enceintes attendues du CSR de Nangakaha dans le mois de janvier ?

A. 65

B. 66

C. 64

Nbre FE= 5% x 15500 = 775 Femmes Enceintes/an

12mois → 775 FE

1mois → $y = 775/12 = 64,58 = 65$

2- D'après les résultats de cette étude, quel est le nombre d'enfants de 0 à 23 mois attendus du CSR de Nangakaha dans le mois de janvier ?

A. 88

B. 89

C. 90

Nbre Enfts 0-23mois = 6,82% x 15500 = 1058 Enfts/an

12mois → 1058 Enfts/an

1mois → $y = 1058/12 = 88,16 = 89$

3- D'après les résultats de cette étude, quel est le nombre de jeunes filles de 9 ans attendues du CSR de Nangakaha dans le mois de janvier ?

A. 25

B. 26

C. 22

Nbre JF de 9ans= 1,86% x 15500 = 289 JF/an

12mois → 289 JF/an

1mois → $y = 289/12 = 24,08 = 25$

4- Quel est le taux d'abandon spécifique ? Cochez la bonne réponse.

A. 77,26%

B. 78,26%

C. 78,36%

TAS= ((Penta 1- Penta 3) / Penta 1) x 100

TAS= ((46 - 10) / 46) x 100 = 78,26%

5- Quel est le taux d'abandon global ? Cochez la bonne réponse.

A. 76,10%

B. 76,09%

C. 76,11%

TAG= ((Penta 1- RR1) / Penta 1) x 100

TAG= ((46 - 11) / 46) x 100 = 76,09%

6- Quel est le nombre de boîtes de sécurité utilisées ? Cochez la bonne réponse.

- A. 3
- B. 4**
- C. 1

$$\text{Nbre de seringue} = 135 + 180 = 315$$

$$1 \text{ Boîte de sécurité} \longrightarrow 100 \text{ seringues}$$

$$X = 315 / 100 = 3,15 \longleftarrow 315 \text{ seringues}$$

7- Quelle est la fréquence de séances de vaccination devez-vous faire par semaine ? Cochez la bonne réponse.

- A. 2
- B. 3**
- C. 4

$$15500 \text{ hbts inclus dans } 12000 \text{ à } 19999 \text{ hbts} = 3 \text{ séances/SEM}$$

8- Le taux de perte du vaccin Td. Cochez la bonne réponse

- A. 16,66%**
- B. 17,24%
- C. 16,75%

$$Tp = ((DS - DA) / DS) \times 100 = ((30 - 25) / 30) \times 100$$

$$Tp = 16,66\%$$

9- Le besoin théorique en vaccin Td. Cochez la bonne réponse

- A. 12 doses
- B. 18 doses
- C. 138 doses
- D. 206 doses**

$$BT = PC \times OV \times NC \times Fp = 65 \times 0,95 \times 3 \times 1,11$$

$$BT = 205,62 = 206$$

10- Le besoin réel en vaccin Td. Cochez la bonne réponse

- A. 255 doses
- B. 173 doses
- C. 257 doses**
- D. 178 doses

$$BR = BT + SS \quad \text{or} \quad SS = 25\% BT = 25\% \times 205,62 = 51,40$$

$$BR = 205,62 + 51,40 = 257$$

QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES (QCM)

Répondez aux assertions ci-dessous en choisissant la bonne réponse

Une réponse juste : 01 point, une réponse fausse : 0 point, pas de réponse : 0 point

11- Parmi les expressions suivantes, indiquez celles qui sont justes **L3p59**

- A. Retirer les accumulateurs congelés du compartiment du **réfrigérateur** au moins 30 minutes avant le début de la séance. **B (congélateur)**
- B. Laisser les accumulateurs à la température ambiante jusqu'à ce que la glace commence à fondre et que de l'eau commence à se former à l'intérieur**
- C. Vérifier si l'accumulateur contient de l'eau en le secouant et en écoutant le bruit de clapotis.**
- D. Retirer les accumulateurs congelés du compartiment congélateur **au plus** 30 minutes avant le début de la séance. **B (au moins 30 minutes)**
- E. Laisser les accumulateurs à une forte température ambiante jusqu'à ce que la glace commence à fondre et que de l'eau commence à se former à l'intérieur **B**

12- Parmi les éléments suivants, identifiez ceux qui constituent des buts de la supervision : **L3p43**

- A. La vérification de la ponctualité du personnel de santé au service **B**
- B. La promotion de l'amélioration continue de la performance du personnel de santé**
- C. L'assiduité du personnel de santé au service **B**

- D. Promouvoir un esprit de stimulation de l'agent de santé
- E. Vérification de la possibilité de l'atteinte des objectifs définis par un programme.
- F. Vérification de la compétence du personnel de santé. **B**

13- Dans le style démocratique de la supervision, le superviseur : L3p45

- A. Fait participer ses collaborateurs à la planification des activités et des projets
- B. Aide à prendre des décisions
- C. Fait confiance à ses collaborateurs
- D. Reconnaît et encourage certaines initiatives prises par le supervisé
- E. Cherche à tout savoir **B**
- F. Surveille de près l'exécution des tâches **B**

14- Parmi les outils de gestion suivants, indiquez trois utilisés par le responsable de la gestion administrative et technique : L3p22-23

- A. Les registres du système d'informations et de gestion
- B. Le cahier de versement journalier du centre
- C. Les reçus des sommes confiées au président du COGES **B**
- D. Le plan des bâtiments du centre de santé **B**
- E. Le cahier des comptes rendus des différentes réunions du COGES.
- F. L'inventaire de tous les produits.

15- En dehors du centre, indiquez deux rôles du comité de gestion L3p22

- A. Faire connaître aux populations les activités menées au centre de santé
- B. Faire le contrôle de présence du personnel de santé et de soutien **B**
- C. Rendre disponible des médicaments essentiels et des vaccins **B**
- D. Encourager les changements de comportements observés au niveau des différents acteurs et utilisateurs
- E. Confier Les reçus des sommes au responsable de la gestion financière

16- Le concept de santé publique a été défini par WILSON en : L1p9

- A. 1920
- B. 1945
- C. 1946

17- Parmi les éléments suivants, indiquez ceux qui ne constituent pas des niveaux de perception des besoins de santé L1p12

- A. Le niveau des besoins non satisfaits ;
- B. Le niveau des besoins latents
- C. Le niveau des besoins ressentis
- D. Le niveau des besoins satisfaits
- E. Le niveau des besoins fondamentaux
- F. Le niveau des besoins exprimés

18- Parmi les facteurs suivants favorisant la santé, indiquez ceux qui sont socio-économiques L1p15

- A. Absence de troubles psychiques
- B. Absence de troubles métaboliques
- C. L'existence d'un habitat salubre
- D. Environnement affectif satisfaisant
- E. L'existence d'eau courante
- F. L'absence de promiscuité

19- Parmi les actions suivantes, une seule permet d'améliorer la saveur et odeur de l'eau. Laquelle ? L1p62

- A. L'ébullition
- B. Usage du charbon de bois**
- C. La filtration
- D. La sédimentation
- E. L'ionisation

20- Le contenu de l'initiative de Bamako préconise entre autre : L1p75

- A. Un accès prioritaire des femmes et des enfants aux soins de santé
- B. Une autonomie de gestion au niveau local à travers les comités de gestion**
- C. Une interdiction des médicaments génériques dans les structures de santé
- D. Une définition des niveaux d'application des soins de santé primaires

21- Parmi les éléments suivants, indiquez ceux qui relèvent de l'approche clinique de résolution des problèmes de santé L1p82

- A. Analyse de l'impact des interventions
- B. Recherche des causes d'apparition de la maladie chez le sujet**
- C. A pour diagnostic l'identification d'un phénomène de groupe important
- D. A pour sujet d'intérêt, le malade**

22- Parmi les éléments suivants, identifiez ceux qui sont des intrants : L3p51

- A. Le personnel soignant**
- B. Le nombre de séances de vaccination organisées
- C. Le nombre de kits d'IST distribués
- D. Le budget de réalisation du projet/ programme**
- E. Le nombre de femmes utilisant les méthodes contraceptives

ETUDE DE CAS 2

Soulougoutogo est un village de la sous-préfecture de Kong. Il compte 16 000 habitants au 31/12/2020 et 16640 habitants au 1er/01/2022. Une enquête épidémiologique et socio-démographique effectuée dans le village par l'infirmier a donné les informations suivantes :

- Total de cas de morbidités toutes causes confondues : 6 500 cas
- 5200 cas de paludisme notifiés au cours de l'année dont 1/3 de nouveaux cas.
- Naissances dans la localité : 583 dont 25 mort-nés.
- Nombre total de décès : 46
- 5 décès maternels dont 02 survenus deux mois après l'accouchement.
- 9 décès dans la tranche d'âge de 0 à 7 jours dont 4 liés au tétanos néonatal ;
- 5 décès dans la tranche d'âge de 8 à 27 jours ;
- 11 décès dans la tranche d'âge de 1 à 11 mois
- 12 à 48 mois : 16 décès dont 7 liés au paludisme, 4 aux IRA et 5 à la rougeole

En outre, une étude menée dans la localité révèle le diagnostic communautaire suivant :

- 20% des enfants malnutris de 0 à 5 ans n'ont pas leur calendrier vaccinal à jour.
- L'eau consommée par cette communauté provient des puits traditionnels non aménagés.
- La lèpre sévit dans la région sanitaire de Korhogo de façon endémique ;

QUESTIONS

Consignes : Une réponse juste : 01 point, une réponse fausse ou pas de réponse : 0 point

23- Parmi les critères suivants, indiquez ceux qui permettent de sélectionner un problème prioritaire de santé L2p56

- A. La population totale de la localité
- B. L'ampleur du problème**
- C. La gravité du problème**
- D. Le niveau d'instruction des populations
- E. La vulnérabilité du problème**
- F. La durée des interventions.

24- Quel est le taux d'accroissement annuel de la population de Soulougoutogo ?

- A. 0,38%
- B. 0,40%
- C. 3,84%
- D. 4,00%**

$$\begin{aligned} \text{Pop du 31/12/20} &= \text{Pop du 01/01/21} = 16000 \text{ hbts} \\ \text{Pop du 01/01/22} &= \text{Pop du 31/12/21} = 16640 \text{ hbts} \\ \text{TAA} &= ((16640 - 16000) / 16000) \times 100 = 4\% \end{aligned}$$

25- Quel est la population totale en 2022 ?

- A. 17280 habitants
- B. 17306 habitants**
- C. 17278 habitants
- D. 16703 habitants

$$\begin{aligned} P_{2022} &= P_{2021} (1 + (\text{TAA}/100)) \exp 1 \\ P_{2022} &= 16640 (1 + (4/100)) \exp 1 = 17306 \text{ hbts} \end{aligned}$$

26- Quelle est la population moyenne en 2022 ?

- A. 16973 habitants**
- B. 16960 habitants
- C. 16672 habitants
- D. 16459 habitants

$$\begin{aligned} P_{\text{moy}} &= ((\text{Pop début} + \text{Pop fin}) / 2) \\ P_{\text{moy}} &= ((16640 + 17306) / 2) = 16973 \text{ hbts} \end{aligned}$$

27- Quel est le taux brut de natalité de Soulougoutogo en 2022 ?

- A. 3,22%
- B. 3,28%**
- C. 3,43%
- D. 3,58%

$$\text{TBN} = (\text{NV}/P_{\text{moy}}) \times 100 = (558/16973) \times 100 = 3,28\%$$

28- Quel est le taux brut de mortalité de Soulougoutogo en 2022 ?

- A. 0,23%
- B. 0,26%
- C. 0,27%**
- D. 0,29%

$$\text{TBM} = (\text{Décès}/P_{\text{moy}}) \times 100 = (46/16973) \times 100 = 0,27\%$$

29- Quel est le taux de mortalité néonatale précoce de Soulougoutogo en 2022 ?

- A. 1,54%
- B. 1,61%**
- C. 2,22%
- D. 2,32%

$$\text{TMNPP} = (\text{Décès des enfants de 0 à 7jrs}/\text{NV}) \times 100 = (9/558) \times 100 = 1,61\%$$

30- Quel est le taux de mortalité néonatale tardive de Soulougoutogo en 2022 ?

- A. 0,82%
- B. 0,85%
- C. 0,89%**

$$\text{TMNNT} = (\text{Décès des enfants de 8 à 27jrs}/\text{NV}) \times 100 = (5/558) \times 100 = 0,89\%$$

31- Quel est le taux de mortalité post néonatale de Soulougoutogo en 2022 ?

- A. 1,97%**
- B. 1,88%

$$\text{TMPNN} = (\text{Décès des enfants de 28 à 11mois}/\text{NV}) \times 100 = (11/558) \times 100 = 1,97\%$$

C. 1,80%

32- Quel est le taux de mortalité infantile de Soulougoutogo en 2022 ?

A. 2,50%

B. 2,86%

C. 3,58%

D. 4,48%

Décès des enfants de 0 à 11mois = 9 + 5 + 11 = 25

$TMI = (\text{Décès des enfants de 0 à 11mois}/NV) \times 100 = (25/558) \times 100 = 4,48\%$

33- Quel est le taux de mortalité juvénile de Soulougoutogo en 2022 ?

A. 4,62‰

B. 5,33‰

C. 9,24‰

D. 10,67‰

$TMJ = (\text{Décès des enfants de 1 à 4an}/\text{Nbre d'enfts de 1 à 4 ans}) \times 1000$

Nbre d'enfts de 1 à 4ans = 17,32% x 17306 = 2998

$TMJ = (16/2998) \times 1000 = 5,33\%$

34- Quel est le taux de mortalité maternelle de Soulougoutogo en 2022 ?

A. 896,05 décès maternel pour 100000 naissances vivantes

B. 857,63 décès maternel pour 100000 naissances vivantes

C. 537,63 décès maternel pour 100000 naissances vivantes

D. 514,57 décès maternel pour 100000 naissances vivantes

$TMM = (3/558) \times 100000 = 537,63$

35- Quel est le taux d'incidence du paludisme de Soulougoutogo en 2022 ?

A. 10,01%

B. 10,21%

C. 10,81%

$TI = (\text{Nouveau Cas}/Pmoy) \times 100 = (1733,33/16973) \times 100 = 10,21\%$

QUESTIONS A CHOIX DICHOTOMIQUE (Q.C.D)

Répondez aux assertions ci-dessous en choisissant l'alvéole A pour vrai et B pour faux

Une réponse juste : 1 point, une réponse fausse : -1 point, pas de réponse : 0 point

36- Le style démocratique s'applique à toutes les situations, les situations moins urgentes, les situations d'urgence et de blocage. L3p45

A. Vrai

B. Faux

37- Les membres du COGES sont désignés pour une durée de deux ans renouvelable. L3p21

A. Vrai

B. Faux

38- Les décès influencent l'accroissance naturelle prend en compte les naissances et les décès survenus dans la population ainsi l'immigration et l'émigration : L2p26

A. Vrai

B. Faux

39- Faire la vaccination en stratégie avancée est une solution pour réduire les populations hors de portée : L2p38 « HORS D'ACCES »

A. Vrai

B. Faux

40- Les piliers d'un système de santé sont au nombre de cinq (5). L1p29 « 6 PILIERS »

A. Vrai

B. Faux

41- La lutte contre les insectes, les rongeurs et autres animaux nuisibles est un critère de salubrité de l'habitat relatif aux besoins psychologique. L1p64 « RELATIFS A LA PROTECTION CONTRE LA CONTGION »

A. Vrai

B. Faux

42- Le site de vaccination est un lieu choisi pour installer l'équipe de vaccination. L3p58

A. Vrai

B. Faux

43- Promouvoir l'amélioration continue de la performance du personnel de santé est un but de la supervision. L3p43

A. Vrai

B. Faux

44- Le début effectif de la mise en œuvre des activités des soins de de santé en Côte d'Ivoire a eu lieu en 1991 au district sanitaire de Bouaflé. L1p76

A. Vrai

B. Faux

45- L'ONG de santé est le responsable de l'action de mobilisation sociale :

A. Vrai

B. Faux

MAN

ANTENNE DE MAN

LICENCE3 IDE EXAMEN BLANC : EPREUVE DE CHIRURGIE

Durée=1H30 minutes

CONSIGNES➤ Questions à choix double (Q.C.D.)

Répondre par A=VRAI ou B=FAUX

Bonne réponse=1 point, Fausse réponse =-1 point

Absence de réponse = 0 point

➤ Questions à choix multiple (Q.C.M.)

Répondre en choisissant la ou les bonnes réponses selon les items sachant que par question :

Bonne réponse =1 point

Fausse ou absence de réponse = 0 point

I/ QUESTION A CHOIX DOUBLE (Q.C.D.)

1- La neurologie est la discipline médicale qui prend en charge les maladies du système nerveux

A B L3p1(Doc de neurologie)2- La hernie peut être congénitale ou acquise **A B L2p93 (Doc chirurgie)**3- Le signe de l'épaulette est la conséquence de la vacuité de la glène dans la luxation de l'épaule **A B**4- Le syndrome de Wolkman siège sur les membres inférieurs **A B**

5- S'agissant de la cotation de Glasgow, la décortication est un élément de la réponse verbale

A B L3p4 (Doc Neurochirurgie)6- L'ostéoporose est une cause des fractures pathologiques **A B**7- Le volet costal est une fracture étagée **A B**

8- Le signe de Rovsing positif est la mise en évidence du signe pathognomonique de l'appendicite

A B9- Le principal organe de la région épigastrique est le foie **A B** « l'estomac »10- L'occlusion haute siège sur l'œsophage **A B** « le grêle »11- La tuméfaction de l'étranglement herniaire est dure, réductible et impulsive à la toux **A****B L2p102 (Doc chirurgie)** « Irréductible, non impulsive et non expansive a la toux »12- DIZO, ayant reçu 7,200 litres le deuxième jour de réanimation hydro électrolytique pour un poids de 80kg, est donc brûlé à 45% **A B**

$$SCB = \frac{QJ2}{2 \times Pds} = \frac{7200}{2 \times 80} = 45\%$$

13- L'adénome de la prostate est une maladie maligne **A B L2p154(Doc chirurgie)** « benigne »14- Le mal de pott est une infection disco-vertébrale due au staphylocoque aureus **A B****L 3p31(Doc chirurgie)** « bacille de koch »15- Le traitement de l'appendicite est uniquement chirurgical **A B L2p111(Doc chirurgie)**16- Le signe capital de la péritonite est la contracture abdominale **A B**17- Les occlusions fonctionnelles sont le fait du dérèglement du système nerveux intestinal **A****B L2p116(Doc chirurgie)**18- La hernie n'existe pas chez la femme **A B L2p97(Doc chirurgie)**19- Les brûlures provoquées par contact sont plus graves que celles faites par rayonnement **A****B**

20- La ponction sus-pubienne est conditionnée par l'impossibilité d'une pose de sonde vésicale
A B

II/ QUESTION ACHOIX MULTIPLES (Q.C.M.)

21- Les signes ci-dessous relèvent de la palpation dans la luxation de l'épaule (2 réponses)
L2p19(Doc chirurgie)

- A. Abduction irréductible
- B. Coup de hache extrême → Inspection
- C. Vacuité de l'espace sous acromial
- D. Signe de l'épaulette
- E. Rotation externe du bras } → Inspection

22- Identifiez dans les items ci-dessous les signes du syndrome de Wolkman ?

- A. Œdème de la jambe
- B. Douleur intense
- C. Nausées et vomissements
- D. Pâleur et froideur des doigts
- E. Hyperthermie
- F. Engourdissement ou picotement des doigts

23- Deux items ne font pas partis des étiologies de l'appendicite aiguë parmi ceux qui sont énumérés en dessous. Lesquels ? (2 réponses)

- A. Infections gastro-intestinales
- B. Hernie discale
- C. Parasitoses intestinales
- D. Corps étrangers
- E. Fécalome
- F. Alimentation pauvre en viande

24- La liste ci-dessous est celle des signes fonctionnels de la fracture ; lesquels ? (2 réponses)

- A. Crépitation osseuse
- B. Douleur vive
- C. Déformation du membre
- D. Impotence fonctionnelle
- E. Mobilité anormale du membre atteint

25- Sur le lieu de l'accident, certains gestes suivants sont proscrits en cas de fracture du fémur ; lesquels ? (2 réponses)

- A. Préparer psychologiquement à l'intervention du blessé
- B. Immobiliser dans une gouttière le membre atteint
- C. Chercher à réduire une fracture ouverte
- D. Laisser le blessé couché par terre
- E. Baliser l'emplacement du patient
- F. Faire des manœuvres ou de mobilisations intempestives

26- Un brûlé à 30% reçoit 9720 ml de soluté en deux (2) jours. Quel est son poids ?
(1réponse)

- A. 50 kg
- B. 54 kg
- C. 55 kg

$QJ1 + QJ2 = 9720$ $(4 \times Pds \times SCB) + (2 \times Pds \times SCB) = 9720$ $(4 \times 30 \times Pds) + (2 \times 30 \times Pds) = 9720$ $(120 \times Pds) + (60 \times Pds) = 9720$	$180 \times Pds = 9720$ $Pds = \frac{9720}{180}$
--	--

27- S'agissant de la gangrène gazeuse, les assertions ci-dessous sont justes, sauf trois, Lesquelles ? (3 réponses)

- A. Nécrose tissulaire due à l'infection par des bactéries
- B. Nécrose tissulaire sans infection bactérienne**
- C. Tissus gonflés et suintants
- D. Forte circulation sanguine au niveau de la partie atteinte**
- E. Ne se propage pas à d'autres tissus**
- F. Se propageant à d'autres tissus

28- Laquelle des malformations congénitales parmi celles énumérées ci-dessus est une déviation des jambes en dehors et des genoux en dedans (jambes en X) (1 réponse)

- A. Genu valgus**
- B. Varus équin
- C. Genu varus

L1p74(Doc sémio chirurgicale)

29- Parmi les éléments de la surveillance post opératoire ci-dessous, trois (3) relèvent de l'état végétatif du patient. Lesquels ?

- A. Perméabilité des tuyaux
- B. Fréquence respiratoire**
- C. Pression artérielle**
- D. Profondeur du coma
- E. Niveau de conscience
- F. Fréquence cardiaque**

L3p9(Doc Neurochirurgie)

30- Les signes ci-dessous sont des signes méninges après un traumatisme craniocéphalique, sauf deux. Lesquels ?

- A. Syndrome Wolkman**
- B. Raideur de la nuque
- C. Céphalées intenses
- D. Hémiplégie**
- E. Vomissements incoercibles

31- La liste ci-dessous comprend les moyens du traitement de la sciatalgie sauf un ; lequel ? (1 réponse)

- A. Traitement chirurgical
- B. Traitement radiologique**
- C. Traitement médicamenteux

L3p29(Doc Neurochirurgie)

32- Les items ci-dessous font partie des étiologies de l'appendicite aiguë exceptés deux ; lesquels ? (2 réponses)

- A. Infections gastro-intestinales
- B. Alimentation pauvre en viande**
- C. Parasitoses intestinales
- D. Corps étrangers
- E. Hernie discale**
- F. Fécalome

CAS CLINIQUE N°1(De Q33 à Q36)

Infirmier au service des urgences chirurgicales de l'EPHD de Lakota, vous recevez pendant votre garde, TOUALI Ibrahim cultivateur âgé de 33 ans pesant 70 kg pour AVP. A l'examen clinique du médecin, il ressort un traumatisme thoraco-abdominal sans solution de continuité, une dyspnée respiratoire accompagnée de sueurs froides. Les examens paracliniques d'urgence révèlent une fracture étagée costale gauche au niveau de l'avant dernière paire de

côtes sternales, une rupture appendiculaire, un taux d'hémoglobine 4 g/dl et un groupe sanguin B négatif

33-Qu'est que le volet costal ? (1 réponse)

- A. C'est l'existence de 2 traits de fracture sur une même côte qui isole un fragment intermédiaire qui est Indépendant du reste
- B. C'est un type particulier de fracture qui siège sur la tête
- C. C'est l'existence de fracture avec enfoncement des os du crane

34-Qu'est-ce que la respiration paradoxale ? (1 réponse)

- A. L'expiration entraine l'enfoncement du volet costal et gonflement de la cage thoracique et l'inspiration entraine l'expulsion du volet costal et affaissement de la cage thoracique
- B. L'inspiration entraine l'enfoncement du volet costal et gonflement de la cage thoracique et l'expiration entraine l'expulsion du volet costal et affaissement de la cage thoracique
- C. A l'inspiration le diaphragme se contracte et descend, la cage thoracique s'élève et le thorax se dilate, et à l'expiration le diaphragme se relâche et remonte ; la cage thoracique se rétracte

35- De quels examens paracliniques demandes en urgence s'agit-il ? (3réponses)

- A. Echographie abdominale
- B. Endoscopie bronchique
- C. Radiographie du thorax
- D. Groupage sanguin
- E. Radiographie Blondeau
- F. Ionogramme urinaire

36- Quels types de sang peut recevoir M. TOUALI Ibrahim ? (2 réponses)

- A. B positif
- B. O positif
- C. AB négatif
- D. B négatif
- E. O négatif

Avant de l'opérer en urgence, le chirurgien prescrit 1 poche de sang iso groupe (450 ml) à passer en trois heures et quart.

37- Quel sera le débit ? (1 réponse)

- A. 30 gouttes/minute
- B. 35 gouttes/minute
- C. 38 gouttes/minute

$$D = \frac{Q \times 15}{T} \quad \text{avec } T = (3 \times 60) + 15 = 195 \text{min}$$

$$D = \frac{450 \times 15}{195} = 34,61 \text{gttes/min} \approx 35 \text{gttes/min}$$

38- La surveillance infirmière per transfusionnelle de TOUALI Ibrahim comprend quels items ? (3 réponses)

- A. Prise de la TA les 15 premières minutes puis toutes les heures
- B. Contrôle de la date et de l'intégrité de la poche
- C. Mesure régulière de la fréquence respiratoire
- D. Etre attentif aux plaintes du patient
- E. Vérification de l'identité du patient
- F. Installation confortable du patient

CAS CLINIQUE N°2 (Q37 a Q41)

Mme KONDE Kalidia 28 ans sans antécédents médicaux consulte aux urgences pour des douleurs abdominales depuis 24 heures

A l'examen, la douleur d'intensité croissante exacerée par la mobilisation et la toux a débuté dans la région péri-ombilicale et a migré vers la fosse iliaque droite.

On note :

- $T^0=38,1^{\circ}\text{C}$
- Signe de Blumberg positif
- Pas de défense ni de contracture abdominale
- Test de grossesse négatif

QUESTIONS

39- A quelle affection pensez-vous pour Mme KONDE Kalidia ? (1 réponse)

- A. Ulcère gastroduodénal perforé
- B. Salpingite
- C. Appendicite

40- Quels sont les diagnostics chirurgicaux différentiels à évoquer chez Mme KONDE Kalidia ? (2 réponses)

- A. Grossesse tubaire rompue
- B. Colique néphrétique droite
- C. Torsion de kyste
- D. Ovarite droite
- E. Appendicite rompue
- F. Salpingite droite

41- Quels sont les éléments de la prise en charge de Mme KONDE Kalidia ? (2réponses)

- A. Lancer le bilan préopératoire
- B. Prise de voie veineuse
- C. Mise en quarantaine
- D. Administration d'antalgiques
- E. Demander les examens de confirmation du diagnostic

42- Pourquoi l'échographie est-elle privilégiée chez Mme KONDE Kalidia ? (2 réponses)

- A. Elle est inappropriée que la tomодensitométrie
- B. Elle est économique et permet de rassurer le patient
- C. Elle est moins chère et permet de visualiser un appendice inflammatoire
- D. Elle est moins invasive et plus accessible que le scanner
- E. Elle est inaccessible et coûteuse

43- Quels sont les risques que court Mme KONDE Kalidia si sa prise en charge est tardive ? (3 réponses)

- A. Perforation de l'appendice
- B. Formation d'un abcès appendiculaire
- C. Impuissance sexuelle
- D. Cardiomégalie
- E. Stérilité
- F. Sepsis en cas d'infection non contrôlée

Bonne chance à tous !

EPREUVE DE SOINS INFIRMIERS EN MEDECINE.

Consignes de composition VERSION C

Pour les questions QCD, cochez sur la grille, la lettre A si vous estimez que la proposition est VRAIE ou la lettre B si vous estimez qu'elle est fausse.

Pour les QCM, cochez sur la grille la ou les lettres correspondant à la ou aux réponses justes

Pénalité : QCD=1 si réponse juste ; fausse=-1 sans réponse=0

QCM : Réponse juste=1 réponse fausse=0 ; sans réponse juste = 0

PARTIE III : CAS CLINIQUE

Vous êtes de garde au service des urgences médicales du CHR de Duékoué. Vous recevez M. KPAN âgé de 53 ans. Il est instituteur. Il est hospitalisé. A l'interrogatoire il se plaint de : céphalées occipitales matinales, acouphènes, sensations de mouches volantes, pollakiurie nocturne.

1. Quelle est votre hypothèse diagnostique ? **L2p4(Doc de médecine)**

- A. Insuffisance cardiaque
- B. Hypertension artérielle**
- C. Infection urinaire
- D. Diabète insipide

2. Donner un facteur de risque de cette maladie

- A. Polyurie
- B. Insalubrité
- C. Diabète**

3. Citer une manifestation des complications de cette pathologie

- A. Épistaxis**
- B. Céphalée
- C. Hyperthermie
- D. Polydipsie

4. Quelle est votre conduite à tenir en tant qu'infirmier ? (Deux réponses)

- A. Mesurer la température
- B. Mesurer la pression artérielle aux deux bras**
- C. Créer un environnement calme**
- D. Administrer un antalgique
- E. Donner à boire au malade

5. L'un des rôles propres de l'infirmier dans cette prise en charge consiste à faire une bandelette urinaire à la recherche de protéinurie et d'hématurie. **A**

6. Le besoin de s'occuper en vue de se réaliser n'est pas satisfait chez monsieur KPAN. **A**

PARTIE I : QCD

7. Le TDR est un examen de référence pour établir le diagnostic de paludisme. **B**
« certitude »

8. Le diabète de type 2 résulte d'une mauvaise utilisation de l'insuline par l'organisme. **A**

9. Le diabète de type 2 est aussi appelé diabète de la maturité. **A**

10. L'hyperglycémie est une élévation de la teneur en sucre dans le sang. **A**

11. Le diabète a des conséquences sur le cœur, les yeux, les reins et les nerfs et les vaisseaux sanguins. **A**

12. Chez l'adulte le premier test rapide utilisé pour le dépistage du VIH est le déterminé. **A**

13. L'indice de masse corporelle (IMC) d'une personne de poids 79 kg et de taille 1m 80 est de IMC=24,38 **A**

14. La charge virale est la quantité de virus présente dans le sang. **A**
15. L'utilisation de préservatifs **n'est pas nécessaire** si le patient prend des ARV **B**
« **nécessaire** »
16. La prévention de la transmission du VIH inclut uniquement la prise d'ARV après l'accouchement. **B**
17. Avant de mesurer la pression artérielle d'un malade il doit être au repos **pendant 5 minutes**. **B** « **pdt au moins 5min** »
18. Les cardiopathies coronariennes touchent les vaisseaux sanguins qui alimentent le muscle cardiaque **et le cerveau**. **B** « **cerveau** → **AVC** »
19. L'asthme est une inflammation des voies respiratoires entraînant une hyperactivité des bronches. **A**
20. Les bactéries sont responsables des maladies infectieuses **et parasitaires**. **B**
« **bactériennes** »
21. Le réservoir de germe dans la fièvre typhoïde est strictement **animal**. **B** « **humain** »
22. Dans la fièvre typhoïde, il existe deux modes de contamination. **A** « **Directe et Indirecte** »
23. Une pneumonie lobaire est une infection de **toutes les portions du poumon**. **B** « **un seul lobe pulmonaire** »
24. La cyanose est un signe de gravité en cas de détresse respiratoire. **A**
25. La réduction du nombre de maladies opportunistes, d'hospitalisations, de décès liés au VIH et l'amélioration de l'espérance de vie fait partie des principes de base du TARV. **A**
26. La goutte épaisse et le Frottis sanguin permettent de **déterminer l'espèce plasmodiale et la densité parasitaire**. **A**
27. Le TDR ne permet pas d'évaluer l'efficacité du paludisme. **A**
28. La quinine par voie orale est un traitement de 2ème intention du paludisme. **A**
29. La transmission de la covid 19 est **strictement directe**. **B** « **directe et indirecte** »
30. L'agent pathogène de la dengue est un arbovirus du genre Aedes. **A**
31. L'homme est l'unique réservoir de virus de la dengue. **A**
32. Le diabète multiplie le risque de souffrir d'AVC. **A**

PARTIE II : QCM

33. Le milieu de Conservation du Kit complet du TDR doit être de :
A. 2 et 40 °C
B. 4 et 40 °C
C. 4 et 20 °C
34. Quel est le débit d'une perfusion de sérum glucosé isotonique de 500 ml avec 8 cc sels de quinine et 8 cc d'électrolyte ? Durée 4 heures.
- $$D = \frac{Q \times 20}{T \times 60} = \frac{516 \times 20}{4 \times 60} = 43$$
- A. 40 gouttes/minute
B. 41 gouttes/minute
C. 42 gouttes/minute
D. 43 gouttes/minutes
35. Si, après le traitement antipaludique, le patient revient pour un nouvel épisode de fièvre plus de deux semaines
A. Il doit faire un nouveau TDR
B. Il doit faire un nouveau traitement antipaludique
C. Il doit être testé par l'examen de GE ou FS.
36. Pour un patient vu au niveau périphérique, présentant des symptômes graves de paludisme, il faudra
A. Commencer immédiatement le traitement antipaludique par voie veineuse
B. Effectuer immédiatement un TDR et le mettre en observation pendant trois jours

C. Effectuer immédiatement un TDR et référer le patient avec un traitement de pré-transfert.

37. Parmi les propositions suivantes, indiquez la bonne réponse. Dans la Bilharziose à *Schistosoma Haematobium*, l'hématurie est : **L1p18(Doc maladie infectieuse)**
A. Capricieuse, non douloureuse, intermittente, récidivante
B. Capricieuse, douloureuse, intermittente, récidivante
C. Capricieuse, douloureuse, intermittente, non récidivante
38. Parmi les propositions suivantes, indiquez la bonne réponse. La Bilharziose peut avoir des complications. **L1p19(Doc maladie infectieuse)**
A. Vésicales, Urétrales, Rénales, Génitales
B. Vésicales, Urétrales, Pulmonaires, Génitales
C. Vésicales, Urétrales, Cardiaques, Génitales
39. La présence d'*Ascaris* adultes dans la voie biliaire et pancréatique entraîne les signes suivants sauf un lequel ? **L1p22(Doc maladie infectieuse)**
A. Colique hépatique
B. Appendicite aigue
C. Angiocholite aigue
40. Parmi les propositions suivantes, indiquez la bonne réponse. Les déterminants de la transmission de l'*Ascaris* sont : **L1p21(Doc maladie infectieuse)**
A. La sécheresse, l'humidité, le péril fécal
B. La chaleur, l'humidité, le péril fécal
C. La chaleur, le froid, le péril fécal
41. Parmi les propositions suivantes, indiquez la bonne réponse. L'ankylostomose se transmet par voie : **L1p20(Doc maladie infectieuse)**
A. Cutanée et orale
B. Exclusivement cutanée
C. Exclusivement orale
42. Les mesures suivantes permettent de prévenir la teniase sauf un. Lequel ? **L1p38(Doc maladie infectieuse)**
A. Cuisson suffisante de la viande de bœuf.
B. Abattage de tous les porteurs de ténia,
C. Construction et utilisation des latrines,
43. Parmi les propositions suivantes, indiquez les bonnes réponses. Les symptômes du diabète de type 1 sont:(03 réponses)
A. Polyurie
B. Dysphagie
C. Faim constante
D. Prise de poids
E. Polydipsie
F. Pollakiurie
44. Parmi les examens de laboratoires suivant, deux ne sont pas indiqués dans le diagnostic du diabète. Lesquels ?
A. La coproculture
B. La glycémie
C. NFS
D. Acétonurie
E. La glycosurie
45. L'insuline est une hormone sécrétée par :
A. Le foie
B. Le pancréas exocrine

C. Le pancréas endocrine

46. Quels sont les deux signes du syndrome infectieux de la méningite purulente parmi les propositions suivantes ? **L1p101(Doc maladie infectieuse)**

- A. Fièvre à 39-40°C**
- B. Raideur de la nuque
- C. Convulsions
- D. Signes de Kerning positifs
- E. Pouls rapide**

47. Parmi les propositions suivantes identifiez celles qui sont conformes aux différentes formes de la dengue ? (02 réponses)

- A. Dengue fébrile**
- B. Dengue frusque
- C. Dengue sévère
- D. Dengue fébrile hémorragique**

48. Parmi les propositions suivantes, laquelle est vraie ? Les souches du virus de la dengue se répartissent :

- A. En trois sérotypes distincts
- B. En quatre sérotypes distincts**
- C. En cinq sérotypes distincts

4 sérotypes distincts qui sont :	➤ DENV-1
	➤ DENV-2
	➤ DENV-3
	➤ DENV-4

49. Comment préparer le patient au traitement ARV ? (03 réponses)

- A. Faire comprendre au patient l'importance d'une bonne observance ;**
- B. Gérer les effets indésirables des ARV
- C. Faire savoir au patient que le traitement ARV est un traitement de longue durée ou à vie.**
- D. Choisir le bon schéma de traitement ;
- E. Respecter le calendrier de suivi ;
- F. Prendre en compte les préoccupations et les priorités du patient ;**

50. Quelle est la contre-indication des diurétiques parmi les propositions suivantes ?

- A. Insuffisance cardiaque
- B. Syndrome néphrotique
- C. Trouble potassique**
- D. Insuffisance hépatique

Bonne chance à tous !

SUJET D'EXAMEN BLANC N°1 INFAS MAN

Cible : IDE/SFM

Durée : 01 h 30mn

VERSION C**SANTE PUBLIQUE****CONSIGNES :**

Traiter obligatoirement toutes les questions

➤ **QUESTIONS A CHOIX DOUBLE : De Q15 à Q39 :**

0,5 Point par réponse juste

-0,5 Point par réponse fausse /

0 Point pour absence de réponse

➤ **QUESTIONS A CHOIX MULTIPLE De Q1aQ 14 ct Q40 aQ47**

01 Point par élément d'item juste

0 Point par réponse fausse

A/ ETUDE DE CAS N°1 (Budgétisation des ressources propres)

La somme a la banque a la veille du monitoring du Centre de santé Rural de GBANGBEUGOUINE est de 8645000 f pour l'exercice 2024 non compris les intérêts et y compris les agios qui représentent respectivement 65000f et 43500f. Il faut noter que le montant pendant les six mois couverts par le monitoring a été déposée à la banque. Les recettes du centre issues de la vente des médicaments essentiels représentent le quart de la somme a la banque. Celles issues des coûts des actes sont égales à la moitié de la somme a la banque après mouvement bancaire. Les dépenses obligatoires du centre de santé font 4050000 f.

A partir des données financières du centre de santé rural pour l'année 2024

Q1 Quel est le montant de la somme a la banque après mouvement bancaire ?

- A. 8666500 f**
- B. 8665005 f
- C. 8566650 f
- D. 8065566 f

$$SB \text{ après mouvement bancaire} = 8645000 + 65000 - 43500 = 8666500$$

Q2 Quel est la somme issue de la vente des médicaments essentiels ?

- A. 8666500 f
- B. 8665005 f
- C. 2161250 f**
- D. 8065566 f

RVME représentent le quart de la somme a la banque (SB)

avec SB = 8645000

$$RVME = SB / 4 = 8645000 / 4 = 2161250$$

Q3 Quel est la somme issue des recettes des actes de santé ?

- A. 4053253 f
- B. 4350235 f
- C. 4332350 f
- D. 4333250 f**

RCAS sont égales à la moitié de la somme a la banque après mouvement bancaire

$$RCAS = SB \text{ après mouvement bancaire} / 2 = 8666500 / 2 = 4333250$$

Q4 Quel est la valeur de la somme à budgétiser ?

- A. 6945400 f
- B. 6500495 f
- C. 6494500 f**
- D. 6944005 f

$$SAB = RVME + RCAS$$

$$SAB = 2161250 + 4333250 = 6494500$$

Q5 Quel est la valeur des dépenses de fonctionnement local ?

- A. 2445400 f
- B. 2444500 f**
- C. 2500445 f
- D. 2440005 f

$$SAB = DO + DFL$$

$$DFL = SAB - DO$$

$$DFL = 6494500 - 4050000 = 2444500$$

Q6 Quel est la valeur des autres dépenses de fonctionnement local en dehors des montants réservés à l'immeuble et aux imprévus ?

- A. 2877025 f
- B. 2770285 f
- C. 2077825 f**
- D. 22580770 f

$$AUTRES = 85\% \times DFL$$

$$AUTRES = 85\% \times 2444500 = 2077825$$

B/ ETUDE CAS N°2 (Monitoring des activités)

Un monitoring portant sur l'activité de vaccination des jeunes filles de 9 ans du centre de santé rurale de GBANGBEUGOUINE pour la période du 01/06/2020 au 31/12/2020 a donné les résultats ci-dessous. Rappelons que la population totale du bassin de desserte était 15000 habitants au 31/12/2020

Disponibilité des ressources : 65%

Accessibilité géographique : 70%

Utilisation des services : 80%

Couverture adéquate : 50%

Couverture effective : 30%

A partir de la population totale du centre de santé rural

Q7 Quelle est la population cible annuelle ?

- A. 279 jeunes filles de 9 ans**
- B. 297 jeunes filles de 9 ans
- C. 227 jeunes filles de 9 ans
- D. 272 jeunes filles de 9 ans

$$\text{Pop Jeune fille} = 1,86\% \times Pt = 1,86\% \times 15000 = 279$$

Q8 Quelle est la population cible du monitoring ?

- A. 103 jeunes filles de 9 ans
- B. 104 jeunes filles de 9 ans
- C. 140 jeunes filles de 9 ans**
- D. 107 jeunes filles de 9 ans

$$\text{Pop Jeune fille du monitoring} = 279 / 2 = 140$$

Q9 Quelle est la durée du monitoring ?

- A. 181 jours
- B. 187 jours
- C. 182 jours
- D. 183 jours**

pour la période du 01/06/2020 au 31/12/2020
DONC la durée du monitoring est **183 jours**

Q10 Combien de goulots d'étranglement a ressorti le monitoring (01 seule réponses) ?

- A. 05 goulots d'étranglement
- B. 03 goulots d'étranglement**
- C. 01 goulots d'étranglement
- D. 02 goulots d'étranglement

$$PC - DR - AG - US - CA - CE$$

$$100\% - 65\% - 70\% - 80\% - 50\% - 30\%$$

35% -5% -10% 30% 20%

Q11 Quels sont les sites des trois goulots d'étranglement ressortis par le monitoring ?

- A. 01 goulots d'étranglement entre la population cible et la disponibilité des ressources**
- B. 01 goulots d'étranglement entre la disponibilité des ressources et Inaccessibilité géographique
- C. 01 goulots d'étranglement entre l'accessibilité géographique et l'utilisation des services
- D. 01 goulots d'étranglement entre l'utilisation des services et la couverture adéquate**

E. 01 goulots d'étranglement entre la couverture adéquate et la couverture effective

Q12 Quels sont les causes correspondantes aux trois goulots d'étranglement ressortis par le monitoring ?

- A. La population de jeunes filles n'a pas bénéficié des vaccins de qualité**
- B. Le centre de santé n'est pas fréquenté par jeunes filles de 9 ans
- C. Les jeunes filles de 9 ans sont très éloignées du centre de santé
- D. L'infirmier de la localité ne respecte l'intervalle de commande de vaccin recommandé dans les centres de santé périphériques**
- E. Le centre de santé n'est pas intensément fréquenté par les jeunes filles de 9 ans**
- F. Existence de préjugés sur la vaccination au sein de la population

Q14 Quels sont les trois supports de données qui ont permis de faire le monitoring.

L3P11

- A. La fiche de stock du vaccin HPV**
- B. Le livret de bord de la moto de l'infirmier
- C. Le registre de vaccination**
- D. La fiche de relevé de la température du réfrigérateur du centre de santé**
- E. Le registre de consultation
- F. La fiche d'entretien du réfrigérateur du centre de santé

C/ QUESTIONS A CHOIX DOUBLE

Q15 La santé communautaire vise la protection de la population. **B L1p8**

Q16 La santé publique se situe au niveau de la communauté. **B L1p8**

Q17 Le niveau décisionnel de la santé publique se situe au niveau étatique. **A L1p8**

Q18 Le système de santé ivoirien est sous forme pyramidale avec deux versants et trois niveaux. **A L1p35**

Q19 Un enfant qui suit correctement son calendrier de vaccination, reçoit le VPO1 à 10 semaines. **B L1p46**

Q20 Un enfant séropositif qui suit correctement son calendrier de vaccination, reçoit le RR-1 à 6 mois. **B L1p46**

Q21 A la 14ème semaine de vie, le nourrisson doit recevoir idéalement les doses de vaccin comme suit : DTCHepBHib+VPO+Pev13 +Rota et VPI. **B L1p46**

Q22 Dans le monitoring de l'activité de vaccination, la mauvaise estimation des besoins en vaccins est une cause probable du goulot d'étranglement situé entre la population cible et l'accessibilité géographique aux soins. **B L2p81**

Q23 Dans le monitoring des activités, les déterminants de couverture mesurent les indicateurs. **A L3p4**

Q24 L'accessibilité géographique aux soins dans le monitoring des consultations des soins curatifs se définit comme la population cible habitant dans un rayon de moins de 10 km. **A L3p5**

Q25 L'accueil humaniste des populations par les agents de santé est la stratégie pour corriger le goulot d'étranglement entre la couverture adéquate et l'utilisation de service. **A L2p80**

Q26 Il n'y a pas de différence entre les ressources propres et les ressources brutes d'une structure de Santé. **B L3p13**

Q27 La somme à budgétiser est aussi appelée le fonds de réserve dans la budgétisation des ressources Propres d'un ESPC dans le cadre des SSP. **A L3p15**

Q28 La somme à budgétiser est égale aux recettes issues de la vente des médicaments essentiels plus celles issues du coût des actes de santé. **A L3p16**

- Q29 La somme allouée aux imprévus dans la budgétisation des ressources propres d'un centre de santé rural ne doit pas excéder 10%des recettes brutes. **B L3p16**
- Q30 les étapes de l'organisation d'une séance de vaccination commencent toujours l'enregistrement de la population cible à vacciner. **B L3p61**
- Q31 Un enfant âgé de 2 semaines ayant déjà reçu le VPO0, le BCG et sa dose d'hépatite B a la naissance est correctement vaccine. **A L2p38**
- Q32 Un enfant correctement vacciné est celui qui reçoit toutes les doses de vaccins inscrites dans le programme élargi de vaccination. **B L2p38**
- Q33 Un enfant de 8 mois ayant reçu toutes ses doses de vaccins à l'exception des doses de RR1 et du VAA et du Men A est correctement vacciné **A** (RR1 est à 9mois)
- Q34 Un vaccin dont la PCV à virée et qui ne peut plus être utilise est un vaccin sacrifié. **B L2p38**
- Q35 Au cours de la gestion des vaccins, la règle PEPU permet d'éviter les doses gaspillées. **B L2p47**
- Q36 Le niveau de mise en œuvre des soins de santé primaires est aussi appelé niveau primaire. **A L1p75**
- Q37 Le niveau de mise en œuvre des soins de santé primaires est aussi appelé périphérique. **A L1p75**
- Q38 La conférence du 6 au 12 septembres 1978 au cours de laquelle la politique des SSP a été définie par l'OMS a eu lieu à ATA-ALMA en ex URSS. **B L1p74**
- Q39 L'Hôpital général est l'une des structures prestataires du niveau périphérique de la pyramide Sanitaire ivoirienne. **B**

D/ ETUDE DE CAS N°3(Epidémiologie)

La population au 31/12/2020 du bassin de desserte du centre rurale de GBANGBEUGOUINE, dans le district sanitaire de MAN est estimée à 14500habitants contre 14000 habitants au 01/01/2020. Les données démographiques et sanitaires ci-dessous ont été enregistrées au cours de l'année 2024

Naissances vivantes : 120

Nombre d'accouchement effectue par la sage-femme et les accoucheuses traditionnelles du bassin de desserte : 80

Décès toutes causes confondues : 55

Effectifs d'accouchement attendus : 705

250 cas de paludisme parmi lesquels : 10 cas décès ont été dénombrés

320 cas de maladies diarrhéiques sont les 2/3 sont des anciens cas

8 décès de femmes enceintes dont 2 survenus des suites d'un accident survenu du retour des champs

03 enfants dont l'âge est compris entre 0 et 11 mois sont morts dès suite d'une malnutrition sévère

QUESTIONS : A partir des données démographiques et sanitaires du centre de santé rural de GBANGBEUGOUINE:

Q40 Quel est le taux d'accroissement annuel de la population du CSR de GBANGBEUGOUINE en 2024 ?

A. 3,75%

B. 3,57%

C. 3,35%

D. 3,53%

$$\text{TAA} = \frac{((P_f - P_d) / P_d) \times 100}{100} = \frac{((14500 - 14000) / 14000) \times 100}{100}$$

$$\text{TAA} = 3,57\%$$

Q41 Quel est la population du CSR de GBANGBEUGOUIE au 01/01/2024 ?

- A. 16566 Habitants
- B. 16665 Habitants
- C. 16516 Habitants
- D. 16615 Habitants

$$P(01/01/2024) = P(01/01/2020) \times (1 + (TAA/100)) \exp 4$$

$$P(01/01/2024) = 14000 (1 + (3,57/100)) \exp 4 = 16109 \text{ hbts}$$

Q42 Quel est la population du CSR de GBANGBEUGOUTNE au 31/12/2024 ?

- A. 17062 Habitants
- B. 17620 Habitants
- C. 17026 Habitants
- D. 17260 Habitants

$$P(31/12/2024) = P(31/12/2023) \times (1 + (TAA/100)) \exp 1$$

$$P(31/12/2024) = 16109 (1 + (3,57/100)) \exp 1 = 16685 \text{ hbts}$$

Q43 Quel est la population moyenne du CSR de GIBANGBEUGOUIE en 2024 ?

- A. 16693 Habitants
- B. 16396 Habitants
- C. 16963 Habitants
- D. 16369 Habitants

$$P_{\text{moy}} = (P_d + P_f) / 2 = (16109 + 16685) / 2 = 16397 \text{ hbts}$$

Q44 Quel est le Taux d'accouchement assiste du CSR de GBANGBEUGOUIE en 2024 ?

- A. 11,43%
- B. 11,34%**
- C. 11,14%
- D. 11,13%

TAA= (Nb de femmes enceintes ayant été assistée pdt l'accouchement par un professionnel de santé ou par une accoucheuse traditionnelle) / (Nb de accouchements attendus) x 100

$$TAA = (80 / 705) \times 100 = 11,34\%$$

Q45 Quel est le Taux d'incidence des maladies diarrhéiques du CSR de GBANGBEUGOUIE en 2024 ?

- A. 0,06%
- B. 0,03%
- C. 0,36%
- D. 0,63%

$$TI = (\text{Nouveau Cas} / P_{\text{moy}}) \times 100, \text{ Nb de Cas} = 320, \text{ Anciens} = 2/3 \times 320$$

$$\text{Nouveau cas} = 320 - ((2/3) \times 320) = 107$$

$$TI = (107 / 16397) \times 100 = 0,65\%$$

Q46 Quel est le Taux de mortalité infantile du CSR de GBANGBEUGOUIE en 2024 ?

- A. 25‰.**
- B. 2,5‰.
- C. 26‰.
- D. 2,6‰.

$$TMI = ((\text{Décès des enfants de 0 à 11 mois}) / NV) \times 1000$$

$$TMI = (3 / 120) \times 1000 = 25\%$$

Q47 Quel est le Taux de mortalité maternelle du CSR de GBANGBEUGOUIE en 2024 ?

- A. 5400 décès maternels pour 100000 naissances vivantes
- B. 5000 décès maternels pour 100000 naissances vivantes**
- C. 5050 décès maternels pour 100000 naissances vivantes
- D. 5200 décès maternels pour 100000 naissances vivantes

TMM= ((Décès de femmes pdt la grossesse, l'accouchement et 42jrs après accouchement, ni accidentel, ni fortuit) / NV) x 100

$$TMM = (6 / 120) \times 100000 = 5000$$

BONNE CHANCE